PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS MUNICIPAL

PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DO ACESSO A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

NOVA MUTUM – MT

Setembro/2025

1º edição

Prefeito de Nova Mutum – MT
Leandro Felix da Silva

Vice-prefeito de Nova Mutum – MT
Alcindo Uggeri

Secretária Municipal de Saúde de Nova Mutum – MT
Sonia Maria de Avila

Diretora da Secretaria Municipal de Saúde
Luciane Mayer

Médicos Reguladores
Vandoir Valter Scheuermann
Luciana Maria Dalmas

Médico da Atenção Primária à Saúde
Lucas de Lima Ferreira

.

Coordenadora do Bloco Média e Alta Complexidade
Elisane Maria Della Mea

Coordenador da Atenção Primária à Saúde
Anderson Lins Ferreira Formighieri

Coordenação da Central de Regulação de Vagas Municipal
Luciana Albano (julho/2025)
Sandra Benedita Neves (presente)

Coordenadora do Setor de Controle, Avaliação e Auditoria Municipal SUS
Cleide da Silva

Colaboradores
Mariana Alves de Paula

Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT

www.novamutum.mt.gov.br (65) 3308-5400 Av.Mutum 1250 N , Centro CEP: 78452-034, Nova Mutum – MT

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AIH – Autorização de Internação Hospitalar

AIT – Acidente Isquêmico Transitório

APS – Atenção Primária à Saúde

APAC – Autorização de Procedimento Ambulatorial (Alta Complexidade / Custo)

AVC – Acidente Vascular Cerebral

BAV – Bloqueio Atrioventricular

CCO – Colpocitologia Oncótica

CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde

CNS – Cartão Nacional de Saúde

DIU – Dispositivo Intrauterino

DMG – Diabetes Mellitus Gestacional

DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

EAS – Elementos Anormais do Sedimento

EDA – Endoscopia Digestiva Alta

FAN – Fator Antinuclear

FTA-Abs – Fluorescent Treponemal Antibody Absorption

GGT – Gama Glutamil Transpeptidase

HCG – Hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana

HDL – High Density Lipoproteins

HRHSR – Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro

IST – Infecção Sexualmente Transmissível

KTPP – Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada

LDH – Desidrogenase Láctica.

PAM – Pronto Atendimento Municipal

PSF – Programa Saúde da Família

RG – Registro Geral

RNM – Ressonância Nuclear Magnética

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TC – Tomografia Computadorizada

TGO – Transaminase Oxalacética

TGP – Transaminase Pirúvica

TP – Tempo de Protrombina

TSH – Hormônio Tireoestimulante

VDRL – Venereal Disease Research Laboratory

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo de Atendimento Eletivo Regulado – Com Autorização Prévia.

Sumário

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES..... 3
LISTA DE FIGURAS..... 4
APRESENTAÇÃO..... 12
NORMATIZAÇÃO E ASPECTOS CONCEITUAIS..... 13
AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL-APAC.....13
LAUDO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH.....16
AÇÃO REGULATÓRIA.....19
REGRAS PARA A PRIORIZAÇÃO/REGULAÇÃO.....20
AGENDAMENTO.....21
SOLICITAÇÕES DE RAIO X..... 22
Figura 1 – Fluxo de Atendimento Eletivo Regulado – Com Autorização Prévia..... 23
PARTE I – REFERENCIAMENTOS.....24
PROTOCOLO MUNICIPAL BUCOMAXILOFACIAL.....24
Patologias maxilofacial.....24
Traumatologia.....25
Articulação Temporomandibular (ATM).....25
Problemas respiratórios..... 25
Pacientes Portadores de Necessidades Especiais.....25
PROTOCOLO MUNICIPAL CARDIOLOGIA.....27
Arritmias.....27
Cardiopatia Isquêmica..... 28
Hipertensão Arterial Sistêmica.....28
Insuficiência Cardíaca..... 29
Síncope ou Perda Transitória de Consciência.....30
Valvopatias.....31
PROTOCOLO MUNICIPAL CIRURGIA PLÁSTICA..... 32
Hipertrofia Mamária..... 32
PROTOCOLO MUNICIPAL CIRURGIA GERAL..... 34
Colelitíase e Coledocolitíase..... 34
Hemorróidas..... 34
Hérnias de Parede Abdominal e Diástase de Retos Abdominais..... 34
Pólipo de Vesícula Biliar..... 35
PROTOCOLO MUNICIPAL CIRURGIA VASCULAR.....37
Aneurisma de Aorta.....37
Doença Arterial Periférica.....37
Tromboembolismo Venoso.....38
PROTOCOLO MUNICIPAL DERMATOLOGIA..... 40

Acne....40
Alopecia....40
Dermatite Atópica....41
Melasma....41
Micoses....42
Outros Eczemas ou Dermatites (Dermatite Seborreica, Dermatite de Contato,....42
Eczema Disidrótico e Eczema de Estase)....42
Prurido....43
Psoríase....43
Rosácea....44
Urticária e Angioedema....44
Vitiligo....45
PROTOCOLO MUNICIPAL ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA....46
Bócio Multinodular....46
Diabetes Mellitus....46
Hipertireoidismo....47
Hipotireoidismo....47
Nódulo de Tireoide....47
Obesidade....48
PROTOCOLO MUNICIPAL GASTROENTEROLOGIA....51
Alteração de Hábito Intestinal....51
Dispepsia....51
Doença do Refluxo Gastroesofágico....52
Dor Abdominal....53
Esteatose Hepática....53
Hepatite B....54
Hepatite C....54
Suspeita de cirrose ou alterações laboratoriais hepáticas....55
PROTOCOLO MUNICIPAL GINECOLOGIA....56
Amenorreia....56
Climatério....56
Condiloma Acuminado / Verrugas Virais....57
Dor Pélvica Crônica / Endometriose....57
Incontinência Urinária....58
Massa Anexial....58
Miomatose Uterina....59
Neoplasia do Colo do Útero....60
Neoplasia do Endométrio....61

Prolapso Genital..... 61
Sangramento Uterino Anormal..... 62
PROTOCOLO MUNICIPAL HEMATOLOGIA..... 64
Anemia..... 64
Citopenias (bicitopenia/pancitopenia)..... 65
Distúrbios Hemorrágico..... 66
Hiperferritinemia..... 66
Leucócitos..... 67
Leucopenia..... 67
Policitemia..... 68
Trombocitopenia..... 69
Trombocitose..... 70
Trombofilias..... 70
PROTOCOLO MUNICIPAL MASTOLOGIA..... 73
Alterações Benignas da Mama..... 73
Neoplasia da Mama e Lesões Suspeitas..... 73
Ginecomastia..... 74
PROTOCOLO MUNICIPAL NEFROLOGIA..... 76
Cistos / Doença Policística Renal..... 76
Diabetes Mellitus..... 76
Doença Renal Crônica..... 77
Hipertensão Arterial Sistêmica..... 77
PROTOCOLO MUNICIPAL NEUROCIRURGIA..... 78
Acidente Vascular Cerebral..... 78
Cefaleia..... 78
Dor Cervical..... 79
Dor Lombar..... 80
Hidrocefalia..... 81
Malformações Vasculares Cerebrais..... 82
Neoplasia do Sistema Nervoso Central..... 82
Síndrome do Túnel do Carpo..... 83
PROTOCOLO MUNICIPAL NEUROLOGIA..... 84
Acidente Vascular Cerebral..... 84
Cefaleia..... 84
Convulsão / Epilepsia..... 85
Demência..... 86
Distúrbios do Movimento (Ataxias, Coreias e Distonias)..... 86
Polineuropatia..... 87

Tremores e Síndrome Parkinsonianas....88
Vertigem....88
PROTOCOLO MUNICIPAL NEUROPEDIATRIA....90
Atraso Global do Desenvolvimento (AGD) e Deficiência Intelectual....90
Cefaleia....91
Distúrbios do Movimento (Ataxias e Coreias)....92
Epilepsia....92
Microcefalia....93
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH)....93
Transtornos do Espectro Autista (TEA)....94
PROTOCOLO MUNICIPAL OFTALMOLOGIA....95
Catarata....95
Distúrbios de Refração ou Acomodação....95
Doenças da Córnea e da Superfície Ocular....95
Estrabismo....96
Glaucoma....96
Retinopatias ou Outras Doenças da Retina....97
Toxoplasmose....97
PROTOCOLO MUNICIPAL ORTOPEDIA....99
Bursite / Tendinite....99
Dor Cervical....99
Dor Lombar....100
Dor no Joelho....101
Dor no Ombro....102
Dor no Quadril....103
Osteoartrite....103
Patologias do Tornozelo e Pé....104
Problemas de Mão e Punho....104
PROTOCOLO MUNICIPAL OTORRINOLARINGOLOGIA....106
Disfagia....106
Disfonia....106
Hipoacusia / Perda auditiva e Protetização Auditiva....106
Obstrução Nasal....107
Otites....108
Rinossinusite....108
Ronco e Apneia do Sono....109
Vertigem....109
PROTOCOLO MUNICIPAL PEQUENAS CIRURGIAS....111

Fluxo de Referenciamento..... 111
PROTOCOLO MUNICIPAL PNEUMOLOGIA..... 112
Asma..... 112
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica..... 113
Tosse Crônica e Dispneia..... 114
PROTOCOLO MUNICIPAL PROCTOLOGIA..... 116
Fissura Anal..... 116
Fístula Anal..... 116
PROTOCOLO/FLUXO MUNICIPAL PSIQUIATRIA..... 117
Fluxo para encaminhamentos ao CAPS/Psiquiatra..... 117
Psicoses (Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos)..... 117
Transtornos Alimentares..... 118
Transtorno Bipolar..... 119
Transtorno de Ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)..... 120
Transtornos Depressivos..... 120
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Exposição a Evento..... 121
Traumático..... 121
Transtornos por Uso de Substância..... 122
PROTOCOLO MUNICIPAL REUMATOLOGIA..... 124
Artrite por Deposição de Cristais (Gota)..... 124
Artrite Psoriásica..... 124
Artrite Reumatoide..... 125
Fibromialgia..... 125
Lúpus Eritematoso Sistêmico..... 126
Osteoartrite..... 127
PROTOCOLO MUNICIPAL UROLOGIA..... 128
Cisto Doença Policística Renal..... 128
Disfunção Sexual Masculina..... 128
Fimose..... 129
Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)..... 130
Incontinência Urinária..... 131
Infecção Urinária Recorrente..... 131
Infertilidade Masculina..... 132
Litíase Renal..... 132
Neoplasia da Próstata..... 133
Varicocele..... 134
PARTE II..... 135
EXAMES DE IMAGEM..... 135

Angioressonância....135
Angiotomografia....135
Audiometria Tonal Limiar / Logoaudiometria / Imitanciometria....136
Broncoscopia....137
Cateterismo Cardíaco....137
Cintilografia da Tireoide com/ sem Captação....138
Cintilografia do Corpo Todo....139
Cintilografia do Miocárdio com / sem Captação....139
Cintilografia Renal Qualitativa e/ou Quantitativa....140
Colonoscopia....141
Densitometria Óssea....142
Ecocardiografia com Estresse....143
Ecocardiografia Transesofágico....144
Ecocardiografia Transtorácica....145
Eletroencefalograma....145
Eletroneuromiografia....146
Endoscopia Digestiva Alta....147
Espirometria....148
Laringoscopia Direta (Nasofibroscopia....148
Mamografia....149
Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA de 24 Horas)....150
Monitoramento pelo Sistema Holter de 24 Horas....151
Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (BERA)....151
Ressonância Magnética de Coluna Cervical / Torácica e Lombossacra....152
Ressonância Magnética de Abdome....153
Ressonância Magnética de Articulações....154
Ressonância Magnética de Crânio e Encéfalo....154
Ressonância Magnética de Pelve....155
Teste de Esforço / Ergométrico....156
Tomografia Computadorizada da Pelve....156
Tomografia Computadorizada de Abdome Superior....157
Tomografia Computadorizada de Articulações....158
Tomografia Computadorizada de Crânio e Sela Túrcica....159
Tomografia Computadorizada de Mediastino e Pulmão....160
Tomografia Computadorizada de Seios da Face....161
Tomografia Computadorizada de Tórax....161
Ultrassonografia de Articulação....162
Ultrassonografia com Doppler de Artéria Aorta Abdominal....163

Ultrassonografia com Doppler de Artérias dos Membros Inferiores.....164
Ultrassonografia com Doppler de Artérias dos Membros Superiores.....164
Ultrassonografia com Doppler de Artérias Renais.....165
Ultrassonografia com Doppler de Veias dos Membros Inferiores.....165
Ultrassonografia com Doppler de Veias dos Membros Superiores.....166
Ultrassonografia da Próstata Via Abdominal.....167
Ultrassonografia de Abdome Superior.....167
Ultrassonografia de Abdome Total.....168
Ultrassonografia de Aparelho Urinário.....169
Ultrassonografia de Bolsa Escrotal.....169
Ultrassonografia de Tireoide.....170
Ultrassonografia Mamária.....171
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica com Doppler.....171
Ultrassonografia Pélvica Ginecológica.....172
Ultrassonografia Transfontanela.....172
Ultrassonografia Transvaginal.....173
Uretrocistografia Miccional.....174
Link para anexos do Protocolo Municipal de Regulação.....175
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....176
ANEXO I - APAC.....186
ANEXO II - AIH.....187
ANEXO VI - FLUXO DE ENCAMINHAMENTO À FISIOTERAPIA DOMICILIAR.195
ANEXO VII - FLUXO DE ENCAMINHAMENTO À INSERÇÃO DE DIU.....197
ANEXO VIII - FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA.....198
ANEXO IX - FLUXO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGISTA DE URGÊNCIA.....199
ANEXO X - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.....201
ANEXO XI - PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS).....203
ANEXO XII -FORMULÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA.....204
ANEXO XIII - PROTOCOLO DE IMPLANTE INTRADÉRMICO HORMONAL.....206
ANEXO XIV - PROTOCOLO DE EQUOTERAPIA.....230
ANEXO XV - PROTOCOLO DE PEDIATRIA.....272
ANEXO XVI - PLANEJAMENTO FAMILIAR.....331
ANEXO XVI - PRÉ-NATAL.....357

APRESENTAÇÃO

A Central de Regulação de Vagas Municipal, tem grande importância para a garantia de serviços aos indivíduos dentro dos moldes constitucionais de universalidade, equidade no acesso aos serviços e integralidade nos cuidados. Segundo Eugênio Vilaça, 2010, “procurando garantir a prestação da atenção certa, no lugar certo, com a qualidade certa e com o custo e de forma humanizada”.

Esse protocolo tem como objetivo auxiliar os profissionais de saúde nas assistências, orientações e encaminhamentos dos usuários, permitindo resolução mais rápida e eficiente das enfermidades, gerando melhor qualidade de vida aos pacientes usuários do SUS.. Todas as orientações são baseadas em evidências e de acordo com os protocolos clínicos e linhas de cuidados da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum, bem como do Ministério da Saúde e de outras fontes de informações científicas, descrevendo a prática da medicina para subsidiar as decisões terapêuticas.

Protocolos de regulação são instrumentos de ordenação dos fluxos de encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente, orientando quanto à competência dos níveis de atenção, observando o grau de complexidade e resolutividade de cada um deles, devendo ser realizado por profissional de saúde, levando em conta a classificação de risco, ordem cronológica e alternativa assistencial mais adequada.

A Central de Regulação de Vagas Municipal, destina-se a regular, controlar e avaliar as solicitações de consultas, procedimentos, cirurgias e exames eletivos. As vagas para esse nível de complexidade são disponibilizadas através de contratualizações Municipal ou vagas ofertadas via Estado, portanto os encaminhamentos para consultas e a solicitação dos exames complementares deve ser uma conduta reservada àqueles pacientes que se enquadram através de indicações clínica, baseada nas melhores evidências disponíveis e de acordo com os Protocolos do Ministério da Saúde. Além disso, em atendimento a atual Política Nacional de Humanização, deve-se em todos os níveis de atenção à saúde estabelecer acolhimento com postura ética. Esses protocolos são dinâmicos e devem ser revistos regularmente para atualização e implantação de novas tecnologias em saúde, visando garantir a detecção precoce, o atendimento de qualidade, a longitudinalidade e a promoção à saúde do município de Nova Mutum - MT, considerando e garantido os princípios do SUS determinado por lei.

NORMATIZAÇÃO E ASPECTOS CONCEITUAIS

Como regra, qualquer encaminhamento realizado pela Rede Municipal de Saúde do Município de Nova Mutum para ser válido, deverá ser solicitado em formulário específico APAC (Autorização de Procedimento de Média e Alta Complexidade), via sistema, para unidades que realizam atendimento dentro do Município, sendo a mesma de obrigação de todos os profissionais (médicos, enfermeiro poderá encaminhar para primeira consulta do RN ao pediatra, fonoaudiólogo (exames pertinentes a especialidade), enfermeiros podem solicitar mamografia para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, bianual (somente para Campanhas da Carreta do Amor,) não é necessário APAC somente com o formulário específico.

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL-APAC

Cada Unidade de Saúde é responsável pelas APACs geradas na sua unidade, **ou de APACs de pacientes que pertencem a sua área** (por receber e retirar), realizar a conferência dos dados pessoais como de identificação do paciente, conferência de endereço, telefones de contato, sendo estes sempre atualizados pela Unidade de Saúde do paciente, conferir a compatibilidade de códigos e Cid´s, ou seja o preenchimento de todos os campos da APAC (conferência administrativa), para encaminhamento via sistema, ou física se for o caso, e posterior priorização, que será realizada pelo médico regulador municipal e após encaminhada para fila de espera.

Encaminhamentos para exames, consultas ou procedimentos, de atendimentos realizados por médicos profissionais de fora do Município, deverão dar entrada diretamente na Unidade Básica de Saúde pertencente ao paciente, para verificação dos dados e preenchimento adequado.

<u>O que verificar na APAC</u> :

- Todos os campos preenchidos;

  IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (SOLICITANTE)
  Nome Do Estabelecimento De Saúde;
  CNES.

  IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
  Nome do paciente;
  Data de nascimento;
  Sexo;
  Cartão SUS / CPF;
  Nome da mãe ou do responsável se for o caso;
  Endereço do paciente (Logradouro, bairro, número, CEP);
  Telefone atualizado para contato.

PROCEDIMENTO SOLICITADO
Código e Nome do Procedimento

JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO SOLICITADO:
Descrição do Diagnóstico e CID compatível;
Anamnese completa.

PROFISSIONAL SOLICITANTE
Nome do profissional;
CPF ou CNS do profissional,
Assinatura, carimbo e número de registro no conselho;
Data de solicitação (em caso de transcrição de encaminhamento manter a data da APAC original).

- Não conter rasuras, rasgos ou qualquer forma de alteração (inclusive corretivo);
- No caso de preenchimento manual, a APAC deve ser completamente manuscrita;
- APAC digitadas, sem combinação de métodos, (não podendo inserir informações posteriormente);

https://cpsvtp.pentagono.info/public/files/Portaria_033_2024___PROCESSO_DE_FATURAMENTO_07FA.pdf

- O preenchimento manual da APAC não deverá ter combinação de cores de caneta (preta ou azul);
- Confirmar código e CID no SIGTAP;

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.js

- Não inserir no sistema APAC física (EXTERNA);
- Manter data de solicitação na APAC gerada pelo especialista;
- Gerar uma APAC para cada solicitação de procedimento e/ou conferir compatibilidade quando órgão/estrutura bilateral (exemplo: mamas, olhos, ouvidos e outros);
- Anexar cópia de documentos pessoais e dos responsáveis quando necessário;
- Anexar espelho do sistema de informatização de saúde municipal (EXCETO HOSPITAL) e Cartão SUS, ambos ATUALIZADOS (ANEXOS OBRIGATÓRIOS PARA SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL);
- Anexar comprovante de residência (validade 06 meses) inclusive no sistema de informatização de saúde municipal (ANEXOS OBRIGATÓRIOS PARA SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL);

- Telefone para contato ATUALIZADO (sempre que o paciente for consultar atualizar os dados, inclusive no sistema de saúde municipal);
- Anexar cópia dos exames laboratoriais, orientar o paciente que deverá levar os exames originais no dia da consulta;
- Anexar raio-X quando houver;
- Anexar comprovação de exames solicitados para o retorno do paciente.
- APAC no sistema aguardando análise administrativa, terá o prazo de seis meses para ser analisada, logo após será cancelada.
- APAC para o especialista poderá ser solicitada após exames pré requisitos prontos;

- Seguir o protocolo para os exames em anexo em cada especialidade encaminhada.
- APACs de **Oftalmologia**, com a informação de Identificação do Estabelecimento CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, é recebida pela Unidade de Saúde do paciente, **NÃO** é inserida e **NEM** analisada administrativamente no sistema de saúde do município, esta será encaminhada ao Setor de Controle, Avaliação e Auditoria Municipal SUS com seus devidos preenchimentos e anexos.
- Paciente aguardando agendamento no sistema para consultas ou exames, identificado pelo médico da unidade de saúde piora no quadro clínico, o médico da unidade deverá entrar em contato com médico regulador da Central de Regulação para discutir o caso.
- **LEMBRANDO que todas as APACs físicas e via sistema devem seguir o fluxo descrito acima.**
- Somente realizar a troca de encaminhamentos de pacientes que consultam no sistema **particular** e vão ao PSF para solicitar encaminhamentos via SUS, quando houver indicação clínica;
- Pacientes diabéticos e hipertensos com indicação cirúrgica para avaliação com especialista deverão ter hemoglobina glicada solicitada previamente ao encaminhamento.

Toda solicitação de procedimento (Oftalmologia) que o código no SIGTAP permite AIH e APAC Seguir Os critérios de exames conforme protocolo em (Anexo).

*Ver modelo em branco de APAC em *link*.

ANEXOS PROTOCOLO REGULAÇÃO

LAUDO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH

AIH (Autorização de Internação Hospitalar) é um documento utilizado para registrar e autorizar internações hospitalares em unidades de saúde. A AIH contém informações do paciente, como diagnóstico, CIDs, procedimentos. As AIHs deverão ser encaminhadas ao Setor de Controle, Avaliação e Auditoria SUS Municipal, em 2 (duas) vias devidamente preenchidas e assinadas .

O que verificar na AIH :

- Todos os campos preenchidos;

  IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (SOLICITANTE)
  Nome Do Estabelecimento De Saúde;
  CNES.

  IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
  Nome do paciente;
  Data de nascimento;
  Sexo;
  Cartão SUS / CPF;
  Nome da mãe ou do responsável se for o caso;
  Endereço do paciente (Logradouro, bairro, número, CEP);
  Telefone atualizado para contato.

  JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO
  Principais Sinais e Sintomas Clínicos,
  Condições que Justificam a Internação;
  Principais Resultados de Provas Diagnósticas (Resultados de Exames Realizados);
  Diagnóstico Inicial e CID compatível.

  PROCEDIMENTO SOLICITADO
  Descrição Do Procedimento Solicitado;
  Código Do Procedimento;
  Clínica;
  Caráter Da Internação.

PROFISSIONAL SOLICITANTE
Nome do profissional;
CPF ou CNS do profissional;
Assinatura, carimbo e número de registro no conselho;
Data de solicitação (em caso de transcrição de encaminhamento manter a data da APAC original).

- Não conter rasuras, rasgos ou qualquer forma de alteração (inclusive corretivo);
- No caso de preenchimento manual, a AIH deve ser completamente manuscrita;
- AIH digitadas, sem combinação de métodos, (não podendo inserir informações posteriormente);

  https://cpsvtp.pentagono.info/public/files/Portaria_033_2024___PROCESSO_DE_FATURAMENTO_07FA.pdf

- O preenchimento manual da AIH não deverá ter combinação de cores de caneta (preta ou azul);
- Confirmar código e CID no SIGTAP;

  http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.js
- Não inserir no sistema AIH;
- Conferir compatibilidade quando órgão/estrutura bilateral (exemplo: hérnias unilaterais ou bilaterais, varizes unilaterais ou bilaterais e outros);
- Manter data de solicitação na AIH gerada pelo especialista;
- Anexar cópia de documentos pessoais e dos responsáveis quando necessário;
- Anexar espelho do sistema de saúde municipal e Cartão SUS, ambos ATUALIZADOS;
- Anexar comprovante de residência (validade 06 meses) (inclusive no sistema de saúde municipal);
- Telefone para contato ATUALIZADO (sempre que o paciente for consultas atualizar os dados, inclusive no sistema de saúde municipal);
- Pacientes abaixo de 60 anos de idades com solicitação de risco cirúrgico (cardiológico) sem justificativa terá o processo devolvido;
- Anexar cópia dos exames laboratoriais pré-requisito para AIHs Eletivas, e orientar o paciente que deverá levar os exames originais no dia da consulta;

Exames pré-requisitos obrigatórios para todas AIHs Eletivas:

- Hemograma
- Coagulograma
- Ureia e Creatinina
- Hemoglobina Glicada

Exames pré-requisitos para todas AIHs Eletivas pacientes **acima de 45 anos**:

- Hemograma
- Coagulograma
- Ureia E Creatinina
- Hemoglobina Glicada
- Eletrocardiograma.

Exames pré-requisitos para todas AIHs Eletivas pacientes **acima de 60 anos e/ou com comorbidades (justificativa)**:

- Hemograma
- Coagulograma
- Ureia E Creatinina
- Hemoglobina Glicada
- Eletrocardiograma
- Raio-x tórax
- Apac com solicitação de Risco Cardiológico.

- Anexar exames complementares (Raio-x, Tomografias, Ultrassonografias, Ressonâncias Magnéticas, Estudo Urodinâmico, Densitometrias, Colonoscopias e dentre outros que se fizerem necessários).

*Ver modelo em branco de AIH em *link*.

ANEXOS PROTOCOLO REGULAÇÃO

Após o processo montado conforme acima, deverá ter toda a documentação encaminhada, através de Protocolo em ordem alfabética, ao Setor de Controle, Avaliação e Auditoria Municipal SUS.

O Município de Nova Mutum, através do médico do Setor de Controle, Avaliação e Auditoria SUS Municipal, realiza a priorização de todos os encaminhamentos recebidos através do Sistema de informatização e/ou encaminhamentos físicos, oriundos dos serviços de saúde, que utiliza a classificação como grau de prioridade **P1, P2, P3, P4.**

P1= Urgente eletivo (atendimento o mais rápido possível)
P2= Eletivo Prioritário
P3= Prioridade não Urgente
P4= Eletivo

O Setor de Controle, Avaliação e Auditoria SUS Municipal não prioriza solicitações de atendimento com Grau de Prioridade zero, que são os atendimentos de urgência e emergência hospitalar, devendo estes serem encaminhados/direcionados através da Regulação Municipal via SISREG.

Pacientes encaminhados via ambulatorial, de forma eletiva, ficam aos cuidados da Unidade Básica de Saúde, enquanto aguardam o agendamento especializado (exame/consulta/procedimento ou cirurgia solicitada).

APAC com CID C e D, pacientes com NIC II e III deverão dar entrada em tempo hábil (48hrs).

Obs: Procedimentos Autorizados – São solicitações de autorizações de exames, consultas ou procedimentos de baixa, média ou alta Complexidade, solicitados pela equipe de saúde da rede Municipal (APAC), sendo submetidos à análise e autorização do regulador de acordo com o protocolo municipal e estadual.

AÇÃO REGULATÓRIA

A ação regulatória é o elemento ordenador e orientador dos fluxos assistenciais, sendo responsável pelo mecanismo de relação entre a gestão e os vários serviços de saúde, assim como da relação entre esses serviços, deve ser iniciada na Atenção Primária que exerce função de coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde. Na prática, a ação regulatória é definida como o processo de operacionalização, monitoramento e avaliação da solicitação de procedimentos, realizada por um profissional de saúde, levando em conta a classificação de risco, o cumprimento de protocolos de regulação estabelecidos para disponibilizar a alternativa assistencial mais adequada.

A ação regulatória deve estar fundamentada em Protocolos de Regulação que compreendem os protocolos de fluxos de encaminhamento, que são instrumentos ordenadores e que qualificam o acesso viabilizando a assistência integral ao usuário, entre os diversos níveis de complexidade da atenção, e os protocolos clínicos, que tratam da forma de intervenção por patologia, para subsidiar as decisões terapêuticas, que atendam às necessidades do usuário.

A estruturação do Complexo Regulador e das centrais que o compõem exige

profissionais capacitados, responsáveis pela execução de ações específicas.

REGRAS PARA A PRIORIZAÇÃO/REGULAÇÃO

- O REGULADOR irá realizar a priorização de todas as consultas, exames e procedimentos e pedidos de cirurgias que dão entrada neste serviço (físico ou via sistema), sendo permitido as seguintes possibilidades:

- **NEGAR:** neste caso o procedimento/consulta especializada é efetivamente negado (falta de critérios para o encaminhamento ou paciente encaminhado para especialidade/exame incompatível com a clínica). Deve-se justificar o motivo da negativa, baseado em dados reais. Todos os casos sem necessidade ou o encaminhamento para especialidade/exame incompatível com o caso clínico devem ser NEGADOS a fim de não mais permanecerem na lista de espera ou pendentes para regulação. TODA APAC CANCELADA DEVERÁ TER O MOTIVO DO CANCELAMENTO DESCRITO.

- DEVOLVER: neste caso o procedimento/consulta especializada é devolvido para complementação de dados (faltam informações clínicas para subsidiar a decisão do REGULADOR). Assim o SOLICITANTE recebe uma informação da devolução e pode complementar a indicação. O paciente permanece na lista de casos DEVOLVIDOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE SOLICITANTE.

- AUTORIZAR: neste caso o REGULADOR autoriza o encaminhamento e o mesmo passará para a FILA DE ESPERA gerando um número de ordem da Central de Regulação Vagas para posterior agendamento municipal ou estadual.

OBS: Todo caso **NEGADO ou DEVOLVIDO** deve ser discutido com o profissional solicitante ou em equipe, o que contribui para a educação permanente de todos os profissionais envolvidos na assistência.

NEGAR todo caso cuja indicação não esteja suportada em boa fundamentação científica, ou baseada em evidências. As solicitações para nível secundário são finitas e todo paciente mal indicado para exames complementares e consultas especializadas, acabam ocupando uma vaga de algum paciente que realmente necessita ou que tem prioridade na indicação clínica, prejudicando toda a rede assistencial, aumentando o tempo de espera para todos.

IMPORTANTE! Todos os protocolos estarão sujeitos a revisão anual e abertos a sugestões de inclusão de novas indicações de sua realização conforme demanda por escrito e embasada cientificamente por todos os profissionais da Rede Municipal de Saúde. A realização dos mesmos não tem como objetivo tirar a liberdade ética da equipe, mas sim promover e facilitar o acesso à saúde de forma prioritária aos pacientes, aos exames, o que lhe trará agilidade de acesso e consequente tratamento precoce.

Protocolo de Agendamento da fila de espera da Central de Regulação de Vagas Municipal

Considerando a Lei 10.783, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a transparência da Política Estadual de Regulação do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado do Mato Grosso.

Considerando o Decreto Nº 670, de 07 de Outubro de 2020, que Regulamenta os termos da Lei nº 10.783, de 28 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre a transparência na Política Estadual de Regulação do Sistema Único de Saúde -SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Considerando a Lei Nº 11.619, de 13 de dezembro 2021 – DOEAL/MT de 14.12.21 e do 15.12.21, que dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consulta (discriminadas por especialidade), exames, internações cirúrgica e outros procedimentos da rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum, através da Central de Regulação de Vagas Municipal vem informar que a partir do mês de _____ todos os encaminhamentos que estão no aguardo de agendamentos na Central de Regulação de Vagas Municipal, seguirão os mesmos critérios do protocolo Municipal e do Estado, seguindo a atualização cadastral e o andamento da fila de espera.

AGENDAMENTO

Após analisada administrativamente e priorizada pelo médico auditor, o agendamento segue por ordem cronológica de solicitação médica e/ou por grau de prioridade. Após realizado o agendamento na data definida, os pacientes com os encaminhamentos selecionados conforme grau de prioridade e ou ordem cronológica de solicitação médica serão comunicados através de contato telefônico, sobre a data, horário e local do agendamento

Os pacientes em que não for possível contato via telefone para serem comunicados sobre o agendamento (não localizado, cx postal, número inexistente....), serão encaminhados para busca ativa através das Unidades Básicas de Saúde, via sistema, para que o paciente seja comunicado sobre o agendamento já realizado;

A Unidade Básica ficará responsável por comunicar o paciente e dar um retorno sobre a busca ativa, via sistema, no prazo de cinco (05) dias;

Os casos em que não houver devolutiva da Unidade Básica de Saúde sobre a busca ativa após o prazo definido (05 dias), o encaminhamento será arquivado com a seguinte descrição:**sem resposta da busca ativa** realizada pela UBS - Unidade Básica de Saúde, e o próximo, um novo encaminhamento (paciente), que encontra-se na fila de espera será agendado para esta vaga (próximo paciente da fila de espera);

Seguindo assim até preencher o total de vagas pré determinadas para cada tipo de especialidade.

Relacionados aos processos cirúrgicos de pacientes faltantes e ou nos casos em que o paciente solicitar reagendamento, será aceito com o prazo de 30 dias para a próxima data, caso o paciente não se apresente o processo será arquivado.

Será justificativa para reagendamento: atestado médico

OBS: Após o arquivamento, o registro do motivo do arquivamento estará informado no sistema de saúde do Município, Caso o paciente tenha interesse em realizar a cirurgia/exame ou consulta, deverá ser reiniciado novo processo pela Unidade Básica de Saúde de origem do paciente.

SOLICITAÇÕES DE RAIO X

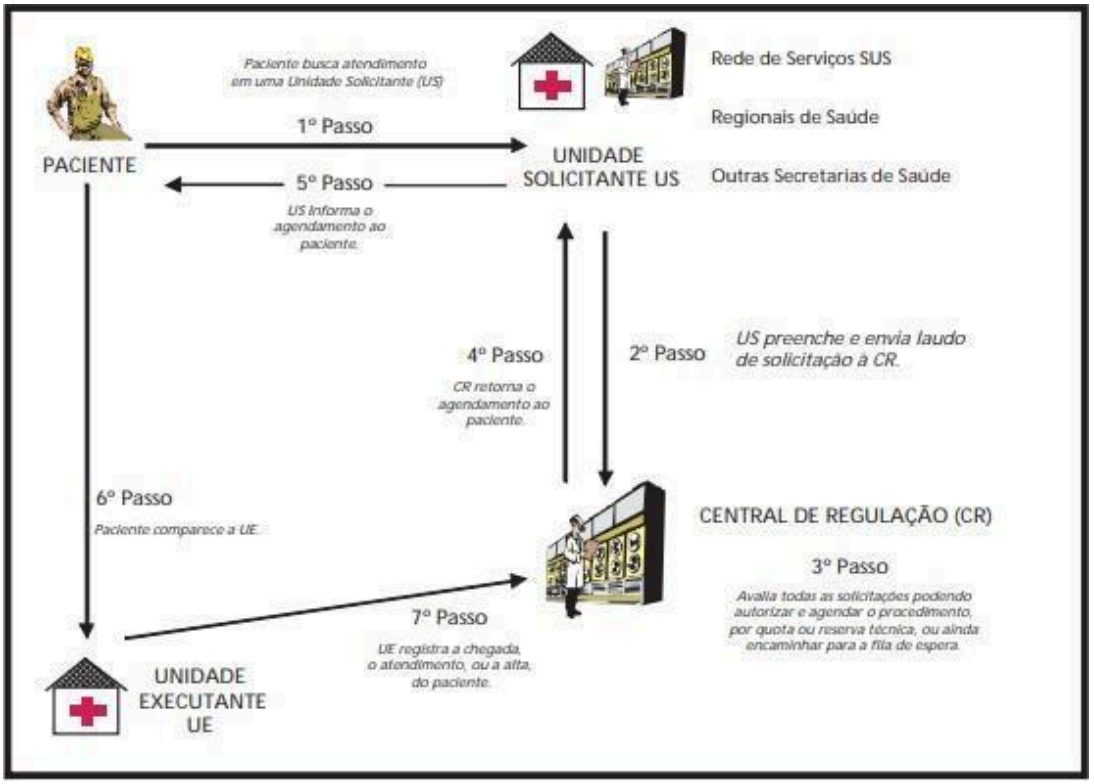
Os pedidos de RX gerados pelas unidades de saúde municipal, deverão ser realizadas a análise administrativa e logo agendados pela própria unidade, conforme disponibilidade das agendas via Consórcio, gerando a guia do exame e as orientações ao paciente, logo realizar a baixa do exame no sistema, evitando que o mesmo caia na fila de espera da Central de Vagas.

Os pedidos de RX, solicitados pelo Hospital, serão priorizados conforme como P1, P2, P3 e P4 pelo médico auditor da Central de Vagas/Controle e Avaliação do município, levando em consideração a descrição clínica do paciente, registrada na Apac. As demandas do hospital, deverão ser entregues no Controle e Avaliação. Os RX serão agendados pelos agendadores da Central de Vagas, conforme prestadores credenciados.

Esses pedidos serão lançados via APAC devidamente preenchidos, o agendador é responsável por dar baixa/saída no sistema desses pedidos e informar o motivo, evitando que os mesmos fiquem poluindo a fila de espera.

Pacientes atendidos no pronto atendimento municipal, não terão direito a encaminhamentos (Apac) via SUS eletivos , pois a investigação deverá ser realizada pelas unidades básicas de saúde em que o paciente é cadastrado.

Figura 1 – Fluxo de Atendimento Eletivo Regulado – Com Autorização Prévia.



Fonte: Diretrizes para a Implantação de Complexos Reguladores, página 23, 2º edição, 2010

PARTE I – REFERENCIAMENTOS.

PROTOCOLO MUNICIPAL BUCOMAXILOFACIAL
1. Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) : ● Pacientes politraumatizados com fraturas de face que incluem: ● Fraturas do osso frontal, fraturas de maxila, complexo zigomático-maxilar, órbita, fraturas nasais, fraturas de mandíbula; ● Fraturas complexas de face que exigem reconstrução maxilo-mandibular, fraturas complexas por disparo de armas de fogo; ● Pacientes com rinorragia em decorrência de fratura dos ossos nasais. Pacientes com abscessos e/ou celulite faciais: ● Infecção que envolva espaços anatômicos – orbital, submandibular, submentual, além dos casos de abscesso facial com extensão para região cervical os quais podem evoluir para casos de angina de Ludwig; Geralmente nesses casos, os pacientes encontra-se em ATB V.O sem melhora clínica. ● Tumores faciais com sinais clínicos de: ● Extenso edema em face, com drenagem de secreção purulenta; ● Casos de luxação mandibular. ● Ferimentos extensos de face em decorrência de traumas e/ou mordeduras de animais.
Patologias maxilofacial
2. Encaminhar ao bucomaxilofacial: ● Lesão da região bucomaxilofacial com crescimento rápido, não associado a fatores irritativos como trauma ou dentes necróticos e que não regride após 14 dias de acompanhamento; ● Lesão intra óssea do complexo maxilomandibular, não associada a dentes necróticos; ● Cistos ou outras lesões benignas dos tecidos moles da boca, da face e/ ou das articulações temporomandibulares (ATM), ● Processos infecciosos / obstrutivos de glândulas salivares (maiores ou menores); ● Cistos ou outras lesões potencialmente benignas em glândulas salivares menores; ● Paciente com diagnóstico de osteonecrose de mandíbula por uso de bifosfonato ou com alto risco de desenvolvimento de osteonecrose (uso de bifosfonado oral por mais de 4 anos ou uso de bifosfonado endovenoso); ● Edemas em face compatível com tumores e/ou quadros infecciosos.

Traumatologia

Encaminhar ao bucomaxilofacial:

- Sequelas de trauma na região bucomaxilofacial que causam limitações funcionais;
- Necessidade de enxerto ósseo na maxila e na mandíbula;
- Alterações estéticas e/ou funcionais em decorrência de traumas faciais antigos;
- Pacientes com anomalias crânio-faciais - retrognatismo mandibular, protusão mandibular e assimetrias faciais;

Articulação Temporomandibular (ATM)

- Paciente com disfunção de ATM com sintomas graves (dor ou prejuízo funcional) refratários ao tratamento conservador por 6 meses (usando prótese superior e inferior, se paciente edentado);
- Pacientes com DTM, que incluem como sinais e sintomas - dor articular, dor muscular, limitação dos movimentos mandibulares, ruídos articulares audíveis, quadros de travamento mandibular e alterações otológicas, incluindo, otalgia e zumbido;
- Cistos e/ou tumores em ATM visualizados em exames de imagem – referenciar o paciente com exames em mãos (Tomografia de ATM);
- Pacientes com histórico de quadros recidivantes de travamento mandibular.

Problemas respiratórios

- Pacientes com hipótese de apneia obstrutiva do sono, que apresentam como sinais e sintomas - dificuldade respiratória, cansaço excessivo ao falar e/ou andar, ronco noturno.

Pacientes Portadores de Necessidades Especiais

- Pacientes com déficits neurológicos que necessitem de intervenção cirúrgica.

3. Dados que devem conter no encaminhamento:

- História médica pregressa com sinais e sintomas;
- Tratamentos anteriores já realizados;
- Resultado de exame de imagem, radiografia panorâmica, com data;
- Resultado de biópsia de lesões, com data (se realizado)Tratamentos já realizados (descrever tempo de acompanhamento, procedimentos e medicamentos empregados).
- Cistos e/ou tumores odontogênicos - radiografia panorâmica já em mãos;
- Lesões em boca - radiografia panorâmica;

PROTOCOLO MUNICIPAL CARDIOLOGIA

Arritmias

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Arritmia em paciente com sinais de hipoperfusão, síncope, dispneia, fibrilação de início recente, suspeita de síndrome coronariana aguda, entre outras.

2. **Encaminhar ao Cardiologista:**

- Bradicardia sinusal sintomática ou assintomática com frequência cardíaca menor que 45 bpm (após avaliação em serviço de emergência);
- Bloqueio bifascicular (bloqueio completo de ramo esquerdo; bloqueio completo de ramo direito associado à hemibloqueio anterior esquerdo ou associado à hemibloqueio posterior esquerdo);
- Fibrilação atrial com possibilidade de cardioversão (paciente com idade menor que 65 anos e átrio menor que 5 cm); ou
- Taquicardia supraventricular sintomática ou recorrente, sem resposta ao tratamento;
- Taquiarritmias ou alterações na condução cardíaca potencialmente grave (considerar sempre necessidade de encaminhar para serviço de emergência); ou
- Investigação de palpitação recorrente de origem indeterminada.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução, frequência dos sintomas, relação com esforço, consequências hemodinâmicas);
- Tipo de arritmia, quando estabelecida;
- Medicações em uso (todas), com posologia;
- Descrição do eletrocardiograma, com data;
- Descrição de exames laboratoriais com data (sodio e potassio);
- Outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou não).
- Radiografia do Tórax PA+Perfil.

4. **Prioridades para o agendamento:**

- Pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca ou insuficiência coronariana associada a BAV grau II ou III e bloqueio bi ou trifascicular.

Cardiopatia Isquêmica

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Suspeita ou diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda.

2. **Encaminhar ao Cardiologista:**

- Cardiopatia isquêmica estabelecida em pacientes com necessidade de estratificação de risco após evento agudo (quando não realizada no serviço de urgência ou emergência);
- Cardiopatia isquêmica estabelecida em paciente ainda sintomático, mesmo com tratamento clínico otimizado (nitrato oral, betabloqueador e/ou antagonista do canal de cálcio), ou impossibilidade de uso das medicações por efeito adverso ou contraindicação; ou
- Suspeita de cardiopatia isquêmica, sem impossibilidade de investigação com exames não invasivos (ergometria, ecocardiografia de estresse, cintilografia miocárdica) ou indicação de cateterismo cardíaco.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Idade;
- Sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução, frequência dos sintomas, relação com esforço ou outros fatores desencadeantes ou de alívio, consequências hemodinâmicas);
- Medicamentos em uso, com posologia;
- Resultado do eletrocardiograma, com data;
- Descrição de exames laboratoriais com data (sodio e potassio);
- Presença de fatores de risco para doença arterial coronariana (diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia).
- História de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral.

Hipertensão Arterial Sistêmica

1- Encaminhar ao Cardiologista:

- Suspeita de hipertensão secundária.
- Hipertensão mal controlada (fora do alvo terapêutico) com no mínimo três medicações anti-hipertensivas em dose plena, após avaliar adesão;
- Hipertensão mal controlada (fora do alvo terapêutico) com no mínimo três medicações anti-hipertensivas em dose plena e lesões de órgão – alvo.

2- Dados que devem conter no encaminhamento:

- Sinais e sintomas;

- Medicações em uso, com posologia;
- Duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes;
- Resultado do eletrocardiograma, com data;
- Descrição de exames laboratoriais com data (sodio e potassio);
- Descrever alterações na ausculta cardíaca e respiratória e/ou presença de edemas, se presentes;
- Avaliação clínica da adesão ao tratamento.

3- Prioridades para o agendamento:

- HAS severa com sinais de doenças associadas descompensada – insuficiência cardíaca congestiva; diabetes mellitus; doença vascular periférica, doenças cerebrovascular; coronariopatas pós-cirurgia; insuficiência renal crônica; infecção pelo HIV; dislipidemia familiar e maiores de 40 anos.

Insuficiência Cardíaca

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG):**

- Pacientes com insuficiência cardíaca com sinais de hipoperfusão, síncope ou com sinais de congestão pulmonar.

2. **Encaminhar ao Cardiologista:**

- Classe funcional (NYHA) III e IV em pacientes já com tratamento clínico otimizado em uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina, beta bloqueador e diurético, na ausência de intolerância.
- Episódio de internação hospitalar devido à insuficiência cardíaca descompensada no último ano.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução, frequência dos sintomas, classe funcional (NYHA), sinais de congestão e hipoperfusão);
- Resultado do eletrocardiograma, com data ;
- Resultado do raio-X de tórax, com data;
- Descrição de exames laboratoriais com data (sodio e potassio);
- Medicações em uso, com posologia;
- Outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou não).

4. **Prioridades para o agendamento:**

- Pacientes pós-infarto, pós-revascularização e pós-angioplastia

Síncope ou Perda Transitória de Consciência

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Episódio de síncope em paciente com sinais de hipoperfusão, congestão pulmonar, fibrilação de início recente, suspeita de síndrome coronariana aguda e alterações de risco em eletrocardiograma.

2. **Encaminhar ao Cardiologista:**

- Síncope associada a sinais e sintomas de provável origem cardiológica (dispneia, hipotensão, dor torácica, sopro, episódio que ocorre durante o exercício); ou
- Síncope em paciente com alteração compatível no eletrocardiograma; ou
- Síncope em paciente com cardiopatia estabelecida (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, valvulopatia, miocardiopatia dilatada, doenças cardíacas congênitas); ou
- Síncope em paciente com história familiar (pais ou irmãos) de morte súbita antes dos 40 anos;
- Síncope / pré-síncope de origem indeterminada.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas (descrever episódio com sua frequência e duração, associação com outros sintomas de provável origem cardiológica (palpitação, dispneia, desconforto precordial), relação com exercício ou outros fatores desencadeantes e exame físico neurológico e cardiológico);
- Presença de cardiopatia e sua descrição.
- Descrição de exames laboratoriais com data (glicemia jejum,sodio e potassio);
- História familiar de morte súbita. Se sim, idade do evento e grau de parentesco;
- Resultado de eletrocardiograma com data;
- Medicamentos que podem causar síncope (antiarrítmicos, antihipertensivos).

4. **Situações associadas à síncope que usualmente não necessitam avaliação em serviço especializado (síncope vasovagal):**

- Postura ortostática prolongada; ou
- Estresse emocional (fatores definidos como: dor, medo, fobia de sangue ou procedimentos médicos) ou situações específicas (tosse, espirro, estimulação gastrintestinal, pós-miccional); ou
- Sintomas prodrômicos, como sudorese, calor e escurecimento da visão.

Valvopatias

1- Encaminhar ao Cardiologista:

Todos os pacientes com valvopatias moderadas / graves; ou

Paciente sintomático com qualquer valvopatia detectada em ecocardiografia.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas – presença de síncope, dor torácica ou dispneia, descrever também tempo de evolução; frequência dos sintomas, classe funcional (NYHA);

Presença de sopro, sua localização e as características dele, bem como intensidade, com ou sem frêmito;

Outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou não);

Descrição de exames laboratoriais com data (glicemia jejum,sodio e potassio);

Descrição do eletrocardiograma e raio-X de tórax, com data;

Descrição da ecocardiografia (área valvar, gradiente médio, fração de ejeção e diâmetros do ventrículo esquerdo), com data (se disponível).

3-Condições clínicas que indicam a necessidade de ecocardiograma:

Qualquer sopro diastólico ou contínuo; ou

Sopro sistólico associado a pelo menos um dos sintomas:

Dispneia, dor torácica, síncope/pré-síncope; ou - sopro de grau elevado (≥3/6) ou frêmito; ou

Alterações significativas em eletrocardiograma e/ou raio-x de tórax; ou Sopro de início recente e suspeita de valvopatia.

PROTOCOLO MUNICIPAL CIRURGIA PLÁSTICA

Hipertrofia Mamária

1- Encaminhar ao Cirurgia Plástica:

Hipertrofia mamária, em paciente com 18 anos ou mais, não tabagista, com IMC<27 com alterações funcionais como (ter no mínimo 2 critérios):

a) Dor recorrente nas costas, pescoço ou ombros;
b) Sintomas neurológicos associados à compressão do plexo braquial dos membros superiores;
c) Intertrigo crônico ou dermatite recorrente nas mamas ou no tórax.

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

- Sinais e sintomas (descrever achados no exame físico, dor ou desconforto, complicações associadas), tratamento conservador já realizado (perda de peso, uso de sutiã de tamanho adequado, atividade física ou fisioterapia);
- Descrever/anexar resultado de mamografia ou ultrassonografia de mamas conforme idade, para rastreamento de câncer de mama;
- Índice de massa corporal (IMC < 27);
- Se é ou não tabagista,(se era, a quanto tempo parou)

Antes do encaminhamento deve ser concluída a investigação de doença mamária/nódulo mamário a esclarecer ou com necessidade de tratamento complementar.

O tabagismo aumenta consideravelmente os riscos de complicações pós-operatórias e pode comprometer os resultados da mamoplastia. Está indicada a cessação do tabagismo antes de um procedimento eletivo, com suporte e tratamento realizados preferencialmente na Atenção Primária à Saúde.

Processo deverá ser iniciado na Unidade Basica de Saude, com os seguintes anexos:

- UBS solicita exames de imagem raio-x de coluna, Mamografia ou Ultrassonografia conforme idade;
- Após exame de imagem (USG e Mamografia) pronto, encaminhar ao Ginecologista;

- Ginecologista encaminha ao Ortopedista se critério **a** e/ou **b** do ítem 1;
- Ginecologista encaminhar ao Dermatologista se critério **c** do ítem 1;
- Ortopedista/Dermatologista encaminha ao Cirurgião Plástico;
- Se houver solicitação de procedimento cirúrgico a Atenção Especializada deverá encaminhar o processo de forma física ao Setor de Controle, Avaliação SUS Municipal.

PROTOCOLO MUNICIPAL CIRURGIA GERAL

Colelitíase e Coledocolitíase

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Suspeita de colecistite aguda, pancreatite aguda, coledocolitíase sintomática ou colangite.

2. **Encaminhar ao Cirurgião Geral:**

- Colelitíase sintomática;
- Colelitíase com complicação prévia (colecistite aguda ou pancreatite biliar) em paciente não submetido à colecistectomia;
- Colelitíase assintomática associada a fatores de risco para neoplasia do trato biliar.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Quadro clínico (sinais e sintomas associados, achados no exame físico, história de complicações - colecistite, colangite ou pancreatite aguda, comorbidades);
- História de colecistectomia ou outros procedimentos biliares;
- Descrever laudo ultrassonografia de abdomen total ou superior, com data;
- Descrição de exames laboratoriais com data (Tgo,tgp bilirrubinas, lipase e amilase, hemograma);

Hemorróidas

1. **Encaminhar ao Cirurgião Geral:**

- Hemorroidas internas ou mistas que persistem sintomáticas após tratamento conservador por 2 meses (suplementação alimentar de fibras e aumento de ingesta hídrica, banho de assento, evitar uso de papel higiênico); ou
- Hemorroidas internas com grau III e IV.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas (descrever inspeção anal e toque retal);
- Classificação das hemorroidas (interna, externa ou mista) e classe das hemorroidas internas (Grau I a IV);
- Tratamentos já realizados para hemorroidas (tratamento conservador com tempo de duração e procedimentos, quando realizado).

Hérnias de Parede Abdominal e Diástase de Retos Abdominais

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Suspeita de hérnia encarcerada (dolorosa e não redutível) ou estrangulamento herniário.

2. **Encaminhar ao Cirurgião Geral:**

- Hérnia inguinal;
- Hérnia umbilical sintomática;
- Hérnia incisional;
- Hérnia epigástrica;
- Hérnia abdominal de outra localização (como hérnia femoral e hérnia de Spiegel);
- Diástase de retos abdominais que sejam sintomáticos (desconforto local, grande abaulamento, dor), associada à hérnia umbilical ou epigástrica.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Quadro clínico (sinais e sintomas associados, achados no exame físico, história de complicações, ocorrências de recidiva, comorbidades);
- Se diástase, descrever tratamento conservador realizado e por quanto tempo;
- Descrever na íntegra, laudo de exame de imagem com data;
- Anexar exame de imagem com laudo;
- Cirurgias prévias (tipo, data e serviço que realizou a cirurgia), se realizado.

4. **Condições passíveis de acompanhamento na Atenção Primária à Saúde (APS):**

- Em pacientes com hérnia umbilical ou incisional minimamente sintomática ou assintomática pode-se considerar observação clínica, especialmente em idosos com comorbidades clínicas que aumentam risco cirúrgico ou que não desejam submeter-se à cirurgia;
- Pacientes com comorbidades como obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m2), diabetes ou hipertensão descompensados, tabagismo ativo, apresentam contra indicação relativa ao procedimento cirúrgico. Assim que identificadas essas condições, o seu manejo na APS deve ocorrer concomitantemente ao encaminhamento ao serviço de Cirurgia Geral.

Pólipo de Vesícula Biliar

1. **Encaminhar ao Cirurgião Geral:**

- Pólipo de vesícula biliar associada a alguma das seguintes características:
- Ma
- sintomas; ou

- Crescimento durante o acompanhamento ultrassonográfico; ou
- Pólipos de 6 a 9 mm associados a colelitíase ou fatores de risco para neoplasia de vesícula biliar.
- Pólipos assintomáticos menores que 10 mm devem ser acompanhados na APS com ultrassonografia.

2. Dados que devem conter no encaminhamento:

- Quadro clínico (sinais e sintomas associados, achados no exame físico, história de complicações - colecistite, colangite ou pancreatite aguda, comorbidades);
- Descrever se há fatores de risco para neoplasia de vesícula biliar.
- Descrever na íntegra, laudo de exame de imagem ultrassonografia de abdomen total ou abdome superior com data.

PROTOCOLO MUNICIPAL CIRURGIA VASCULAR

Aneurisma de Aorta

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Suspeita ou diagnóstico de ruptura de aneurisma da aorta;
- Paciente com aneurisma não roto que apresenta suspeita de ruptura iminente, progressão / complicação aguda ou sintomas não controláveis.

2. **Encaminhar ao Cirurgião Vascular:**

- Aneurisma sintomático não-roto da aorta abdominal, excluídas outras causas para os sintomas e não operados após avaliação em serviço de emergência;
- Aneurisma da aorta abdominal assintomático: Com Diâmetro maior ou igual a 4,5 cm;
- ou Com expansão rápida (maior do que 1 cm no ano ou 0,5 cm em 6 meses); ou
- Em paciente com outros aneurismas periféricos (artérias ilíacas, femorais ou poplíteas).

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas (descrever tempo de evolução, frequência dos sintomas, relação com esforço ou outros fatores desencadeantes ou de alívio, alterações ao exame físico);
- Descrever atendimentos prévios em emergência e conduta na ocasião (se realizado);
- Medicamentos em uso, com posologia;
- Descrever na íntegra, laudo de exames complementares, como raio-X de tórax e/ou. Ecocardiografia,;
- Presença de fatores de risco para ruptura de aneurisma, se presentes.

4. **Prioridade para o agendamento:**

- Suspeita de aneurisma aorta abdominal.

Doença Arterial Periférica

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Suspeita de isquemia crítica aguda do membro de início recente (dor constante em repouso, palidez, ausência de pulso, membro mais frio em relação ao contralateral,

alteração de sensibilidade ou força, parestesia e paralisia do membro, sinais de gangrena).

2. **Encaminhar ao Cirurgião Vascular:**

- Doença arterial crônica avançada com sinais ameaçadores ao membro (dor crônica em repouso, úlcera arterial ou gangrena);
- Doença arterial crônica sintomática com claudicação que limita as atividades diárias refratária ao tratamento conservador por 6 meses (uso de cilostazol, exercício físico apropriado, antiagregante plaquetário, controle de fatores de risco cardiovascular - cessar tabagismo, tratamento de diabetes, hipertensão e dislipidemia).

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas (ausência de pulsos, atrofia da musculatura, perda de pêlos, presença de lesão trófica, presença de necrose, tempo de evolução, amputações prévias);
- Fatores de risco (HAS, dislipidemia, tabagismo, diabetes, doença cardiovascular, síndrome metabólica);
- Tratamento realizado na APS (exercício, medicações em uso, com posologia, mudanças no estilo de vida);
- Descrever na íntegra, laudo de ecodoppler arterial, com data;
- Anexar exame de imagem com laudo

Tromboembolismo Venoso

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Suspeita clínica de trombose venosa profunda (TVP);
- Suspeita clínica de tromboembolismo pulmonar (TEP).

2. **Encaminhar ao Cirurgião Vascular:**

- Síndrome pós-trombótica (insuficiência venosa secundária a trombose de membro inferior) com sintomas persistentes (dor, edema, dermatite ocre, úlcera venosa) refratária ao tratamento conservador na APS (exercícios, elevação de membros, terapia compressiva) por 6 meses.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Descrição do episódio de TEV, localização, conduta realizada na emergência e data do evento;
- Especificar se o paciente já está em uso de anticoagulante;
- Descrever se presença de episódios recorrentes de tromboembolismo venoso;
- Presença de fatores de risco ou fatores desencadeantes para TEV;
- Descrever na íntegra, laudo de exames realizados, com data.
- Anexar exame de imagem com laudo

PROTOCOLO MUNICIPAL DERMATOLOGIA

Acne

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**

- Acne fulminans (acne com nódulos e placas de surgimento súbito, crostas hemorrágicas com ou sem febre e artralgias);
- Acne conglobata (acne nodular grave, com drenagem de secreção, trajetos fistulosos e cicatrizes);
- Acne moderada com prejuízo na qualidade de vida.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Descrição do quadro clínico com o tipo das lesões (comedões, pápulas, pústulas, nódulos, cistos), sua distribuição (localização), tempo de evolução, gravidade (leve, moderada ou grave) e presença ou não de sintomas sistêmicos como febre ou artralgia;
- Descrever tratamentos já realizados (medicações tópicas e sistêmicas com o tempo de tratamento).

3. **Prioridade para o agendamento:**

- Pacientes com acne grau IV e V; e rosácea.

Alopecia

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**

- Alopecias cicatriciais;
- Alopecia areata com mais de 30% da área do couro cabeludo acometida;
- Alopecia areata ofiásica (alopecia em faixa nas regiões laterais e occipital do couro cabeludo);
- Alopecia areata;
- Alopecia androgenética;
- Queda de cabelo há pelo menos 6 meses, na ausência de fatores desencadeantes.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;

- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).
- Utilização de outros medicamentos continuamente.
- Resultado de exames laboratoriais, com data: hemograma,testes rápidos para rastreio de IST e TSH.

Dermatite Atópica

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

- Eczema herpeticum grave sobreposto às lesões de dermatite atópica;
- Infecção bacteriana secundária (impetiginização) grave e extensa, sem resposta à antibioticoterapia sistêmica oral.

2. **Encaminhar ao Dermatologista:**

- Dermatite atópica grave e extensa;
- Dermatite atópica que ocasione prejuízo funcional grave;
- Dermatite atópica refratária ao tratamento clínico otimizado contínuo por um período de 1 mês;
- Dermatite atópica recidivante (3 ou mais recidivas em um período de 6 meses) apesar do tratamento clínico otimizado.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado para dermatite atópica (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).

Melasma

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**

- Paciente com melasma e importante prejuízo psicológico ou funcional, com boa adesão a medidas de fotoproteção.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;

- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).

Micoses

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**

- Suspeita clínica ou diagnóstico confirmado de micose subcutânea;
- Candidíase mucocutânea, dermatofitoses (tineas) ou pitiríase versicolor, se quadro extenso em pacientes imunocomprometidos (por medicamentos, HIV, imunodeficiências primárias); ou refratária ao tratamento clínico otimizado;
- Onicomicose refratária ao tratamento clínico e com pelo menos 1 dos critérios: Erisipela ou celulite no membro ipsilateral;
- ou Presença de dor ou desconforto;
- ou Suspeita de alteração ungueal não associada à infecção fúngica.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).
- Presença de imunossupressão;
- Episódios prévios de erisipela ou celulite.

Outros Eczemas ou Dermatites (Dermatite Seborreica, Dermatite de Contato, Eczema Disidrótico e Eczema de Estase)

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**

- Eczemas graves e extensos ou que ocasione prejuízo funcional grave;
- Eczemas refratários ao tratamento clínico otimizado, conforme o tipo de eczema.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;

Presença de prejuízo funcional;
Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo

de uso).

3. **Prioridade para o agendamento:**
- Pacientes com quadros extensos e/ou graves

Prurido

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**
- Paciente com prurido, sem lesões cutâneas, refratárias ao tratamento clínico otimizado e sem causa identificada após investigação inicial na APS.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).
- Utilização de outros medicamentos continuamente.
- Resultado de exames laboratoriais, com data: hemograma, TGO, TGP, fosfatase alcalina, bilirrubinas, GGT, TSH, creatinina e testes rápidos para rastreio de IST.

3. **Prioridade para o agendamento:**
- Pacientes com quadros extensos e/ou graves.

Psoríase

1. **Encaminhar ao PAM:**
- Suspeita ou diagnóstico de psoríase pustulosa generalizada;
- Suspeita ou diagnóstico de psoríase eritrodérmica com instabilidade hemodinâmica ou sinais de infecção sistêmica.

2. **Encaminhar ao Dermatologista:**
- Suspeita ou diagnóstico de psoríase pustulosa generalizada, após avaliação em serviço de urgência/emergência;
- Suspeita ou diagnóstico de psoríase eritrodérmica;
- Psoríase extensa;
- Psoríase que ocasione prejuízo funcional grave;
- Psoríase refratária ou sem resposta satisfatória ao tratamento tópico otimizado por 3

meses.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).

4. **Prioridade para o agendamento:**
- Pacientes com quadros extensos e/ou graves.

Rosácea

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**
- Rosácea fimatosa (aumento de volume do tecido afetado na região do nariz, mento, glabela ou região malar);
- Rosácea granulomatosa/pioderma facial (pápulas eritematosas, pústulas, cistos e trajetos fibrosos na região malar, periorbital e perioral, de surgimento súbito e na ausência de comedões).

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).

Urticária e Angioedema

1. **Encaminhar ao PAM:**
- Episódio de angioedema e/ou urticária associados a sinais de gravidade (obstrução de via aérea, broncoespasmo e hipotensão).

2. **Encaminhar ao Dermatologista:**
- Urticária crônica (lesões recorrentes, no mínimo 2 vezes na semana, por pelo menos 6 semanas) refratária ao tratamento clínico otimizado por 4 semanas ou mais.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso).
- Utilização de outros medicamentos continuamente.
- Resultado de exames laboratoriais (hemograma com plaquetas, VHS e PCR), com data.

Vitiligo

1. **Encaminhar ao Dermatologista:**
- Vitiligo extenso;
- Vitiligo rapidamente progressivo.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Descrição do quadro clínico com as lesões e sua localização, tempo de evolução, outros sinais e sintomas associados;
- Presença de prejuízo funcional;
- Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso);

PROTOCOLO MUNICIPAL ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Bócio Multinodular

1. **Encaminhar ao Endocrinologista:**

- TSH diminuído (suspeita de nódulo quente);
- Nódulo com indicação de PAAF (quando ainda não foi realizada); ou
- Sintomas compressivos atribuíveis ao bócio ou suspeita de malignidade; ou
- Indicação de tratamento cirúrgico ou iodo radioativo (bócio grande, bócio que está crescendo).

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Sinais e sintomas;
- Resultado de exame TSH t4, cálcio, com data;
- Resultado de ultrassonografia de tireoide, com descrição do tamanho, característica dos nódulos e volume do bócio, com data;
- História familiar de câncer de tireoide com indicação do parentesco.

Diabetes Mellitus

1. **Encaminhar ao Endocrinologista:**

- Paciente em uso de insulina em dose otimizada (mais de uma unidade por quilograma de peso); ou
- Insuficiência renal crônica (creatinina > 1,5 mg/dl); ou
- Paciente com DM tipo 1 (uso de insulina como medicação principal antes dos 40 anos), tendo este preferência no encaminhamento.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Resultado de exame de hemoglobina glicada, com data;
- Medida da circunferência abdominal;
- Descrição do uso de insulina, com dose e posologia;
- Outras medicações em uso, com dose e posologia;
- Peso do paciente em quilogramas (kg) e IMC;
- Tabela de glicêmico dos últimos 30 dias.

Hipertireoidismo

1. **Encaminhar ao Endocrinologista:**
- Todos os pacientes, tendo eles preferência no encaminhamento.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Sinais e sintomas;
- Resultado de exame TSH atualizado;
- Resultado de exame T4 livre ou T4 total, glicemia jejum, atualizado;
- Descrição do uso de metimazol ou propiltiouracil com dose e posologia se em uso;
- Outras medicações em uso, com posologia e dose;
- Anexar resultado dos exames.

Hipotireoidismo

1. **Encaminhar ao Endocrinologista:**
- Suspeita de hipotireoidismo central (TSH normal ou baixo, e T4 livre ou total baixo); ou
- Paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,5 mcg/kg de levotiroxina, quando já avaliada adesão e uso de medicações ou condições que cursam com alteração de metabolismo/absorção de T4.

2. **Dados que devem conter no encaminhamento:**
- Sinais e sintomas;
- Resultado de exame TSH, atualizado;
- Resultado de exame T4 livre ou T4 total, atualizado;
- Uso de levotiroxina com dose;
- Outras medicações em uso, com posologia e dose;
- Peso do paciente em quilogramas (kg);
- Anexar resultado dos exames.

3. **Prioridade para o agendamento:**
- Patologias associadas principalmente cardiopatias, suspeita de tumor e gestante.

Nódulo de Tireoide

1. **Encaminhar ao Endocrinologista:**
- TSH diminuído (suspeita de nódulo quente); ou

- Nódulos sólidos com mais de 1 cm (para PAAF, quando ainda não foi realizada); ou
- História clínica, exame físico ou características do nódulo suspeito para malignidade (para PAAF, quando ainda não foi realizada); ou Sinais e sintomas compressivos ou com suspeita para malignidade (dispneia, rouquidão, tosse, disfagia, adenomegalias patológicas).

2. Dados que devem conter no encaminhamento:
- Sinais e sintomas;
- Resultado de exame TSH e T4 livre, atualizado;
- Resultado de ultrassonografia de tireoide, com descrição do tamanho e característica do(s) nódulo(s), com data;
- História familiar de câncer de tireoide (sim ou não), com indicação do parentesco.
- Anexar resultado dos exames.

3. Prioridade para o agendamento:
- Nódulos únicos, sexo masculino, história prévia de radioterapia cervical, aumento ganglionar com sinais de malignidade.

Obesidade

O diagnóstico de sobrepeso ou obesidade é clínico, com base na estimativa do IMC, que é dado pela relação entre o peso e a altura do indivíduo, segundo a fórmula.

$$IMC = \frac{Peso}{altura^2} \quad (kg/m^2)$$

Classificação do estado nutricional de adultos e risco de comorbidades, segundo IMC.

Classificação	imc	Risco de comorbidades
Abaixo do peso	<18,50	Baixo
Sobrepeso Pouco	25,00 – 29,99	Elevado
Obesidade grau I	30,00 – 34,99	Elevado
Obesidade grau II	35,00 – 39,99	Muito elevado
Obesidade grau III ≥	40,00	Muitíssimo elevado

1. Encaminhar ao Endocrinologista:
- Pacientes com suspeita de obesidade secundária (provocada por problema

endocrinológico).

- Pacientes com indicação clínica (acima de 40 IMC sem presença de comorbidades)

2. Dados que devem conter no encaminhamento:

- Sinais e sintomas;
- Peso do paciente em quilogramas (kg), estatura em metros e IMC;
- Breve descrição do tratamento clínico longitudinal (realizado por, no mínimo, um ano para paciente sem comorbidades);
- Risco cardiovascular (em %), ou doença cardiovascular;
- Diabetes mellitus de difícil controle (sim/não).
- Hipertensão arterial de difícil controle (sim/não).
- Apneia do sono (sim/não);
- Doenças articulares degenerativas.

OBS: em caso de indicação para cirurgia bariátrica, o endócrino deverá referenciar o paciente para dar início ao processo cirúrgico na Unidade Básica de Saúde, conforme protocolo de cirurgia bariátrica (para preenchimento dos formulários).

PROTOCOLO MUNICIPAL FISIOTERAPIA DOMICILIAR

Fluxo de atendimento

1. **Verificar *link* a seguir: ANEXOS PROTOCOLO REGULAÇÃO**
2. **Condições sensíveis à Fisioterapia domiciliar e profissionais habilitados a solicitar o serviço:**

- Médicos da SMS e fisioterapeuta:
- Doenças infecciosas como hanseníase, pneumonia, COVID-19, bronquiolite, entre outras;
- Doenças Pulmonares / Respiratórias como DPOC, asma, entre outras;
- Sequelas de AVC;
- Paralisia facial;
- Fisioterapia pélvica;
- Hidroterapia;
- Doenças osteomusculares caracterizadas por lesões nos músculos, tendões, articulações, ligamentos, ossos, nervos, entre outros.
- Médico Ortopedista e Neurocirurgião:
- Doenças traumato-ortopédicas.

3. **Dados que devem conter no encaminhamento:**

- Relato da história clínica completa que justifique a reabilitação, inclusive resultado de exames complementares, possibilitando assim o contrarreferenciamento, caso o paciente não evolua da maneira esperada e precise de nova avaliação médica.

4. **Demais orientações:**

- O número de sessões de fisioterapia será determinado pelo profissional fisioterapeuta, bem como a frequência das mesmas.
- O tratamento fisioterapêutico contemplará apenas residentes da cidade de Nova Mutum - MT;
- Para o agendamento, o agendador seguirá a fila de espera.
- A Fisioterapia Municipal não oferece o serviço de transporte.

PROTOCOLO MUNICIPAL GASTROENTEROLOGIA

Alteração de Hábito Intestinal

1- Encaminhar ao Gastroenterologista:

Suspeita ou diagnóstico de doença inflamatória intestinal;

Constipação sem melhora após 12 semanas de tratamento na APS.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Tratamentos prévios e atuais para os sintomas;

Em caso de diarreia: resultado de exame parasitológico de fezes, coprocultura, sangue oculto nas fezes, hemograma e testes rápidos para rastreio de IST, com data;

Em caso de constipação: resultado da pesquisa de sangue oculto nas fezes, hemograma, glicemia ,com data;

Resultado de exame de imagem, quando realizado, com data;

História familiar de câncer colorretal (sim ou não). Se sim, indicar o grau de parentesco e a idade que este apresentou o câncer colorretal;

Resultado de endoscopia digestiva alta ou colonoscopia, se realizado, com data.

Dispepsia

1- Encaminhar ao Gastroenterologista:

Impossibilidade de realizar endoscopia digestiva alta na APS;

Úlcera péptica que persiste após controle endoscópico (realizado de 8 a 12 semanas do início do tratamento).

2-Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para EDA:

Dispepsia e sinais de alarme; ou

Pessoa com idade maior ou igual a 50 anos com dispepsia recente sem melhoras ao tratamento medicamentoso e conservador; ou

Dispepsia não controlada com tratamento clínico otimizado (inibidor de bomba de prótons por mínimo 8 semanas) e erradicação H. pylori;

Confirmação de erradicação de H. pylori em paciente com úlcera péptica.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução, fatores associados à piora ou melhora, perda involuntária de peso e em quanto tempo, outros sinais de alarme presentes);
Resultado de hemograma, com data (se anemia, descreva hemoglobina, VCM, ferro e ferritina);

Resultado de endoscopia digestiva alta, testagem H. pylori e biópsia, com data;
História familiar de câncer de estômago ou esôfago (sim ou não). Se sim, indicar grau de parentesco;
Tratamento em uso ou já realizado para dispepsia (medicamentos utilizados com dose e posologia).
Outros medicamentos em uso.

Doença do Refluxo Gastroesofágico

1- Encaminhar ao Gastroenterologista:

Esofagite graus C e D de Los Angeles; ou
Estenose péptica; ou
Hérnia hiatal e doença do refluxo gastroesofágico refratário ao tratamento otimizado por 2 meses (medidas comportamentais, inibidor da bomba de prótons em dose plena).

2-Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para EDA:

Sintomas típicos mais de uma vez por semana, associado a sinais de alarme; ou
Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) não controlado com tratamento otimizado (medidas comportamentais, inibidor da bomba de prótons em dose plena) por 2 meses.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever tempo de evolução, frequência dos sintomas, fatores associados à piora ou melhora, perda involuntária de peso e em quanto tempo, outros sinais de alarme presentes);
Descrever resultado da EDA;

Tratamento em uso ou já realizado para a DRGE (não farmacológico e medicamento utilizado com dose e posologia);
Outros medicamentos em uso (com dose e posologia).

Dor Abdominal

1- Encaminhar ao Gastroenterologista:

Dor abdominal crônica sem diagnóstico após avaliação inconclusiva na APS.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever sintomas constitucionais, exame abdominal);

Resultado de hemograma, com data;

Resultado de exame parasitológico de fezes, com data;

Resultado de exame de imagem abdominal, com data;
História familiar de câncer colorretal (sim ou não). Se sim, indicar o grau de parentesco e a idade que este apresentou o câncer colorretal.

Esteatose Hepática

1- Encaminhar ao Gastroenterologista:

Esteatose hepática e suspeita de cirrose; ou

Esteatose hepática e elevação persistente de aminotransferases (≥ 2 vezes o limite superior de normalidade) após tratamento conservador por 6 meses na APS;

Esteatose hepática persistente após tratamento conservador por 6 meses em pessoa com risco elevado para fibrose (paciente com idade > 45 anos com obesidade e/ou diabetes; ferritina com valor ≥ 1,5 vezes o limite superior de normalidade).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Índice de massa corporal;

Paciente é diabético? (sim ou não);

Paciente faz uso crônico ou abusivo de álcool (sim ou não);

Resultado dos exames laboratoriais, com data: aminotransferases (em paciente sem

suspeita de cirrose, descreva 2 resultados de TGO, TGP com intervalo de 6 meses), hemograma, plaquetas, bilirrubinas, testes rápidos para rastreio de IST;

Resultado do exame ultrassonografia de abdomen total e/ou abdomen superior com data.

Hepatite B

1-Encaminhar ao Gastroenterologista:

Hepatite viral crônica por vírus B.

2-Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para infectologia (SAE):

Paciente com coinfecção HBV e HIV.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Resultado de exames de TGO e TGP, bilirrubinas, hemograma com data;

Resultado de HBsAg e anti-HBc (IgM e IgG), com data;

Resultado de testes rápidos para rastreio de outras IST, com data.

Hepatite C

1- Encaminhar ao Gastroenterologista:

Hepatite viral aguda por vírus C; ou

Hepatite viral crônica por vírus C.

2-Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Serviço de Atendimento Especializado em HIV/Aids (SAE):

Pacientes com coinfecção HCV e HIV.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Resultado do exame anti-HCV, com data;

Se suspeitar de infecção aguda, descrever data e forma de contágio, e como foi feita a suspeita diagnóstica;

Resultado de testes rápidos para rastreio de outras IST, com data.

Suspeita de cirrose ou alterações laboratoriais hepáticas

1- Encaminhar ao Hospital Hilda Strenger: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG)

Suspeita ou diagnóstico de cirrose hepática com sinais de descompensação - ascite com início ou piora recente, encefalopatia hepática de início ou piora recente, sangramento digestivo (hematêmese, melena, hematoquezia), icterícia.

2-Encaminhar ao Gastroenterologista:

Suspeita ou diagnóstico de cirrose hepática; ou elevação persistente, sem etiologia definida após investigação inicial na APS de:

TGO e TGP (≥ 2 vezes o limite superior da normalidade);

Fosfatase alcalina (≥ 1,5 vezes o limite superior da normalidade) por provável etiologia hepática;

TGO e TGP (< 2 vezes o limite superior de normalidade) e/ou fosfatase alcalina (<1,5 vezes o limite superior de normalidade) que persistem elevadas por 6 meses.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Avaliação laboratorial realizada, com data: TGO e TGP, fosfatase alcalina, bilirrubinas, hemograma com plaquetas, testes rápidos para rastreio de IST;

Resultado de exame de ultrassonografia abdominal total, ou abdomen superior, com data

Comorbidades (como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, doenças autoimunes);

Medicamentos em uso (com dose e posologia).

PROTOCOLO MUNICIPAL GINECOLOGIA

Amenorreia

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Amenorreia primária: maiores de 14 anos sem caracteres sexuais secundários; ou maiores de 16 anos com caracteres sexuais secundários;

Amenorreia secundária: resposta negativa ao teste do progestogênio; ou falência ovariana precoce; ou história de exposição à rádio e/ou quimioterapia no passado;

Sempre descartar gravidez na investigação inicial de amenorreia.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Tempo de início da amenorreia, com data da última menstruação;

Descrever uso prévio de métodos contraceptivos;

Resultado dos exames de hemograma, EAS, preventivo com data;

Resultado de ultrassonografia pélvica ou transvaginal, com data;

Medicamentos em uso.

Climatério

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Menopausa precoce (antes dos 40 anos); ou

Persistência de sintomas associados ao climatério após tratamento clínico otimizado por 6 meses.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Idade da paciente quando iniciou a menopausa;

Tratamentos em uso ou já realizados para os sintomas do climatério (medicamentos utilizados com dose e posologia);

História prévia de neoplasia maligna ginecológica ou ooforectomia.

Condiloma Acuminado / Verrugas Virais

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Mulheres com condiloma acuminado (verruga viral genital e perianal) com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas ou numerosas).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição da lesão (incluir localização, extensão, evolução, toque retal quando condiloma anorretal);

Descrever uso prévio de métodos contraceptivos;

Descrever data da última menstruação;

Resultado de testes rápidos para rastreio de IST, eas e preventivo, com data;

Tratamento prévio realizado (descrever medicamentos, duração).

Dor Pélvica Crônica / Endometriose

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Dor pélvica por mais de 6 meses de origem ginecológica, refratária ao tratamento clínico otimizado, não associada a gestação; ou

Alteração em exame de imagem ou exame físico sugestivo de endometriose.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (caracterização do quadro, descrição do hábito intestinal e urinário, exame físico e ginecológico completo);

Descrever uso prévio de métodos contraceptivos;

Descrever data da última menstruação;

Tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose e posologia);

História de cirurgias abdominais ou ginecológicas prévias;

Resultado de ultrassonografia pélvica ou transvaginal, atualizado;

Resultado de testes rápidos para rastreio de IST, EAS e preventivo, atualizada.

Incontinência Urinária

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Incontinência urinária sem resposta ao tratamento clínico otimizado (exercícios para músculos do assoalho pélvico, treinamento vesical e intervenções no estilo de vida (perda de peso quando necessário, diminuição ingesta de cafeína/álcool).

Paciente com prolapso genital e incontinência urinária associada, sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3 meses.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Descrição do exame pélvico (presença e grau de prolapso);

Tratamento em uso ou já realizado para incontinência urinária (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Descrição de outros medicamentos em uso que afetam a continência urinária.

Massa Anexial

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Em qualquer faixa etária:

Tumores em mulheres com sintomas (distensão ou dor abdominal, saciedade precoce ou perda de apetite, perda de peso involuntária, mudança hábito intestinal, etc.); ou

Tumores sólidos independente do tamanho; ou

Tumores císticos com aspecto complexo (multisseptado, conteúdo misto, projeções sólidas); ou

Tumores com ascite.

Cistos simples em mulheres na menopausa.

Cistos simples em mulheres na menacme:

Menor que 8,0 cm que não tenham regredido em duas ecografias pélvicas transvaginais com intervalo de 3 meses entre elas; ou

Maior ou igual a 8,0 cm.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever exame físico abdominal e toque vaginal);

Descrever se a paciente está na menopausa e o tempo da mesma, se possível colocar a data da última menstruação;

Descrever uso de métodos contraceptivos;

Descrição do exame de imagem (USG TV e/ou USG de abdomen total, Rm ou tomografia abdominal, atualizado;
História familiar de câncer de mama ou ovário, devendo descrever parentesco dos familiares, sexo e idade de diagnóstico do câncer.

Resultado de testes rápidos para rastreio de IST, EAS e preventivo, com data.

Miomatose Uterina

***1*-Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**
Mulher com sangramento uterino anormal (com ou sem mioma) que apresenta instabilidade hemodinâmica ou anemia com sintomas graves.

2-Encaminhar ao Ginecologista:

Sintomas (sangramento, distensão abdominal/pélvica, dispareunia) que persistem após tratamento clínico otimizado por três meses.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever exame físico abdominal e toque vaginal);

Resultado de hemograma, teste rápido para ISTs, EAS, preventivo atualizado;

Descrever uso prévio de métodos contraceptivos;

Descrever data da última menstruação;

Descrição do exame de imagem (USG TV e/ ou de abdomen total,e/ou Rm, tomografia abdominal), atualizado;
Tratamento em uso ou já realizado para miomatose (medicamentos utilizados com dose e posologia).

Neoplasia do Colo do Útero

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Preventivo com:

Células escamosas atípicas de significado indeterminado quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H); ou

Células glandulares atípicas de significado indeterminado (possivelmente não neoplásico ou quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau) (AGC); ou

Células atípicas de origem indefinida (possivelmente não neoplásica ou quando não se pode excluir lesão de alto grau); ou

Lesão intraepitelial de alto grau (HSIL); ou

Lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide invasor; ou

Mulheres imunossuprimidas (HIV e transplantadas), com doenças autoimunes ou em uso de drogas imunossupressoras com lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL).

Resultado de dois Preventivos consecutivos com intervalo de 6 meses:

Células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASC-US); ou

Lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Descrever uso prévio de métodos contraceptivos;

Descrever data da última menstruação;

Exame físico ginecológico (especular e toque vaginal);

Descrição do último preventivo, atualizado;

Resultado de testes rápidos para rastreio de IST, EAS atualizados;

Anexar exames

Neoplasia do Endométrio

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Mulheres na menopausa: - com sangramento uterino anormal (sem terapia hormonal) com espessura endometrial maior que 5 mm ou descrição de endométrio heterogêneo e irregular na ecografia.

Não está indicado solicitar ecografia transvaginal como exame de rotina ou para rastreamento de câncer de endométrio.

2-Solicitar ultrassonografia transvaginal:

Mulheres na menopausa com sangramento uterino anormal.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Descrição do exame especular;

Descrever uso prévio de métodos contraceptivos;

Descrever data da última menstruação;

Descrever se a paciente está na menopausa (tempo desta) ou não e quanto tempo;

Descrição do exame de imagem,atualizado;

Resultado de biópsia de endométrio com data, quando realizado.

Descrição do exame de preventivo, com data.

Prolapso Genital

1- Encaminhar ao Ginecologista:

Paciente com prolapso genital sintomática, independente do grau, que deseja tratamento cirúrgico; ou

Paciente com prolapso genital e incontinência urinária associada, sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3 meses (exercícios para músculos do assoalho pélvico, treinamento vesical e intervenções no estilo de vida (perda de peso quando necessário, diminuição da ingesta de cafeína/álcool).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever exame especular e toque vaginal);

Tratamentos em uso ou já realizados.

Sangramento Uterino Anormal

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Mulher com sangramento uterino anormal (com ou sem mioma) que apresenta instabilidade hemodinâmica ou anemia com sintomas graves.

2-Encaminhar ao Ginecologista:

Mulher na menacme com:

Sangramento disfuncional sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3 meses (excluídas causas secundárias como alteração tireoidiana, hiperprolactinemia, escape por anticoncepcional hormonal de baixa dosagem); ou

Sangramento uterino anormal associado a mioma, refratário ao tratamento clínico otimizado por 3 meses; ou

Sangramento uterino anormal associado a pólipo ou hiperplasia de endométrio (espessura endometrial maior ou igual a 12 mm por ecografia pélvica transvaginal realizada na primeira fase do ciclo menstrual); ou

Sangramento uterino aumentado persistente em mulheres com fator de risco para câncer de endométrio (idade superior a 45 anos e pelo menos mais um fator de risco, como: obesidade, nuliparidade, diabete, anovulação crônica, uso de tamoxifeno).

Mulher na menopausa com:

Espessura endometrial maior ou igual a 5,0 mm evidenciada na ecografia pélvica transvaginal;

Sangramento uterino anormal e impossibilidade de solicitar ecografia pélvica transvaginal.

Sempre descartar gravidez (em mulher na menacme) e sangramento por patologias cervicais na investigação inicial de sangramento uterino anormal.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (características do sangramento, tempo de evolução, outras informações relevantes);
Exame físico ginecológico (especular e toque vaginal);

Descrever se a paciente está na menopausa e o tempo da mesma ou ainda a data da última menstruação;

Descrever uso de métodos contraceptivos;

Resultado de hemograma, eas teste rápido para ISTS com data;

Descrição da ultrassonografia pélvica transvaginal, com data;

Tratamento em uso ou já realizado para o sangramento uterino (medicamentos utilizados com dose e posologia).

PROTOCOLO MUNICIPAL HEMATOLOGIA

Anemia

1- Encaminhar ao Hospital Hilda Strenger: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG)

Anemia sintomática (dispneia, taquicardia, hipotensão) e/ou instabilidade hemodinâmica; ou

Doença falciforme com crise álgica ou outros sinais de gravidade; ou

Presença de citopenias concomitantes com critérios de gravidade.

2-Encaminhar ao Hematologista:

Suspeita ou diagnóstico de doença falciforme; ou

Suspeita ou diagnóstico de talassemia; ou

Suspeita ou diagnóstico de outras anemias hemolíticas; ou

Anemia por causa desconhecida após investigação inconclusiva na APS.

Não há indicação de referência ao serviço especializado pessoas exclusivamente com traço falciforme ou com traço talassêmico alfa ou com talassemia beta menor (traço talassêmico beta). Essas pessoas podem seguir acompanhamento na APS com orientações sobre a condição genética.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia se presente) e número de plaquetas, atualizado;

Resultado de exames complementares se realizados na investigação de anemia conforme VCM;

Tratamento prévio e atual para anemia (medicamento com dose e posologia);

Presença de comorbidades (como doença renal crônica, hepatopatias, HIV, hepatite C) que cursem com citopenias (sim ou não). Se sim, quais?

OBS.: ao encaminhar para hemocentro Mato Grosso, estará sujeito a Regulação do hemocentro, podendo assim o próprio hematologista devolver, sugerindo seguimento via PSF.

Citopenias (bicitopenia/pancitopenia)

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Citopenias e manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda (como fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções recorrentes); ou

Citopenias em pessoas com linfonodomegalia e esplenomegalia não explicada por quadro infeccioso agudo; ou

Presença de blastos e promielócitos no sangue periférico; ou

Paciente com febre e neutropenia (< 1500 neutrófilos/µL); ou

Bicitopenia/pancitopenia com alterações hematológicas graves, como: hemoglobina < 7 g/dL; e/ou neutrófilos < 500 céls/µL; e/ou plaquetas < 50 mil céls/mm3.

2-Encaminhar ao Hematologista:

Citopenias, sem critérios de gravidade, após exclusão de causas secundárias comuns na APS.

3-Dados que deve conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever sintomas constitucionais, exame físico abdominal, presença de linfonodomegalias e outras alterações relevantes no exame físico);

Resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia se presente) e número de plaquetas, com data;

Resultado de exames, com data, realizados para excluir causas secundárias em pessoas sem critérios de gravidade. Na ausência de suspeita clínica para direcionar investigação descrever: teste rápido para rastreio de IST, TGO/ TGP;

Resultado de ecografia abdominal, com data;

Medicamentos em uso.

Distúrbios Hemorrágico

1- Encaminhar ao Hematologista:

História de sangramentos de repetição na suspeita de doença hematológica e com uma ou mais características de maior gravidade:

Necessidade de transfusão de hemocomponentes; ou sangramento excessivo após pequenos cortes ou procedimentos; ou hemartrose; ou história familiar de distúrbio hemorrágico em parente de primeiro grau; ou

acima dos valores de normalidade após exclusão de causas secundárias na APS.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever histórico de manifestações hemorrágicas - presença de menorragia, melena / hematêmese, equimose, petéquias), com frequência e situações desencadeantes. Incluir alterações relevantes no exame físico;

Resultados de dois exames de TP e TTPA (repetir o exame alterado), com data;

Resultados de exames laboratoriais para investigação de causa secundária (hemograma, plaquetas, TGO, TGP, GGT, creatinina e EAS, com data);

Histórico familiar de distúrbios hemorrágicos (sim ou não). Se sim, indique qual o distúrbio e grau de parentesco;

Descreva medicamentos em uso.

Hiperferritinemia

1- Encaminhar ao Hematologista:

Hiperferritinemia e suspeita de cirrose.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Índice de massa corporal (IMC);

Resultado de ferritina sérica, com data.

Resultado de saturação da transferrina, com data;

Se saturação de transferrina inferior a 45%, descreva os seguintes exames, com data: hemograma e número de plaquetas (descrever hematoscopia se presente), transaminases

(TGO/TGP), fosfatase alcalina, Bilirrubinas total e fraçoes;

Resultado de ecografia abdominal total, com data;

Medicamentos em uso.

Leucócitos

1. **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Leucocitose e manifestações clínicas suspeitas de leucemia aguda (como fadiga generalizada, fraqueza, palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções recorrentes); ou

Presença de blastos e promielócitos no sangue periférico; ou Leucostase (presença de sintomas respiratórios, neurológicos, priapismo em pessoas com hiperleucocitose) ou leucócitos com valores superiores a 100 mil cels/mm3.

2-Encaminhar ao Hematologista:

Leucocitose maciça (acima de 50 mil/mm3), sem causa infecciosa aparente; ou

Leucocitose persistente após exclusão de causas secundárias (quadros infecciosos, medicamentos - lítio, carbamazepina, beta agonistas) na APS.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever sintomas constitucionais, eventos hemorrágicos e trombóticos, exame físico completo);

Resultado de dois hemogramas/ leucogramas, com diferença de 2 a 4 semanas (com exceção de leucocitose maciça ou outros sinais de gravidade);

Se eosinofilia isolada, foi realizado tratamento empírico para parasitose? (sim ou não);

Utiliza medicamento que causa leucocitose (lítio, carbamazepina, beta agonistas) (sim ou não).

Leucopenia

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Paciente com febre e neutropenia (< 1500 neutrófilos/µL); ou

Citopenias com critérios de gravidade.

2-Encaminhar ao Hematologista:

Leucopenia persistente após exclusão de causas secundárias na APS.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever exame físico abdominal, presença de linfonodomegalias, sintomas constitucionais ou outras alterações relevantes no exame físico);

Resultado de hemograma (descrever hematoscopia se presente) e número de plaquetas (se pessoa com leucopenia sem critérios de gravidade, descreva dois resultados de hemograma e plaquetas com intervalo mínimo de 1 mês entre os exames), com data;

Resultado de exames complementares na investigação de causas secundárias em pessoas sem critérios de gravidade: testes rápidos para rastreio de IST, FAN

Medicamentos em uso.

Policitemia

1- Encaminhar ao Hematologista:

Suspeita de policitemia vera (hemoglobina maior que 16,0g/dL em mulheres, e maior que 16,5g/dL em homens), em pessoas com sintomas sugestivos: prurido após o banho, eritromelalgia, gota, trombose venosa ou arterial prévia, sangramento, esplenomegalia;

Policitemia persistente (hemoglobina maior que 16,0g/dL em mulheres, e maior que 16,5g/dL em homens) após repetição do hemograma em 1 mês e exclusão de causas secundárias (DPOC, tabagismo, hepatocarcinoma, carcinoma renal) na APS.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia se presente) e número de plaquetas, com data (em pessoas sem sintomas sugestivos de policitemia vera, descrever 2 resultados com intervalo de 1 mês entre eles) tgo, tgp;

Exames complementares realizados para investigar causa secundária, com data (raio- X de tórax, ecografia abdominal) com data;

Paciente é tabagista? (sim ou não).

Trombocitopenia

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Pessoa com trombocitopenia (<20.000 plaquetas por mm3) e manifestação hemorrágica;

ou

Pessoa assintomática e valor de plaquetas inferior a 10 mil/mm3;

Citopenias com critérios de gravidade.

2-Encaminhar ao Hematologista:

Trombocitopenia com contagem plaquetária <50.000 células/mm3 em pacientes assintomáticos, sem necessidade de repetir hemograma; ou

Trombocitopenia persistente após exclusão de pseudoplaquetopenia e causas secundárias na APS.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever manifestações hemorrágicas atuais e prévias, exame físico abdominal, linfonodomegalia, sintomas constitucionais e outras alterações relevantes no exame físico);

Resultado de hemograma (descrever hematoscopia se presente) e número de plaquetas (se pessoa com trombocitopenia isolada persistente sem critérios de gravidade, descreva dois resultados de hemograma e plaquetas com intervalo mínimo de 1 mês entre os exames), com data;

Resultado de exames complementares na investigação de causas secundárias em pessoas sem critérios de gravidade: teste rápido para rastreio de ISTs, TGO/TGP, GGT, .

Apresenta comorbidades não hematológicas que podem cursar com trombocitopenia (sim ou não). Se sim, quais?;

Descreva todos os medicamentos em uso.

Trombocitose

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Paciente com trombocitose e sintomas vasomotores (cefaleia, sintomas visuais, dor precordial atípica), sangramento ou trombose; ou

Presença de blastos ou promielócitos no sangue periférico.

2-Encaminhar ao Hematologista: Trombocitose associada a sintomas vasomotores, sangramento ou trombose (após avaliação em serviço de emergência/urgência); ou

Trombocitose associada à leucocitose ou policitemia; ou

Trombocitose com plaquetas superiores a 1 milhão/mm3; ou

Trombocitose persistente após exclusão de causas secundárias (quadro infeccioso atual, anemia ferropriva, esplenectomia / asplenia, trauma / cirurgia recente) na APS.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (sintomas constitucionais, sangramento, sintomas vasomotores, trombose);

Apresenta história compatível com causa secundária (quadro infeccioso atual, história de trauma / cirurgia recente, esplenectomia prévia) (sim ou não)? Se sim, descreva;

Resultado de hemograma completo (descrever hematoscopia se presente) e número de plaquetas, com data (se trombocitose isolada em pessoa sem gravidade, descrever 2 resultados dos exames para confirmação da persistência);

Se anemia concomitante descreva resultado de ferritina, com data.

Trombofilias

1- Encaminhar ao Hematologista:

Episódio confirmado de tromboembolismo venoso (TEV) idiopático em pessoa que possua uma ou mais das seguintes características:

Episódio de TEV ocorreu antes dos 45 anos; ou

História de TEV antes dos 45 anos em familiar de primeiro grau (pais ou irmãos ou

filhos); ou

TEV em sítio incomum (veia mesentérica, portal, hepática ou cerebral); ou

TEV recorrente; ou

Pacientes com história de aborto recorrente (perda espontânea e consecutiva de três ou mais gestações antes da 20º semana gestacional) após exclusão de causa ginecológica.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrever histórico e exame realizado que comprovam tromboembolismo;

Apresenta condição clínica (cirurgia recente, imobilização, neoplasia) ou uso de medicamentos (como anticoncepcional) associados a tromboembolismo (sim ou não). Se sim, qual?

Histórico familiar de TEV (sim ou não). Se sim, indicar grau de parentesco e idade no acometimento;

Se aborto de repetição, descreva histórico dos abortos e avaliação com serviço de ginecologia;

Resultado do hemograma e plaquetas, com data.

PROTOCOLO MUNICIPAL INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) DE COBRE
Seguir Protocolo Municipal da Atenção Primária **Nota: ver anexo VII.**

PROTOCOLO MUNICIPAL MASTOLOGIA

Alterações Benignas da Mama

1- Encaminhar ao Mastologista:

Cisto simples recidivante; ou

Cisto simples sintomático (dor/desconforto); ou

Lesão benigna sintomática (dor/desconforto/assimetria mamária), como fibroadenoma ou lipoma, em que mesmo com confirmação benigna (por biópsia ou imagem) haja desejo de exérese cirúrgica; ou

Abscesso subareolar crônico recidivante; ou

Pacientes com mamas acessórias ou supranumerárias que desejem cirurgia;

Descarga papilar bilateral leitosa sem hiperprolactinemia, descartadas causas secundárias, se desejado tratamento pela paciente.

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Descrição de exame de imagem, (ultrassonografia de mama e/ou mamografia) com data.

Neoplasia da Mama e Lesões Suspeitas

1- Encaminhar ao Mastologista:

Nódulo palpável em mulheres com alto risco para câncer de mama;

Paciente assintomática com BI-RADS categoria 3 com indicação precisa de Terapia de Reposição Hormonal - provável indicação de citologia e/ou histologia.

Nódulo palpável ao exame físico, mesmo com exame de imagem sem lesão suspeita, nas seguintes condições:

Nódulo palpável persistente por mais de um ciclo menstrual em mulher com mais de 30 anos;

Nódulo palpável recente depois da menopausa;

Nódulo palpável persistente por mais de um ciclo menstrual em mulher com menos de 30 anos, com exame de imagem negativo (lesão não visualizada);

Nódulo palpável em mulher com menos de 30 anos, com ecografia mostrando lesão sólida ≥ 2 cm ou com alta suspeita clínica.

2-Encaminhar ao oncologista:

Achados no exame físico altamente sugestivos de neoplasia da mama; ou

Adenopatia axilar, mesmo com exame de imagem normal (na ausência de causa infecciosa ou inflamatória conhecida após investigação inicial na APS); ou

Achados em exame de imagem de BI-RADS categoria 4 ou 5; ou

Diagnóstico histopatológico ou citopatológico de neoplasia da mama.

3- Nódulos palpáveis com indicação de avaliação com exame de imagem:

Idade < 30 anos solicitar ecografia, se persistência por mais de 1 ciclo menstrual;

Idade ≥ 30 anos solicitar mamografia, se persistência por mais de 1 ciclo menstrual.

4-Dados que deve conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;
Descrever na íntegra, resultado de exames de imagem realizados, principalmente mamografia e/ou ecografia mamária, com data;
História pessoal de câncer de mama (sim ou não), ou de câncer em outros órgãos. Se sim, descreva a lateralidade (se câncer de mama), qual o órgão acometido, tratamentos realizados e o local de tratamento do câncer;
História familiar de neoplasia mamária ou de ovário (sim ou não). Se sim, grau de parentesco e idade no diagnóstico.

Ginecomastia

Ginecomastia é definida como a presença de tecido mamário palpável em homens, podendo ser unilateral ou bilateral. Costuma ser fisiológica em neonatos ou na fase puberal.

1 - Encaminhar a Cirurgia Plástica:

- Ginecomastia secundária (com causa identificada) que não regrediu espontaneamente em 12 meses, após manejo específico adequado, em paciente com 18 anos ou mais que deseja procedimento cirúrgico;

- Ginecomastia idiopática (causa não identificada e investigação normal), em paciente com 18 anos ou mais, que deseja procedimento cirúrgico;
- Ginecomastia puberal que não regrediu espontaneamente em 24 meses, após afastadas causas secundárias, em adolescente com desenvolvimento puberal completo (estágio Tanner 5).

Antes do encaminhamento deve ser concluída a investigação de doença mamária/nódulo mamário a esclarecer ou com necessidade de tratamento complementar.

O tabagismo aumenta consideravelmente os riscos de complicações pós-operatórias e pode comprometer os resultados da mamoplastia. Está indicada a cessação do tabagismo antes de um procedimento eletivo, com suporte e tratamento realizados preferencialmente na Atenção Primária à Saúde.

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

- Sinais e sintomas (descrever se achado unilateral ou bilateral, dor ou desconforto, evolução, palpação testicular) descrever/anexar investigação laboratorial já realizada, com resultados dos exames com data, presença de comorbidades que justifiquem a ginecomastia. **EXAMES:**
    - Estradiol, Testosterona, LH (hormônio luteinizante), TSH (hormônio tireoestimulante), Prolactina, B-hCG (gonadotropina coriônica humana) SHBG (globulina ligadora de hormônios sexuais) e DHEA-S (sulfato de prasterona), ultrassonografia de mamas.
- (cirrose, hipertireoidismo) (sim ou não), medicamentos em uso;
- Índice de massa corporal (IMC);
- Presença de comorbidades que justifiquem a ginecomastia (cirrose, hipertireoidismo);
- Descrever medicamentos em uso.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Endocrinologia:

- Adolescente com ginecomastia que não regrediu após 2 anos ou quando paciente completar 17 anos;
- Suspeita de anormalidade endocrinológica como hipogonadismo (atrofia testicular, diminuição de massa muscular, pelos faciais ou no corpo), hipertireoidismo, resistência androgênica, entre outras.

PROTOCOLO MUNICIPAL NEFROLOGIA

Cistos / Doença Policística Renal

1- Encaminhar ao Nefrologista:

Suspeita de doença policística renal.

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou outros achados relevantes);

Resultado de exame de imagem (ecografia rins e via urinária/abdomen total ou tomografia), com data. O exame deve descrever tamanho dos cistos, número e localização;

Resultado de exame de creatinina, com data (se suspeita de perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina com no mínimo seis meses de diferença entre eles);

Cor de pele (preta ou não), idade e sexo;

Resultado de EAS, com data (quando alterado, dois exames com oito semanas de diferença entre eles);

Presença de história familiar para doença policística renal (sim ou não), e parentesco com o paciente.

Diabetes Mellitus

1- Encaminhar ao Nefrologista:

Pacientes com taxa de filtração glomerular < 30 /min/1,73 m2 (estágio 4 e 5); ou

Proteinúria (microalbuminúria); ou

Perda rápida da função renal (> 5 /min/ 1,73 m2 em um período de seis meses, com uma TFG < 60 /min/1,73 m2, confirmado em dois exames); ou

Suspeita de nefropatia por outras causas.

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

Resultado de exame de creatinina, com data (se suspeita de perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina com no mínimo seis meses de diferença entre eles);

Cor de pele (preta ou não), idade e sexo;

Alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes.

Doença Renal Crônica

1- Encaminhar ao Nefrologista:

Taxa de filtração glomerular (TFG) < 30 /min/1,73m2 (estágio 4 e 5); ou

Proteinúria; ou

Hematúria persistente; ou

Alterações anatômicas que provoquem lesão ou perda de função renal; ou

Perda rápida da função renal (> 5 /min/1,73 m2 em seis meses, com uma TFG < 60 / min/1,73 m2, confirmado em dois exames); ou

Presença de cilindros com potencial patológico (céreos, largos, graxos, epiteliais, hemáticos ou leucocitários).

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

Resultado de exame de creatinina sérica, com data (se suspeita de perda rápida de função renal, colocar dois resultados da creatinina sérica com no mínimo seis meses de diferença entre eles);

Resultado de EAS quando alterado (dois exames, com oito semanas de diferença entre eles) e pesquisa de hemácias dismórficas, com data, quando realizado (para investigação de hematúria);

Resultado de ecografia de vias urinárias, com data;

Cor de pele (preta ou não), idade e sexo.

Hipertensão Arterial Sistêmica

1- Encaminhar ao Nefrologista:

Suspeita de hipertensão secundária; ou

2-Dados que deve conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Medicações em uso, com dose e posologia;

Duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes;

Alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes, com data;

Avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não).

PROTOCOLO MUNICIPAL NEUROCIRURGIA

Acidente Vascular Cerebral

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de acidente vascular cerebral (AVC) ou acidente isquêmico transitório (AIT) agudo.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

AVC isquêmico ou AIT em paciente com estenose de carótida, ipsilateral à lesão cerebral, maior ou igual a 70%, que não foi submetido a procedimento cirúrgico emergencial no momento do diagnóstico; ou

Estenose de carótida assintomática maior que 70%, com indicação de intervenção após avaliação de riscos e benefícios pela neurologia.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade de início da cefaleia, tempo de evolução, características da dor, frequência das crises, mudança no padrão, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas associados);

Comorbidades (infecção pelo HIV, neoplasia, trauma craniano recente);

Tratamentos em uso ou já realizados para cefaleia (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Resultado do exame de imagem (TC ou RMN de crânio), com data.

Cefaleia

1- ***Encaminhar ao Hospital Hilda Strenger: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG)***

Pacientes com cefaleia e presença de sinais de alerta.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

Paciente com cefaleia e exame de imagem (RADIOGRAFIA , RNM ou TC de crânio)

com alteração sugestiva de potencial indicação cirúrgica.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade de início da cefaleia, tempo de evolução, características da dor, frequência das crises, mudança no padrão, exame físico

neurológico, outros sinais e sintomas associados);
Comorbidades (infecção pelo HIV, neoplasia, trauma craniano recente);

Tratamentos em uso ou já realizados para cefaleia (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Resultado do exame de imagem (RADIOGRAFIA,TC ou RNM de crânio), com data.

Dor Cervical

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de síndrome de compressão medular; ou

Exame de imagem com evidência de compressão medular e/ou mielopatia; ou

Suspeita de infecção (especialmente em pessoas imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas); ou

Suspeita de fratura vertebral, luxação ou lesão medular associada a traumatismo recente; ou

Diagnóstico de neoplasia acometendo a coluna vertebral.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

Diagnóstico de estenose de canal cervical ou mielopatia que não operado em caráter emergencial; ou

Pacientes com cervicalgia e diagnóstico definido de artrite reumatoide; ou

Dor cervical e sintomas de radiculopatia (dor irradiada para os braços, fraqueza, parestesia), sem resposta após 6 semanas de tratamento clínico otimizado ; ou

Dor cervical com sinais de alerta, sem indicação de avaliação emergencial; ou

Dor cervical crônica inespecífica sem melhora após tratamento clínico otimizado por 6 meses ;

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas como - características da dor, presença de sintomas de radiculopatia cervical, tempo de início e duração dos sintomas, fatores desencadeantes e de alívio,

Presença de alterações em exame físico neurológico (sim ou não). Se sim, descreva;

Outros sinais e sintomas relevantes (sistêmicos);
Tratamento em uso ou já realizado para dor cervical (não farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta à medicação);
Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou Rm, tomografia), com data.;

Presença de imunossupressão ou artrite reumatoide (sim ou não). Se sim, qual?

Se suspeita de neoplasia, descreva o motivo;

Osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como foi feito o diagnóstico;
Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva a atividade.

Dor Lombar

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de compressão de cone medular ou síndrome da cauda equina;

Perda de força progressiva medida de maneira objetiva; ou

Diagnóstico de neoplasia acometendo a coluna vertebral; ou

Suspeita de infecção (especialmente em pessoas imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas); ou

Suspeita de fratura ou luxação associada a traumatismo recente.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

Síndrome radicular sem melhora clínica após 6 semanas de tratamento clínico otimizado;

Diagnóstico de estenose de canal lombar ou espondilolistese e sintomas compatíveis com síndrome radicular e/ou claudicação neurogênica;

Suspeita clínica de claudicação neurogênica.

Lombalgia de característica mecânica e diagnóstico de espondilolistese ístmica (qualquer grau) ou espondilolistese degenerativa ≥ grau 2;

Dor lombar crônica inespecífica sem melhora após tratamento clínico otimizado para dor crônica por 6 meses ;

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas, com descrição das características da dor, presença ou não de ciatalgia ou claudicação neurogênica, tempo de início e duração dos sintomas, fatores desencadeantes e de alívio;

Presença de alterações em exame físico neurológico (sim ou não). Se sim, descreva;
Outros sinais e sintomas relevantes (sintomas constitucionais);

Tratamento em uso ou já realizado para dor lombar (não farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta à medicação);

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou Rm, tomografia), com data.;

Presença de imunossupressão (sim ou não). Se sim, qual?

Se suspeita de neoplasia, descreva o motivo;

Osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como foi feito o diagnóstico;
Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva a atividade.

Hidrocefalia

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Paciente com história ou exame de imagem com hidrocefalia e:

Sinais/sintomas de hipertensão intracraniana e/ou obstrução e mau funcionamento da derivação ventricular; ou

Presença de fístula liquórica com exteriorização de líquor pela pele, nariz ou ouvido; ou

Suspeita de infecção do sistema nervoso central.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

Paciente com alteração em exame de imagem sugestiva de hidrocefalia; ou

Paciente com derivação ventricular – derivação ventrículo-peritoneal (DVP), ventrículo-atrial ou outras.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever presença de sintomas neurológicos focais, exame físico neurológico, outros achados relevantes);

Paciente apresenta DVP ou outro tipo de derivação ou tratamento (sim ou não). Se sim,

quando foi realizado;

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou Rm, tomografia), com data.

Malformações Vasculares Cerebrais

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de aneurisma ou outra malformação vascular cerebral com sinais / sintomas de alerta.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

Paciente com exame de imagem evidenciando aneurisma intracraniano não roto; ou

Paciente com malformações vasculares cerebrais não rotas; ou

Paciente com malformações vasculares cerebrais rotas (incluindo hemorragia subaracnóidea, aneurismas, malformações arteriovenosas ou outras malformações vasculares rotas), não tratados em caráter emergencial; ou

Paciente com história familiar de aneurisma intracraniano (dois ou mais parentes de primeiro grau com comprovação).

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever presença de sintomas neurológicos focais, exame físico neurológico, outros achados relevantes);

Presença de história prévia de aneurisma e/ou malformação vascular rota (sim ou não). Se sim, descrever quando, se realizou e qual modalidade de tratamento;

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou Rm, tomografia), com data.

Neoplasia do Sistema Nervoso Central

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de neoplasia com sintomas / sinais de hipertensão intracraniana (cefaléia persistente acompanhada de vômitos, alteração no nível de consciência, fundo de olho com papiledema) e/ou sintomas neurológicos focais de instalação rápida (horas ou dias); ou

Suspeita de neoplasia com sinais e sintomas de compressão medular e/ou síndrome de cauda equina; ou

Exame de imagem com lesão compatível com neoplasia e evidência de hipertensão intracraniana (desvio da linha média, herniação subfalcina, uncal ou transtentorial), presença de hidrocefalia, compressão do tronco encefálico; ou

Exame de imagem com lesão compatível com neoplasia e evidência de compressão medular.

2-Encaminhar ao Neurocirurgião:

Paciente com alteração em exame de imagem sugestiva de neoplasia, sem critérios para avaliação na emergência.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever presença de sintomas neurológicos focais, exame físico neurológico, outros achados relevantes);

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou Rm, tomografia), com data.

Síndrome do Túnel do Carpo

1- Encaminhar ao Neurocirurgião:

Síndrome do túnel do carpo com déficit de força objetivo na mão e/ou atrofia tenar; ou

Síndrome do túnel do carpo com déficit sensitivo contínuo por 3 meses (persistente, que não apresenta períodos de melhora dos sintomas sensitivos); ou

Síndrome do túnel do carpo há mais de 6 meses sem resposta ao tratamento clínico otimizado.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever características da dor, tempo de evolução, manobras de Tinel e Phalen, fatores desencadeantes e de alívio, outros sinais e sintomas relevantes);

Tratamento em uso ou já realizado para síndrome do túnel do carpo (não farmacológico, tipo, duração e resposta terapêutica; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta às medicações);

Tratamento cirúrgico, se realizado (sim ou não e local de atendimento);

Conclusão da ultrassonografia, com data;

Associação dos sintomas com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva a atividade.

PROTOCOLO MUNICIPAL NEUROLOGIA

Acidente Vascular Cerebral

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Acidente Isquêmico Transitório (AIT) agudo.

2-Encaminhar à Neurologia:

AVC hemorrágico sem etiologia definida;

AVC isquêmico ou AIT em paciente com menos de 45 anos;

AVC isquêmico ou AIT com investigação diagnóstica inconclusiva ou não realizada na emergência (ecodoppler de carótidas, ecocardiograma, eletrocardiograma);

AVC isquêmico ou AIT com evidência de obstrução de carótida, ipsilateral à lesão cerebral, entre 50% a 69%;

Estenose de carótida assintomática maior que 70%.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do tipo de AVC (hemorrágico ou isquêmico), data do evento e etiologia, quando conhecida;

Descrever na íntegra, laudo de exame de imagem (RADIOGRAFIA.e/ou TC ou RNM de crânio), com data;

Anexar eletrocardiograma, preferencialmente, ou descrever na íntegra os seus resultados, com data;

Descrever na íntegra ecodoppler de carótidas os seus resultados, com data (se realizado);

Comorbidades (hipertensão, diabetes, arritmia) (sim ou não). Se sim, quais.

Cefaleia

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Pacientes com cefaléia e sinais de alerta.

2-Encaminhar à Neurologia:

Migrânea (enxaqueca) ou cefaleia tipo tensão refratária ao manejo profilático na APS;
Outras cefaleias primárias que não se caracterizam como migrânea (enxaqueca) ou tipo tensão;

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade de início da cefaleia, tempo de evolução, características da dor, frequência das crises, mudança no padrão, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas associados);

Comorbidades (infecção pelo HIV, neoplasia, trauma craniano recente);

Tratamentos em uso ou já realizados para cefaleia (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Descrever na íntegra os seus resultados de exame de imagem (RADIOGRAFIA e/ou TC ou RNM de crânio), com data.

Convulsão / Epilepsia

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Crise convulsiva secundária a suspeita de infecção do sistema nervoso central, distúrbio hidroeletrolítico, abstinência de álcool ou suspeita de acidente vascular cerebral;

Crise convulsiva que dura mais de 5 minutos ou crises que recorrem sem a completa recuperação da consciência.

2-Encaminhar à Neurologia:

Pelo menos um episódio de alteração de consciência sugestivo de crise convulsiva, sem fatores desencadeantes reconhecíveis e reversíveis na APS;

Dúvida diagnóstica sobre a natureza das convulsões;

Diagnóstico prévio de epilepsia com controle inadequado das crises com tratamento otimizado e descartado má adesão;

Paciente com epilepsia e efeitos adversos intoleráveis da medicação;

Paciente com epilepsia controlada há pelo menos 2 anos que deseja avaliação para retirada da medicação;

Mulheres com epilepsia que estão gestantes ou que desejam planejar gravidez.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever as características e a frequência das crises convulsivas, idade de início, tempo de evolução, fatores desencadeantes, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas fora das crises convulsivas);

Diagnóstico prévio de epilepsia (sim ou não). Se sim, descreva o tipo;

Tratamentos em uso ou já realizados para epilepsia (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Medicamentos em uso que interferem no limiar convulsivo (sim ou não). Se sim, quais;

Avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não).

Demência

1- Encaminhar à Neurologia:

Declínio cognitivo rapidamente progressivo (limitação funcional, cognitiva, comportamental ou motora significativas com evolução menor que dois anos);

Declínio cognitivo em que foram excluídas causas reversíveis e transtornos psiquiátricos descompensados.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade e modo de início, tempo de evolução, situações e tarefas que o paciente apresenta prejuízo, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas associados);

Pontuação no mini-exame do estado mental e escolaridade (anos concluídos de educação formal);

Sintomas depressivos (sim ou não). Se sim, qual o tratamento em uso e resposta;

Resultado dos exames: TSH, FTA-Abs e VDRL (com data);

Descrever na íntegra os seus resultados de exame de imagem (RADIOGRAFIA e/ou TC ou RNM de crânio), com data.

Distúrbios do Movimento (Ataxias, Coreias e Distonias)

Suspeita ou diagnóstico de distonia ou espasmo hemifacial.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

História familiar de ataxia, coreia ou distonia hereditária (sim ou não). Se sim, descreva o quadro e grau de parentesco;

História de consanguinidade entre os pais (sim ou não). Se sim, descreva o grau de parentesco.

Polineuropatia

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de polineuropatia aguda (como Guillain-Barré).

2-Encaminhar à Neurologia:

Polineuropatia desmielinizante;

Polineuropatia com características atípicas, após avaliação em serviço de emergência, se necessário;

Polineuropatia com etiologia definida, porém com sintomas progressivos ou refratários ao tratamento clínico otimizado (tratamento da causa base e uso de medicamentos como tricíclicos ou gabapentina);

Sintomas de polineuropatia (perda de sensibilidade, sensação de queimação, formigamento, perda de força) sem etiologia definida após investigação inicial na APS.

Pacientes com sintomas de polineuropatia com características típicas e etiologia definida (como DM, abuso de álcool, quimioterapia, entre outros) devem inicialmente ser manejados na APS. Encaminhar pacientes ao neurologista que apresentam sintomas atípicos, refratários ou sem etiologia definida.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (evolução dos sintomas no tempo, características dos sintomas sensitivos, motores, reflexos miotáticos profundos, entre outros);

Descrever laudo de eletroneuromiografia, com data ;

Descrever resultado de exames realizados na investigação (hemograma, glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, TSH, teste rápido para rastreio de IST), com data;

Paciente tem outras comorbidades? (sim ou não) Se sim, quais?

Tratamento em uso ou já realizado para polineuropatia (descreva medicamento e posologia);

Outros medicamentos em uso;
História familiar de neuropatia hereditária (sim ou não)? Se sim, descreva a doença e grau de parentesco.

Tremores e Síndrome Parkinsonianas

1- Encaminhar à Neurologia:

Suspeita de doença de Parkinson sem uso de medicamentos potencialmente indutores;

Suspeita de tremor essencial sem resposta ao tratamento clínico otimizado.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade de início e tempo de evolução dos sintomas, características do tremor, bradicinesia, rigidez muscular do tipo plástica, alteração da marcha, instabilidade postural e demais exames neurológicos);

Tratamentos em uso ou já realizados para tremor e/ou síndrome parkinsoniana (medicamentos utilizados com dose e duração do tratamento);

Outros medicamentos em uso (com dose e posologia).

Vertigem

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Vertigem com suspeita de origem central e sinais de gravidade: sintomas ou sinais neurológicos focais (como cefaleia, borramento visual, diplopia, disartria, parestesia, fraqueza muscular, dismetria, ataxia); ou

Novo tipo de cefaléia (especialmente occipital); ou

Surdez aguda unilateral; ou

Nistagmo vertical.

2-Encaminhar à Neurologia:

Vertigem com suspeita de origem central, após avaliação em serviço de emergência.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (duração, tempo de evolução e frequência dos episódios de vertigem; fatores desencadeantes; outros sintomas associados, exame físico neurológico e otoscopia);

Tratamento em uso ou já realizado para vertigem (não farmacológico e/ou

medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação);

Resultado de TSH e glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, com data;

Medicamentos que cursam com vertigem.

PROTOCOLO MUNICIPAL NEUROPEDIATRIA

Atraso Global do Desenvolvimento (AGD) e Deficiência Intelectual

1- Encaminhar à Neurologia:

Deficiência intelectual ou provável AGD ou possível AGD em crianças com episódio de convulsão ou outras manifestações neurológicas como ataxia / coreia; ou

Regressão neurológica com perda de habilidades previamente adquiridas do desenvolvimento neuropsicomotor como perda de fala e / ou marcha e/ou compreensão; ou

Deficiência intelectual recente sem etiologia estabelecida ou com necessidade de manejo de alterações comportamentais refratárias.

Obs: Atraso Global do Desenvolvimento (AGD) é um termo reservado a crianças menores que 5 anos de idade. Utilizado quando o indivíduo fracassa em alcançar os marcos do desenvolvimento em várias áreas da função intelectual, aplicada a crianças muito pequenas que não são capazes de passar por avaliações formais.

3-Encaminhar ao Pediatra:

Provável AGD sem etiologia identificada; ou

Possível AGD que persiste após reavaliação em 30 dias.

4-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade de início dos sintomas e áreas de prejuízo, perímetro cefálico atual e marcos do desenvolvimento que estão atrasados, presença de dismorfias ou características sindrômicas, episódios de convulsão ou outros achados relevantes);

História familiar de AGD, deficiência intelectual ou doenças raras (sim ou não). Se sim, descreva o quadro e grau de parentesco;

História de consanguinidade entre os pais (sim ou não). Se sim, descreva o grau de parentesco;

Criança está em acompanhamento com reabilitação intelectual de sua referência (sim ou não)? Se sim, descreva.

Relatório escolar e relatórios de profissionais de acompanhamento (psicólogo,

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e outros).

Cefaleia

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Pacientes com cefaléia e sinais de alerta:

Criança com menos de 3 anos de idade; ou

Aparecimento súbito e de intensidade muito forte; ou

Sintoma que inicia após trauma de crânio recente; ou

Suspeita de meningite (febre, rigidez de nuca, petéquias, alteração de sensório); ou

Sinais neurológicos focais; ou

Piora de intensidade em decúbito; ou o

Edema de papila; ou

Criança que apresenta comorbidades de maior risco (anemia falciforme, imunodeficiências, história de neoplasia, coagulopatias, doenças cardíacas, neurofibromatose, esclerose tuberosa, entre outras).

2-Encaminhar à Neurologia:

Migrânea (enxaqueca) ou cefaleia tipo tensão refratária ao manejo profilático na Atenção Primária à Saúde (APS) por um período mínimo de 2 meses; ou

Outras cefaleias primárias que não se caracterizam como migrânea (enxaqueca) ou cefaleia tipo tensão; ou

Necessidade de investigação com exame de imagem, quando esse não for disponível na APS.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever idade de início da cefaleia, características da dor, tempo de evolução, frequência das crises, mudança no padrão, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas associados);

Tratamentos em uso ou já´ realizados para cefaleia (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Resultado do exame de imagem (RADIOGRAFIA e/ou TC ou RNM de crânio), com data (se realizado).

Distúrbios do Movimento (Ataxias e Coreias)

1- **Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Episódio agudo de ataxia em crianças (principais causas: infecção, tumor, intoxicação exógena).

2-Encaminhar à Neurologia:

Suspeita ou diagnóstico de ataxia; ou

Suspeita ou diagnóstico de coreia.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

História familiar de ataxia ou coreia hereditária (sim ou não). Se sim, descreva o quadro e grau de parentesco;

História de consanguinidade entre os pais (sim ou não). Se sim, descreva o grau de parentesco.

Epilepsia

1- Encaminhar à Neurologia:

Um ou mais episódios de alteração de consciência sugestiva de crise epiléptica, exceto quadro de convulsão febril simples de característica benigna; ou

Criança com diagnóstico prévio de epilepsia com controle inadequado das crises apesar do tratamento otimizado e descartado má adesão.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever as características e a frequência das crises convulsivas, idade de início, tempo de evolução, fatores desencadeantes, exame físico neurológico, outros sinais e sintomas fora das crises convulsivas);

História prévia de epilepsia (sim ou não). Se sim, descreva o tipo;

Tratamentos em uso ou já realizados para epilepsia (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Medicamentos em uso que interferem no limiar convulsivo.
Descrever exame Eletroencefalograma com data;

Microcefalia

1- Encaminhar à Neurologia:

Recém-nascidos ou crianças com suspeita de microcefalia e alteração do crescimento / desenvolvimento neuropsicomotor; ou
Crianças que no acompanhamento de puericultura, apresentarem desaceleração do crescimento cefálico com medida inferior a – 2 DP para idade e sexo conforme gráfico da OMS ou curva intergrow.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descreva malformações, desproporção craniofacial, abaulamento de fontanela, manifestações como hipertonia e hiperexcitabilidade; atraso em marcos do desenvolvimento, outros achados relevantes);
Descreva medida do perímetro cefálico ao nascimento e medidas realizadas posteriormente, com data;
Descreva idade gestacional no parto da criança;
Descrever resultado de ecografia transfontanelar e/ou tomografia de crânio da criança com data;
Descrever ecografia obstétrica (se achados alterados), com data.

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH)

1- Encaminhar à Neurologia:

Diagnóstico de TDAH - seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas de hiperatividade e impulsividade marcadas como “Bastante” na escala SNAP, considerando resposta de pais e escola, por mais de 6 meses;
TDAH associado à comorbidades psiquiátricas.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro atual (idade de início, evolução dos sintomas, características que sugere diagnóstico);

Sintomas são percebidos em mais de um ambiente (por exemplo, casa e escola)? (sim ou não). Se sim, descreva em quais ambientes;

Histórico de outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não)? Se sim, descreva;

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (medicamentos utilizados com dose e posologia).

Transtornos do Espectro Autista (TEA)

1- Encaminhar à Neurologia:

Suspeita ou diagnóstico de TEA.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro atual (idade de início, evolução dos sintomas);

Histórico de outros transtornos psiquiátricos ou internações psiquiátricas atuais e/ou passados (sim ou não)? Se sim, descreva;

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (se medicamentos, quais estão sendo ou foram utilizados, com dose e posologia);

História familiar de TEA/deficiência intelectual ou pais consanguíneos (sim ou não). Se sim, descreva.

Relatório escolar e relatórios de profissionais de acompanhamento (psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e outros).

PROTOCOLO MUNICIPAL OFTALMOLOGIA

Catarata

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Paciente com diagnóstico de catarata, previamente operados, com necessidade de revisão por queixa de diminuição de acuidade visual; ou

Paciente com suspeita de catarata.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descreva quadro de diminuição visual e prejuízo funcional, perda de reflexo vermelho, outros achados relevantes);

Paciente previamente operado de catarata (sim ou não).

Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Distúrbios de Refração ou Acomodação

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Paciente com queixa de diminuição não aguda da acuidade visual; ou

Paciente com distúrbio de refração (miopia, hipermetropia, astigmatismo) ou acomodação (presbiopia) com necessidade de revisão por modificação na acuidade visual; ou

Paciente usuário de lente de contato, sem acompanhamento com oftalmologista.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (diminuição visual; alteração na visão para perto ou para longe) e outros achados do exame físico como: torcicolo, nistagmo, estrabismo, pterígio ou achados corneanos;

Diagnóstico prévio de distúrbio de refração ou acomodação? (sim ou não). Se sim, qual o distúrbio e quando foi a última revisão oftalmológica?

Prejuízo funcional devido à diminuição da acuidade visual? (sim ou não). Se sim, descreva.

Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Doenças da Córnea e da Superfície Ocular

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Pterígio associado à diminuição de acuidade visual; ou

Pterígio sintomático (irritação ocular) ou olho seco sem alívio com tratamento clínico (lubrificante ocular 3 a 6 vezes ao dia) por 1 mês; ou

Outras doenças da córnea sintomáticas (ceratocone, distrofia, displasia, leucoma, edema da córnea, ceratopatia bolhosa, etc.).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Apresenta diminuição de acuidade visual (sim ou não);

Descreva tratamento realizado para condição (se indicado).
Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Estrabismo

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Estrabismo de início recente e/ou queixa de diplopia aguda após avaliação em serviço de emergência clínica; ou

Estrabismo associado à diminuição de acuidade visual ou outros sintomas como torcicolo; ou

Estrabismo em pessoas assintomáticas que desejam intervenção cirúrgica por motivo estético.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descreva idade de início, evolução e sintomas associados como diminuição de acuidade visual, torcicolo, diplopia);

Descreva o tipo de desvio, convergente, divergente ou desvio vertical.
Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Glaucoma

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Suspeita ou diagnóstico de glaucoma (por exemplo, por aumento da pressão intraocular ou aumento da escavação do disco óptico).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Há quanto tempo apresenta diagnóstico de glaucoma?
Tratamento prévio ou atual para glaucoma (descreva medicamentos e posologia em uso, realização de cirurgia ou terapia com laser).
Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Retinopatias ou Outras Doenças da Retina

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Avaliação inicial de pacientes com DM2 (no momento do diagnóstico) ou DM1 (cinco anos após o diagnóstico); ou

Rastreamento anual de retinopatia diabética em pacientes com DM1 ou DM2;
Diagnóstico de retinopatía diabética identificado por retinografía, edema macular diabético; retinopatia proliferativa; retinopatia não proliferativa moderada/grave; retinopatia não proliferativa leve;

Rastreamento de maculopatia em pacientes que utilizam cloroquina/hidroxicloroquina; ou

Outras doenças de retina estabelecidas (degeneração macular, descolamento de retina, oclusão de veia central da retina, entre outros).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever se há diminuição de acuidade visual e outros achados relevantes);

Realizar teste de acuidade visual, snellen.
Apresenta diagnóstico prévio de doença de retina (sim ou não). Se sim, descreva o tipo e exame realizado no diagnóstico;

Apresenta diagnóstico de diabetes (sim ou não)? Se sim, descreva o tipo e idade aproximada no diagnóstico;

Realizou retinografia previamente (sim ou não). Se sim, descreva o laudo com data.
Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Toxoplasmose

1- Encaminhar ao Oftalmologista:

Pacientes com toxoplasmose ocular que necessite acompanhamento ambulatorial,

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Resultado de sorologia para toxoplasmose (IgM e IgG);
Realizar teste de acuidade visual, snellen.

Paciente apresenta imunossupressão (sim ou não). Se sim, causa da imunossupressão.

PROTOCOLO MUNICIPAL ORTOPEDIA

Bursite / Tendinite

1- Encaminhar ao Ortopedista:

Bursite ou tendinite sem resposta satisfatória ao tratamento não farmacológico (exercícios, acompanhamento fisioterápico) otimizado por um período de 6 meses.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas - descrever características da dor, tempo de evolução, fatores desencadeantes e de alívio; presença de restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva.

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia, RM, tomografia da região envolvida, com data;

História prévia de trauma local (sim ou não). Se sim, descreva;

Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva a atividade;

Tratamento não farmacológico em uso ou já realizado para a dor periarticular (tipo e duração).

Dor Cervical

4. Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Suspeita de síndrome de compressão medular; ou

Exame de imagem com evidência de compressão medular e/ou mielopatia; ou

Suspeita de infecção (especialmente em pessoas imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas); ou

Suspeita de fratura vertebral, luxação ou lesão medular associada a traumatismo recente; ou

Diagnóstico de neoplasia acometendo a coluna vertebral.

2-Encaminhar ao Ortopedista:

Diagnóstico de estenose de canal cervical ou mielopatia que não operado em caráter emergencial; ou

Pacientes com cervicalgia e diagnóstico definido de artrite reumatoide; ou

Dor cervical e sintomas de radiculopatia (dor irradiada para os braços, fraqueza, parestesia), sem resposta após 6 semanas de tratamento clínico otimizado; ou

Dor cervical crônica inespecífica sem melhora após tratamento clínico otimizado por 6 meses, na ausência de serviço especializado para tratamento de dor crônica.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas como, características da dor, presença de sintomas de radiculopatia cervical, tempo de início e duração dos sintomas, fatores desencadeantes e de alívio, presença de alterações em exame físico neurológico (sim ou não). Se sim, descreva;

Outros sinais e sintomas relevantes (sistêmicos);

Tratamento em uso ou já realizado para dor cervical (não farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta à medicação);

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia, RM, tomografia da região envolvida, com data;

Presença de imunossupressão ou artrite reumatoide (sim ou não). Se sim, qual?

Se suspeita de neoplasia, descreva o motivo;

Osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como foi feito o diagnóstico;
Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva a atividade.

Dor Lombar

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Suspeita de compressão de cone medular ou síndrome da cauda equina;

Perda de força progressiva medida de maneira objetiva; ou

Diagnóstico de neoplasia acometendo a coluna vertebral; ou

Suspeita de infecção (especialmente em pessoas imunossuprimidas e/ou usuárias de drogas ilícitas endovenosas); ou

Suspeita de fratura ou luxação associada a traumatismo recente.

2-Encaminhar ao Ortopedista:

Síndrome radicular sem melhora clínica após 6 semanas de tratamento clínico otimizado;

Diagnóstico de estenose de canal lombar ou espondilolistese e sintomas compatíveis com síndrome radicular e/ou claudicação neurogênica;

Suspeita clínica de claudicação neurogênica.
Lombalgia de característica mecânica e diagnóstico de espondilolistese ístmica (qualquer grau) ou espondilolistese degenerativa ≥ grau 2;
Dor lombar crônica inespecífica sem melhora após tratamento clínico otimizado para dor crônica por 6 meses.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas, com descrição das características da dor, presença ou não de ciatalgia ou claudicação neurogênica, tempo de início e duração dos sintomas, fatores desencadeantes e de alívio;

Presença de alterações em exame físico neurológico (sim ou não). Se sim, descreva;

Outros sinais e sintomas relevantes (sintomas constitucionais);

Tratamento em uso ou já realizado para dor lombar (não farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta à medicação);

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia, RM, tomografia da região envolvida, com data;

Presença de imunossupressão (sim ou não). Se sim, qual?

Se suspeita de neoplasia, descreva o motivo.

Osteoporose prévia (sim ou não). Se sim, descreva como foi feito o diagnóstico;
Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva a atividade.

Dor no Joelho

1- Encaminhar ao Ortopedista:

Lesão ligamentar do joelho com potencial indicação cirúrgica; ou

Lesão meniscal com potencial indicação cirúrgica; ou

Suspeita clínica de lesão meniscal ou ligamentar; ou

Subluxação patelar recorrente refratária ao tratamento conservador; ou

Osteoartrite de joelho com potencial indicação de cirurgia (sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado por 6 meses ou importante prejuízo para as atividades de vida diária).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever presença de instabilidade, bloqueio articular, crepitação, tempo de evolução, manobras ortopédicas realizadas);

Apresenta restrição de movimento / prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva;

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia, RM, tomografia da região envolvida, com data;

História prévia de trauma local (sim ou não). Se sim, descreva;

Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva;

Tratamento realizado para a dor no joelho (não - farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação).

Dor no Ombro

1- Encaminhar ao Ortopedista:

Ruptura total de tendão do manguito rotador evidenciada em exame de imagem; ou

Ruptura parcial de tendão do manguito rotador em progressão ou com dor refratária ao tratamento clínico otimizado; ou

Dor no ombro refratária ao tratamento clínico otimizado por um período de 6 meses; ou

Osteoartrite de ombro com potencial indicação de cirurgia (sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado por 6 meses ou importante prejuízo para as atividades de vida diária); ou

Luxação recorrente de ombro após avaliação em serviço de emergência.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Apresenta restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva;

Presença de luxação do ombro (sim ou não). Se sim, descreva quantidade de vezes;

Resultado de exame de imagem do ombro, com data;

História prévia de trauma local (sim ou não). Se sim, descreva;

Associação do sintoma com atividade laboral (sim ou não). Se sim, descreva;

Tratamento realizado para a dor no ombro (não - farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação).

Dor no Quadril

1- Encaminhar ao Ortopedista:

Todos os casos de osteonecrose (necrose avascular ou asséptica); ou

Osteoartrite de quadril com potencial indicação de cirurgia (sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado por 6 meses ou importante prejuízo para as atividades de vida diária).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Apresenta restrição de movimento / prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva;

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia, RM, tomografia da região envolvida, com data;
Tratamento realizado para osteoartrite de quadril (não - farmacológico, tipo e duração; e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação).

Osteoartrite

1- Encaminhar ao Ortopedista:

Osteoartrite de quadril, joelho ou ombro com potencial indicação de cirurgia (sintomas de dor refratários ao tratamento clínico otimizado por 6 meses ou importante prejuízo para as atividades de vida diária); ou

Osteoartrite em mãos com deformidades que comprometem a função da mão.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Manifestações clínicas que sugiram o diagnóstico:

a) dor articular (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas;

b) hipertrofia óssea na articulação (sim ou não). Se sim, articulações acometidas;

c) presença de rigidez matinal (sim ou não). Se sim, descreva duração;

d) presença de crepitação, quando sintoma em articulação de joelho (sim ou não);

e) outros sinais e sintomas relevantes (edema da articulação, calor local, deformidade articular);

Presença de restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva.

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia, RM, tomografia da região envolvida, com data;

PROTOCOLO MUNICIPAL_OTORRINOLARINGOLOGIA

Disfagia

1- Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Disfagia orofaríngea com sinais e sintomas sistêmicos que sugerem neoplasia (sintomas constitucionais, lesão visível a oroscopia, linfonodomegalia cervical ou supraclavicular).

Disfagia orofaríngea persistente com duração maior que 1 mês sem etiologia definida na APS.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever as características, frequência da disfagia, tempo de evolução, fatores desencadeantes e associados, exame físico neurológico);

Medidas ou tratamentos já realizados para disfagia (não farmacológico e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta);

Comorbidades, fatores de risco e sinais de alerta para neoplasia orofaríngea.

Disfonia

1- Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Disfonia em pessoa com alto risco de neoplasia (tabagista, etilista, com sintomas associados, como disfagia orofaríngea ou odinofagia); ou

Disfonia persistente (≥ 6 semanas) sem causa identificável; ou

Disfonia associada a procedimentos cirúrgicos de pescoço ou tórax.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever duração, presença de sintomas constitucionais, palpação cervical);

Fatores de risco - tabagismo, etilismo, profissão;

História recente de cirurgia de pescoço ou tórax.

Hipoacusia / Perda auditiva e Protetização Auditiva

1- Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Perdas auditivas condutivas ou mistas com otoscopia normal; ou

Hipoacusia sem alteração de otoscopia e exame de audiometria.

2-Dados que devem conter no encaminhamento

Sinais e sintomas (duração, gravidade dos sintomas, presença de zumbido, plenitude auricular, vertigem);

Descrição da otoscopia;

Resultado de audiometria tonal/vocal + imitanciometria com data.

Obstrução Nasal

1- Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Obstrução nasal relacionada a fator estrutural:

Tumor nasal (obstrução nasal unilateral persistente associada à epistaxe ou drenagem purulenta); ou

Desvio de septo; ou

Hipertrofia de adenoide.

Obstrução nasal associada a pólipo nasal com potencial indicação cirúrgica (como múltiplos pólipos, sintomas graves refratários ao tratamento conservador (corticóide intranasal); ou

Obstrução nasal sem etiologia definida após avaliação inicial na APS como medicamentos, rinossinusite crônica e rinite alérgica.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (início dos sintomas e duração, obstrução unilateral ou bilateral, presença de rinorréia, roncos, epistaxe, anosmia, desvio de septo, deformidades faciais, entre outros achados relevantes);

Paciente apresenta diagnóstico de rinite ou rinossinusite crônica (sim ou não)? Se sim, descreva tratamento realizado (medicamentos, com posologia e duração);

Faz uso de medicamentos que causam obstrução nasal (sim ou não)? Se sim, quais;

Descrição de exames realizados na investigação, com data.

Resultado de exame de imagem (radiografia cavum boca aberta/fechada e/ou Nasofibroscopia e/ou RM, tomografia da região envolvida, com data.

Otites

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Suspeita de otite externa maligna (otite externa severa com otalgia que não responde ao tratamento da dor, dor em mastóide, tecido de granulação, necrose no conduto ou paralisia facial);

Otite média com complicações graves (mastoidite, paralisia facial, meningite, entre outras).

Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Membrana timpânica perfurada persistente após 6 semanas do tratamento da otite média aguda; ou

Otite média crônica: com efusão/otorreia que persiste por mais de 3 meses ou que apresenta alteração estrutural da membrana timpânica ou da orelha média; ou com presença de hipoacusia; ou

Suspeita de colesteatoma (presença de acúmulo epitelial que pode estar associado à otorréia fétida persistente, hipoacusia, perda auditiva condutiva, cefaleia, vertigem).

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever duração, presença de otorréia, perda auditiva, entre outros);

Descrição da otoscopia (anormalidades, perfuração da membrana timpânica);

Tratamento em uso ou realizado para a condição (descrever medicamentos e posologia).

Rinossinusite

1- Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Rinossinusite crônica:

Associada a anormalidades estruturais (desvio de septo, pólipo, entre outros); ou

Refratária ao tratamento clínico otimizado por 3 meses; ou

Rinossinusite bacteriana recorrente (≥ 4 episódios ao ano).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (características do quadro, alterações anatômicas, episódios recorrentes);

Tratamento em uso ou já realizado para rinossinusite (medicamentos e posologia);
Resultado de exame de imagem (radiografia de face/ossos da face RM, tomografia da região envolvida), com data.

Ronco e Apneia do Sono

1- Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Paciente com suspeita de SAHOS (presença de dois entre os três sintomas: roncos, sonolência diurna excessiva e pausas respiratórias durante o sono presenciadas por outra pessoa) associada a fator obstrutivo de via aérea superior, tais como: desvio de septo nasal; ou pólipos nasais; ou hipertrofia de amígdalas.

Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descreva presença de roncos, sonolência diurna e prejuízo funcional associado, pausas respiratórias durante o sono, identificadas por outra pessoa, entre outros);

Comorbidades (sim ou não). Se sim, quais;

IMC;

Profissão do paciente;

Descrição dos exames realizados (Polissonografia), com data.

Vertigem

1- Encaminhar ao PAM:

Vertigem com suspeita de origem central e sinais de gravidade:

Sintomas ou sinais neurológicos focais (como cefaleia, borramento visual, diplopia, disartria, parestesia, paresia, dismetria, ataxia, entre outros);

Novo tipo de cefaléia (especialmente occipital);

Surdez aguda unilateral; nistagmo vertical.

2-Encaminhar ao Otorrinolaringologista:

Suspeita de doença de Ménière; ou

Vertigem posicional paroxística benigna (manobra de Dix-Hallpike) com mais de 3 episódios de recorrência após manobras de reposição otolítica (manobra de Epley); ou
Labirintite ou neuronite com sintomas que não melhoram após 15 dias de tratamento conservador; ou
Vertigem periférica com dúvida diagnóstica após investigação de causas secundárias na APS.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (duração, tempo de evolução e frequência dos episódios de vertigem; fatores desencadeantes; outros sintomas associados, exame físico neurológico e otoscopia);
Tratamento em uso ou já realizado para vertigem (não farmacológico e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação);
Resultado de e glicemia de jejum ou hemoglobina glicada + lipidograma com data;
Faz uso de medicamentos que podem causar vertigem? Se sim, quais.

PROTOCOLO MUNICIPAL PEQUENAS CIRURGIAS

Fluxo de Referenciamento

1- Encaminhar à Pequenas Cirurgias:

Caso o médico da unidade queira realizar o procedimento sem encaminhar fica a seu critério a realização da exérese e eventual solicitação de exame anatomopatológico de lesão suspeita.

Nevus: com aumento de tamanho, mudança da cor, sangramento, ulceração, com comprometimento funcional, com lesões pigmentares palmo plantar e congênitos > 6 cm.

Verruga Vulgar: resistência ao tratamento clínico usual, com limitação funcional, prejuízo cosmético e risco de malignidade.

Carcinoma Basocelular e Espinocelular: qualquer lesão sugestiva.

Melanoma: qualquer caso suspeito.

Lipoma: dolorosos, com prejuízo cosmético, limitação funcional até 5cm.

Cistos sebáceos: realizar tratamento prévio, se processo inflamatório ativo.

Fibromas moles: localizados em áreas de trauma.

Quelóides: qualquer caso, sempre que desejo de terapêutica cirúrgica do paciente.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Quadro clínico (sinais e sintomas associados, achados no exame físico, história de

complicações, tamanho aproximado da lesão);

Resultado de exame de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia e/ou RM, tomografia da região envolvida, com data.

PROTOCOLO MUNICIPAL PNEUMOLOGIA

Asma

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Crise de asma com sinais de gravidade que não possibilitam manejo na APS.

2-Encaminhar ao Pneumologista:

Asma de difícil controle (paciente que necessita tratamento clínico em estágio 5); ou

Asma grave (paciente que necessita manter tratamento em Estágio 4 e 5 por mais de 6 meses para controle); ou

Pacientes com indicadores de fatalidade; ou

Asma lábil (crises que iniciam abruptamente e de forma grave, principalmente quando o paciente não consegue reconhecer sintomas iniciais da crise).

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever, baseado nas últimas quatro semanas: frequência das crises diurnas e noturnas, frequência de uso de beta-2 de curta ação por semana, limitação da atividade física devido à asma, sintomas associado à exposição ocupacional, outras alterações relevantes);

Tratamento para asma (profilático e de alívio). Descrever medicamentos utilizados com dose e posologia;

Número de exacerbações com uso de corticoide oral no último ano;

Quantidade de internações ou procura a serviços de emergência no último ano;

Paciente apresenta indicadores de fatalidade (sim ou não). Se sim, quais;

Descrição da espirometria, com data;

Descrição do raio - X de tórax, com data.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Exacerbação de DPOC com sinais de gravidade que não possibilitam manejo na APS.

2-Encaminhar ao Pneumologista:

DPOC de difícil controle (duas ou mais internações ou idas à emergência por exacerbação de DPOC no último ano, em uso de corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa ação ou anticolinérgico de longa ação); ou

DPOC muito grave (VEF1 menor do que 30% do previsto);

Paciente que persiste sintomático (pontuação maior ou igual a 2 na escala de dispneia mMRC ou pontuação maior ou igual a 10 no instrumento de Avaliação do DPOC (CAT)) mesmo com tratamento otimizado (em uso de corticoide inalatório e beta-2 agonista de longa ação ou anticolinérgico de longa ação); ou

Suspeita de cor pulmonale; ou

Avaliação para oxigenoterapia domiciliar prolongada (saturação de oxigênio menor ou igual a 92% em repouso no ar ambiente e fora de crise).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever baseado nas últimas quatro semanas: frequência e intensidade das crises; pontuação na escala de dispneia mMRC ou no Instrumento de Avaliação do DPOC (CAT); outras alterações relevantes);

Tabagismo (sim ou não). Se sim, estimar carga tabágica (em maços-ano);

Medicações em uso para DPOC (profiláticas e de alívio);

Número de exacerbações resultando em uso de corticoide oral e antibioticoterapia no último ano;

Quantidade de internações ou atendimentos de emergência no último ano por exacerbação do DPOC;

Descrição da espirometria, com data;

Descrição do Raio - X de tórax, com data.

Tosse Crônica e Dispneia

1- Encaminhar ao Pneumologista:

Pacientes com tosse crônica, após investigação inconclusiva na APS e ausência de resposta ao tratamento empírico para as causas mais comuns (síndrome da tosse de vias aéreas superiores, asma, doença do refluxo gastroesofágico, DPOC); ou

Pacientes com dispnéia crônica de provável etiologia pulmonar, após investigação inconclusiva na APS.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (tempo de evolução, atentar principalmente para anamnese e exame físico cardiológico e pneumológico);

Tabagismo (sim ou não). Se sim, estimar carga tabágica (em maços-ano);

Resultado de exame de imagem de tórax, com data;

Resultado espirometria, com data;

Se presença de dispneia, resultado de eletrocardiograma em repouso, com data;

Se presença de tosse descrever resultado do BAAR, com data (se negativo, mínimo dois exames em dias distintos);

Utiliza medicação anti-hipertensiva da classe dos inibidores da ECA? (sim ou não).

PROTOCOLO PRÉ-NATAL

ANEXOS PROTOCOLO REGULAÇÃO

Verificar Protocolo Municipal de Pré-natal no link de anexos acima.

PROTOCOLO MUNICIPAL PROCTOLOGIA

Fissura Anal

1- Encaminhar ao Proctologista:

Fissura anal recorrente/refratária ao tratamento clínico conservador por 2 meses; ou

Fissura anal com comorbidade orificial cirúrgica (fístula).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever inspeção anal e toque retal);

Presença de comorbidades orificiais com descrição, quando presentes;

Presença de alteração de hábito intestinal (sim ou não);

Tratamentos já realizados para fissura anal (orientações, medicamentos e tempo de duração).

Fístula Anal

1- Encaminhar ao Proctologista:

Caso suspeito (secreção perianal persistente, abscessos anorretais recorrentes) ou diagnóstico de fístula anorretal.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever inspeção anal e toque retal);

Presença de comorbidades relevantes (doença inflamatória intestinal, radioterapia pélvica).

PROTOCOLO/FLUXO MUNICIPAL PSIQUIATRIA

Fluxo para encaminhamentos ao CAPS/Psiquiatra

O paciente deverá ser avaliado pela Unidade Básica de Saúde em que o mesmo está cadastrado, e caso se enquadre para atendimento especializado, encaminhar ao CAPS:

- Paciente adulto (maior de 18 anos) a Unidade Básica de Saúde faz o PTS – Plano Terapêutico Singular e encaminha ao CAPS;

Para encaminhamentos ao médico psiquiatra:

- Paciente adulto que faz acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, que não tem pré requisitos para ser encaminhado e ou acompanhado pelo CAPS e necessita de avaliação psiquiátrica, deverá ser encaminhado via APAC através do sistema, sendo este um encaminhamento ambulatorial eletivo de consulta medica em atenção especializada (psiquiatra), **com PTS em anexo**, descrevendo que está sendo encaminhado para avaliação e ou ajuste de dose e o mesmo retorna seu acompanhamento na Unidade Básica de Saúde;

- Pacientes menores de 0 a 18 anos, que necessitam de avaliação/acompanhamento psiquiátrico, devem ser encaminhados via sistema, através de encaminhamento (Apac), para priorização do médico regulador municipal e após será encaminhado para fila de espera de atendimento eletivo, no Centro de Especialidades Médicas;

OBS: em anexo Regimento Interno do CAPS Renascer

Psicoses (Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos)

1- Encaminhar ao Psiquiatra:

Diagnóstico inicial ou suspeita diagnóstica de transtorno psicótico;

Transtorno psicótico que já vem em tratamento e apresenta recidivas frequentes e/ou sintomas psicóticos persistentes;

Esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos em gestantes.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro psiquiátrico atual (evolução dos sintomas, características que sugere diagnóstico);

Se mulher em idade fértil, está gestante (sim ou não). Se sim, descreva a idade gestacional;

Presença de ideação suicida/tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva, especificando o método e a(s) data(s);

Histórico psiquiátrico - episódios psicóticos prévios (sim ou não). Se sim, descreva sintomas e idade de início; outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não). Se sim, descrever; internações psiquiátricas anteriores (sim ou não). Se sim, número de internações e data (mês e ano) da última internação.

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (não farmacológico - tipo, duração e resposta terapêutica; e farmacológico - medicamento utilizado, posologia, tempo de uso, tolerabilidade e padrão de resposta).

Transtornos Alimentares

1- Encaminhar ao Psiquiatra:

Suspeita ou diagnóstico de anorexia nervosa:

Índice de massa corporal (IMC) menor que 18,5 e pelo menos uma das seguintes características - restrição do consumo calórico em relação à necessidade com a intenção deliberada de perder ou não ganhar peso; ou comportamento persistente que interfira com ganho de peso (por exemplo: indução de vômitos ou prática extenuante de exercícios físicos); ou medo intenso de ganhar peso ou de tornar-se obeso.

Suspeita ou diagnóstico de bulimia:

Episódios de compulsão alimentar, nos quais é ingerida uma quantidade de comida claramente exagerada em um período curto de tempo; e

Comportamento compensatório inadequado para evitar ganho de peso (purgação através de vômitos, uso de laxantes, diuréticos ou outros fármacos, jejum, exercício físico extenuante) pelo menos uma vez por semana por no mínimo três meses.

Suspeita ou diagnóstico de compulsão alimentar:

Episódios de compulsão alimentar, nos quais é ingerida uma quantidade de comida claramente exagerada em um período curto de tempo, que ocorrem ao menos uma vez por semana durante pelo menos três meses; e

Sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio; e

Sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar; e

Refratariedade a pelo menos uma estratégia terapêutica efetiva por pelo menos 8 semanas.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro atual (idade de início, evolução dos sintomas) com características que sugerem o transtorno (conforme condições clínicas descritas acima);

Se mulher em idade fértil, está gestante (sim ou não). Se sim, descreva a idade gestacional;

IMC com data;

Presença de ideação suicida / tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva;

Histórico de outros transtornos psiquiátricos ou internações psiquiátricas (sim ou não). Se sim, descreva;

Tratamentos em uso e/ou já realizados, incluindo medidas não farmacológicas e farmacológicas, descrevendo tempo de uso e resposta terapêutica.

Transtorno Bipolar

1- Encaminhar ao Psiquiatra:

Quadros sugestivo de mania ou sintomas depressivos graves atuais associados à história de episódio maníaco/hipomaníaco;

Transtorno bipolar que já vem em tratamento otimizado e apresenta recidivas frequentes ou sintomas mal controlados;

Transtorno bipolar em mulheres grávidas.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro psiquiátrico atual (evolução dos sintomas, características que sugere diagnóstico);

Se mulher em idade fértil, está gestante (sim ou não). Se sim, descreva a idade gestacional;

Presença de sintomas psicóticos atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, especifique os sintomas e a(s) data(s);

Presença de ideação suicida / tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva, especificando o método e a(s) data(s);

Histórico psiquiátrico - outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não).

Se sim, descreva; internações psiquiátricas anteriores (sim ou não). Se sim, número de internações e data (mês e ano) da última internação.

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (não farmacológico - tipo, duração e resposta terapêutica; e farmacológico - medicamento utilizado, posologia, tempo de uso, tolerabilidade e padrão de resposta) e exames laboratoriais de controle, conforme terapêutica vigente.

Transtorno de Ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)

1- Encaminhar ao Psiquiatra:

Transtorno de ansiedade refratário - ausência de resposta ou resposta parcial a duas estratégias terapêuticas efetivas (não farmacológicas e/ou farmacológicas) em dose terapêutica e por pelo menos 8 semanas cada;

Transtorno de ansiedade e ideação suicida persistente após manejo inicial na APS (ausência de melhora 12 semanas após início do manejo).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro atual (evolução dos sintomas, características que sugere diagnóstico);

Hipótese diagnóstica (pânico, ansiedade social, ansiedade generalizada, TOC);

Presença de ideação suicida / tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não).

Se sim, descreva, especificando o método e a(s) data(s);

Histórico psiquiátrico - outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não). Se sim, descreva; internações psiquiátricas anteriores (sim ou não). Se sim, número de internações e data (mês e ano) da última internação;

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (não farmacológico - tipo, duração e resposta terapêutica; e farmacológico - medicamento utilizado, posologia, tempo de uso, tolerabilidade e padrão de resposta).

Transtornos Depressivos

1- Encaminhar ao Psiquiatra:

Episódio depressivo refratário - ausência de resposta ou resposta parcial a pelo menos duas

estratégias terapêuticas efetivas por pelo menos 8 semanas cada;

Episódio depressivo associado a sintomas psicóticos;

Episódio depressivo em paciente com episódios prévios graves (sintomas psicóticos, tentativa de suicídio ou hospitalização psiquiátrica);

Episódio depressivo e ideação suicida persistente após manejo inicial na APS (ausência de melhora 12 semanas após início do manejo).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro psiquiátrico atual (evolução dos sintomas, características que sugere diagnóstico);

Presença de sintomas psicóticos atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva;

Presença de ideação suicida / tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva, especificando o método e a(s) data(s);

Histórico psiquiátrico - outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não). Se sim, descreva; internações psiquiátricas anteriores (sim ou não). Se sim, número de internações e data (mês e ano) da última internação; presença de abuso de substâncias (sim ou não). Se sim, descreva;

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (não farmacológico - tipo e duração; e farmacológico - posologia, tempo de uso, tolerabilidade e padrão de resposta);

Presença de comorbidades clínicas e tratamentos realizados;

Se mulher em idade fértil, está gestante ou lactante (sim ou não).

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Exposição a Evento Traumático

1- Encaminhar ao Psiquiatra:

TEPT com episódio traumático recente (até 6 meses antes da data do encaminhamento) e:

Ausência de resposta ou resposta parcial a uma estratégia terapêutica efetiva por pelo menos 4 semanas; ou

Ideação suicida.

TEPT com episódio traumático há mais de 6 meses da data do encaminhamento e:

Ausência de resposta ou resposta parcial a duas estratégias terapêuticas efetivas por pelo menos 8 semanas cada; ou

Ideação suicida;

Exposição a situação de violência recente (até 6 meses da data do encaminhamento) com ou sem critérios para TEPT, se:

Pessoa vítima de violência sexual; ou

Ideação suicida.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro atual (evolução dos sintomas, características que sugere diagnóstico);

Hipótese diagnóstica (pânico, ansiedade social, ansiedade generalizada, TOC);

Presença de ideação suicida / tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva, especificando o método e a(s) data(s);

Histórico psiquiátrico - outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não). Se sim, descreva; internações psiquiátricas anteriores (sim ou não). Se sim, número de internações e data (mês e ano) da última internação;

Tratamento em uso ou já realizado para a condição (não farmacológico - tipo, duração e resposta terapêutica; e farmacológico - medicamento utilizado, posologia, tempo de uso, tolerabilidade e padrão de resposta).

Transtornos por Uso de Substância

-Encaminhar ao Psiquiatra:

Transtorno por uso de álcool - pacientes com provável dependência com motivação para tratamento especializado e esgotados os recursos terapêuticos na APS; ou em risco para síndrome de abstinência complicada.

Transtorno por uso de substância moderado a grave (exceto tabaco), com desejo de realizar tratamento e após esgotados os recursos disponíveis na atenção primária;

Transtorno por uso de substância (exceto tabaco) em mulher na gravidez e/ou lactação;

Transtorno por uso de substâncias (exceto tabaco) e ideação suicida.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro psiquiátrico atual (descrever a(s) substância(s), quantidade e tempo de uso, além de outros sinais e sintomas que sugerem transtorno por uso de substâncias);

Se mulher em idade fértil, está gestante ou lactante (sim ou não);

Presença de ideação suicida / tentativas de suicídio atuais ou no passado (sim ou não). Se sim, descreva, especificando o método e a(s) data(s);

Histórico psiquiátrico - histórico de uso de outras substâncias (sim ou não). Se sim, descreva; outros transtornos psiquiátricos atuais e/ou passados (sim ou não). Se sim, descreva; tratamentos em uso e/ou já realizados, incluindo medidas não farmacológicas e farmacológicas, descrevendo tempo de uso e resposta terapêutica; internações psiquiátricas (sim ou não). Se sim, número de internações e data (mês e ano) da última internação.

PROTOCOLO MUNICIPAL REUMATOLOGIA

Artrite por Deposição de Cristais (Gota)

1- Encaminhar ao Reumatologista:

Diagnóstico de gota e crises recorrentes (3 ou mais no ano) mesmo com adequada adesão ao tratamento otimizado (não-farmacológico e farmacológico);

Diagnóstico de gota e ácido úrico fora do alvo terapêutico (alvo determinado por ácido úrico sérico <6 mg/dL em pessoas sem tofo gotoso e < 5 mg/dL em pessoas com tofo gotoso) mesmo com adequada adesão ao tratamento otimizado (não- farmacológico e farmacológico).

Diagnóstico de gota e origem incerta da hiperuricemia (jovens, mulheres pré- menopausa).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Manifestações clínicas que sugerem o diagnóstico: presença de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas, características (calor, rubor, edema) e tempo de evolução do quadro; presença de tofo (sim ou não); número de crises no último ano; outros sinais e sintomas relevantes;

Resultado de ácido úrico , com data;

Resultado de creatinina com data;

Cor da pele (para cálculo de taxa de filtração glomerular);

Tratamentos em uso ou já realizados para gota (não farmacológico e/ou medicamentos utilizados com dose e posologia);

Outras medicações em uso.

Artrite Psoriásica

1- Encaminhar ao Reumatologista:

Diagnóstico de artrite psoriásica; ou

Suspeita de artrite psoriásica.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Manifestações clínicas que sugerem o diagnóstico - presença de artrite (sim ou não). Se

sim, quais articulações acometidas, características e tempo de evolução; presença de distrofia ungueal psoriásica típica (onicólise, pitting, hiperceratose) (sim ou não);
presença de dactilite ou história recente de edema e eritema de dedos (sim ou não);

presença de entesite (dor ou aumento de sensibilidade, especialmente no tendão de aquiles e/ou fáscia plantar) (sim ou não); outros sinais ou sintomas.

Psoríase cutânea atual (sim ou não);

História prévia de psoríase cutânea (sim ou não);

História familiar de psoríase (sim ou não);

Resultado de fator reumatoide, com data;
Resultado de ácido úrico , com data;

Resultado de exame de imagem da articulação acometida, com data (se necessário).

Artrite Reumatoide

1- Encaminhar ao Reumatologista:

Diagnóstico de artrite reumatoide; ou

Suspeita de artrite reumatoide.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Manifestações clínicas que sugiram diagnóstico - presença de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas, características e tempo de evolução; presença de rigidez matinal (sim ou não). Se sim, descreva duração; teste do aperto das articulações metacarpofalangeanas ou metatarsofalangeanas (teste do squeeze) positivo (sim ou não); outros sinais ou sintomas;

Descrição da radiografia das mãos, punhos e pés, com data (se necessário);

Resultado de fator reumatoide, com data;

Resultado de proteína c reativa (PCR) ou velocidade de hemossedimentação (VHS), com data.

Fibromialgia

1- Encaminhar ao Reumatologista:

Suspeita de doença articular inflamatória.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas - citar áreas em que o paciente sente dor, características da dor e tempo de evolução, presença de fadiga (sim ou não). Se sim, descreva gravidade;

Paciente apresenta sono reparador (sim ou não). Se não, descreva gravidade;

Presença de sintomas cognitivos (sim ou não). Se sim, descreva-os e a gravidade;
Outros sinais e sintomas gerais (edema articular, fraqueza, fenômeno de Raynaud, alteração do hábito intestinal, sintomas constitucionais) (sim ou não). Se sim, quais;

Paciente apresenta comorbidades psiquiátrica (sim ou não). Se sim, qual e os medicamentos em uso;
Tratamento em uso ou já realizado para fibromialgia (não farmacológico - tipo e duração e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação).

Lúpus Eritematoso Sistêmico

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Suspeita ou diagnóstico de LES com sinais / sintomas ameaçadores à vida.

2-Encaminhar ao Reumatologista:

Diagnóstico de LES; ou

Suspeita de LES (pelo menos 3 critérios clínicos / laboratoriais).

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Manifestações clínicas que sugerem o diagnóstico; presença de exantema malar (sim ou não); presença de fotossensibilidade (sim ou não); presença de exantema discóide (sim ou não); presença de úlcera oral (sim ou não); presença de artrite (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas, características e tempo de evolução; presença de serosite (pleurite ou pericardite) (sim ou não); presença de sinais ou sintomas neurológicos (sim ou não). Se sim, descrever quais; presença de outros sinais ou sintomas (sintomas constitucionais, fenômeno de Raynaud). Se sim, descreva quais;

Resultado de hemograma e plaquetas (descrever microscopia quando presente), com data;

Se anemia, resultado de exames para avaliar hemólise (reticulócitos, LDH, bilirrubinas e Coombs direto), com data;

Resultado de fator antinuclear (FAN), com data.

Resultado de ácido úrico , com data;

Resultado de creatinina com data;

Osteoartrite

1- Encaminhar ao Reumatologista:

Suspeita de doença articular inflamatória como artrite reumatóide ou artrite psoriásica; ou

Dor por osteoartrite sem melhora após tratamento clínico otimizado por 6 meses.

2- Dados que devem conter no encaminhamento:

Manifestações clínicas que sugerem o diagnóstico: dor articular (sim ou não). Se sim, quais articulações acometidas; hipertrofia óssea na articulação (sim ou não). Se sim, articulações acometidas; presença de rigidez matinal (sim ou não). Se sim, descreva duração; presença de crepitação, quando sintoma em articulação de joelho (sim ou não); outros sinais e sintomas relevantes (edema da articulação, calor local, deformidade articular);

Presença de restrição de movimento/prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva;

Resultado de ácido úrico , com data;

Resultado de creatinina com data;

Resultado de velocidade de hemossedimentação (VHS), com data;

Índice de massa corporal (IMC);

Tratamento em uso ou já realizado para osteoartrite (não farmacológico (tipo e duração) e/ou medicamentos utilizados com dose, posologia e resposta a medicação);

Comorbidades associadas (psoríase, doença inflamatória intestinal e outras).

PROTOCOLO MUNICIPAL UROLOGIA

Cisto Doença Policística Renal

1- Encaminhar ao Urologista:

Cistos com alterações sugestivas de malignidade (achados ecográficos como paredes espessas e irregulares, septações, calcificações ou resultado de tomografia com classificação de Bosniak maior ou igual a 2F); ou

Cistos simples sintomáticos (dor lombar, hematúria persistente, obstrução de via urinária).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou outro achado relevante);

Resultado de exame de imagem (ecografia ou tomografia), com data. O exame deve descrever tamanho dos cistos, número e localização;

Resultado de exame de creatinina sérica, com data;

Cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de Filtração Glomerular;

Resultado EAS, com data (se hematúria, 2 exames com 8 semanas de diferença entre eles);

Presença de história familiar para doença policística renal (sim ou não), e parentesco com o paciente.

Disfunção Sexual Masculina

1- Encaminhar ao Urologista:

Disfunção erétil refratária ao tratamento com inibidores de fosfodiesterase-5 por 6 meses; ou

Disfunção erétil e contraindicação (hipersensibilidade ou uso de nitrato oral) ou efeito adverso ao uso de inibidores de fosfodiesterase-5; ou

Doença de Peyronie (caracterizada por placas ou nódulo palpável no pênis, ereção dolorosa, curvatura peniana e disfunção erétil) com incapacidade de manter relação sexual.

Ejaculação precoce refratária ao tratamento conservador por 3 meses (uso de inibidor seletivo de recaptação de serotonina e terapia comportamental por 3 meses);

Disfunção sexual associada a suspeita ou diagnóstico de hipogonadismo.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Tratamento em uso ou já realizado para disfunção erétil (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Outros medicamentos em uso com posologia;

Se paciente com Doença de Peyronie, apresenta incapacidade de manter relação sexual (sim ou não);

Se suspeita de hipogonadismo, descreva, com data, o resultado de dois exames de testosterona total coletados em dias diferentes.

Fimose

***1*- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :**

Suspeita de parafimose (prepúcio retraído com anel prepucial estreito constringindo o corpo do pênis e/ou glande, causando edema ou possível necrose).

2-Encaminhar ao Urologista:

Fimose fisiológica persistente após tratamento conservador em crianças com mais de 5 anos, quando há desejo de intervenção cirúrgica;

Fimose fisiológica ou patológica persistente após tratamento conservador, em qualquer idade, e que apresente uma das seguintes complicações:

Infecções urinárias de repetição;

Balanopostite recorrente; Sangramento

pelo orifício prepucial;

Retenção urinária crônica (formação de balão que necessita ser reduzido manualmente);

Ereção dolorosa.

Balanite xerótica obliterante (dermatite atrófica crônica caracterizada por tecido cicatricial esbranquiçado).

Obs.: A maioria dos meninos nasce com fimose, sendo a condição considerada fisiológica até os cinco anos de idade. Não é necessário encaminhar para intervenção cirúrgica todos os pacientes com fimose fisiológica. O tratamento conservador inicial pode ser realizado

inicialmente na APS a partir dos dois anos de idade. Casos que persistem com fimose fisiológica podem ser encaminhados de acordo com a preferência do paciente ou dos pais por motivos individualizados (cultural e religioso).

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Descrição do quadro clínico associado à fimose - infecção urinária recorrente (sim ou não). Se sim, quantos episódios no último ano; balanopostite recorrente (sim ou não). Se sim, quantos episódios no último ano; sangramento pelo orifício prepucial (sim ou não); presença de retenção urinária crônica (sim ou não); presença de placa ou cicatriz no pênis (sim ou não); outros sinais e sintomas associados.

Tratamento realizado para fimose (descreva tratamento realizado e duração).
Classificação de kayaba

Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Episódio de obstrução urinária aguda em paciente com hiperplasia prostática benigna.

2-Encaminhar ao Urologista:

Doença renal crônica associada à obstrução prostática (hidronefrose e/ou volume residual pós miccional maior que 300 ml e/ou globo vesical); ou

HPB com episódio de obstrução urinária aguda (após avaliação na emergência); ou

HPB e infecção urinária recorrente (ver protocolo Infecção Urinária Recorrente); ou

Sintomas do trato urinário inferior (jato urinário fraco ou intermitente, esforço, esvaziamento incompleto, polaciúria, urgência/incontinência, noctúria) refratário ao tratamento clínico otimizado (uso de medicamento alfa-bloqueador por pelo menos 30 dias em doses usuais - doxazosina 4 mg/dia - e, nos casos de próstata maior que 40 g ou PSA total maior que 1,4 ng/ml, uso concomitante de inibidor da 5-alfa redutase - finasterida 5 mg/dia - por pelo menos 6 meses).

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e/ou sintomas (tempo de início, histórico de retenção urinária, descrição de toque

retal com tamanho estimado da próstata, consistência, presença de assimetria ou nódulo);

Tratamento em uso ou já realizado para sintomas urinários (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso);

Resultado do exame de PSA total, com data;

Resultado de exame de creatinina sérica, com data;
Cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de Filtração Glomerular;
Resultado de ecografia abdominal ou vias urinárias ou próstata, com data.

Incontinência Urinária

1- Encaminhar ao Urologista:

Incontinência urinária sem resposta ao tratamento clínico otimizado por 3 meses (exercícios para músculo do assoalho pélvico, treinamento vesical e intervenções no estilo de vida - perda de peso quando necessário, diminuição ingesta de cafeína/álcool).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Descrição do exame pélvico (presença e grau de prolapso);

Resultado do estudo urodinâmico, com data (se disponível);

Tratamento em uso ou já realizado para incontinência urinária (medicamentos utilizados com dose e posologia);

Outros medicamentos em uso que afetam a continência urinária (sim ou não). Se sim, quais?

Infecção Urinária Recorrente

1- Encaminhar ao Urologista:

Alteração anatômica no trato urinário que provoque ITU recorrente (três ou mais infecções urinárias no período de um ano).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Número de infecções urinárias nos últimos 12 meses;

Resultado de exame de creatinina sérica, com data;

Cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de Filtração Glomerular;

Resultado de ecografia das vias urinárias, com data;

Descrever se foi realizado profilaxia para infecção urinária recorrente e como foi feita (medicamento, dose e posologia);

Em mulheres, descrever se há alterações anatômicas como cistocele, retocele ou prolapso uterino;

Infertilidade Masculina

1- Encaminhar ao Urologista:

Homem com varicocele clínica associada à oligospermia; ou

Homem com azoospermia ou outras alterações em espermograma que deseja realizar investigação etiológica para infertilidade; ou

Homem que deseja reversão de vasectomia.

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Casal está tentando gestar (sim ou não). Se sim, descreva há quanto tempo;

História de filhos prévios, distúrbios de ereção ou ejaculação, presença de varicocele clinicamente identificada ou realização de vasectomia prévia;

Resultado de espermograma, com data (se realizado);

Litíase Renal

1- Encaminhar ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro: Através de solicitação de internação via Regulação Municipal (SISREG) :

Litíase renal com obstrução de trato urinário provocando hidronefrose, sepse urinária e/ ou dor incontrolável com tratamento otimizado na APS.

2-Encaminhar ao Urologista:

Cálculo ureteral maior que 10 mm; ou

Cálculo ureteral maior que 4 mm que não foi eliminado após 6 semanas de tratamento clínico; ou

Cálculo vesical; ou

Cálculo renal sintomático (episódios recorrentes de dor, hematúria ou infecção trato urinário); ou

Cálculo renal assintomático maior que 10 mm.

3-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas;

Resultado de ecografia urinária ou raio-X, com data;

Resultado de exame de creatinina sérica, com data;

Cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de Filtração Glomerular;

Tratamentos em uso ou já realizados para litíase renal;

Investigação de causas tratáveis de litíase renal (sim ou não). Se sim, descrever achados nos exames séricos e de eletrólitos da urina de 24 horas;

Neoplasia da Próstata

1- Encaminhar ao Urologista:

Neoplasia em biópsia prostática; ou

Suspeita clínica (toque retal suspeito com nódulo, endurecimento ou assimetria); ou

Pacientes com sintomas de trato urinário inferior e PSA total elevado para sua idade. Nesses casos excluir aumento por infecção urinária ou prostatite e, se infecção, repetir PSA total após um mês do tratamento; ou

Pacientes assintomáticos com idade inferior ou igual a 75 anos e PSA total maior ou igual a 10 ng/ml; ou

Pacientes assintomáticos com idade inferior ou igual a 75 anos e PSA total menor do que 10 ng/ml persistentemente elevado para sua idade (repetir PSA total após 1 mês).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (incluir descrição do toque retal com tamanho estimado da próstata, consistência, presença de assimetria ou nódulo);

Resultado de biópsia prostática, se realizada;

Resultado de PSA total, com data (se PSA total < 10 ng/mL em paciente assintomático ou com sintomas de infecção urinária / prostatite, descreva dois exames com intervalo mínimo de um mês);

Resultado de EAS, com data.

Varicocele

1- Encaminhar ao Urologista:

Varicocele associada a:

Testículo ipsilateral diminuído; ou

Espermograma com parâmetros alterados; ou

Sintomas (dor ou desconforto).

2-Dados que devem conter no encaminhamento:

Sinais e sintomas (incluir tempo de evolução, frequência, alteração em volume testicular, varicocele unilateral ou bilateral);

Descrição da ecografia escrotal, com data;

Descrição de ecografia ou tomografia de abdômen total (se realizada para pacientes com varicocele unilateral direita), com data;

Descrição do espermograma, com data (se realizado).

PARTE II

Todo especialista pode solicitar exames de imagem pertinentes a sua especialidade.

EXAMES DE IMAGEM
Angioressonância
1- Indicações: Investigação de doença ateromatosa extracraniana - estudo das artérias carótidas; Estudo de vasos - mesentérica superior, artéria ilíaca e femural; Estudo das doenças estenóticas e oclusivas das artérias cervicais, arco aórtico, e aneurisma da aorta abdominal e torácica; Hipertensão arterial grave ou forte suspeita de origem renal. **2-Dados que devem constar na solicitação do exame:** Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10; Descrever o resultado de ecografia com doppler se realizado. **3-Profissionais que podem solicitar:** Cardiologista; Cirurgião Cardíaco; Cirurgião Torácico; Cirurgião Vascular; Nefrologista.
Angiotomografia
1- Indicações: (mesmo código da tomografia geral, especificando local, com descrição do procedimento constando Angiotomografia Embolia Pulmonar (suspeita); Dilatação, dissecção, fístulas e sub-oclusão de aorta, ilíacas, carótidas e vasos supra-aórticos;

Doenças da aorta;

Estenose artérias renais.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-x (se patologias pulmonares) e ecografia com doppler de vasos se houver.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Cirurgião Vascular;

Intensivista;

Pneumologista.

Audiometria Tonal Limiar / Logoaudiometria / Imitanciometria

02.11.07.020-3 - IMITANCIOMETRIA
02.11.07.021-1 - LOGOAUDIOMETRIA (LDV-IRF-LRF)
02.11.07.004-1 - AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)

1- Indicações:

Deficiência auditiva;

Surdez;

Otalgia;

Pacientes exposto a volumes de 85 decibéis;

Otorreia.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Médicos do PSF;

Otorrinolaringologista.

Broncoscopia

02.09.04.001-7 - BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA)

1- Indicações:

Tumores (diagnóstico e estadiamento);

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião torácico;

Pediatra;

Pneumologista.

Cateterismo Cardíaco

02.11.02.001-0 - CATETERISMO CARDÍACO

1- Indicações:

Identificação da natureza e a gravidade do defeito mecânico;

Indicação de terapêutica cirúrgica;

Visualização das artérias coronarianas;

Pós-operatório em caso de sintomas residuais;

Avaliar o funcionamento de prótese valvular;

Avaliar lesão residual do miocárdio ventricular;

Pesquisa de lesões valvares;

Múltiplos êmbolos pulmonares;

Avaliar presença de lesões potencialmente suscetíveis de curas cirúrgicas - insuficiência mitral, coronariopatia, pericardite constritiva, estenose subaórtica hipertrófica;

ECG com presenças de áreas extensas de comprometimento;

Cintilografia com lesão isquêmica;

Angina após revascularização;

Correção cirúrgica de defeitos valvares em pacientes acima de 40 anos (avaliação de doença coronária concomitante).

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de ECG, raio-x de tórax, ecocardiograma; teste ergométrico; cintilografia do miocárdio; ecocardiograma de estresse.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Cirurgião Cardiovascular.

Cintilografia da Tireoide com/ sem Captação

02.08.03.002-6 - CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE COM OU SEM CAPTAÇÃO

1- Indicações:

Distúrbios funcionais da tireoide e paratireoide;

Tireóide ectópica;

Tumores e nódulos;

2- Hipertireoidismo tipo Graves e Plumer;

Carcinoma diferenciado tireoidiano;

Tireoidite;

Lesões suspeitas;

Tratamento hormonal.

3 - Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de exames laboratoriais e USG.

4- Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral;

Endocrinologista;

Oncologista.

Cintilografia do Corpo Todo

02.08.03.004-2 - CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO

1- Indicações:

Tumores;

Metástases;

Osteomielite;

Necroses ósseas;

Fratura de estresse;

Avaliar integridade de próteses articulares;

Dores ósseas;

Doença de Paget.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de TC (se houver).

3-Profissionais que podem solicitar:

Endocrinologista;

Infectologista;

Oncologista;

Ortopedista.

Cintilografia do Miocárdio com / sem Captação

1- Indicações:

Isquemia;

Quantificação de fluxos anômalos;

Alterações da contratilidade miocárdica;

Diferenciação entre isquemia miocárdica e necrose miocárdica;

Coronariopatias;

Pacientes em quimioterapia cardiotóxica;

Pós-infarto agudo do miocárdio;

Avaliação da função biventricular global;

Avaliar isquemia em pacientes com incapacidade ao teste de esforço;

Avaliar isquemia em pacientes com alterações no eletrocardiograma que interfiram no teste de esforço (bloqueio de ramo esquerdo; hipertrofia de ventrículo esquerdo; síndrome de Wolff-Parkinson-White).

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de eletrocardiograma; ecocardiograma e teste ergométrico (se realizado).

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Cirurgião cardíaco;

Cirurgião cardiovascular;

Hemodinamicista.

Cintilografia Renal Qualitativa e/ou Quantitativa

02.08.04.005-6 - CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA)

1- Indicações:

Verificar função dos rins;

Hipertensão renovascular;

Avaliar cicatrizes remanescentes de infecções renais;

Quantificar funcionalidade do córtex renal;

Avaliar envolvimento renal de tumores;

Avaliar diagnóstico diferencial entre tumor e hipertrofia da coluna de Bertin;

Avaliar refluxo vesico-uretral.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de exames laboratoriais e de ultrassonografia de rins e vias urinárias.

3-Profissionais que podem solicitar:

Nefrologista;

Oncologista;

Urologista.

Colonoscopia

02.09.01.002-9 - COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)
- (ver formulário) *ANEXO XII -FORMULÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA*

1- Indicações:

Rastreio de câncer de cólon e reto, em pacientes entre 50 e 75 anos, após realização de pesquisa de sangue oculto nas fezes;

Neoplasia maligna do cólon;

Neoplasia maligna da junção retossigmoideana;

Neoplasia maligna do reto;

Neoplasia maligna do ânus e do canal anal;

Neoplasia benigna do cólon, reto, canal anal e ânus;

Doença de Crohn;

Colite Ulcerativa;

Doença diverticular do intestino grosso sem perfuração ou abscesso;

Constipação;

Megacólon não classificado em outra parte;

Fissura e fístula das regiões anal e retal;

Pólipo anal;

Pólipo retal;

Pólipo do cólon;

Mau funcionamento de colostomia/enterostomia;

Incontinência fecal;

Alteração do hábito intestinal;

Ileostomia;

Colostomia.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultados de exames laboratoriais, especialmente sangue oculto nas fezes.

3-Profissionais que podem solicitar:

Médicos do PSF e especialistas.

OBS: para pacientes com idade superior a 60 anos e que possuem comorbidades, deve constar em anexo o risco cirúrgico pronto.

O mesmo é composto por: hemograma, ureia, creatinina, coagulograma, hemoglobina glicada, Raio X tórax AP/P, eletrocardiograma e APAC de solicitação para risco cirúrgico (cardiologista).

Densitometria Óssea

1- Indicações:

Fratura não traumática;

Hiperparatireoidismo;

Insuficiência renal crônica;

Endocrinopatias com suspeita de perda de massa óssea;

Evidências radiológicas de osteopenia;

Síndromes de Imobilidade;

Uso crônico de corticoide;

IMC < 19kg/m2;

Terapia de reposição hormonal;

Osteoporose (seguimento);

Mulheres acima de 65 anos;

No hipoestrogenismo, caso apresente fatores de risco;

Síndromes de má-absorção;

Mulheres peri e pós menopausa (com um fator de risco maior ou 2 menores);

Homens acima de 70 anos.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultados dos exames laboratoriais;

Descrever resultados de raio-X simples nos casos de fraturas/cifose/osteopenia.

3-Profissionais que podem solicitar:

Endocrinologista;

Geriatra;

Ginecologista;

Reumatologista

Ortopedista.

4-Outras recomendações:

Nos casos de resultado normal é necessário um intervalo de três anos para repetição do exame;

Para detectar perdas ósseas de 2% a 3% (a média da diminuição da massa óssea anual em mulheres em climatério) é necessário um intervalo de um a dois anos.

Ecocardiografia com Estresse

1- Indicações:

Cardiopatias isquêmicas;

Pesquisa de viabilidade miocárdica.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raios-X simples de tórax;

Descrever resultado de eletrocardiograma;

Descrever resultado de Ecocardiografia doppler.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista.

4-Outras recomendações:

Na indicação do exame com estresse, considerar que a infusão do fármaco (p. ex. a dobutamina) durante o exame poderá acarretar o surgimento de dor torácica, arritmias cardíacas transitórias ou elevação da pressão arterial. Palpitações são relativamente comuns;

O exame ecocardiográfico utiliza-se de recursos bidimensionais com dopplervelocimetria.

Ecocardiografia Transesofágico

1- Indicações:

Cardiopatias isquêmicas;

Avaliação de valvulopatias.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raios-X simples de tórax;

Descrever resultado de eletrocardiograma;

Descrever resultado de ecocardiografia doppler.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista.

Ecocardiografia Transtorácica

1- Indicações:

Cardiopatias congênitas;

Insuficiência cardíaca em pacientes com achados clínicos de maior gravidade e nos que não melhoram com as intervenções terapêuticas iniciais;

Lesões valvulares;

Acompanhamento de próteses valvulares.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raios-X simples de tórax;

Descrever resultado de eletrocardiograma.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Cirurgião cardiovascular;

Geriatra;

Pediatra.

Eletroencefalograma

1- Indicações:

Convulsão maior, menor e focal;

Crise de ausência;

Narcolepsia;

Demências;

Doença de Alzheimer.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Geriatra;

Pediatra;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Psiquiatra.

Médico do PSF/ESF (Atenção Primária à Saúde - APS)

Eletroneuromiografia

02.11.05.006-7 - ELETROMIOGRAMA (EMG)

1- Indicações:

Doenças da junção neuro-muscular;

Miopatia / Distrofia Muscular;

Mononeuropatias;

Plexopatias;

Radiculopatias;

Neuropatias;

Polirradiculoneuropatia;

Polineuropatia/ Mononeuropatia múltipla.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica com sintomas a pelo menos 21 dias, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Anexar formulário de solicitação de eletroneuromiografia para assinalar alterações sensitivas

3-Profissionais que podem solicitar:

Infectologista;

Médico do PSF;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Ortopedista;

Reumatologista.

4-Outras recomendações:

Os pedidos de cada segmento devem ser realizados separadamente;

Exame absolutamente contraindicado para pacientes com marca-passo.

Endoscopia Digestiva Alta

02.09.01.003-7 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
(ver formulário) ANEXO XII -FORMULÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

1- Indicações:

Esofagite;

Complicações do refluxo gastroesofágico (úlceras, estenose péptica e esôfago de Barrett);

Tumor / Metástases;

Varizes esofagianas;

Úlcera gástrica / duodenal;

Sinais de alerta - melena, vômitos persistentes, disfagia, odinofagia, hematêmese, anemia e perda de peso involuntária maior que 5%;

Dispepsia persistente, refratária ao tratamento clínico e farmacológico por 30 dias, ou evidência de piora dos sintomas;

Dispepsia em pacientes maiores de 50 anos ou com maior risco de câncer gástrico, sem melhora ao tratamento clínico.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame: Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever os resultados de exames realizados durante a investigação do caso, se houver.

3-Profissionais que podem solicitar:

Médicos do PSF e especialistas

OBS: para pacientes com idade superior a 60 anos e que possuem comorbidades, deve constar em anexo o risco cirúrgico pronto.

O mesmo é composto por: hemograma, ureia, creatinina, coagulograma, hemoglobina

glicada, Raio X tórax AP/P , eletrocardiograma e APAC de solicitação para risco cirúrgico (cardiologista).

Espirometria

02.11.08.005-5 - ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR

1- Indicações:

Pacientes sujeitos a riscos inalatórios no trabalho;

Acompanhamento trimestral de doenças intersticiais difusas crônicas;

Pacientes com sibilância ou aperto no peito recorrente, para confirmar o diagnóstico diferencial de asma;

Diagnóstico e acompanhamento anual de DPOC;

Cumprimento do protocolo de solicitação de medicamentos de alto custo da Secretaria de Estado, no acompanhamento de asma persistente e grave, quando mudanças no tratamento.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X de tórax, se houver.

3-Profissionais que podem solicitar:

Alergista;

Médicos do PSF;

Pediatra;

Pneumologista.

Laringoscopia Direta (Nasofibroscopia

1- Indicações:

Anomalias congênitas de laringe;

Estenose subglótica congênita ou adquirida;
Disfonia persistente;

Tumores;

Impossibilidade de realização da laringoscopia indireta;

Granulomas / pólipos de cordas vocais;

Disfagia;

Epistaxe de repetição.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Pediatra;

Otorrinolaringologista.

Mamografia

02.04.03.003-0 - MAMOGRAFIA (**APAC E SISCAN SISTEMA**)

02.04.03.018-8 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO (**SISCAN FÍSICO**)

Ver fluxo municipal de solicitação de mamografia no link

ANEXOS PROTOCOLO REGULAÇÃO

1- Indicações:

Seguimento após mastectomia, e após cirurgia conservadora;

Linfonodo regional suspeito;

Diferenciar a ginecomastia verdadeira da lipomastia;

Rotina anual para mulheres com idade igual ou superior 40 anos com fator de risco;

Rotina bianual para mulheres com idade entre 50 e 69 anos;

Para mulheres acima de 70 anos com condições clínicas que permitam a realização do exame e que nunca realizaram o exame;

Antes de iniciar Terapia de Reposição Hormonal;

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultados de ultrassonografia e mamografia prévios, se houver;

Preencher ficha SISCAN .

3-Profissionais que podem solicitar:

Ginecologista e subespecialidades;

Médicos do PSF

Excepcionalmente enfermeiros em campanhas (Carreta do Amor) para rastreio.

As solicitações de mamografia de fora do município, mantêm o mesmo fluxo interno, quando for o caso de transcrever APAC, anexar a original no sistema.

As solicitações de mamografia dos pacientes com idade de 50 a 69 anos, podem ser solicitadas por médico e enfermeiros (formulário) e entregue físico no setor de Controle, Avaliação, solicitação de mamografia abaixo de 50 anos somente em APAC gerado no sistema pelo médico.

Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA de 24 Horas)

02.11.02.005-2 - MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (M.A.P.A)

1- Indicações:

Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica Lábil ou episódica;

Avaliação de normotensos com lesões de órgão-alvo;

Avaliação de sintomas, principalmente hipotensão e síncope hipotensiva, disfunção autonômica;

Suspeita de hipertensão do “avental branco”;

Avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de eletrocardiograma;

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Geriatra;

Nefrologista.

Monitoramento pelo Sistema Holter de 24 Horas

02.11.02.004-4 - MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)

1- Indicações:

Avaliar sintomas possivelmente relacionados a arritmias;

Avaliar o risco, prognóstico e terapêutica aplicada em arritmia independente de sintomas;

Detectar e/ou avaliar a isquemia miocárdica.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de eletrocardiograma + radiografia de tórax;

Descrever resultado de ecocardiografia, nos casos suspeitos de disfunção ventricular.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Geriatra;

Nefrologista.

Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (BERA)

1- Indicações:

Detecção e identificação precoce da deficiência auditiva;

Detecção de anormalidades em nível de tronco cerebral por imaturidade, lesões degenerativas e/ou tumorais ao nível de SNC;

Indicação de aparelho de amplificação sonora individual;

Detecção de afecções de tronco cerebral que envolvem as vias auditivas;

Estadiamento do coma e diagnóstico precoce da morte cerebral;

Monitorização do tronco cerebral em cirurgia cardíaca (intra e pós-operatório).

Predição do limiar psico-acústico;

Diagnóstico diferencial de doenças otológicas.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Médicos do PSF;

Neurologista;

Neuropediatra;

Otorrinolaringologista.

Ressonância Magnética de Coluna Cervical / Torácica e Lombossacra

02.07.01.004-8 - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA
02.07.01.005-6 - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA
02.07.01.003-0 - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOÇO

1- Indicações:

Tumores ósseos primários;

Metástases;

Processos expansivos;

Hérnia de Disco;

Infecções;

Complicações pós- operatórias;

Esclerose múltipla;

Investigação de tuberculose extra-pulmonar;

Prurido braqui radial;

Notalgia parestésica.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-x simples com laudo e/ou tomografia.

3-Profissionais que podem solicitar:

Neurocirurgião;

Neurologista;

Oncologista;

Ortopedista;

Reumatologista.

Ressonância Magnética de Abdome

DESMEMBRAR:
02.07.03.001-4 - RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR
02.07.03.002-2 - RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR

1-Indicações:

Metástase hepática;

Adenoma de supra-renal;

Diferenciar tumor hepático e hemangioma;

Doenças dos ductos pancreáticos e vias biliares;

Suspeita de metástase em veia cava inferior.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever o resultado de raio-X simples de abdome e/ou ultrassonografia de abdome e/ou tomografia de abdome.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Gastroenterologista;

Ginecologista;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Oncologista;

Urologista.

Ressonância Magnética de Articulações

1- Indicações:

Traumatismos articulares;

Derrames articulares;

Fraturas ocultas;

Alterações de partes moles.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado raio-X simples com laudo e/ou ultrassonografia articular;

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Oncologista;

Ortopedista;

Reumatologista.

Ressonância Magnética de Crânio e Encéfalo

02.07.01.006-4 - RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO

1- Indicações:

Avaliar fossa cerebral posterior e tronco encefálico;

AVC de tronco cerebral;

Demência;

Tumores;

Metástases;Lesões orbitárias ou trato visual;

Infecções;

Esclerose Múltipla;

Epilepsia.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de radiografia com laudo e/ou tomografia de crânio.

3-Profissionais que podem solicitar:

Geriatra;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Neuropediatra;

Oftalmologista;

Oncologista.

Ressonância Magnética de Pelve

DESMEMBRAR:
02.07.03.002-2 - RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR
02.07.03.001-4 - RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR

1- Indicações:

Tumores;

Metástases;

Processos inflamatórios, linfoproliferativos ou indefinidos no raio-x, ultrassonografia ou tomografia.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de ultrassonografia pélvica e tomografia de pelve.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Ginecologista;

Oncologista.

Teste de Esforço / Ergométrico

1- Indicações:

Detecção de isquemia miocárdica, arritmias e distúrbios hemodinâmicos esforço-induzidos;

Avaliação da capacidade funcional, diagnóstica e prognóstica das doenças cardiovasculares;

Doença arterial coronariana;

Doença arterial coronariana crônica com modificações no quadro clínico e/ou do eletrocardiograma, desde que estáveis;

Avaliação de taquiarritmias;

Avaliação de bradiarritmias e marcapasso;

Indivíduos assintomáticos ou atletas com história familiar de doença arterial coronariana precoce ou morte súbita;

Hipertensão arterial sistêmica em investigação de doença arterial coronariana em indivíduos hipertensos com mais de 01 fator de risco;

Insuficiência cardíaca e cardiomiopatias.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de eletrocardiograma + radiografia de tórax;

Paciente hipertenso compensado.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Tomografia Computadorizada da Pelve

02.06.03.003-7 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR

1- Indicações:

Traumatismos;

Tumores;

Processos expansivos;

Metástases.

2- Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de ultrassonografia pélvica.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Endocrinologista;

Ginecologista;

Nefrologista;

Reumatologista.

Tomografia Computadorizada de Abdome Superior

02.06.03.001-0 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR

1- Indicações:

Abscessos;

Traumatismos;

Tumores;

Processos expansivos;

Ruptura de órgãos;

Metástases;

Aneurismas;

Pancreatites;

Hemorragias pós-cirurgia;

Linfonodomegalia;

Cálculo renal;

Diverticulite;

Investigar comprometimento de órgãos;

Apendicite.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X simples de abdome com laudo e/ou ultrassonografia de abdomen.

3- Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Endocrinologista;

Ginecologista;

Nefrologista;

Pediatra;

Reumatologista.

Tomografia Computadorizada de Articulações

02.06.02.001-5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR

02.06.03.002-9 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR

1- Indicações:

Traumatismos;

Tumores;

Processos expansivos;

Metástases;

Fraturas.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X de articulação com laudo.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Oncologista;

Ortopedista;

Pediatra;

Reumatologista.

Tomografia Computadorizada de Crânio e Sela Túrcica

02.06.01.006-0 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA

1- Indicações:

Traumatismo;

Hemorragias;

Tumores;

Metástases;

Processos expansivos;

AVCs;

Doenças Degenerativas do Encéfalo;

Aneurismas;

Convulsões recentes a esclarecer;

Hidrocefalia;

Cefaleia grave a esclarecer;

Distúrbio do comportamento;

Estudo da hipófise.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X simples com laudo;

Descrever resultado de exame de líquor, se doença infecciosa.

3-Profissionais que podem solicitar:

Endocrinologista;

Neurocirurgião;

Neurologista;

Neuropediatra;

Oncologista

Pediatra.

Tomografia Computadorizada de Mediastino e Pulmão

02.06.02.004-0 - TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, PULMAO OU DO MEDIASTINO

1- Indicações:

Alargamento do mediastino;

Dissecção de aneurisma;

Síndrome da compressão de veia cava superior;

Suspeita de mediastinite;

Alterações endócrinas ou metabólicas de origem mediastinal;

Estudar transição servico - torácica ou tóraco- abdominal;

Estadiamento dos tumores do esôfago e pulmão;

Rouquidão por lesão laríngeo recorrente;

Pesquisa de adenomegalia;

Pesquisa de metástases pulmonares;
Pesquisa de foco de infecção e neoplasias;

Avaliação de enfisema pulmonar para avaliação de cirurgia redutora de pulmão;

Diferenciar abscesso de empiema;

Hemoptise;

Bronquiectasias;

Trauma.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X com laudo.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral e subespecialidades;

Nefrologista;

Pneumologista;

Reumatologista.

Tomografia Computadorizada de Seios da Face

02.06.01.004-4 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES

1- Indicações:

Sinusopatia;

Trauma facial;

Pólipos mal caracterizados por raio-X de seios da face;

Tumores.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X de seios da face com laudo.

3-Profissionais que podem solicitar:

Bucomaxilofacial;

Cirurgião geral e subespecialidades;

Neurologista;

Otorrinolaringologista.

Tomografia Computadorizada de Tórax

02.06.02.003-1 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX,

1- Indicações:

Traumatismo;

Sangramentos (vias aéreas);

Tumores;

Metástases;

Nódulos não-neoplásicos;

Pneumopatias Intersticiais;

Avaliação de mediastino, hilos e pleura;

Bronquiectasias;

Síndrome de compressão da veia cava superior;

Doenças da aorta;

Tromboembolismo pulmonar;

Investigar comprometimento de órgãos devido micoses sistêmicas, colagenoses e sarcoidosis;

Fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever raio-X de tórax PA / Perfil com laudo.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cardiologista;

Cirurgião geral;

Endocrinologista;

Nefrologista;

Pneumologista;

Reumatologista;

Subespecialidades.

Ultrassonografia de Articulação

02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO

1- Indicações:

Cisto sinovial com limitação funcional;

Derrame articular;

Tendinite;

Metatarsalgias;

Lesão por esforço repetitivo;

Disfunção da articulação temporo-mandibular;

Bursite;

Pesquisa de patologias da parede abdominal.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-x simples nos casos de cisto sinovial; derrame articular e metatarsalgia.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos da SMS.

4-Outras recomendações:

Descrever o local de realização da ultrassonografia;

Para cada local do exame, uma guia deve ser solicitada.

Ultrassonografia com Doppler de Artéria Aorta Abdominal

1- Indicações:

Suspeita de aneurisma;

Avaliar enxerto pós-cirúrgico;

Hipertrofia prostática benigna.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Ultrassonografia com Doppler de Artérias dos Membros Inferiores

1- Indicações:

Sinais clínicos de aterosclerose obliterante periférica;

Aneurisma das artérias dos membros inferiores;

Avaliação de enxerto pós-cirurgia.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Para cada local do exame, uma guia deve ser solicitada.

Ultrassonografia com Doppler de Artérias dos Membros Superiores

1- Indicações:

Síndrome de compressão da subclávia;

Sinais clínicos de aterosclerose obliterante periférica;

Sequela de traumatismo com sinais ou sintomas de pressão ou lesão vascular;

Má formação arteriovenosa;

Hemangioma.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Para cada local do exame, uma guia deve ser solicitada.

Ultrassonografia com Doppler de Artérias Renais

1- Indicações:

Hipertensão renovascular;

Tumores renais e suprarrenais;

Avaliação e acompanhamento de transplante renal;

Avaliação de recém-nascido com diagnóstico de hidronefrose antenatal.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos especialistas.

Ultrassonografia com Doppler de Veias dos Membros Inferiores

02.05.01.004-0 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS

1- Indicações:

Avaliação de refluxo envolvendo território da veia safena magna e/ou parva;

Localização de perfurantes incompetentes;

Avaliação de casos de anomalias vasculares;

Investigação de trombose venosa profunda prévia e de insuficiência valvular;

Trajetos varicosos maiores que 3 mm de diâmetro (classe 2CEAP) para planejamento cirúrgico;

Esclarecimento diagnóstico de edema sem outros sinais de insuficiência venosa crônica;

Avaliação de varizes recidivadas.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Realizar apac para cada segmento solicitado. Definir direita e/ou esquerda, superior e/ou inferior.

Ultrassonografia com Doppler de Veias dos Membros Superiores

02.05.01.004-0 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS

1- Indicações:

Síndrome de compressão da subclávia;

Sinais clínicos de aterosclerose obliterante periférica;

Sequela de traumatismo com sinais ou sintomas de pressão ou lesão vascular;

Má formação arteriovenosa;

Hemangioma.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Realizar apac para cada segmento solicitado. Definir direita e/ou esquerda, superior e/ou inferior.

Ultrassonografia da Próstata Via Abdominal

02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL

1- Indicações:

Prostatismo com exame digital prostático alterado na suspeita de carcinoma de próstata e/ou hipertrofia prostática benigna.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Ultrassonografia de Abdome Superior

02.05.02.003-8 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR

1- Indicações:

Hepatopatias;

Esplenopatias;

Patologias das vias biliares;

Pancreatopatias.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X nos casos do retroperitônio.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Excluir verminoses, meteorismos e constipação intestinal crônica.

Ultrassonografia de Abdome Total

02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL

1- Indicações:

Lesões tumorais palpáveis;

Aneurismas;

Orientar biópsia para punção de lesões tumorais;

Pesquisa de má formação de vísceras;

Suspeita de líquidos em cavidade;

Estudo do retroperitônio.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever resultado de raio-X nos casos do retroperitônio.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Excluir verminoses, meteorismos e constipação intestinal crônica.

Ultrassonografia de Aparelho Urinário

02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO

1- Indicações:

Suspeita de tumores vesicais e renais e suprarrenais;

Pesquisa de má formação do aparelho urinário;

Insuficiência renal;

Rim policístico;

Suspeita de nefrolitíase;

Classificação das disfunções miccionais.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Ultrassonografia de Bolsa Escrotal

02.05.02.007-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL

1- Indicações:

Aumento da bolsa escrotal em adultos;

Tumorações palpáveis;

Cistos de cordão, espermático e de epidídimo;

Suspeita de criptorquidia em crianças com idade superior a um ano.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Ultrassonografia de Tireoide

02.05.02.012-7 - ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE

1- Indicações:

Tumoração palpável;

Aumento do volume cervical anterior;

Suspeita de paratireoideopatias;

Para guiar procedimento invasivo.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Ultrassonografia Mamária

02.05.02.009-7 - ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA

1- Indicações:

Diferenciar e caracterizar nódulos sólidos e cistos identificados pelo exame clínico;

Avaliação de mamografias alteradas;

Estadiamento do câncer de mama;

Caracterizar assimetrias locais que podem corresponder a nódulos;

Avaliar a resposta à quimioterapia neo-adjuvante;

Avaliar nódulos palpáveis em mamas radiologicamente densas;

Orientar procedimentos intervencionistas na mama;

Pesquisar abscessos nas mastites;

Avaliar pacientes jovens, gestantes ou lactantes com alterações clínicas na mama;

Analisar implantes mamários.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico das mamas, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia e/ou mamografia prévia, se houver.

Ultrassonografia Obstétrica Morfológica com Doppler

1- Indicações:

Alterações do líquido amniótico (aumento ou diminuição);

Incompatibilidade ABO / Rh, com coombs indireto positivo;

História pregressa de má formação congênita e/ou aneuploidia;

Suspeita de infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus);

Gestação múltipla;

Idade materna maior que ou igual a 35 anos;

Idade paterna maior ou igual a 55 anos;

Uso de drogas teratogênicas.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10;

Descrever DUM e idade gestacional.

3-Profissionais que podem solicitar:

Ginecologista obstetra.

Ultrassonografia Pélvica Ginecológica

02.05.02.016-0 - ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)

1- Indicações:

Investigação de tumoração pélvica;

Suspeita de malformação no trato geniturinário;

Amenorreia primária na impossibilidade de realização de ecografia transvaginal;

Sangramento genital pós-menopausa, em mulheres sem sexarca ou com vaginas atrofiadas.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3- Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

Ultrassonografia Transfontanela

02.05.02.017-8 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA

1- Indicações:

Investigação de malformações congênitas;

Detecção de lesões encefálicas mais comuns no neonato (hemorragias intracranianas e lesões hipóxico-isquêmicas);

Investigação de infecções congênitas e adquiridas;

Investigação de tocotraumatismos;

Controle de hidrocefalia.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico (perímetro cefálico e DNPM), hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Pediatra;

Neuropediatra.

Ultrassonografia Transvaginal

02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL

1- Indicações:

Sangramento uterino anormal na menacme;

Tumores e cistos ovarianos pré e pós-menopausa;

Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos com diâmetro menor que 10 cm ao exame ginecológico ou ecografia prévia;

Sangramento genital pós-menopausa;

Amenorreia primária;

Dor pélvica crônica;

Seguimento para mulheres em uso de TRH;

Amenorreia secundária não relacionada à gravidez.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico (especular), hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Todos os médicos.

4-Outras recomendações:

Nos casos de sangramento uterino anormal, excluir uso irregular de anticoncepcional hormonal e drogas que interfiram na absorção do mesmo;

Nos casos de dor pélvica crônica, excluir as causas infecciosas.

Uretrocistografia Miccional

1- Indicações:

Nefropatia de refluxo;

Lesão medular;

Pré-operatório de transplante renal;

Lesões obstrutivas da bexiga ou uretra;

Lesões traumáticas do trato urinário inferior.

2-Dados que devem constar na solicitação do exame:

Descrever história clínica, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10.

3-Profissionais que podem solicitar:

Cirurgião geral;

Cirurgião pediátrico;

Nefrologista;

Urologista.

4-Outras recomendações:

Descrever resultado de ultrassonografia prévia, se houver.

O médico regulador tem autonomia para tomar decisões sobre a aceitação ou negação de solicitações de atendimento, mesmo que os pré-requisitos não estejam explicitamente listados nas diretrizes ou protocolos. Esse poder é importante porque, é impossível listar todas as condições de saúde e situações específicas em um único protocolo, especialmente considerando a diversidade dos prestadores de serviços e suas políticas individuais.

A autonomia do médico regulador se justifica pela necessidade de flexibilidade na gestão de casos e na adaptação às particularidades de cada paciente e situação clínica. O médico regulador deve considerar o modelo de encaminhamento baseado na especialidade requerida e levar em conta os níveis de prevenção em saúde, incluindo a prevenção quaternária, que busca evitar intervenções médicas desnecessárias ou prejudiciais.

Em resumo, a decisão do médico regulador é baseada na melhor prática médica, na necessidade clínica do paciente e nas políticas de atendimento vigentes, sempre buscando equilibrar a precisão da regulamentação com a flexibilidade necessária para atender a casos complexos ou não previstos explicitamente nos protocolos.

A prescrição de medicação de alto custo, após falha terapêutica com os medicamentos disponibilizados pelo REMUME tem início do processo estritamente pelo profissional especialista, podendo posteriormente as renovações das receitas serem realizadas pelo médico da Unidade de Saúde.

Link para anexos do Protocolo Municipal de Regulação

ANEXOS PROTOCOLO REGULAÇÃO

https://drive.google.com/drive/folders/1OhnrZgebsebbcZIQj4r2ka92E-WvuIYt?usp=sharing

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BRASIL. Município de Lucas do Rio Verde. Decreto nº 6.327, de 2023. Institui o protocolo de regulação do acesso à rede de atenção especializada ambulatorial, conforme especifica e dá outras providências. Lucas do Rio Verde, MT, 2023. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2023/633/6327/decreto-n-6327-2023 . Acesso em: março, 2023.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. Diretrizes para a implantação de complexos reguladores / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. – 2.ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 56 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 6) ISBN. Acesso em: março, 2023.

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Cardiologia Adulto: versão digital 2022. Porto Alegre: TelessaúdeRS - UFRGS, 20 jan. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Protocolos de encaminhamento para Cirurgia Geral Adulto. Porto Alegre: Telessaúde RSUFRGS, 07 dez. 2020. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

5. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS). Protocolos de encaminhamento para cirurgia vascular. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 2020. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/. Acesso em: março, 2023.

6. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial - Dermatologia Adulto: versão digital 2022. Porto Alegre:

TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

7. Brasil. Ministério da Saúde. Endocrinologia adulto [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 21 p. : il. – (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada ; v. 1). Acesso em: março, 2023.

8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Endocrinologia Adulto: versão digital 2021. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 10 dez 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

9. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Gastroenterologia versão digital 2016. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 10 dez 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

10. Brasil. Ministério da Saúde. Ginecologia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 22 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 2). Acesso em: março, 2023.

11. Protocolos de Regulação Ambulatorial: ginecologia / Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. TelessaúdeRS. – Porto Alegre: UFRGS, 2017. 20 p. ISBN 978-85-9489-052-8 (versão eletrônica). Acesso em: março, 2023.

12. Brasil. Ministério da Saúde. Hematologia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 33 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 8) Modo de acesso: World Wide Web ISBN. Acesso em: março, 2023.

13. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina.

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Hematologia versão digital 2016. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 10 dez 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

14. Brasil. Ministério da Saúde. Hematologia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 33 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 8) Modo de acesso: World Wide Web ISBN. Acesso em: março, 2023.

15. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL.

16. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Hematologia versão digital 2016. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 10 dez 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023. 15.

17. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual Técnico para Profissionais de Saúde : DIU com Cobre TCu 380A / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 32 p. : il. ISBN. Acesso em: março, 2023.

18. Secretaria da Saúde. Departamento de Assistência Integral À Saúde. Protocolo Dispositivo Intrauterino (DIU). Prefeitura de Guarulhos – SP. 07/10/2019, revisão 1, pág. 31-32. Acesso em: março, 2023.

19. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Mastologia: versão digital 2020. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

20. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS

(TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial - Nefrologia: versão digital 2018. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

21. Brasil. Ministério da Saúde. Endocrinologia e nefrologia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 1. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 20 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 1) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN. Acesso em: março, 2023.

22. Brasil. Ministério da Saúde. Neurocirurgia adulto [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022. 21 p. : il. – (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 14) Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_encaminhamento_atencao_neurocirurgia_adulto.pdf ISBN 978-65-5993-250-4. Acesso em: março, 2023.

23. Brasil. Ministério da Saúde. Neurologia adulto [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 31 p. : il. – (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 16) Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_encaminhamento_atencao_basica_neurologia.pdf ISBN 978-65-5993-237-5. Acesso em: março, 2023.

24. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial - Neurologia: versão digital 2020. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

25. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurologia Pediátrica: versão digital 2018. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

26. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 318 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, n° 32). Acesso em: março, 2023.

27. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Obstetrícia (pré-natal de alto risco): versão digital 2019. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

28. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual de Gestação de Alto Risco [recurso eletrônico] / High-risk pregnancy manual. 1ª edição – 2022 – versão preliminar. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

29. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Oftalmologia versão digital 2017. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

30. Brasil. Ministério da Saúde. Ortopedia adulto [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022. 37 p. : il. – (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada ; v. 4) Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_encaminhamento_atencao_ortopedia_adulto.pdf ISBN 978-65-5993-223-8. Acesso em: março, 2023.

31. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Ortopedia Adulto versão digital 2016. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março,

2023.

32. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Otorrinolaringologia Adulto versão digital 2018. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

33. Brasil. Ministério da Saúde. Cirurgia Torácica e Pneumologia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 31 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 5) Modo de acesso: World Wide Web ISBN. Acesso em: março, 2023.

34. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Pneumologia Adulto versão digital 2018. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

35. Brasil. Ministério da Saúde. Proctologia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 1. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 20 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 7) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN. Acesso em: março, 2023.

36. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial - Proctologia Adulto: versão digital 2021. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 26 jul. 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

37. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial - Psiquiatria Adulto: versão digital 2021. Porto

Alegre: Telessaúde RSUFRGS, 29 dez. 2021. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

38. Brasil. Ministério da Saúde. Reumatologia e Ortopedia [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – versão preliminar – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 46 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 3) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN. Acesso em: março, 2023.

39. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Reumatologia Adulto: versão digital 2022. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 20 jan. 2022. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

40. Brasil. Ministério da Saúde. Urologia[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Edição revisada – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 24 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada; v. 6) Modo de acesso: Wold Wide Web: ISBN. Acesso em: março, 2023.

41. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação Ambulatorial – Urologia Adulto: versão digital 2018. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 26 jul. 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

42. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Protocolos de encaminhamento para Urologia Pediátrica. Porto Alegre: TelessaúdeRS- UFRGS, 2020. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

43. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de PósGraduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS); RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Protocolos de Regulação

Ambulatorial – Andrologia: versão digital 2018. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS, 26 jul. 2021. (RegulaSUS). Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos. Acesso em: março, 2023.

44. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 95 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Primária, n. 29) ISBN 978-85-334-1729-8. Acesso em: março, 2023. Brasil. Ministério da Saúde. Portal Saúde Baseada em Evidências. http://periodicos.saude.gov.br. Acesso em: março, 2023.

45. Prefeitura de São Paulo. Protocolo de Regulação do Acesso da Rede de Atenção Especializada Ambulatorial. Exames de Apoio Diagnóstico. São Paulo. 2014, 1º edição. Acesso em: março, 2023.

46. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 160 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36) ISBN 978-85-334-2059-5. Acesso em: março, 2023.

47. Silva, CM; Cabral, ALS; Barros JN; Castro, AA; Santos MERC. Insuficiência venosa crônica. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. 24 de setembro de 2022 < https://amb.org.br/files/_BibliotecaAntiga/insuficiencia-venosa-cronica.pdf> Acesso em: março, 2023.

48. Cruz, MW; Scola, RH; Coelho, RLA; Carneiro, AF; Vaz C. Eletroneuromiografia na abordagem diagnóstica das Neuropatias Periféricas. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. 23 de julho de 2001 < https://amb.org.br/files/_BibliotecaAntiga/eletroneuromiografia-na-abordagem-diagnostica-das-neuropatias-perifericas.pdf> Acesso em: março, 2023.

49. Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde: Versão Profissional 2019./ Josué Souza Gleriano e Itamar Martins Bonfim (organizadores). 1ª edição. Tangará da Serra-MT: Carlini & Caniato Editorial, 2019. 192 p. ISBN 978-85-8009-267-7. Acesso em: março, 2023.

50. Governo do Distrito Federal. Protocolo de Regulação de Exames Eletivos de Endoscopia Digestiva Baixa – Colonoscopia e Retossigmoidoscopia Flexível – na rede SES/DF. Dezembro de 2019

https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/87400/Protocolo+de+Regula%C3%A7%C3%A3o+de+Exames+Eletivos+de+Endoscopia+Digestiva+Baixa+%E2%80%93+Colonoscopia+e+Retossigmoidoscopia+Flex%C3%ADvel+%E2%80%93+na+rede+SES-DF.pdf/c0ee272f-ceb0-3e52-ffb0-730fd1721b4d?t=1648647281507 Acesso em: março, 2023.

51. SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp 51. Autonomia do Médico Regulador e Protocolos de Atendimento: Brasil. Ministério da Saúde. (2013). "Diretrizes para a Regulamentação das Ações e Serviços de Saúde". Disponível em: www.saude.gov.br Brasil. Ministério da Saúde. (2012). "Manual de Procedimentos para o Atendimento de Urgências e Emergências". Disponível em: www.saude.gov.br Prevenção Quaternária: Aragonés, J. A., & Martínez-González, M. Á. (2006). "Prevenção Quaternária: A Necessidade de Evitar Intervenções Desnecessárias". Revista Española de Salud Pública, 80(5), 591-603. DOI: 10.1590/S1135-57272006000500006.

52. Guyatt, G. H., & Rennie, D. (2002). "Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice". Journal of the American Medical Association (JAMA). DOI: 10.1001/jama.288.22.2796. Protocolos e Diretrizes: Pritchard, C., & Cook, T. (2018). "Guideline Development in Health Care". Health Technology Assessment, 22(22), 1-105. DOI: 10.3310/hta22220. Levine, S. R. (2017). "Medical Protocols and Procedures". Journal of Clinical Medicine, 6(12), 123. DOI: 10.3390/jcm6120123.

53. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 212 p.: il. – Cadernos de Atenção Básica, n. 38. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesidade_cab38. pdf

54. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 212 p.: il. – Cadernos de Atenção Básica,n. 38. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesidade_cab38. pdf Acesso em: 27 de junho de 2025

55. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento

de Promoção da Saúde. Manual de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 55 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_pessoas_sobrepeso_obesidade.pdf Acesso em: 27 de junho de 2025

SUS Sistema Único de Saúde — Ministério da Saúde

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (SOLICITANTE)

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SOLICITANTE

2 - CNES

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

3 - NOME DO PACIENTE

4 - SEXO — Mas. ☐ Fem. ☐

5 - Nº DO PRONTUÁRIO

6 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)

7 - DATA DE NASCIMENTO

8 - RAÇA/COR

8.1 - ETNIA

9 - NOME DA MÃE

10 - TELEFONE DE CONTATO — DDD / Nº DO TELEFONE

11 - NOME DO RESPONSÁVEL

12 - TELEFONE DE CONTATO — DDD / Nº DO TELEFONE

13 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO)

14 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA

15 - CÓD. IBGE MUNICÍPIO

16 - UF

17 - CEP

PROCEDIMENTO SOLICITADO

18 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL	19 - NOME DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL	20 - QTDE.

PROCEDIMENTO(S) SECUNDÁRIO(S)

21 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	22 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	23 - QTDE.
24 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	25 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	26 - QTDE.
27 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	28 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	29 - QTDE.
30 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	31 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	32 - QTDE.
33 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	34 - NOME DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO	35 - QTDE.

JUSTIFICATIVA DO(S) PROCEDIMENTO(S) SOLICITADO(S)

36 - DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO	37-CID10 PRINCIPAL	38-CID10 SECUNDÁRIO	39-CID10 CAUSAS ASSOCIADAS

40 - OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO

41 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

42-DATA DA SOLICITAÇÃO

45-ASSINATURA E CARIMBO (Nº REGISTRO DO CONSELHO)

43 - DOCUMENTO ( ) CNS ( ) CPF

44 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO

46 - NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

47 - CÓD. ÓRGÃO EMISSOR

52 - Nº DA AUTORIZAÇÃO (APAC)

48 - DOCUMENTO ( ) CNS ( ) CPF

49 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

50-DATA DA AUTORIZAÇÃO

51 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)

53 - PERÍODO DE VALIDADE DA APAC — / / a / /

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (EXECUTANTE)

54 – NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EXECUTANTE

55 - CNES

SUS — Sistema Único de Saúde — Ministério da Saúde

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Identificação do Estabelecimento de Saúde

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE | 2 - CNES

3 - NOME DO ESTABELECIMENTO EXECUTANTE | 4 - CNES

Identificação do Paciente

5 - NOME DO PACIENTE | 6 - Nº DO PRONTUÁRIO

7 - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS) | 8 - DATA DE NASCIMENTO | 9 - SEXO (Masc. 1 / Fem. 3) | 10 - RAÇA/COR

11 - NOME DA MÃE | 12 - TELEFONE DE CONTATO (DDD / Nº DO TELEFONE)

13 - NOME DO RESPONSÁVEL | 14 - TELEFONE DE CONTATO (DDD / Nº DO TELEFONE)

15 - ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO)

16 - MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA | 17 - CÓD. IBGE MUNICÍPIO | 18 - UF | 19 - CEP

JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO

20 - PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS

21 - CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO

22 - PRINCIPAIS RESULTADOS DE PROVAS DIAGNÓSTICAS (RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS)

23 - DIAGNÓSTICO INICIAL | 24 - CID 10 PRINCIPAL | 25 - CID 10 SECUNDÁRIO | 26 - CID 10 CAUSAS ASSOCIADAS

PROCEDIMENTO SOLICITADO

27 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO | 28 - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

29 - CLÍNICA | 30 - CARÁTER DA INTERNAÇÃO | 31 - DOCUMENTO ( ) CNS ( ) CPF | 32 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE

33 - NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE | 34 - DATA DA SOLICITAÇÃO | 35-ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)

PREENCHER EM CASO DE CAUSAS EXTERNAS (ACIDENTES OU VIOLÊNCIAS)

36 - ( ) ACIDENTE DE TRÂNSITO

37 - ( ) ACIDENTE TRABALHO TÍPICO

38 - ( ) ACIDENTE TRABALHO TRAJETO

39 - CNPJ DA SEGURADORA | 40 - Nº DO BILHETE | 41 - SÉRIE

42 - CNPJ EMPRESA | 43 - CNAE DA EMPRESA | 44 - CBOR

45 - VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA
( ) EMPREGADO ( ) EMPREGADOR ( ) AUTÔNOMO ( ) DESEMPREGADO ( ) APOSENTADO ( ) NÃO SEGURADO

AUTORIZAÇÃO

46 - NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR | 47 - CÓD. ÓRGÃO EMISSOR | 52 - Nº DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

48 - DOCUMENTO ( ) CNS ( ) CPF | 49 - Nº DOCUMENTO (CNS/CPF) DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR

50-DATA DA AUTORIZAÇÃO / / | 51 - ASSINATURA E CARIMBO (Nº DO REGISTRO DO CONSELHO)

ANEXO VI - FLUXO DE ENCAMINHAMENTO À FISIOTERAPIA DOMICILIAR

Critérios de inclusão de pacientes na Reabilitação Fisioterapêutica Domiciliar.

A Fisioterapia Domiciliar é indicada conforme critério e dirigida aos **Acamados**: (restritos ao leito temporário ou permanente) e por isso com impossibilidade de serem encaminhados para Fisioterapia ambulatorial. Esses pacientes devem apresentar como **critérios** tais como:

1. Residir na cidade de Nova Mutum - MT em zona urbana e ser acompanhado por sua Unidade de Saúde de Origem por pelo menos 3 meses, conforme fluxo já estabelecido, para comprovar a residência no município e manter contato telefônico do paciente e família atualizado.

2. Ser paciente restrito ao leito e/ou asilado em domicílio, ou apresentar incapacidade temporária ou permanente de locomoção física;

3. Pacientes com doenças **neurodegenerativas** como Alzheimer, Parkinson, Amiotrofia Espinhal Infantil - AMEI, Esclerose Lateral Amiotrófia - ELA, Distrofia muscular de Duchenne, Doença Wohlfart- Kugelberg Welander que se incluem restrito ao leito;

4. Pacientes com doenças **respiratórias** como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) Bronquite crônica; Enfisema pulmonar; Câncer de pulmão; Doenças Cardiopulmonares; que se incluem restrito ao leito;

5. Pacientes com doenças **neurológicas** que se incluem restrito ao leito. Acidente Vascular Encefálico - TCE, Paralisia Cerebral;

6. Pacientes com necessidade do uso de oxigenoterapia e/ou Suporte Ventilatório não invasivo como (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP), Pressão Aéreas Positiva por dois Níveis (BIPAP), Concentrador de O2;

Encaminhamento (APAC) :

1. Deve conter, diagnóstico Clínico, CID. avaliação terapêutica da rede municipal SUS, informar se realizou tratamento fisioterápico para mesma condição.

2. Ter um familiar cuidador, responsável pela continuidade e realização das orientações da equipe e cuidados necessários ao paciente;

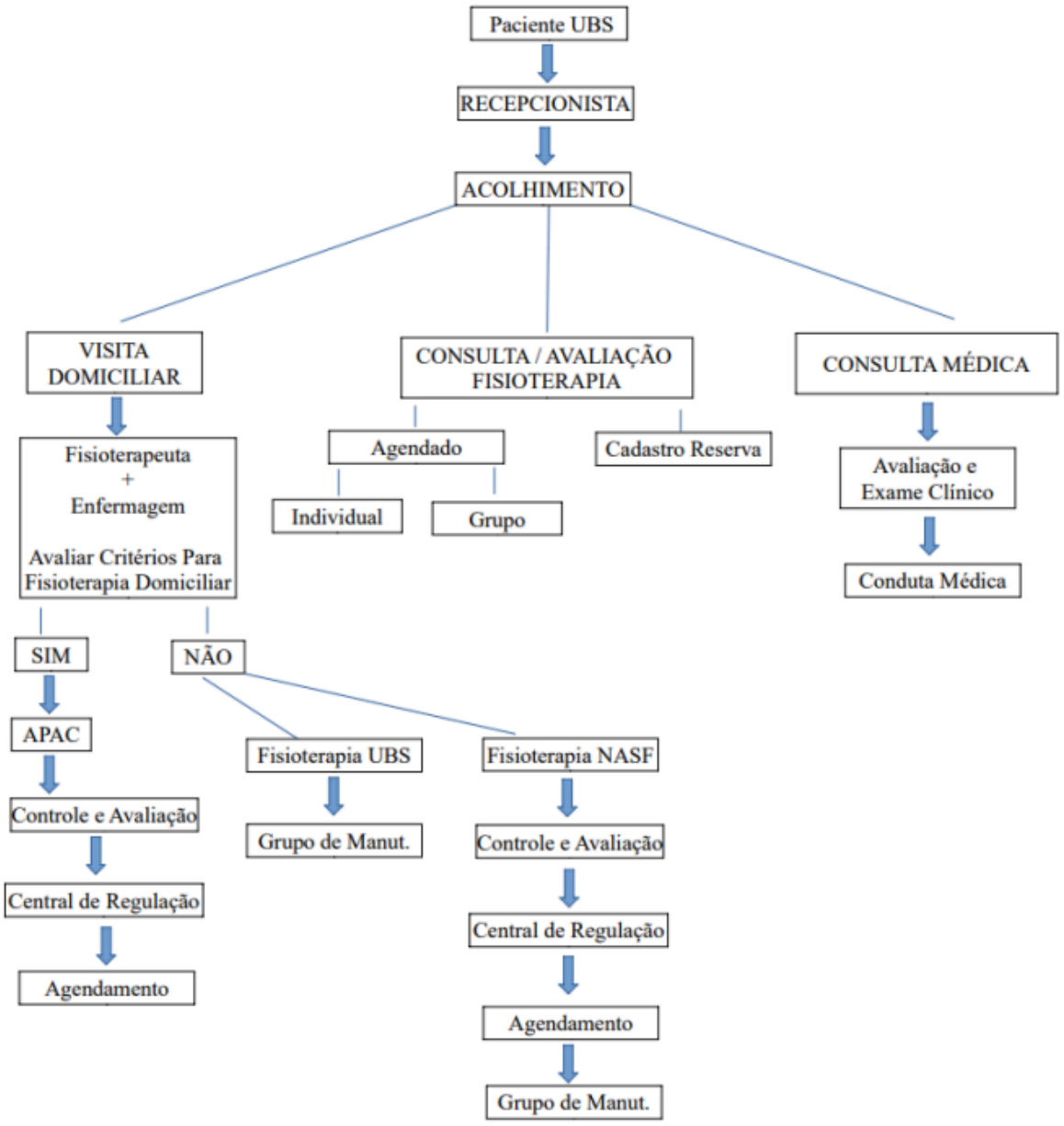
3. Os atendimentos de fisioterapia domiciliar terão duração de acordo com a avaliação realizada na 1° consulta, segundo o critério de, até no máximo 30 sessões consecutivas, para casos agudos (não permanentes);

4. As sessões variam de 1 a 2 vezes na semana, de acordo com a proposta terapêutica, sob risco de perda da vaga em caso de ausência de acompanhante e/ou desmarcar sem justificativas.

Critérios de Devolução:

1. Paciente sem diagnóstico clínico pelo profissional solicitante e sem avaliação fisioterápica, ou relatório médico detalhado da patologia atual/crônica.

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA



ANEXO VII - FLUXO DE ENCAMINHAMENTO À INSERÇÃO DE DIU

FLUXO PARA O DIU

ATENDIMENTO MÉDICO OU DE ENFERMAGEM

↓

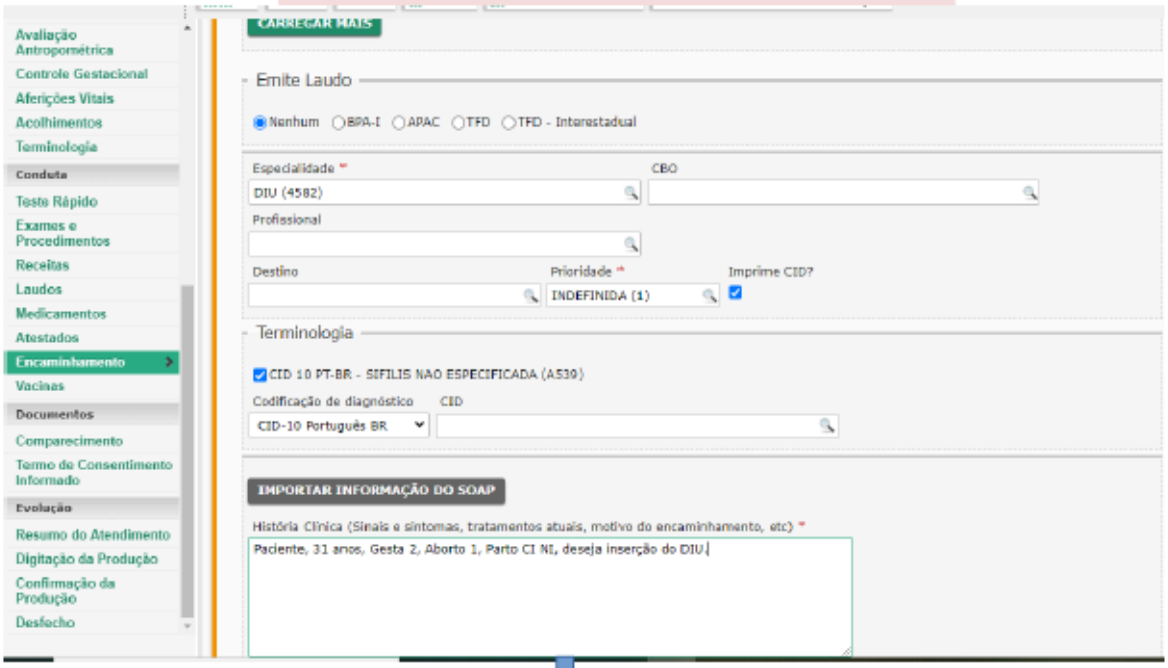
CONSULTA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR – EXPOR A PACIENTE OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO SUS.

↓

Paciente optou pelo DIU!

↓

>Realizar encaminhamento simples no GMUS, DIU.
>Solicitar BHCG com descrição: DIU para realizar 1 dia antes ou no dia do procedimento.
Conforme foto abaixo:



↓

Este Encaminhamento deve ser tratado pela Recepção com documentos em anexo e com telefone do cadastro atualizado.

↓

Equipe do DIU entrará em contato para agendar procedimento.

28 de agosto de 2023, Nova Mutum-MT
Equipe DIU – Dra Andressa Fabrizio

ANEXO VIII - FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA

FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA



Exame agendado através da Carreta do Amor.

02.04.03.018-8 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO

Aplica-se prioritariamente a mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, com periodicidade bianual.

↓

Atendimento na Unidade de saúde de origem do paciente.

↓

Solicitação feita por médico ou enfermeiro em formulário específico.

Preencher ficha SISCAN.

↓

Documento físico será entregue no Setor de Controle, Avaliação e Auditoria SUS Municipal com seus devidos anexos e posteriormente inserido no sistema.

02.04.03.003-0 - MAMOGRAFIA

Finalidade de avaliação periódica de mulheres de alto risco de câncer de mama, diagnóstico em mulheres com mamas alteradas ao exame clínico, estadiamento (avaliação da extensão de um tumor maligno já diagnosticado) e acompanhamento de doente operado de câncer de mama. Pode ser realizada unilateralmente ou bilateralmente e aplica-se a homens e mulheres, em qualquer faixa etária.

↓

Atendimento na Unidade de saúde de origem do paciente.

↓

Solicitação feita por médico, em APAC e formulário específico.

Preencher ficha SISCAN.

↓

Documento será gerado no sistema e analisado administrativamente na unidade de saúde, com história clínica completa, exame físico, hipótese diagnóstica e CID-10, para contribuir na priorização.

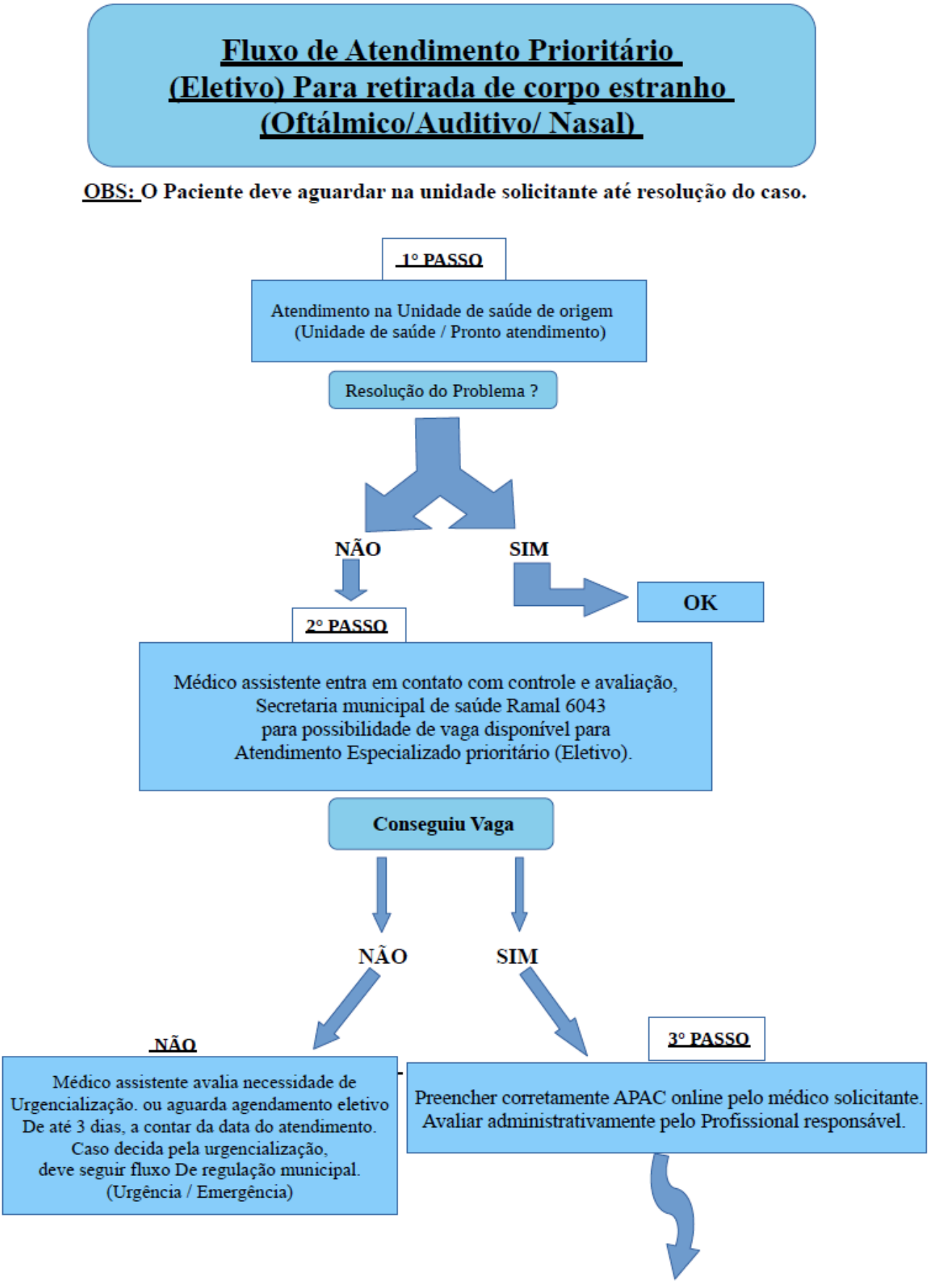
gov.br Documento assinado digitalmente CLEIDE DA SILVA Data: 04/12/2024 16:43:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fonte: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp





ANEXO IX - FLUXO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGISTA DE URGÊNCIA



4° PASSO

Médico regulador prioriza/autoriza via sistema G-MUS. Central de Agendamento
Emite guia de autorização e encaminha via e-mail á unidade solicitante.

5° PASSO

Unidade imprime a guia de autorização, e entrega ao paciente e/ou familiar.
E encaminha ao atendimento em unidade orientada pelo
Setor de controle/avaliação/agendamento.

SUS Sistema Único de Saúde

Governo de Mato Grosso

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA

ESTABELECIMENTO SOLICITANTE:_____

A-IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE:

Nome Paciente:

Sexo:_____ Data Nasc: ____/____/_____ Idade: _____ Telefones: _____

Cartão Sus:_____ CPF: _____ RG:_____

Nome Mãe: _____

Endereço: _____

Município: _____ UF: _____ CEP: _____

A – DADOS CLÍNICOS (natureza da lesão, tempo de evolução, sintomas):

_____

_____

_____

B- SINAIS SUGESTIVOS DE LESÃO NERVOSA:

1. Deficit motor (descrever a distribuição e intensidade):

_____

_____

_____

_____

2. Deficit sensitivo (descrever tipo, intensidade, distribuição). Preencher mapa no verso:

_____

_____

_____

_____

3. Segmentos a serem examinados:

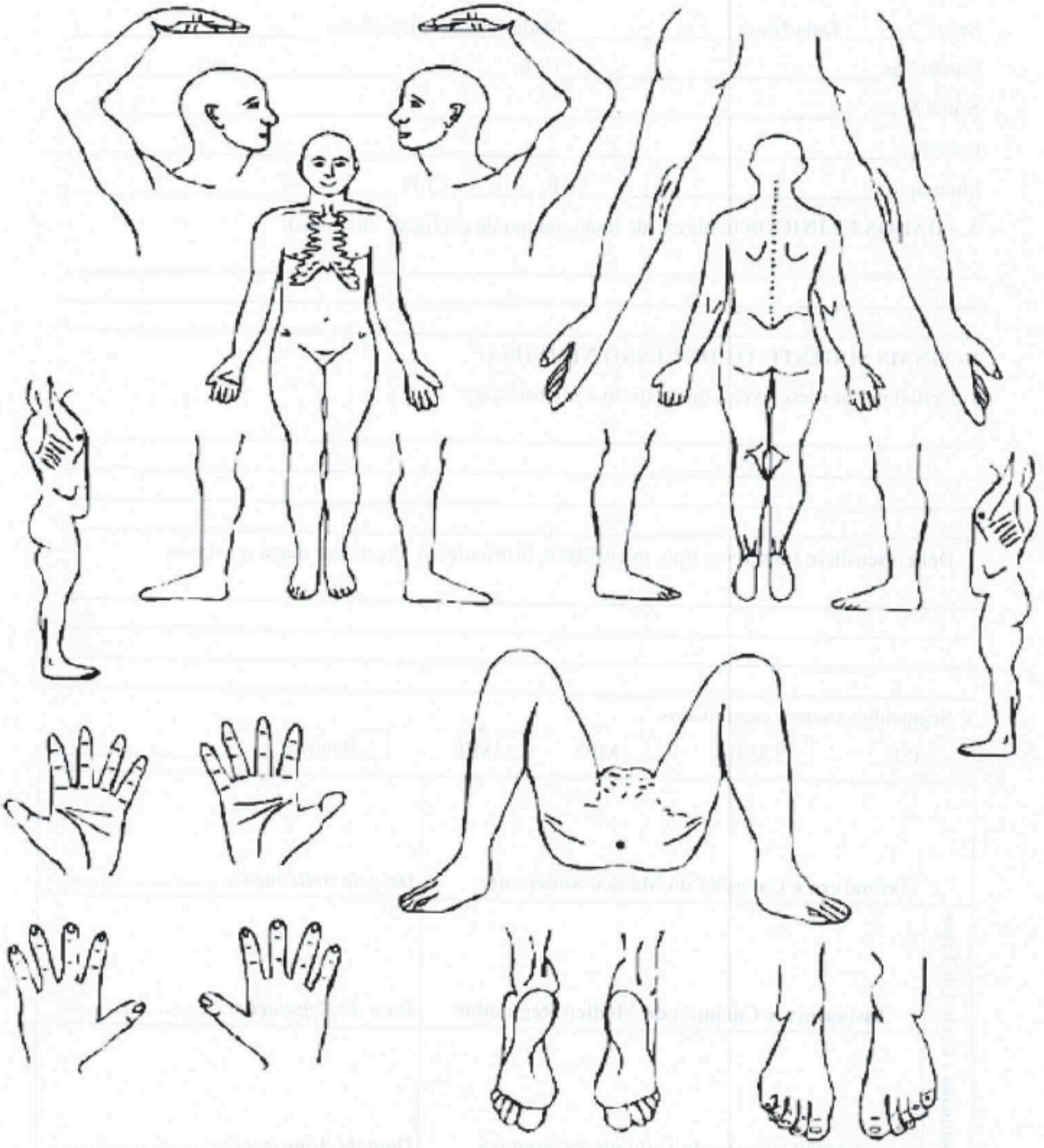
☐ MSD ☐ MSE ☐ MID ☐ MIE ☐ Outros: _____

	Assinatura e Carimbo do Médico Solicitante	***Data da Solicitação:*** *...../...../.....*
Destinado a Central de Vagas	**Assinatura e Carimbo do Médico Regulador**	***Data da Regulação:*** *...../...../.....*
	Nome/Carimbo da Unidade Prestadora	***Data da Autorização:*** *...../...../.....*

SUS Sistema Único de Saúde

Governo de Mato Grosso

Assinale as alterações sensitivas:



PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR- PTS

1)Identificação
Unidade de saúde:
Nome:
Data de Nascimento:
Endereço:
Telefone:

2)Constituição Familiar:

3)Dados Importantes:

4) Diagnóstico/Queixa:

5)Medicações em uso:

6) Intervenções já realizadas pela UBS:

7) Avaliação:

8) Plano:

_____
Assinatura do profissional

Nova Mutum, de de 2025.

Formulário para encaminhamento de Endoscopia e Colonoscopia

Orientação quanto à solicitação de risco cirúrgico e avaliação pré-anestésica para pacientes indicados à realização de endoscopia e colonoscopia.

Nome completo do paciente:	**Data de nascimento** / /

- É obrigatória a solicitação de risco cirúrgico/avaliação pré nos seguintes casos:

- Pacientes com 65 anos ou mais;
- Pacientes com comorbidades descompensadas, como:

Diabetes não controlada		
Está em uso de medicação?	☐ **Não**	☐ **Sim**
Se a resposta acima for "Sim", qual medicação? E quanto tempo de uso? _____		

Hipertensão arterial não controlada		
Está em uso de medicação?	☐ **Não**	☐ **Sim**
Se a resposta acima for "Sim", qual medicação? E quanto tempo de uso? _____		

Doenças cardíacas		
Paciente é portador de doença cardíaca?	☐ **Não**	☐ **Sim**
Se a resposta acima for "Sim", qual doença? _____ **(ex: insuficiência, arritmia)**		
Está em uso de medicação?	☐ **Não**	☐ **Sim**
Se a resposta acima for "Sim", qual medicação? E quanto tempo de uso? _____		

Doença Renal Crônica		
Está em uso de medicação?	☐ **Não**	☐ **Sim**
Se a resposta acima for "Sim", qual medicação? E quanto tempo de uso?		
_____		

Tabagismo			
É ou já foi tabagista?	☐ **Nunca fumou**	☐ **Ex- tabagista**	☐ **Tabagista atual**

Obesidade		
Paciente tem histórico de obesidade?	☐ **Não**	☐ **Sim**

Informações adicionais consideradas pertinentes pelo médico:

_____
_____
_____
_____

_____

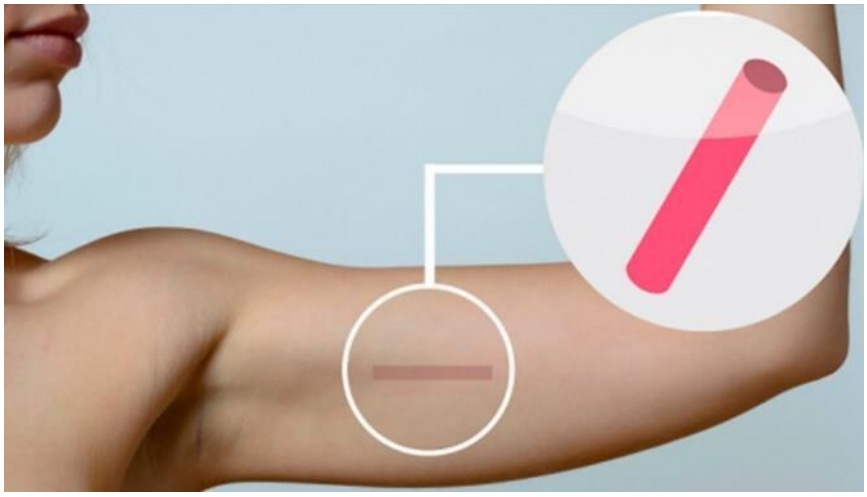
Assinatura e carimbo com CRM do(a) Médico(a)

Data da solicitação ____/____/_____.

Todo paciente com solicitação de Endoscopia e Colonoscopia, deve ser anexado a este formulário.

Pacientes com até 65 anos, sem comorbidades, e que estejam estáveis, podem realizar o exame normalmente, sem necessidade de avaliação pré.
Os pacientes acima de 65 anos, deverão vir com risco cirúrgico, entregar no Controle e Avaliação documento físico.

PROTOCOLO: CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE



NOVA MUTUM – MT, JUNHO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM –MT

ESTADO DE MATO GROSSO – CNPJ: 24.772.162/0001-06

Endereço Eletrônico: admsaude@novamutum.mt.gov.br

PROTOCOLO: CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Leandro Félix
PREFEITO MUNICIPAL

Sônia Maria de Ávila
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

Secretária Municipal de Saúde - Sônia Maria de Ávila
Diretora da Secretaria de Saúde - Luciane Mayer
Coordenador da Atenção Básica - Anderson Formighieri
Coordenadora da Atenção Básica - Edenilza Neta da Silva
Coordenadora da Média e Alta Complexidade - Elisane Della Mea
Médica Clínica Geral/Especialista em Saúde da Família e Comunidade - Andressa Fabrizio
Médico Clínico Geral - Lucas de Lima Ferreira
Coordenadora da Assistência Farmacêutica - Alini da Fonseca Reis
Enfermeira Estratégia Saúde da Família - Malu Suzane de Almeida
Enfermeira Estratégia Saúde da Família - Hosana Gomes Ramos
Enfermeira Estratégia Saúde da Família - Eliana Rosa de Oliveira

Junho/2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO4

2. JUSTIFICATIVA5

3. OBJETIVOS6

7

4. METODOLOGIA7

4.1. Profissionais Habilitados7

4.2. Avaliação e monitoramento7

8

9

9

5. FICHA TÉCNICA DO CONTRACEPTIVO INTRADÉRMICO DE ETONOGESTREL – IMPLANON NXT®11

11

12

13

13

13

14

15

17

5.9 Interações medicamentosas18

6. RESULTADOS ESPERADOS18

7. ORÇAMENTO18

8. REFERÊNCIA20

21

1. INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel para a prevenção da gravidez não planejada por mulheres adultas em idade reprodutiva entre 18 e 49 anos. Produzido em laboratório, o etonogestrel é um hormônio que se assemelha à progesterona (hormônio feminino que atua no sistema reprodutor) e trata-se de um método contraceptivo de longa duração e que pode permanecer no corpo da mulher por um período de até três anos.

A Portaria SCTIE/MS nº 13, de 19 de abril de 2021, torna pública a decisão de incorporar o implante subdérmico de etonogestrel, condicionada à criação de programa específico, na prevenção da gravidez não planejada para mulheres em idade fértil: em situação de rua; com HIV/AIDS em uso de dolutegravir; em uso de talidomida; privadas de liberdade; trabalhadoras do sexo; e em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicosídeos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

A gravidez não intencional se caracteriza como um problema de saúde pública e abrange de forma ampla a gravidez não planejada e a gravidez não desejada. A taxa global de gravidez não intencional tem apresentado declínio nos últimos anos em todo o mundo. No Brasil, estima-se que mais da metade das gravidezes podem ser consideradas como não planejadas. A contracepção é a prevenção intencional da gravidez e é capaz de reduzir a mortalidade materna e neonatal. Contudo, muitas mulheres que desejam evitar a gravidez não utilizam contraceptivos, usam de forma inconsistente ou incorreto. O aconselhamento sobre os métodos contraceptivos e a educação sexual são estratégias que auxiliam a evitar a gravidez não intencional. O SUS disponibiliza uma variedade de métodos contraceptivos, reversíveis ou permanentes, além de ações e políticas voltadas para a saúde sexual e o planejamento familiar.

A saúde reprodutiva pressupõe que a pessoa possa “ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo, de acordo com o Ministério da Saúde, 2022, o sistema de saúde deve ampliar o cuidado integral para que as mulheres e suas famílias tenham acesso amplo ao conhecimento sobre seus direitos sexuais e reprodutivos.

Já o planejamento reprodutivo, também chamado de planejamento familiar, traz um conjunto de ações de regulação da fecundidade que podem auxiliar as pessoas a prever e controlar a geração e o nascimento de filhos, e englobam adultos, jovens e adolescentes com

vida sexual, de todas as orientações sexuais, com e sem parcerias estáveis, bem como quem se prepara para iniciar a vida sexual. As ações do planejamento reprodutivo são voltadas para o fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos dos indivíduos e se baseiam em ações clínicas, preventivas e educativas, na oferta de informações e nos meios, métodos e técnicas para regulação da fecundidade.

No Brasil, desde a implantação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), a partir de 1984, tem havido a preocupação de melhorar a qualidade da atenção em planejamento familiar. Isto levou vários serviços públicos de saúde a oferecerem, pelo menos uma ação educativa às mulheres que os procuram para solicitar métodos anticoncepcionais (COSTA, 2002).

Em 1996, um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional (Lei 9.263), sancionado pela Presidência da República, regulamentou o planejamento familiar. Formalmente, esta lei democratiza o acesso aos meios contraceptivos nos serviços públicos de saúde, assim como regulamenta essa prática na rede privada, sob controle do SUS (BRASIL, 2002).

A oferta de métodos contraceptivos aliada ao acompanhamento médico com garantia de escolha informada no contexto maior da saúde reprodutiva foi contemplada pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), lançado, em 1983, pelo Ministério da Saúde (OSIS, 2006).

Segundo Martinez et al. (2011), a literatura tem evidenciado associações entre a gestação precoce e variáveis, como a desigualdade social e econômica, ademais outros tipos de vulnerabilidades, como o uso frequente de drogas ilícitas por familiares. Ainda de acordo com os autores supracitados, hoje a adolescência é considerada uma idade inadequada para a mulher ter filhos diante da associação com morbidades do neonato e impactos econômicos, educacionais e sociais.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando que as estimativas recentes apontam que 218 milhões de mulheres em idade reprodutiva, de 15 a 49 anos, em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil, querem evitar a gravidez, mas não estão usando um método contraceptivomoderno. O não uso, o uso inconsistente ou incorreto ou a interrupção do uso de contraceptivos é um dos fatores que colaboram para uma gravidez não planejada.

Considerando que a gestação precoce está associada a situações como a desigualdade social e econômica, ademais outros tipos de vulnerabilidades, como o uso frequente de drogas ilícitas por familiares.

Considerando a população feminina estimada do município de Nova Mutum, na estimativa do IBGE/2021 é de 11.618 mulheres, entre 20 a 49 anos**.** A população de adolescentes feminina estimada do município, distribuídas nas faixas etárias: 10 - 14 anos o total de 1.868 e de 15 – 19 anos total de 2.121 adolescentes.

O número de gestantes vivendo com HIV/AIDS vem aumentando ao longo dos anos, e tem sido observado aumento da proporção dessas mulheres que se tornamgestantes.

Dentre os vários aspectos da saúde reprodutiva, a anticoncepção adquire papel igual de seu uso de forma inadequada implica vários agravos à saúde da mulher, como gravidez indesejada, gravidez na adolescência, abortamentos ilegais e até mesmo aumento na mortalidade materna. Nesse sentido, promover os métodos contraceptivos de longa duração para adolescentes e mulheres adultas em idade reprodutiva entre 16 e 49 anos, em situação de vulnerabilidades e de risco, se caracteriza como uma medida de promoção da saúde púbica.

No entanto, o oferecimento do Implante Contraceptivo Subdérmico de Etonogestrel torna-se importante, visto que este se caracteriza como um método seguro de contracepção, pois trata-se de um método contraceptivo de longa duração e que pode permanecer no corpo da mulher por um período de até três anos e está no conjunto das orientações sobre métodos contraceptivos do Ministério da Saúde incorporado ao SUS.

A oferta de contraceptivos é uma forma importante que permite aos programas de planejamento familiar e demais programas de saúde reprodutiva, melhorar a qualidade de seus serviços e atender melhor às necessidades das usuárias do SUS.

Além disso, o fornecimento de educação sexual abrangente, o aconselhamento, o apoio efetivo em planejamento familiar e a escolha de métodos contraceptivos modernos e acessíveis são fundamentais para a prevenção da gravidez não intencional, justificando assim a implantação do Contraceptivo Intradérmico de Etonogestrel, de acordo com as PRIORIDADES elencadas neste Protocolo.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral:

Atender às necessidades de planejamento reprodutivo das mulheres do Município de Nova Mutum-MT, em situação específicas, através do uso de contraceptivo de longa duração, evitando a gravidez não planejada bem como o risco de mortalidade materna e infantil.

3.1. Objetivos Específicos:

- Apoiar tecnicamente os profissionais que atuam no aconselhamento reprodutivo a nível municipal, onde se evidencia a possibilidade de recomendação deste método.
- Possibilitar um planejamento reprodutivo de longo prazo para a mulher e/ou casal.
- Diminuir a ocorrência de casos de gravidez não planejada e/ou precoce, com consequentes abortos provocados, exercendo grande impacto na morbimortalidade materno-infantil;

4. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi orientada pelos princípios do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde e submetido as diretrizes do Programa de Planejamento Familiar.

O município de Nova Mutum estabelecerá um Protocolo Técnico a ser seguido pelos profissionais de saúde que foram capacitados/treinados e que atuam nas Unidades de Saúde do SUS.

4.1. Profissionais Habilitados

A inserção do implante hormonal será solicitada pelos médicos e enfermeiros da rede pública municipal, vinculados a Unidade Básica de Saúde, conforme fluxograma exibido abaixo, e realizada por profissional capacitado no manejo do implante hormonal.

4.2.Avaliação e monitoramento

As usuárias do Implante Intradérmico Hormonal serão avaliadas de forma contínua no decorrer dos três anos e ao final do período, sendo reavaliadas, conforme os critérios

estabelecidos, e o Implante é removido 3 anos após a sua inserção, ou antes, a pedido ou com indicação do profissional de saúde capacitado.

É assegurada a oferta de novo Implante na ocasião da retirada, se houver estoque disponível e se a paciente estiver nos critérios de inserção, ou será oferecido outro método contraceptivo existente na rede municipal de saúde.

4.3 Público Alvo - Prioridades

O público prioritário, serão as usuárias do SUS sob vulnerabilidade social e clínica, para inserção do implante hormonal pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo:

- **Mulheres em idade fértil em situação de rua, privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo e em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicosídeos** (Atendimento a Portaria SCTIE/MS nº 13, de 19/04/2021);
- **Adolescentes - 14 a 17 anos,** sob vulnerabilidade social, inscritas no CADÚNICO, que realizam acompanhamento no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de Nova Mutum – MT;
- **Adolescentes de 14 a 17 anos,** com histórico de gestação ou abortamento.
- **Usuárias de drogas ilícitas e álcool em idade reprodutiva -** usuárias de álcool e drogas, reincidentes, que estejam em acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde e/ou no Grupo Cuidar do Município Nova Mutum – MT.
- **Pacientes com HIV/AIDS e/ou Hepatites Virais, em idade reprodutiva, não adeptas a outros contraceptivos.**
- **Pacientes com Transtorno Psíquico moderado a grave em idade reprodutiva,** em acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde do Município ou no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), por tempo mínimo de 06 (seis) meses.
- **Paciente multípara com 3 ou mais filhos, alto risco gestacional** e com contraindicação aos outros métodos contraceptivos e aos métodos de esterilização.

Em todas as prioridades elencadas, a paciente deve residir no município há pelo menos 6 meses, com comprovante de endereço do munícipio que comprove tal fato e/ou cadastro do Agente Comunitário de Saúde (ACS).

4.4. Critérios de exclusão

Os citados abaixo, nas contraindicações, item 5.1.

4.5. Fluxo de Atendimento

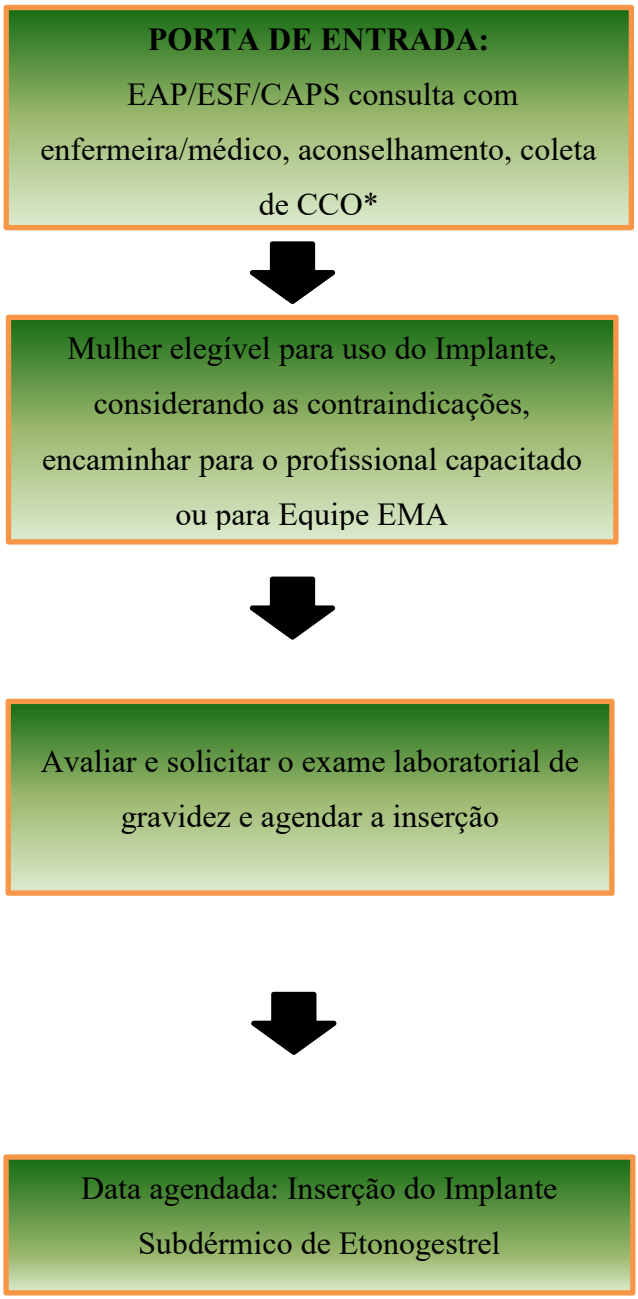
O fluxo do atendimento do implante hormonal está descrito abaixo e as mulheres que desejam o Implante, devem atender a um ou mais dos critérios de elegibilidade do item 4.3, considerando as contraindicações do item 5.1, serão encaminhadas pelas Unidades de Saúde, com o ANEXO I devidamente preenchido, e em casos de pacientes menores de idade, deverão ter autorização e acompanhamento do responsável.

A inserção do implante hormonal será solicitada pelos médicos e enfermeiros da rede pública municipal vinculada as Unidades de Saúde do SUS, e inserido por profissionais devidamente capacitados e treinados, desde que as mulheres atendam aos critérios definidos neste Protocolo com as documentações solicitadas.

No dia da inserção deverá ser apresentado para leitura, entendimento e assinatura o **TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO IMPLANON** (ANEXO II) e o Exame Laboratorial de Gravidez.

Será solicitado o exame de gravidez laboratorial para apresentar antes da inserção do Implante SD, para todas as mulheres elegíveis.

Se a mulher em idade fértil é do grupo prioritário e não deseja o implante, orientar os demais métodos contraceptivos, como contraceptivos hormonais orais, injetáveis mensal ou trimestral, preservativo, DIU, progestagênio (VO, IM) e cirúrgico (vasectomia e laqueadura), disponíveis nas UBSs e rede hospitalar contratualizada, de acordo com cada caso e em observância aos fluxos estabelecidos.



- CCO – Realizar a coleta nas mulheres que não tenham o exame atualizado (1 ano). (O resultado não impede a inserção do implante)
- Usuárias menores de idade - somente será realizada a inserção do Implante com autorização dos pais/responsáveis;
- Se Exame de Gravidez reagente - encaminhar para Unidade de Referência para iniciar o Pré Natal.

5. FICHA TÉCNICA DO CONTRACEPTIVO INTRADÉRMICO DE ETONOGESTREL – IMPLANON NXT®

De acordo com a CONITEC, o IMPLANON NXT® é um método contraceptivo reversível de ação prolongada, consistindo em um bastão, contendo 68 mg de etonogestrel, que é aplicado na subderme, macio e flexível, branco a levemente amarelo ou marrom, com 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, radiopaco, não biodegradável, disponível em um aplicador descartável e estéril para uso subdérmico. O efeito contraceptivo deste progestágeno é obtido principalmente por inibição da ovulação, além da alteração no muco cervical, impedindo a passagem dos espermatozóides.

O principal diferencial proposto pelo IMPLANON NXT® para o alto grau de contracepção é a independência da adesão da usuária a um regime diário, semanal ou mensal auto administrado. A taxa de liberação do etonogestrel diminui com o tempo, sendo de aproximadamente 60 mcg/dia a 70 mcg/dia na 5ª a 6ª semana, reduzindo a cerca de 35 mcg/dia a 45 mcg/dia no final do primeiro ano, 30 mcg/dia a 40 mcg/dia no final do segundo ano e 25 mcg/dia a 30 mcg/dia no final do terceiro ano, causando variações nas concentrações séricas do progestágeno. Essas variações podem ser parcialmente atribuídas a diferenças no peso corporal. Raras ovulações foram observadas no terceiro ano. O fabricante informa que, uma vez aplicado o IMPLANON NXT®, não é necessário que a usuária inicie qualquer regime de administração, visto que o princípio ativo é liberado durante o período de três anos. Porém, na bula há uma recomendação acerca da necessidade da utilização de um método anticoncepcional não hormonal até que seja confirmada a presença do implante contraceptivo subdérmico, caso não seja palpável após a inserção.

5.1. Contraindicações:

Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres nas seguintes condições:

- Distúrbio tromboembólico venoso ativo;
- Presença ou histórico de tumor hepático, (benigno ou maligno);
- Presença ou histórico de doença hepática grave, enquanto os valores dos testes de função hepática não retornarem ao normal;
- Presença ou suspeita de malignidades sensíveis a esteroide sexual;
- Sangramento vaginal não diagnosticado;

- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer componente de IMPLANON NXT®;

Este medicamento é contraindicado para uso durante a gravidez ou em caso de suspeita de gravidez.

5.2. Cuidados e Precauções:

- Carcinoma das mamas: possibilidade de aumentar o risco de ter câncer de mama diagnosticado;
- Eventos trombóticos e outros vasculares: mulheres com histórico de distúrbios tromboembólicos devem ser alertadas sobre a possibilidade de recorrência. Em caso de trombose, IMPLANON NXT® deve ser removido;
- Efeitos no metabolismo lipídico e dos carboidratos: as mulheres com diabetes devem ser cuidadosamente observadas enquanto usarem anticoncepcionais de progestagênio isolado e as mulheres que estão em tratamento de hiperlipidemia devem ser rigorosamente acompanhadas se optarem por usar IMPLANON NXT®;
- Gravidez ectópica: deve ser considerada no diagnóstico diferencial se a mulher apresentar amenorreia ou dor abdominal;
- Pressão sanguínea elevada: se durante o uso ocorrer hipertensão persistente ou se um aumento significativo da pressão arterial não responder adequadamente ao tratamento anti-hipertensivo, IMPLANON NXT® deve ser retirado;
- Doença hepática: caso ocorram distúrbios crônicos ou agudos da função hepática, a mulher deve ser encaminhada a um especialista para exame e orientação;
- Peso corporal: é possível que o médico necessite considerar a substituição do implante em um prazo menor em mulheres com sobrepeso;
- Cloasma e cistos ovarianos: podem ocorrer ocasionalmente;
- Complicações da inserção: podem ocorrer inserção profunda ou vascular, migração ou expulsão do implante, necessitando de intervenções médicas objetivando a sua localização e a sua remoção.

5.3 Eventos adversos:

Durante o uso de IMPLANON NXT®, as mulheres ficam suscetíveis a mudanças no padrão de sangramento menstrual que podem incluir alterações na frequência (ausente, menos frequente, mais frequente ou contínua), na intensidade (reduzida ou aumentada) ou na duração do sangramento. Reações adversas muito comuns relatadas em estudos clínicos foram infecção vaginal, cefaleia, acne, sensibilidade mamária, dor mamária e aumento de peso. Além disso, foram relatadas complicações no local do implante, como: eritema, hematoma, equimose, dor e edema.

5.4. Características do método:

Tem uma eficácia superior a 99%, igual ou superior a eficácia da laqueadura tubária.

Vantagens:

• É um método prático e de longa duração (3 anos);
• Evita ter que tomar a pílula todos os dias.
• Não interfere com a relação sexual.
• Não interfere com a amamentação.
• Melhora as cólicas menstruais.
• Pode ser usado pelas mulheres que não podem tomar pílulas contendo estrogênio.
• Não diminui a massa óssea (osteoporose).

Desvantagens:

• Irregularidades da menstruação. Na maioria dos casos, há sangramento irregular, podendo haver aumento do fluxo menstrual ou ausência de menstruação. Estas alterações são mais comuns no primeiro ano e não têm consequências negativas na saúde da mulher. De cada 100 mulheres, 15 terão sangramento mais frequente.
• Pode ocorrer algumas alterações da pele, dores de cabeça,náuseas, aumento da sensibilidade mamária e variações do humor (semelhantes às que ocorrem com outros métodos contraceptivos como a pílula).
• Podem aparecer cistos benignos nos ovários, que geralmente não necessitam de tratamento.

5.5. Período para inserção e remoção do Implante Subdérmico de Etonogestrel:

O Implante é eficaz logo após a colocação, é inserido na parte interna do braço, não dominante, sob a pele, como se fosse uma injeção, sendo necessária anestesia no local para inserção do implante. Pode ocorrer alguma dor, algum inchaço ou hematoma pequeno no local da colocação.

Momento de inserir o Implante de etonogestrel, de acordo com as situações abaixo:

Se puérpera:

- Amamenta: Após 28 dias ou no alojamento conjunto (24 a 48 horas pós-parto). O implante será inserido de 24 a 48 horas sempre que se detectar risco de curto intervalo intergestacional.
- Não amamenta: 24-48 horas após parto ou após 28 dias.
- Paciente deverá comparecer com exame laboratorial de gravidez.

Se não-puérpera

- Paciente deverá comparecer com Exame Laboratorial de Gravidez

Pós-aborto: imediatamente após o aborto.

- O momento para retirar o Implante é 03 (três) anos após a sua inserção, ou antes, a pedido, e para a remoção do implante, também é preciso ser aplicada a anestesia. Mulheres com Obesidade, avaliar após dois anos de inserção, para retirada.

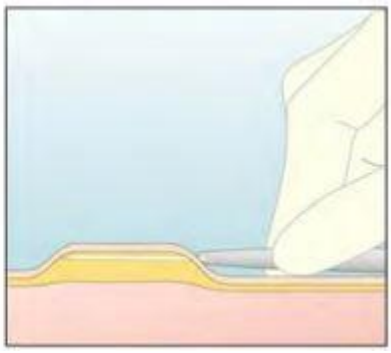
É assegurada a oferta de novo implante subdérmico na ocasião da retirada, se houver estoque disponível e se paciente estiver nos critérios de inserção, ou será oferecido outro método contraceptivo existente na rede municipal de saúde, como contraceptivos hormonais orais, injetáveis mensal ou trimestral, preservativo, DIU de cobre e cirúrgico (vasectomia e laqueadura), disponíveis nas UBSs e rede hospitalar contratualizada, de acordo com cada caso e em observância aos fluxos estabelecidos.

5.6. Como inserir o Implante

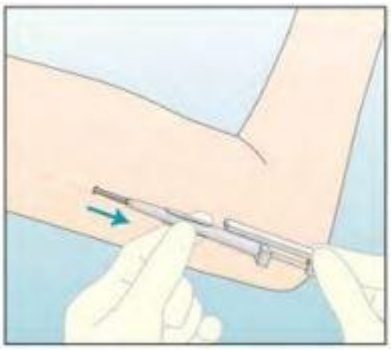
- A inserção do Implante de etonogestrel deve ser feita apenas por um médico ou enfermeiro capacitado para realizar o procedimento.
- Para facilitar a inserção, deitar a usuária de costas, com o braço levemente dobrado no cotovelo e virado para fora.
- O implante será inserido com a ajuda de um aplicador desenvolvido especialmente para essa função, na parte interna do braço que não é usado para escrever.

- O local da inserção será indicado na pele; o local será desinfetado e anestesiado.





- A pele é distendida e a agulha inserida diretamente sob a pele. Quando a ponta da agulha estiver dentro da pele, a agulha é inserida completamente com um movimento paralelo à superfície da pele.



- O implante permanecerá no braço quando a agulha for retirada, após a quebra do lacre. O médico ou enfermeiro verificará, juntamente com a usuária, se o implante realmente está dentro do braço. Em caso de dúvida utilizar camisinha até que usuária e médico estejam completamente seguros de que o implante foi inserido. Em raros casos, o médico pode ter que utilizar exame por ultrassonografia ou ressonância magnética, ou exame de sangue, para ter certeza de que o implante foi inserido no local.
- Será feito um curativo compressivo com uma gaze estéril para minimizar as lesões.

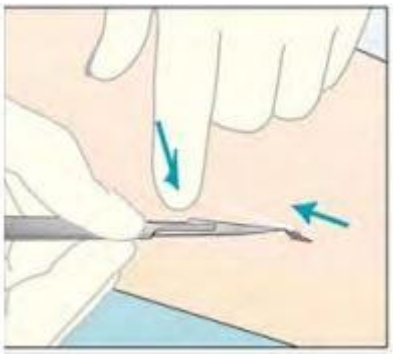
5.7 Como retirar o Implante

- A retirada do Implante deve ser feita apenas por médico ou enfermeiro.
- A localização precisa do implante é indicada no cartão da usuária.

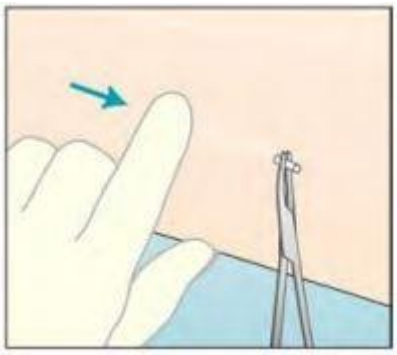
- O médico/enfermeiro localizará o final do implante. Quando o implante não puder ser localizado, o médico pode recorrer às técnicas de ultrassonografia ou ressonância magnética.
- O braço da usuária deverá ser desinfetado e anestesiado.



- Será feito um pequeno corte na direção longitudinal do braço, logo abaixo da ponta do implante.



- O implante será puxado delicadamente e retirado com uma pinça



- Ocasionalmente, o implante pode estar encapsulado. Nesse caso, será necessário um corte pequeno na pele antes que o implante possa ser retirado.

- O corte será fechado com curativo aproximativo e será colocada uma gaze estéril compressiva para minimizar as lesões.

5.8 Retornos Clínicos e Avaliações:

a. Pós inserção: Agendar retorno para avaliação em 30 dias;

b. Após este período, os retornos serão semestrais ou anuais a depender dos critérios clínicos, ou do perfil de adesão da paciente. Mulheres com efeitos adversos ou intercorrências deverão ter avaliações com intervalos mais curtos.

Avaliar de forma regular se sangrar mais de 10 dias consecutivos. Visto que a principal intercorrência observada com os métodos contraceptivos que utilizam apenas progestagênios é o sangramento uterino anormal, foram padronizados tipos de sangramentos e condutas:

Padrões de sangramento com contraceptivos apenas de progestagênios - período mínimo de observação para estas definições: 90 dias.

Amenorréia: sem sangramento;

Sangramento prolongado: período de sangramento e/ou mancha com duração maior que 14 dias;

Sangramento frequente: > 5 episódios de sangramento e/ou mancha (não importa a duração);

Sangramento infrequente: ≤ 2 episódios de sangramento e/ou mancha (não importa a duração);

Sangramento Normal: 3 a 5 episódios de sangramento e/ou mancha (não importa a duração)

Considera-se padrões de sangramento favoráveis, a amenorreia, o sangramento infrequente e o regular. Já o frequente e o prolongado são desfavoráveis, importante reavaliar, descartar outras doenças, tratar o sangramento se necessário e considerar a possibilidade de troca de método anticoncepcioal, se paciente desejar.

Orientações dos métodos contraceptivos apenas de progestagênios para queixa de sangramento com padrão desfavorável

Orientar:

• Nos 4 a 6 primeiros meses são comuns irregularidades. Orientar a taxa de amenorréia esperada do método;

• Irregularidade é diferente de falha;

• Descartar outras doenças se sangramento com mais de 6 meses ou dispareunia ou dor pélvica associada.

Nestes 3 casos, solicitar USTV.

Sempre que o sangramento for superior a 7 dias consecutivos

Tratamento:

1º: Usar AINE (antiinflamatórios não hormonais) por 5 dias;

2º: Doxiciclina 100 mg de 12/12 h por 7 dias;

3º: Contraceptivo oral combinado (EE 30 mcg + 150 mcg de Levonorgestrel) por 21 dias. Fazer 3 ciclos com pausa;

4º: Troca de método se paciente desejar.

5.9 Interações medicamentosas

Alguns medicamentos podem interferir no perfeito funcionamento do Implante deEtonogestrel. Eles incluem medicamentos usados para tratar epilepsia (ex.: primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato); tuberculose (ex.: rifampicina, rifabutina) e infecções por HIV (ex.: ritonavir, nelfinavir); e o fitoterápico Erva de São João(utilizado principalmente para tratamento de depressão).

O Implante também pode interferir no funcionamento de outros medicamentos, sempre questionar a usuária se a mesma está tomando outros medicamentos ou fitoterápicos, em caso afirmativo, por quanto tempo, e se necessário, orientar as precauções anticoncepcionais adicionais.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Redução dos índices de gravidez indesejada nos públicos priorizados, redução da mortalidade materno-infantil e redução de gravidez em adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidades.

7. ORÇAMENTO

A compra do implante se dará através do Consórcio Vale do Teles Pires, CNJP 23.019.551/0001-00, onde este fará a licitação e adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum/MT para as Unidades Básicas de Saúde, conforme quantidade inicial e valores discriminados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNIDADE
IMPLANTE DE ETONOGESTREL 110 UNIDADES	110 UNIDADES	R$ 460,00
TOTAL		R$ **50.600,00**

Apesar das recomendações favoráveis sobre a incorporação do implante subdérmico de etonogestrel para prevenção da gravidez não planejada por adolescentes e mulheres adultas em idade reprodutiva, entre 18 e 49 anos, no SUS, a disponibilização juntamente com o impacto orçamentário calculado, dificulta a incorporação desta tecnologia no SUS a todas as usuárias desta faixa etária, motivo pelo qual, implantou-se prioritariamente para grupos específicos/prioritários.

8. REFERÊNCIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. 2ª Edição, Brasília/DF, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 13, de 19 de abril de 2021.

BULA IMPLANON etenogestrel. Farm. Resp.: Cristina Matushima – CRF-SP no 35.496. Fabricado e embalado por: N.V. Organon, Oss, Holanda. Importado e registrado por: Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda.

CONITEC – Relatório de Recomendação: Implante subdérmico de etonogestrel na prevenção da gravidez não planejada por mulheres adultas em idade reprodutiva entre 18 e 49 anos, nº 599, Brasília/DF, 2021.

MARTINEZ, E. Z.; ROZA, D. L.; CACCIA-BAVA, M. C. G. G.; ACHCAR, J. A.; DAL-FABRO, A. L. Gravidez na adolescência e características socioeconômicas dos municípios do Estado de São Paulo, Brasil: análise espacial. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 27, n. 5;p. 855-867, mai, 2011. Acessado em 26/06/2023, site: https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/13336/1/TCC-LUZIL-9.pdf

OMS . Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais. Acessado em julho de 2023: https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340375131Portuguese-AppendixD.pdf

RESOLUÇÃO COFEN, Nº 690/222. Normatiza a atuação do enfermeiro no Planejamento Familiar.

ANEXOS

ANEXO I

FICHA PARA INSERÇÃO DO IMPLANON

Paciente: _____

Data de Nascimento:_____/____/_____

ESF de Origem: _____

Endereço: _____

Para inserção do INPLANON é necessário, obrigatoriamente, que a paciente se encaixe em um ou mais dos itens abaixo:

1) Adolescentes - 14 a 17 anos, sob vulnerabilidade social, inscritas no CADÚNICO, que realizam acompanhamento no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de Nova Mutum – MT. ( ) Sim ( ) Não

2) Adolescentes de 14 a 17 anos, com histórico de gestação ou abortamento. ( ) Sim ( ) Não

3) Pacientes com Transtorno Psíquico moderado a grave em idade reprodutiva, em acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde do Município ou no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), por tempo mínimo de 06 (seis) meses, com solicitação médica.
( ) Sim ( ) Não

4) Paciente multípara com 3 ou mais filhos, alto risco gestacional e com contraindicação aos outros métodos contraceptivos e aos métodos de esterilização. ( ) Sim ( ) Não

5) Usuárias de drogas ilícitas e álcool em idade reprodutiva - usuárias de álcool e drogas, reincidentes, que estejam em acompanhamento regular na Unidade Básica de Saúde do Município Nova Mutum – MT. ( ) Sim ( ) Não

6) Mulheres em idade fértil em situação de rua. ( ) Sim ( ) Não

7) Mulheres em idade fértil privadas de liberdade. ( ) Sim ( ) Não

8) Mulheres em idade fértil trabalhadoras do sexo. ( ) Sim ( ) Não

9) Mulheres em idade fértil em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicosídeos.
( ) Sim ( ) Não

10) Pacientes com HIV/AIDS e/ou Hepatites Virais, em idade reprodutiva, não adeptas a outros contraceptivos. ( ) Sim ( ) Não

A paciente deve residir no município há pelo menos 6 meses, com comprovante de endereço do munícipio que comprove tal fato e/ou cadastro do Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Anexar certidões de nascimento dos filhos e cópia de receita dos medicamentos, caso faça uso de alguma medicação.

A inserção do implante hormonal será solicitada pelos médicos e enfermeiros da rede pública municipal vinculada a Unidade Básica de Saúde.

O fluxo do atendimento do IMPLANON está estabelecido no Protocolo do Contraceptivo Subdérmico de Etonogestrel na Rede Pública de Saúde de Nova Mutum/MT.

_____ , ____/____/_____ _____

Local e Data Médico

ANEXO II

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO IMPLANON - 68 mg de Etonogestrel

É um pequeno bastão de plástico semirrígido que é colocado diretamente sob a pele. Uma pequena quantidade de hormônio feminino, o progestagênio etonogestrel, é liberada continuamente, passando do implante para a corrente sanguínea, resultando em efeito anticoncepcional por um período de até três anos.

Modo da ação: Impede a liberação do óvulo e altera a secreção do colo do útero dificultando a entrada dos espermatozoides no útero.

Indicação: Anticoncepção.

Contraindicações:

· Distúrbio tromboembólico venoso ativo.

· Presença ou histórico de tumor hepático (benigno ou maligno).

· Presença ou histórico de doença hepática grave, enquanto os valores dos testes de função hepática não retornarem ao normal.

· Presença ou suspeita de malignidades sensíveis a esteroide sexual.

· Sangramento vaginal não diagnosticado.

· Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer componente de IMPLANON.

Este medicamento é contraindicado para uso durante a gravidez ou em caso de suspeita de gravidez. Caso ocorra gravidez durante o uso de IMPLANON, o implante deverá ser retirado.

Reações adversas:

· Reações muito comuns (mais de 10% das pacientes): acne, dor de cabeça, aumento de peso corporal, sensibilidade e dor nas mamas, infecções vaginais, menstruação irregular.

· Reações comuns (entre ≥ 1% e < 10%): queda de cabelo, tontura, depressão,

instabilidade emocional, nervosismo, diminuição do desejo sexual, diminuição do apetite, dor abdominal, náusea, gases no estômago e intestino, cólicas menstruais, diminuição de peso corporal, sintomas de gripe, dor, fadiga, ondas de calor, dor no local do implante, reação no local do implante, cistos ovarianos.

· Reações incomuns (≥ 0,1% e < 1%): coceira, coceira na área genital, vermelhidão na pele, crescimento excessivo de pelos, enxaqueca, ansiedade, insônia, sonolência, diarreia, vômitos, constipação, dor para urinar, infecção do trato urinário, desconforto vaginal (exemplo, secreção vaginal), aumento das mamas, secreção nas mamas, dores pélvicas, dor nas costas, febre, retenção de líquidos, reações alérgicas, inflamação e dor de garganta, rinite, dores articulares, dores musculares, dores ósseas. Elevação da pressão sanguínea. Urticária.

Reações raras: adormecimento ou sensação de falta de sensibilidade. Expulsão ou migração de IMPLANON.

Mediante o exposto:

"Declaro que concordo com a colocação do IMPLANTE conforme me foi explicado pelo profissional de saúde, fiz todas as perguntas sobre o assunto. Fui esclarecida que a taxa de falha do método é de 1 gravidez a cada 2.000 mulheres com o uso do método e que o IMPLANTE SUBCUTÂNEO DE ETONOGESTREL 68 MG, não apresenta contraindicações. Assim, autorizo a realização do ato indicado nas condições em que me foram explicadas e constam deste documento."

_____ _____

Data e Local da Inserção Médico/Enfermeiro Responsável

_____

Assinatura do Paciente

Em caso de incapacidade ou menor de idade, assina também este documento, o representante legal da paciente.

_____

Assinatura do Responsável

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA NOVA MUTUM – MT

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Associação Nacional de Equoterapia – ANDE - BRASIL, a **EQUOTERAPIA** é um método terapêutico e educacional - **reconhecido e regulamentado pela lei 13.830/2019 -** que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Dentro deste método utiliza-se o termo **PRATICANTE DE EQUOTERAPIA** para designar a pessoa com deficiência quando em atividades equoterápicas. Nessa atividade, o sujeito do processo participa ativamente de sua reabilitação à medida que interage com o cavalo.

Já a **EQUITAÇÃO** consiste na arte de montar a cavalo, adestrá-lo e prepará-lo para as diversas atividades, a partir dela, se desenvolvem práticas esportivas; a equitação também se constitui como importante instrumento de formação do caráter e proporciona ao praticante: atividade física, destreza, robustez e desenvolvimento moral. Além disso, fortalece o equilíbrio, coordenação motora, agilidade, melhora a autoimagem, sentimento de força física, autoconfiança, vontade, espírito de decisão, iniciativa e resolução. Para isso, é de extrema importância que seja ministrada de forma didático-pedagógica por um instrutor capacitado.

1.1. PRINCÍPIOS E NORMAS FUNDAMENTAIS DA EQUOTERAPIA

Toda atividade equoterápica baseia-se em fundamentos técnico-científicos. As atividades equoterápicas devem ser desenvolvidas por equipe multiprofissional com atuação interdisciplinar, com participação de maior número possível de áreas profissionais nos campos da saúde, educação e equitação.

O atendimento equoterápico deve ser iniciado mediante parecer favorável de avaliação multidisciplinar. As sessões de Equoterapia podem ser realizadas em grupo, porém o planejamento e o acompanhamento devem ser individualizados. Para acompanhar a evolução do trabalho e avaliar os resultados obtidos, deve haver registros periódicos e sistemáticos das atividades desenvolvidas com os praticantes.

A ética profissional e a preservação da imagem dos cidadãos praticantes de Equoterapia devem ser constantemente observadas.

A segurança física do praticante deve ser uma preocupação constante de toda a equipe, com vistas particularmente:

• Ao comportamento e atitudes habituais do cavalo e às circunstâncias que podem vir a modificá-los, como por exemplo uma bola arremessada ou um tecido esvoaçando, nas proximidades do animal;

• Ao equipamento de montaria, particularmente correias, presilhas, estribos, sela e manta;

• À vestimenta do praticante, principalmente nos itens que podem trazer desconforto ou riscos à segurança;

• Ao local das sessões onde possam ocorrer, por exemplo, ruídos anormais que venham assustar os animais.

1.2. RECONHECIMENTO DA EQUOTERAPIA

A Equoterapia como Método Terapêutico e Educacional

A Equoterapia foi reconhecida e regulamentada pela Lei Nº 13.830, de 13 de Maio de 2019 que dispõe sobre a prática da mesma.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), em Sessão Plenária de 9 de abril de 1997, aprovou o Parecer 06/97, que diz:

• "A Equoterapia tal como conceitua a Associação Nacional de Equoterapia - ANDE-BRASIL, é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar aplicada nas áreas de saúde e educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais.

Somos, portanto, pelo reconhecimento da Equoterapia como método a ser incorporado ao arsenal de métodos e técnicas direcionados aos programas de reabilitação de pessoas com necessidades especiais..."

• "Pela estratégia traçada pela ANDE-BRASIL e dentro da legislação brasileira, há necessidade de comprovação científica, feita por profissionais brasileiros, e dentro do que prescreve a resolução n.° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das normas de pesquisa envolvendo seres humanos."

Diz ainda o parecer: "Os dados levantados nas pesquisas devem ser concentrados na ANDE-BRASIL que, juntamente com a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, encaminhará ao CFM para avaliação e posicionamento definitivo desta Casa".

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, reconhece a Equoterapia como um método educacional que favorece a alfabetização, a socialização e o desenvolvimento global dos alunos com necessidades educativas especiais.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em Resolução n°348, de 27 de março de 2008 (DOU n°63, seção 1 de 02/04/2008 pag.150), reconhece a Equoterapia como recurso terapêutico da fisioterapia e da terapia ocupacional.

1.3. INDICAÇÕES DA EQUOTERAPIA

A prática da Equoterapia busca benefícios biopsicossociais às pessoas com deficiências físicas ou mentais, tais como:

• Lesões neuromotoras de origem encefálica ou medular;
• Patologias ortopédicas congênitas ou adquiridas por acidentes diversos;
• Disfunções sensório-motoras.
• Distúrbios:
-Evolutivos;
- Comportamentais;

- De aprendizagem;
- Emocionais.

1.4. ÁREAS DE APLICAÇÃO DA EQUOTERAPIA

• Saúde - na reabilitação de pessoas com deficiência física e/ou mental (PCD);
• Educação - para pessoas com necessidades educativas especiais (PNE) e outros;
• Social - para pessoas com distúrbios evolutivos ou comportamentais.

1.5. PROGRAMAS DE EQUOTERAPIA

É sabido que cada indivíduo, com deficiência e/ou com necessidades especiais, tem o seu prognóstico, o que o torna único. Evidenciando a necessidade de formular **programas e protocolos individualizados**, que levem em consideração as demandas individuais em determinadas fases de seu processo evolutivo.

Sendo a Equoterapia aplicada por intermédio de programas e protocolos individualizados organizados de acordo com:
- As necessidades e potencialidades do praticante;
- A finalidade do programa.

- **Os objetivos a serem alcançados estão em três ênfases:**
• A primeira, com **intenções terapêuticas e educacionais**, utilizando técnicas que visem, principalmente, **a reabilitação física e/ou mental**;
• A segunda, com **fins educacionais e/ou sociais**, com a **aplicação de técnicas pedagógicas aliadas às terapêuticas**, visando a integração ou reintegração sociofamiliar;
• A terceira, com fins de inserção/reinserção social.

1.6. PROGRAMAS BÁSICOS DE EQUOTERAPIA

• Hipoterapia
• Educação/Reeducação
• Pré-esportivo
• Prática Esportiva Paraequestre

a) Programa Hipoterapia

Voltado para as pessoas com deficiência física e/ou mental, sendo chamada em várias partes do mundo de hipoterapia, tal nome adotado também pela ANDE-BRASIL para este programa da Equoterapia.

Neste caso o praticante que não tem condições físicas e/ou mentais para se manter sozinho a cavalo, **não praticará a equitação**. Necessitando de um auxiliar-guia para conduzir o cavalo, e em alguns casos também do auxiliar lateral para mantê-lo montado, dando-lhe maior segurança.

A ênfase das ações é dos profissionais envolvidos no atendimento, necessitando de um terapeuta ou mediador, a pé ou montado para a execução dos exercícios programados. A segurança e o conforto do praticante são observados a todo momento. O maior estímulo no atendimento ocorre devido o movimento tridimensional da marcha do cavalo.

O cavalo é usado principalmente como agente **cinesioterapêutico**.

b) Programa Educação/Reeducação

Pode ser aplicado tanto na área de reabilitação quanto na de educação/reeducação. Neste caso o praticante tem condições de exercer alguma atuação sobre o cavalo e pode até conduzi-lo, dependendo em menor grau do auxiliar guia e do auxiliar lateral.

A ação dos profissionais de equitação tem mais intensidade, embora os exercícios devam ser programados por toda a equipe, segundo os objetivos a serem alcançados.

O cavalo continua propiciando benefícios pelo seu movimento tridimensional a multidirecional e o praticante passa a interagir com o animal e o meio com intensidade. Neste programa o praticante ainda não realiza equitação e/ou hipismo.

O cavalo atua como agente **pedagógico.**

c) Programa Pré-esportivo

Pode ser aplicado nas áreas de reabilitação ou educativa. Neste programa o praticante tem boas condições para atuar e conduzir o cavalo, realizando exercícios específicos de hipismo programados pela equipe. O trabalho do profissional de equitação habilitado em Equoterapia tem ênfase em relação aos demais, sendo realizados pequenos exercícios de hipismo que visam a melhoria da qualidade de vida e sua inserção/reinserção social.

O cavalo é utilizado principalmente como **agente de inserção social.**

d) Programa Prática Esportiva Paraequestre

O Programa Prática Esportiva Paraequestre tem como finalidade preparar a pessoa com deficiência para competições paraequestres.

O praticante deve ter boas condições para estar a cavalo, já podendo participar de festivais de Equoterapia e hipismo adaptado.

A ação do profissional de equitação habilitado em Equoterapia é mais intensa; segue necessária, contudo, a orientação dos profissionais das áreas de saúde e educação.

Além, da inserção social, buscam-se:

- o prazer pelo esporte;
- a melhoria da autoestima, bem-estar, autoconfiança e da qualidade de vida.

2. NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO

No município de Nova Mutum, a Equoterapia – enquanto prática para reabilitação dos praticantes que vão usufruir deste método – e equitação – enquanto prática que desenvolverá uma série de outros benefícios complementares a Equoterapia –, funcionarão em parceria entre a Prefeitura Municipal através Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de

Estado de Segurança Pública por meio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – 1° Esquadrão Independente de Policiamento Montado – Cavalaria de Nova Mutum. A Equoterapia se tratará de um serviço público e obedecerá aos princípios doutrinários do SUS de:

Universalidade: determina que todos os cidadãos brasileiros, independentemente de classe social, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde.

Integralidade: está relacionada à condição integral, e não parcial, de compreensão do ser humano. Ou seja; o sistema de saúde deve estar preparado para ouvir o usuário, entendê-lo inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender as demandas e necessidades dessa pessoa – em síntese, este princípio trata-se da compreensão do ser humano como um ser biopsicossocial.

Equidade: se apresenta nos atendimentos aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. Através desse princípio se reconhecem as diferenças nas condições de vida e saúde e das necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender a diversidade (Ascom SE/UNA-SUS, 2015).

2.1. PORTA DE ENTRADA

Considerando o vínculo da Equoterapia com a Secretaria de Saúde do Município de Nova Mutum, a porta de entrada para início das práticas equoterápicas será à **Atenção Básica**. Todo praticante, independentemente da classe social, deverá pertencer a rede de saúde do município e estar com seu cadastro atualizado, sem exceções.

Portanto, o acesso ao serviço de Equoterapia será realizado, a princípio, através das Unidades Básicas de Saúde – onde a equipe multidisciplinar, terá a liberdade de indicar o candidato à prática da Equoterapia. Para isso, a equipe em questão, deverá realizar uma anamnese completa (sendo uma específica para crianças e outra para adultos) **(em anexo)**, que será encaminhada à equipe multidisciplinar da Equoterapia.

Os casos que serão encaminhados à Equipe da Equoterapia deverão ser pensados e analisados criteriosamente pela equipe multiprofissional das Unidades Básicas de Saúde do Município.

É importante salientar, que os **critérios obrigatórios** para a indicação à Equoterapia são:

- Candidato a praticante ser pessoa com deficiência - cabe salientar que de acordo com o **Art. 2º da LEI 13.146 de 6 de Julho de 2015**, "Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Brasil, 2015).
- Candidato à praticante residir há no mínimo 03 meses no município de Nova Mutum – MT (com exceção das indicações da Cavalaria);
- Estar devidamente cadastrado no Sistema Único de saúde do Município.

Já os **critérios relevantes** para a indicação à Equoterapia são:

- Candidato estar passando ou já ter passado por acompanhamento na Unidade Básica de Saúde de origem (Seja por Fono, Fisio ou Psico) – o que facilitará o preenchimento completo da Anamnese, cujos dados são de **EXTREMA RELEVÂNCIA** para posterior avaliação;

2.2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO CANDIDATO A PRATICANTE DA EQUOTERAPIA (ANAMNESE INFANTIL E ADULTA).

O preenchimento das anamneses – infantil ou adulta – (**em anexo**), vai consolidar o primeiro acesso do candidato a praticante à porta de entrada do SUS – Atenção Básica.

Portanto, pedimos que a equipe multiprofissional a preencha de maneira completa e rigorosa, visto que a mesma se trata de um documento essencial, que servirá de base para as avaliações realizadas posteriormente e para o planejamento individual das sessões de cada praticante que será atendido no Centro de Equoterapia.

A anamnese abrange dados que **poderão ser preenchidos por diversos profissionais da Atenção Básica**, incluindo: Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Fisioterapeutas e Fonoaudiólogos – Como sugestão, a **anamnese infantil** – que contempla uma quantidade maior de informações – foi divida por partes que concernem a diferentes profissionais, entretanto, ficará a critério de cada Unidade pensar na realização completa desse preenchimento, envolvendo todos os profissionais acima mencionados (ou não) – a depender de cada Unidade.

2.2. FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUOTERAPIA

Recebendo a anamnese realizada pela equipe multidisciplinar da Atenção Básica, a equipe da Equoterapia realizará posteriores avaliações **(em anexo):** médica, fisioterápica e psicológica**.** A depender do caso, haverá reencaminhamento para avaliação de médico especialista (neurologista e/ ou psiquiatra, ortopedista, etc); a este, será enviada pela equipe multidisciplinar, carta de solicitação para avaliação complementar **(em anexo).**

Finalizando todas as avaliações necessárias e após o candidato a praticante ser considerado apto para a Equoterapia, a equipe multidisciplinar se reunirá para criar o planejamento individual para ao praticante, em questão **(ficha de planejamento individual em anexo).**

2.2.1. O MÉDICO NA EQUOTERAPIA

O médico integrante da equipe dará atendimento institucional, sendo um dos responsáveis pela avaliação à prática equoterápica, devendo ter um tempo disponibilizado apenas para análises e avaliações dos candidatos a praticante da Equoterapia, procedendo a avaliação com o objetivo de indicar/contraindicar a prática da Equoterapia e realizar avaliações periódicas acompanhado da equipe multidisciplinar, para verificação de progressos e altas terapêuticas.

2.2.2. EQUIPE DE ATENDIMENTO EQUOTERÁPICO

O Centro de Equoterapia irá dispor de uma equipe constituída por profissionais das áreas de saúde e equitação, atuando de forma interdisciplinar, sendo a equipe mínima de atendimento composta inicialmente por: **Médico, Fisioterapeuta, Psicólogo e Equitador.**

As principais atribuições da equipe serão:

• Avaliar cada praticante antes do início do tratamento;

• Estabelecer os objetivos do tratamento para cada praticante e planejar as atividades a serem desenvolvidas;

• Conduzir as sessões de Equoterapia, seguindo o plano proposto;

• Reavaliar periodicamente, o desenvolvimento de cada praticante, para eventual modificação no programa;

• Zelar permanentemente pela segurança dos praticantes.

3. ATENDIMENTOS EQUOTERÁPICOS

A *priori* serão disponibilizadas **20 vagas** para praticantes no Centro de Equoterapia. Das 20 vagas, 30% serão direcionadas à Cavalaria – que indicará os praticantes para a Anamnese e avaliações posteriores: médica, psicológica, fisioterápica e com médico especialista (se necessário).

O tempo máximo de duração das práticas serão de **12 meses** para cada praticante. Entretanto, este tempo de permanência poderá ser reduzido em casos específicos após análise da equipe multiprofissional, conforme disposto em Termo de Compromisso **(em anexo).**

Serão toleradas apenas 02 faltas sem justificativas de cada praticante, caso esse número seja excedido, haverá o desligamento do praticante.

Os atendimentos em Equoterapia serão mediados pela equipe de saúde (fisioterapeuta e psicóloga, a princípio) e contará com o auxílio da equipe de apoio (auxiliar guia, auxiliar lateral e tratador).

Os mediadores, ao final de cada prática, farão o registro das sessões em fichas individuais **(em anexo)**, a fim de acompanharem a evolução dos praticantes a cada sessão de Equoterapia.

3.1. EQUIPE DE APOIO

Os integrantes da equipe de apoio desempenharão tarefas em estreita ligação com pessoas com deficiência.

O auxiliar-guia é a pessoa que conduz, com a maior atenção possível, o cavalo do praticante. Deve estar sempre atento às orientações do mediador e às reações do animal.

O auxiliar lateral é aquele que, durante a sessão, acompanha o praticante, seguindo as diretrizes do mediador com especial atenção na segurança.

O tratador desempenha os cuidados básicos com os cavalos e com as instalações Equestres e pode atuar, também, como auxiliar-guia.

4. REFERÊNCIAS

CURSO Básico de Equoterapia. Brasília: Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão - Coepe, 2000. 202 p.

BRASIL. Constituição (1990). Lei nº 8080/1990, de 19 de setembro de 1990. **Dos Princípios e Diretrizes do SUS**. Brasília, 1990.

BRASIL. Constituição (2015). Lei nº 13.146 de 6 de Julho de 2015. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Brasília. 2015.

BRASIL. Constituição (2019). Lei nº 13.830/2019, de 13 de maio de 2019. **Prática da Equoterapia**. Brasília, 2019.

SE/UNA-SUS, Ascom. **Você sabe o que é equidade?** 2015. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/voce-sabe-o-que-e-equidade#:~:text=No%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde,a%20quem%20requer%20menos%20cuidados.. Acesso em: 14 fev. 2023.

FIOCRUZ. **Atenção Básica**. Disponível em: https://pensesus.fiocruz.br/atencao-basica. Acesso em: 14 fev. 2023.

5. ANEXOS

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO CANDIDATO A PRATICANTE DA EQUOTERAPIA

ANAMNESE (INFATIL)

(Sugestão: Se possível, Médico/Enfermagem preencher)

1. Identificação:

Nome: _____
Nascimento: ____/____/____ **Idade**: _____ **Sexo**: ( ) M ( ) F
Local de Nascimento:_____
Com quem vive:_____
Unidade Básica de Origem: _____
Telefone Para Contato:_____
Profissional (ais) responsável (s) pela execução da Anamnese:
( ) Médico/Enfermagem
( ) Fonoaudióloga
( ) Fisioterapeuta
( ) Psicólogo

Candidato a praticante por:
( ) Indicação da Cavalaria
( ) Fluxo da Atenção Básica

2. Filiação:

PAI: _____
MÃE:_____

Idade (**Mãe**) _____ Idade (**Pai**) _____

Profissão _____ Profissão _____

Renda mensal da Família:_____

2.1: Irmãos:

Tem irmãos? S( ) N( ) Quantos irmãos? _____ Idade **_____.**

3. Antecedentes pessoais

3.1. Concepção

A Mãe era saudável? Se não, qual era o motivo?_____
O Pai era saudável? Se não, qual era o motivo?_____

4. Gravidez

Planejada ( ) Não planejada ( )

Quantas gravidezes (anteriores e posteriores) teve a Mãe?_____
Teve abortos? ____ Quantos? ____ n° de gravidez _____
Teve natimortos?____Quantos ____ n° de gravidez _____
Prematuro? _____Quantos? ____ n° de gravidez _____

4.1. Gestação

Vigilância médica pré-natal: Fez algum tratamento?_____

Durante quanto tempo? _____

Sofreu alguma(s) doença(s) ou perturbação (ões) durante a gestação?

_____

Tomou algum medicamento? Qual? _____

5. Patologia atual:_____

Medicação em uso (caso tenha):_____

6. Desenvolvimento

6.1. Respiração ao dormir:

Regular ( ) Só pela boca ( )
Barulhenta ( ) Só pelo nariz ( )

Tem enurese quando dorme? _____.

6.2. Alimentação:

Que tipo de leite mamou após o nascimento?

Leite materno? ( ) Outro ( ) Qual ? _____

A criança tem apetite? _____

Demora para comer? _____

Tem algum(s) alimento(s) preferido(s)? Qual(ais)?

_____

_____

Recusa comer algum(ns) alimentos(s)? Qual(ais)?

_____

_____

Gosta de provar alimentos novos?

_____

_____

Local das refeições:

_____

_____

Peso atual da criança:_____. Altura atual da criança: _____.

7. Dados Clínicos

Está saudável atualmente? ( ) Sim ( ) Não

Que tipo de doença já apresentou? E em que idade?

_____

_____

Tem o boletim de vacinas em dia? _____.

Existe (m) alguma (s) doença (s) familiar (es) hereditária (s)?

_____

_____

Tem alguma alergia?

_____

_____

A criança tem alguma deficiência? ( ) Sim ( ) Não

Qual (ais)? _____ Quando foi detectada? _____

Já esteve hospitalizado (a)?

_____

_____

Alguma vez foi operado?

_____

_____

(Sugestão: Se possível, Fonoaudiólogo preencher)

8. Linguagem

Atualmente a criança apresenta algum problema de linguagem? Qual (ais)?

_____

_____

Faz terapia da fala?

_____

_____

Quais intervenções já foram realizadas?

_____

_____

_____

Em quais aspectos da linguagem já evoluiu?

_____

_____

(Sugestão: Se possível, Fisioterapeuta preencher)

9. Alguns dados referentes ao nascimento:

Tempo de gravidez? Semanas: _____
Parto Normal ( ) Cesária ( )

Local de nascimento da criança: Hospital ( ) Qual? _____.
O parto foi assistido? Qual a duração? _____

Primeiras reações da criança:

Chorou logo? _____ Durante quanto tempo?_____.

Precisou de oxigênio? _____

APGAR ao minuto_____.

Outros dados relevantes sobre o

nascimento:_____

_____

Perímetro cefálico:_____.

Peso Kg: _____

Comprimento/ medida (cm): _____

Apresentou alguma(s) doença(s) logo após o nascimento? _____

10. Motricidade

Quando segurou a cabeça?

_____

Quando se sentou a criança sem apoio?

_____

Engatinhou? Até quando?

_____

Quando se pôs de pé sozinhos apoiando-se?

_____

Quando deu os primeiros passos?

_____

Quando começou andar firme?

_____

Lateralidade definida? Dominância de pé e mão?

_____

Com que idade se definiu a lateralidade?

_____

Apresenta algum tipo de descontrole de movimentos?

_____

11. Controle dos Esfíncteres

Fecal ( ) Urinário ( )

(Sugestão: Se possível, Psicólogo preencher)

12. Hábitos

Atividades de ocupação dos tempos livres:

_____

_____

13. Sociabilidade

Pessoas com quem gosta de se relacionar:

_____

_____

Situação acadêmica atual:

Que ano frequenta?_____

Nível de ensino:_____

Qual (ais) e (são) a(s) disciplinas(s) preferida(s)? _____.

Como é que se comporta na escola ao nível: Das aquisições? Do comportamento com os professore? Do comportamento com os colegas?

_____

_____

_____

Apresenta dificuldades escolares? Quais?

_____

_____

14. Enquadramento Familiar e Social

Os pais tem tempo para estar com o (a) filho (a)? _____

Durante a semana _____ Durante o fim de semana? _____ nas férias _____

A quem fica entregue na ausência dos pais? _____

Evita a companhia dos outros:

( ) adultos ( ) jovens ( ) crianças

Preocupa-se quando separado (a) dos pais? _____

Em que circunstâncias? _____

Tem animal (ais) de estimação? _____

Objetos lúdicos que utiliza em casa:

Jogos ( ) bolas ( ) Automóveis ( ) miniaturas ( ) computador ( ).

Instrumentos musicais ( ) livros ( ) bicicletas ( ).

15. Escolaridade

Ensino: ( ) Particular ( ) Público

É: ( ) calmo ( ) nervoso ( ) hiperativo

Como é que se adaptou:

Ao ritmo e às regras impostas pela estrutura escolar?

_____

_____

Aos colegas e aos professores?

_____

_____

O seu comportamento se altera na presença de estranhos?

_____

_____

Como reage às novidades (pessoas, locais, brincadeiras...)?

_____

_____

Tem companheiros? _____ Faz amigos? _____

Quem São? São escolhidos por ele (a)?

_____

_____

Como se dá com eles?

_____

_____

Que tipo de atividades lúdicas prefere?

_____

_____

Quanto tempo se dedica a mesma atividade?

_____

Como se adapta a novos espaços?

_____

_____

16. Autonomia

Manifesta alguma autonomia?

Em casa: no banho ( ) Vestir/despir ( ) Higiene ( ) Outros ( )

Quais? _____

_____

Assinatura/Carimbo do Profissional

Data de preenchimento: _____ de _____ de _____

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO CANDIDATO A PRATICANTE DA EQUOTERAPIA

ANAMNESE (ADULTA)

1. Identificação:

Nome: _____
Nascimento: ____/____/____ **Idade**: _____ **Sexo**: ( ) M ( ) F
Local de Nascimento:_____
Com quem vive:_____
Unidade Básica de Origem: _____
Telefone Para Contato:_____
Profissão:_____

Renda mensal da Família:_____

Profissional (ais) responsável (s) pela execução da Anamnese:
( ) Médico/Enfermagem
( ) Fonoaudióloga
( ) Fisioterapeuta
( ) Psicólogo

Candidato a praticante por:
( ) Indicação da Cavalaria
( ) Fluxo da Atenção Básica

2. Diagnóstico/condição:_____

Medicação em uso (caso tenha):_____

3. Informações acerca do desenvolvimento da patologia:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4. Dados Clínicos

Está saudável atualmente? ( ) Sim ( ) Não

Que tipo de doença já apresentou? E em que idade?

_____

_____

_____

_____

Tem o boletim de vacinas em dia? _____.

Existe (m) alguma (s) doença (s) familiar (es) hereditária (s)?

_____

_____

Tem alguma alergia?

_____

_____

5. Autonomia

Manifesta alguma autonomia?

Em casa: no banho ( ) Vestir/despir ( ) Higiene ( ) Outros ( )

Quais? _____

6. Outros dados relevantes

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Assinatura/Carimbo do Profissional

Data de preenchimento: _____ de _____ de _____.

NOVA MUTUM
PREFEITURA

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS

AVALIAÇÃO MÉDICA

1. DADOS DO AVALIADO

Nome:_____
Data de Nascimento:____/____/_____ Sexo:_____ Peso:_____ Altura:_____
Diagnóstico:_____ Etiologia:_____
Tipo sanguíneo:_____ Fator RH_____

2. DADOS DO AVALIADOR

Nome: _____ CRM:_____
Telefone:_____ E-mail:_____
É seu paciente habitual?_____ Há quanto tempo?_____

I – ASPECTOS GERAIS

O PACIENTE TEM:

1. Lesão cerebral ( )
2. Distúrbio muscular ( )
3. Distúrbio de marcha ( )
4. Epilepsia ( )
5. Linguagem oral desenvolvida ( )
6. Déficit cognitivo ( )
7. Cromossomopatia ( )

Obs:
_____
_____
_____
_____
_____

II – ALTERAÇÕES

Indique as alterações que correspondem ao seu paciente, de acordo com sua resposta nos itens anteriores:

1. LESÃO CEREBRAL POR:

1. Isquemia ( )
2. Hemorragia ( )
3. Tumor ( )
4. Malformação ( )
5. TCE ( )

Obs:

_____
_____
_____
_____
_____

2. DISTÚRBIOS MUSCULARES POR:

1. Lesão periférica ( )
2. Lesão central ( )

2.1. Em função disso, ele apresenta:
Atrofia ( ) hipotonia ( ) hipertrofia de panturrilhas ( ) fraqueza muscular generalizada ( )
2.2. O membro ou os membros afetados são:
mmss: esquerdo ( ) direito ( ) ambos ( )
mmii: esquerdo ( ) direito ( ) ambos ( )

Obs:

_____
_____
_____
_____
_____

3. DISTÚRBIO DE MARCHA:

3.1. Tipo:
Ceifante ( ) atáxica ( ) talonante ( ) espástica ( ) de pequenos passos ( )

3.2. Classificação:
Hemiplégico ( )
Hemiparético ( )
Tetraparético ( )
Paraparético ( )
Cerebelar ( )
Parkinsoniano ( )

Obs:

_____
_____
_____
_____
_____

4. EPILEPSIA:
Está controlada ( ) parcialmente controlada ( ) usa monoterapia ( ) usa politerapia ( )

4.1. Apresenta crises generalizadas:
Tcg ( ) clônicas ( ) mioclônicas ( ) atônicas ( ) ausências ( )

4.2. Apresenta crises parciais:
Facial ( )
Hemicorpo: direito ( ) esquerdo ( )
Envolve somente o membro superior: direito ( ) esquerdo ( )
Envolve somente o membro inferior: direito ( ) esquerdo ( )

4.3. Presença de aura:
Sim ( ) Não ( )
Tipo: _____.

Obs:
_____
_____
_____
_____
_____

5. LINGUAGEM ORAL:
5.1. O desenvolvimento da linguagem oral foi normal?
Sim ( ) Não ( )

5.2. Causa do déficit de linguagem:
Distúrbio psíquico ( ) deficiência sensorial ( )

5.3. Se tem deficiência auditiva, a causa foi:
Congênita ( ) Adquirida ( )

6. DÉFICIT COGNITIVO
6.1. Entende ordens ( ) às vezes ( )
6.2. Atende ao comando verbal ( ) às vezes ( )
6.3. Apresenta distúrbio de compreensão ( )
6.4. Tem distúrbio de atenção ( )
6.5. Tem hiperatividade ( )
6.6. Frequenta escola especial ( )

Obs:
_____
_____
_____
_____
_____

NOVA MUTUM
PREFEITURA

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS

III – INDICAÇÃO MÉDICA

JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DA EQUOTERAPIA:

Local e data_____,_____ de _____ de _____.

_____
Assinatura e carimbo

NOVA MUTUM PREFEITURA | SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS

AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA

1 – DADOS DO AVALIADO

Nome:_____
Data de nascimento:____/____/_____ Sexo: ____ Peso: _____ Altura:_____
Escolaridade:_____
Nome Responsável: _____
Telefone: ( ) _____

2 – DIAGNÓSTICO CLÍNICO

_____
_____

3 – ANAMNESE

_____
_____
_____
_____

4 – EXAMES COMPLEMENTARES

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

7 – HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR

Controle cervical e de tronco/Rolar/Engatinhar/Deambular/Falar

_____
_____

8 – ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

_____
_____
_____

9 – EXAME FÍSICO

9.1. – Inspeção / Palpação / Tônus Muscular/Marcha/ Equilibrio Estático e Dinâmico:

_____
_____
_____

10 – PARECER FISIOTERÁPICO

_____
_____
_____
_____
_____

Local e data:_____,____de_____de_____.

_____
Assinatura e carimbo

NOVA MUTUM PREFEITURA | SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Dados do Avaliado:

Nome completo:_____

Data de Nascimento ____/____/____

Responsável legal: _____

Diagnóstico_____

Idade em que recebeu o diagnóstico:_____

Dados do Avaliador:

Nome _____CRP: 18/_____

Tel para contato: (65) _____.

1. É seu paciente habitual ( ) Não Sim ( )

2. Já fez Equoterapia antes ( ) Não Sim ( ) onde e a quanto tempo?_____

_____

3. Medicações e Terapias complementares:

_____

_____

_____

4. Situação Escolar e/ou de Trabalho:

_____

_____

_____

5. Déficit Cognitivo:

_____

_____

_____

6. Atenção/Concentração:

_____
_____
_____

7. Distúrbio de Comportamento:

_____
_____
_____

8. Rotina

8.1. Atividades da vida diária:

Sono:

_____

Alimentação

_____
_____
_____

Brincadeiras (onde, como):

_____
_____
_____

Aceita mudança em sua rotina?

_____

9. Traços de Personalidade (Comportamento, pensamento e emoção)

( ) Extroversão ( ) fobia ( ) obsessão ( ) Psicoticismo

( ) Introversão ( ) Ansiedade ( ) Histeria ( ) Amabilidade

( ) Impulsividade ( ) Neuroticismo ( ) Diligencia

Outros: _____

10. Socialização

( ) Interage bem ( ) tem oportunidade de contato ( ) expressa afetos

Interação: ( ) adequada ( ) Barganha ( ) indiferença

( ) Birras ( ) Solicitação ( ) Pró-socialbilidade

Outros _____

Como é o contato social no ambiente escolar?

_____
_____
_____

Relação com a família:

_____
_____
_____

Educação (limites, castigos e repreensões):

_____
_____
_____

Tem irmãos? Quantos? _____

E superprotegido? ( ) Não ( ) Sim Por quem: _____

11. Comunicação e Linguagem

Aquisição de linguagem ( ) Não ( ) Sim com que idade: _____

Como se comunica:

( ) Verbal ( ) Não verbal ( ) Ecolalia

É entendido quando fala ( ) relata experiências ( ) tem sequência de pensamentos ( )

Entende ordens? Quais? _____

12. Desenvolvimento Psicomotor

Conhece partes do corpo ( ) Lateralidade definida ( )

12.1. Estruturação Espaço Temporal

Reconhece: ( ) em cima ( ) atrás ( ) direita

( ) em baixo ( ) na frente ( ) esquerda ( ) ao lado

Noção de tempo: ( ) Noções de meses do ano

( ) noções de durações de situações ( ) noções de manhã e tarde

( ) Memória de curto prazo ( ) Memória de longo prazo

Grafismo: ( ) rabisca espontaneamente ( ) Garantuja desordenadamente

( ) Garantuja com atribuições de significado

13. Conteúdos de Vivência

Como acredita que a Equoterapia pode ajudar?

_____
_____
_____
_____

Justificativa para inserção na Equoterapia:

_____
_____
_____
_____

14. Outras informações relevantes:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Nova Mutum, ___ de _____ de _____.

_____

Assinatura/ Carimbo

NOVA MUTUM PREFEITURA | SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS

EQUOTERAPIA
NOVA MUTUM – MT

Prezado (a) Médico (a),

Seu paciente, _____, está interessado em participar de atividades equoterápicas.

Para que possamos oferecer um atendimento seguro e de qualidade, nosso centro requisita o preenchimento criterioso da **avaliação médica** anexa. É importante esclarecer que algumas condições clínicas necessitam de uma **análise mais aprofundada**, pois podem exigir **precauções** ou mesmo **contraindicar** a prática equoterápica em função do grau de comprometimento do seu paciente.

Portanto, durante o preenchimento da avaliação médica, caso seu paciente apresente algumas das situações abaixo citadas, pedimos por gentileza, especificar com clareza, a justificativa da indicação à prática da Equoterapia.

1. Ortopédicas
- Artrogripose
- Instabilidade atlantoaxial
- Craniotomia
- Luxação ou deslocamento de quadril
- Osteoporose de moderada a severa
- Osteogênese imperfeita com fraturas frequente e escoliose significativa
- Fusão ou fixação cirúrgica da coluna
- Órteses espinhais
- Cifose e lordose – se há desencadeamento de dor com atividades físicas
- Escoliose – se a curvatura for maior que 30 graus.

2. Neurológicas
- Hidrocefalia com shunt e sem controle cervical
- Distrofia muscular e miopatias se o paciente referir fadiga fácil
- Mielodisplasias, mielomeningocele, espinha bífida cística – se o paciente tem dificuldade em manter uma postura sentada confortável, sem provocar lordose ou cifose excessiva
- Má formação de Chiari – se o paciente não estiver bem controlado
- Epilepsia com crises atônicas sem controle ou com qualquer tipo de crise – se as mesmas se repetem muitas vezes no dia
- Aneurisma ou angioma cerebral – não resolvido cirurgicamente
- Distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção – se o paciente tem tendências a agressividade e maus tratos a animais.

3. Psicológicas
- Abuso físico, sexual e emocional
- Confusão mental
- Oscilações do estado mental
- Tendência a delírios
- Auto e heteroagressividade

4. Outras causas
- Hipertensão sem controle
- Distúrbio vesicular periférico
- Alergias

- Comprometimentos respiratórios
- Distúrbios cardíacos (congênitos, uso de marca passo, infartos repetidos)
- Diabetes sem controle
- Obesidade

Agradecemos a sua assistência e dedicação. Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

NOVA MUTUM
PREFEITURA

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR

Solicito a avaliação:

	Neurológica
	Psiquiátrica
	Fisioterápica
	Psicopedagógica
	Outros (especificar): _____

Do Praticante de Equoterapia:

_____

Justificativa:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Nova Mutum, ____ de _____ de _____.

_____
Carimbo e identificação do solicitante

NOVA MUTUM
PREFEITURA

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS

PLANEJAMENTO INDIVIDUAL

Ano:_____

Praticante: _____
Início das práticas ____/____/____ D.N ____/____/____ Idade: _____

Programa Equoterápico:
_____

Diagnóstico/ Características:
_____

Objetivos:
Geral:
_____
_____
_____

Específicos:

Estratégias a serem utilizadas:

Cuidados Especiais:

_____
_____
_____
_____
_____

Mediador da Sessão: _____.
Equitador:_____.
Cavalo:_____.

Critérios de Reavaliação:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____.

Nova Mutum, ____ de _____ de _____.

_____

Carimbo

NOVA MUTUM
PREFEITURA

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO DO TRATAMENTO EQUOTERÁPICO

O sucesso do tratamento depende principalmente da rigorosa observância das normas que o Centro de Equoterapia ELO estabelece a seu praticante. Em consequência disto, é necessário cumprir o seguinte:

1. A entrada do público externo ao Centro de Equoterapia dar-se-a pelo portão principal da Unidade Militar, devendo se identificar à algum Policial Militar, no momento da chegada.

2. Aos praticantes e seus acompanhantes será autorizado a entrada e permanencia na área destinada ao Centro de Equoterapia/pátio/estacionamento. No setor de baias, piquetes, selaria/ferradoria do esquadrão, mediante acompanhamento de algum militar.

3. O uso de capacete é obrigatório. Cada praticante poderá adquirir o seu (caso prefira) em lojas especializadas. O centro de Equoterapia ELO também disponibilizará capacetes adequados aos praticantes. Somente o mediador poderá suspender o uso do capacete pelo praticante.

4. O praticante deverá vestir-se apropriadamente, sendo obrigatório o uso de calças compridas de tecido maleável, confortável e de cores neutras, juntamente com um calçado fechado como bota ou tênis. Não será permitido o uso de "short", saia, bermuda, sandália, chinelo e calça jeans. Não é recomendado o uso de acessórios como brincos, colares, pulseiras e relógios.

5. Pais e/ou responsáveis não poderão acompanhar as sessões equoterápicas ao lado do cavalo, somente quando convidados pelo mediador. Em caso de dúvidas, questionamentos e sugestões, os mesmos deverão ser apresentados ao mediador somente **após** o término da sessão.

6. Animais de estimação não serão permitidos no Centro de Equoterapia ELO.

7. A frequência as sessões equoterápicas e a pontualidade contribuem decisivamente para o desenvolvimento do praticante.

8. Em caso de ausência do praticante, não haverá reposição da sessão, visto que cada praticante tem o seu horário pré-agendado.

9. É importante **comunicar a falta** do praticante à sessão, em caso de imprevistos.

10. No caso de **02 faltas** sem justificativa, o praticante será automaticamente desligado da Equoterapia.

11. A tolerância máxima para o início de cada sessão será de **15 min**, após esse prazo a sessão será cancelada ou sofrerá alterações significativas em decorrência do atraso.

12. O atraso máximo permitido ao mediador é de 10 min, o que não acarretará em diminuição do horário normal da sessão.

13. O tempo previsto de duração da sessão equoterápica no programa hipoterapia é de 30 min. Educação/Reeducação - 30 min; Pré-Esportivo - 30 min e Esportivo - 40 min. Em cada tempo pré-determinado está inclusa a fase de aproximação, o processo de montar e apear e também a fase de despedida do cavalo.

14. O tempo de duração máximo do tratamento equoterápico neste Centro de Equoterapia é de 01 um ano letivo para cada praticante. Entretanto, este tempo de permanência poderá ser reduzido, em casos específicos, após análise da equipe multiprofissional.

15. No caso de haver interrupção definitiva do tratamento, dentro do período pré-determinado o responsável pelo praticante obriga-se a assinar um termo declarando o motivo, com a finalidade de resgatar os interesses de ambas as partes.

16. Não haverá reposição das sessões canceladas quando da realização de cursos de formação em Equoterapia e outros eventos que exijam a participação da equipe multiprofissional.

17. Em caso de emergências, o Centro de Equoterapia ELO contará com um Kit de Primeiros Socorros e se necessário, será acionada uma ambulância.

18. Nesse Centro de Equoterapia, há um compromisso da equipe em relação às necessidades físicas, fisiológicas e psicológicas dos cavalos, principalmente com relação ao peso do praticante versus esforço físico gerado ao cavalo. O praticante não pode pesar mais do que 20% do peso do animal. Atualmente o peso limite para atendimento nesse centro é de 85 kg.

Nova Mutum, ____ de _____ de _____.

Ciente:_____
Assinatura do Praticante ou responsável

NOVA MUTUM PREFEITURA | SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUS

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como principal agente do tratamento. O cavalo de Equoterapia é especialmente treinado e condicionado para realizar suas tarefas. Entretanto, é um ser vivo com características físicas, fisiológicas e psicológicas peculiares. Desta maneira ele está sujeito a algumas alterações comportamentais naturais e/ou causadas por fatores externos não previsíveis, que podem gerar riscos aos praticantes.

O Centro de Equoterapia ELO possui uma equipe multiprofissional treinada e qualificada nos procedimentos básicos de emergência requeridos nessa terapia. O Centro contará também com um kit de primeiros socorros e em casos de acidentes mais graves, uma ambulância será acionada.

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,_____responsabilizo-me pela participação do praticante _____

nas atividades equoterápicas, conhecendo os benefícios da terapia, bem como os seus riscos. Estou ciente que a equipe multiprofissional estará atenta para reduzir os riscos dos possíveis acidentes. Entendo que o Centro de Equoterapia ELO e sua equipe multiprofissional, seus dirigentes, funcionários, voluntários e estagiários, assumirão a responsabilidade de tomar as medidas iniciais, dentro dos protocolos previstos – de dispor de Kit de primeiros socorros e de acionar uma ambulância, se necessário –, em face de qualquer acidente que o praticante possa vir a sofrer durante a terapia com o cavalo.

Nova Mutum, _____ de _____de_____.

_____

Assinatura do Responsável

2. LIBERAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

Eu, _____ responsável, autorizo a divulgação de imagem e voz do/da praticante_____.

Sendo assim, o Centro de Equoterapia ELO, em parceria com o 1° Esquadrão Independente de Policiamento Montado – Cavalaria e a Prefeitura Municipal de Nova Mutum poderá utilizar e reproduzir as imagens colhidas em vídeo e foto durante a terapia para divulgação dos benefícios da Equoterapia em entrevistas, material impresso, congressos, atividades educacionais e outros.

Nova Mutum, _____ de _____de_____.

_____

Assinatura do Responsável

3. LIBERAÇÃO DE DADOS

Eu, _____ responsável, autorizo o Centro de Equoterapia ELO, em parceria com o 1° Esquadrão Independente de Policiamento Montado – Cavalaria e a Prefeitura Municipal de Nova Mutum a utilizar os registros e as avaliações do praticante já mencionado para estudos e pesquisas científicas.

Nova Mutum, _____ de _____de_____.

_____

Assinatura do Responsável

RELATÓRIO DIÁRIO

NOVA MUTUM
PREFEITURA

SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS

Praticante:_____
Mediador:_____
Turma:_____ Data:___/____/_____
Cavalo:_____ Arreamento:_____ Guia:_____
Montar:_____ Apear:_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

RELATÓRIO DIÁRIO

Praticante:_____
Mediador:_____
Turma:_____ Data:___/____/_____
Cavalo:_____ Arreamento:_____ Guia:_____
Montar:_____ Apear:_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM – MT

ESTADO DE MATO GROSSO – CNPJ: 24.772.162/0001-06

Endereço Eletrônico: admsaude@novamutum.mt.gov.br

MANUAL DE PEDIATRIA

NOVA MUTUM – MT

FEVEREIRO - 2019

MANUAL DE PEDIATRIA

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

ANKE HELGA SCHWABE
Secretária Municipal de Saúde

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:
CLÁUDIA CRISTIANE KNOB
ELISANE DELLA MEA
EMERSON OLIVEIRA
LEILA SIMONE RAIMUNDI
LUANE DE SOUZA TEODORO CORREA
LUCIANA ALBANO
LUCIANE MAYER
MARA DOMINGOS
MÔNICA APARECIDA DA SILVA

COLABORADORES:
ANDRESSA BÁRBARA OLIVEIRA DOS REIS
CAMILA FANTIN
FABIANA KÁTIA CORRÊA
JOÃO VICENTE BORGES DE LARA PINTO
LETÍCIA FERREIRA AGUIAR

ASSESSORIA:
FACILITA GESTÃO PÚBLICA

MANUAL DE PEDIATRIA DE NOVA MUTUM

Sumário

1 - APRESENTAÇÃO.....5
2 - INTRODUÇÃO.....6
3 – RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL DE SAÚDE.....7
4 – ATENDIMENTO AO RECÉM-NASCIDO.....9
4.1 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....9
4.2 - FLUXOGRAMA DE ACOLHIMENTO DO RN.....11
.....11
4.3 - CALENDÁRIO DE CONSULTAS.....12
4.4 - VISITA DOMICILIAR.....12
4.5 - PRIMEIRA CONSULTA DO RN.....14
5 – CONSULTAS SUBSEQUENTES.....19
5.1 – MONITORIZAÇÃO DO CRESCIMENTO.....19
5.2 – MONITORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.....21
5.3 – MONITORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO.....23
5.4 – DESENVOLVIMENTO DA AUDIÇÃO.....23
5.5 – DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM.....25
5.6 – AVALIAÇÃO DA VISÃO.....26
5.7 – RASTREAMENTO DA DISPLASIA DO QUADRIL.....26
5.8 – AVALIAÇÃO GENITAL.....27
5.8.1 - FIMOSE.....27
5.8.2 - DISTOPIA TESTICULAR.....27
5.8.3 - SINÉQUIA DE PEQUENOS LÁBIOS.....28
5.9 – AÇÕES PREVENTIVAS.....28
5.9.1 - Orientação para Atividade Física.....28
5.9.2 - Orientação sobre ingestão de álcool.....29
5.9.3 - Orientação Alimentar.....29
5.9.4 – Prevenção de acidentes.....29
6 - SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINAS E FERRO.....29
6.1 – VITAMINA D.....29

6.2 – VITAMINA A.....30
6.3 - FERRO.....30
7 - ALIMENTAÇÃO INFANTIL.....31
7.1 - ALIMENTAÇÃO DO LACTENTE.....33
7.2 - ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR.....36
7.3 - ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR.....37
8 – SAÚDE BUCAL.....39
9 – VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE.....43
9.1 - SINAIS DE VIOLÊNCIA FÍSICA.....45
9.2 - INDICATIVOS DE NEGLIGÊNCIA - OMISSÃO DE CUIDADOS.....46
9.3 - SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.....47
9.4 – FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.....49
10 – PREVENÇÃO DE ACIDENTES.....51
11 - GRUPOS DE APOIO.....54
12 - GRUPO INTERSETORIAL E MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA CRIANÇA.....55
12.1 – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE DO MARTON LUCCA (ANTIGO CAICA).....55
12.2 – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE).....55
12.3 – NAIFE (Núcleo de Acompanhamento Integrado à Família na Escola).....56
12.4 - NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).....56
13 - BIBLIOGRAFIA.....58

1 - APRESENTAÇÃO

A cidade de Nova Mutum é considerada um dos polos de desenvolvimento econômico do norte de Mato Grosso. Este quadro favorável leva à migração de uma população jovem que acaba se fixando no município e constituindo família. Em decorrência desta situação, o número de nascimentos em nosso perímetro está aumentando progressivamente tendo como consequência o crescimento da população infantil. Para exemplificar este fato, dados obtidos do SINASC mostram que a taxa de nascidos vivos aumentou 39, 68% entre os anos de 2014 e 2018.

Tabela 01: Número de Nascidos Vivos / Ano:

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
2014	70	57	67	63	77	59	61	58	67	70	57	55	761
2015	70	80	78	84	68	64	82	63	76	54	73	60	852
2016	76	68	85	100	97	75	76	81	72	65	58	73	926
2017	66	65	92	87	88	71	68	74	90	86	65	85	937
2018	80	78	86	108	92	82	109	95	82	94	75	82	1063

Fonte: SINASC Nova Mutum/2019.

Sabendo que “A criança de hoje será o adulto de amanhã, o nosso futuro”, observou-se a necessidade de garantir o adequado crescimento e desenvolvimento desta faixa etária com o seguimento ativo em nossas Unidades Básicas de Saúde.

O atendimento deve ser individualizado, tendo como base as particularidades da criança e sua família, mas não podemos esquecer que ações coletivas envolvendo a comunidade também promovem a melhora da saúde da população. Pensando neste contexto, normas básicas precisam ser padronizadas e seguidas pela equipe de saúde para oferecer um acompanhamento adequado.

O seguimento rotineiro de nossas crianças se iniciará no período gestacional se estendendo até 5 anos (4a 11m 29dias), dando ênfase aos primeiros 24 meses de vida, quando as bases do crescimento e desenvolvimento se estabelecem e medidas preventivas surtem maior efeito.

O esquema de consultas se baseará em uma classificação de risco, o que norteará a programação de cada acompanhamento. Assim crianças de baixo risco ou médio risco poderão ter um seguimento semelhante ao preconizado pelo Ministério da Saúde. Já as crianças de alto risco seguirão um calendário com maior frequência de consultas, acima do preconizado para a criança saudável.

A prioridade no seguimento do Recém Nascido de alto risco se deve pelo fato desta criança ter maior probabilidade de apresentar complicações capazes de interferir na sua qualidade de vida com um aumento na taxa de mortalidade. Porém toda a criança merece um acompanhamento regular e de qualidade o que permitirá a intervenção precoce nos problemas identificados e prevenção de outros.

Pensando na eficiência do atendimento de nossas crianças, foi elaborado este manual de puericultura e suas diretrizes deverão ser seguidas pelos profissionais de saúde. Vale lembrar que estas orientações são passíveis de mudanças, conforme o resultado de suas aplicações e as necessidades da comunidade.

2 - INTRODUÇÃO

Diante do aumento da população infantil em nosso município e visando a melhora do atendimento dispensado a este grupo, algumas padronizações nas ações da equipe de saúde foram estabelecidas e deverão ser seguidas pelos profissionais que atuam na rede pública.

O seguimento da criança em nossa rede municipal seguirá os seguintes passos:

- Durante o pré-natal serão realizados grupos de apoio com a participação de especialistas, entre eles Pediatra, Fonoaudiólogo e Dentista, a fim de reforçar o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida, orientar a dieta materna (importante para o desenvolvimento saudável do feto), ressaltar a importância da vacinação da gestante e da criança e esclarecer outros assuntos que possam gerar dúvidas na família.
- O hospital ficará responsável pela realização do Teste do Olhinho, Teste do Coração, Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha. Assim todo o recém – nascido receberá alta do hospital com estes Testes de Triagem realizados e com seus resultados registrados na Caderneta de Saúde da Criança.
- Na alta do Recém-Nascido (RN), o Hospital entregará à família o Resumo de Alta, onde deverão ser registradas informações sobre o parto, detalhes de intercorrências ocorridas, resultado dos Testes de Triagem mencionados acima e orientações oferecidas aos familiares. O momento da alta será oportuno para o profissional de saúde reforçar a importância do acompanhamento da criança em sua Unidade Básica de Saúde (UBS).
- Na Maternidade, o RN será inserido em uma classificação de risco (detalhada nas próximas páginas) e, se considerado de Alto Risco, no momento da alta será encaminhado diretamente para o Pediatra com uma consulta sendo realizada por este especialista nos primeiros 15 dias de vida.
- Nos casos em que o RN for transferido para UTI neonatal, cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) monitorar o retorno desta criança a sua residência e priorizar seu atendimento no Posto de Saúde.
- A UBS ficará responsável pela captação do RN através da visita domiciliar realizada até o quinto dia de vida quando será realizado o Teste do Pezinho pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem.
- No caso do RN já ser classificado como de Alto Risco no momento da alta hospitalar, esta visita terá a participação obrigatória do enfermeiro ou do médico da Unidade de Saúde.
- Durante a visita domiciliar, ressaltar a importância do RN ser avaliado pelo dentista e médico da Unidade de Saúde.
- A UBS poderá contar com apoio da Equipe Multiprofissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários (vide capítulo 12).
- A Classificação de Risco é um processo dinâmico e sujeito à mudanças , assim durante a visita domiciliar a criança será reavaliada quanto ao risco ,se considerada de Alto Risco terá prioridade no atendimento e será avaliada pelo Pediatra até o 15ª dia de vida. O RN tido como de baixo ou médio risco deverá seguir a rotina de consultas estabelecida neste Manual.

- Para conhecer o contexto familiar e sócio-econômico no qual a criança está inserida e o grau de vulnerabilidade a que está exposta, na primeira consulta com enfermeiro ou médico, uma anamnese detalhada deverá ser realizada e o primeiro exame físico também deverá ser minucioso, pois a detecção de anormalidades associada à intervenção precoce poderá repercutir com a melhora no desenvolvimento e crescimento desta criança.
- A Caderneta de Saúde da Criança é um instrumento que merece valorização tanto dos pais quanto do profissional de saúde. Nesta caderneta os dados de peso, comprimento/estatura e perímetro cefálico (este em menores de 2 anos) deverão ser registrados nas curvas da OMS e no espaço destinado a este propósito em todas as consultas de puericultura. No caso de prematuros, este registro deverá ser realizado pelo enfermeiro ou médico tendo como base a Idade Corrigida, cujo cálculo será explicado na parte de Monitorização do Crescimento.
- Os membros da equipe de saúde, como ACS, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, deverão sempre estar atentos à situação vacinal da criança, não perdendo momentos oportunos para esta averiguação. Para a vacinação, a idade cronológica deverá ser a referência para todas as crianças, inclusive prematuros.
- Grupos de Apoio serão formados como meio de ampliar as informações oferecidas à população e melhorar a integração entre a comunidade e a Unidade Básica de Saúde. Estes grupos terão um caráter multiprofissional e atuarão em momentos consideradas marcos no desenvolvimento infantil.

3 – RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

A descrição da competência de cada profissional pertencente à Equipe de Saúde será descrita a seguir. A interação de todas essas ações repercutirá de forma positiva no acolhimento da criança.

Consulta com médico:
-Pesar e medir o Comprimento e o Perímetro Cefálico das crianças até 18 meses de idade que forem avaliadas
-Realizar anamnese e exame clínico e registrar estas informações no prontuário
-Analisar o resultado dos exames laboratoriais e registrá-los no prontuário
-Avaliar presença de fatores de risco
-Avaliar: crescimento, desenvolvimento e estado nutricional
-Avaliar e orientar quanto à imunização
-Preencher: gráfico de peso, estatura e perímetro cefálico, Cartão da Criança e prontuário
-Diagnosticar e tratar as doenças e intercorrências .Registrar as hipóteses diagnósticas e as condutas tomadas no prontuário
-Encaminhar a criança para os serviços de referência quando necessário
-Orientar: alimentação e higiene
-Estimular o aleitamento materno.

Consulta com enfermeiro:
-Pesar e medir o Comprimento e o Perímetro Cefálico das crianças até 18 meses de idade que forem consultadas
-Realizar anamnese e exame clínico e registrar estas informações no prontuário
-Conferir o resultado dos exames laboratoriais e registrá-los no prontuário
-Avaliar presença de fatores de risco
-Avaliar: crescimento, desenvolvimento e estado nutricional
-Avaliar e orientar quanto à imunização
-Preencher: gráfico de peso, estatura e perímetro cefálico, Cartão da Criança e prontuário
-Registrar as condutas tomadas em prontuário
-Orientar sobre as doenças e intercorrências
-Orientar: alimentação e higiene
-Estimular o aleitamento materno.

Consulta com dentista:
-Realizar anamnese e exame clínico específico e registrar estas informações no prontuário
-Orientar a higiene oral
-Avaliar presença de elementos dentários
-Avaliar mobilidade da língua
-Estimular o aleitamento materno
-Registrar as condutas tomadas em prontuário
-Orientar em relação a produtos que não devem ser usados durante a higienização
-Orientar a higiene de objetos usados pela criança (como mamadeira, chupeta, panos de higiene oral)

Consulta com fonoaudiólogo:
-Realizar anamnese e exame específico e registrar estas informações no prontuário
-Avaliar e Orientar sobre Aleitamento Materno
-Realizar o Teste da Linguinha
-Registrar as condutas tomadas em prontuário
-Avaliar e Orientar sobre o Desenvolvimento da Audição, Linguagem e Fala

Atendimento do técnico de Enfermagem:
-Aplicar vacinas
-Realizar os procedimentos solicitados na consulta médica ou de enfermagem
-Realizar as ações educativas
-Realizar a busca ativa das crianças faltosas
-Registrar as condutas realizadas no prontuário
-Preencher os registros necessários

Atendimento pelo Agente Comunitário de Saúde:
-Captar precocemente as crianças para o acompanhamento
-Realizar visita domiciliar para monitoramento das crianças
-Avaliar e orientar a vacinação
-Realizar as ações educativas
-Realizar a busca ativa das crianças faltosas

4 – ATENDIMENTO AO RECÉM-NASCIDO

4.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A classificação do risco é dinâmica; pois influências ambientais, familiares e clínicas são passíveis de mudanças, assim a criança deve ser reavaliada quanto aos riscos a cada consulta.

A estratificação poderá ser realizada nos seguintes momentos:

- No Pré-Natal – para facilitar a captação

É importante que seja feito monitoramento da gestante de alto risco pela equipe de saúde e visitas semanais domiciliares pelo ACS, em especial, no último mês de gestação.

- No Nascimento

A equipe médica do hospital identifica o RN de alto risco criança e vincula o RN à UBS e ao Pediatra

- Na UBS

A classificação do RN quanto ao risco deve ser realizada na visita domiciliar e em todas as consultas, priorizando o atendimento aos considerados de alto risco.

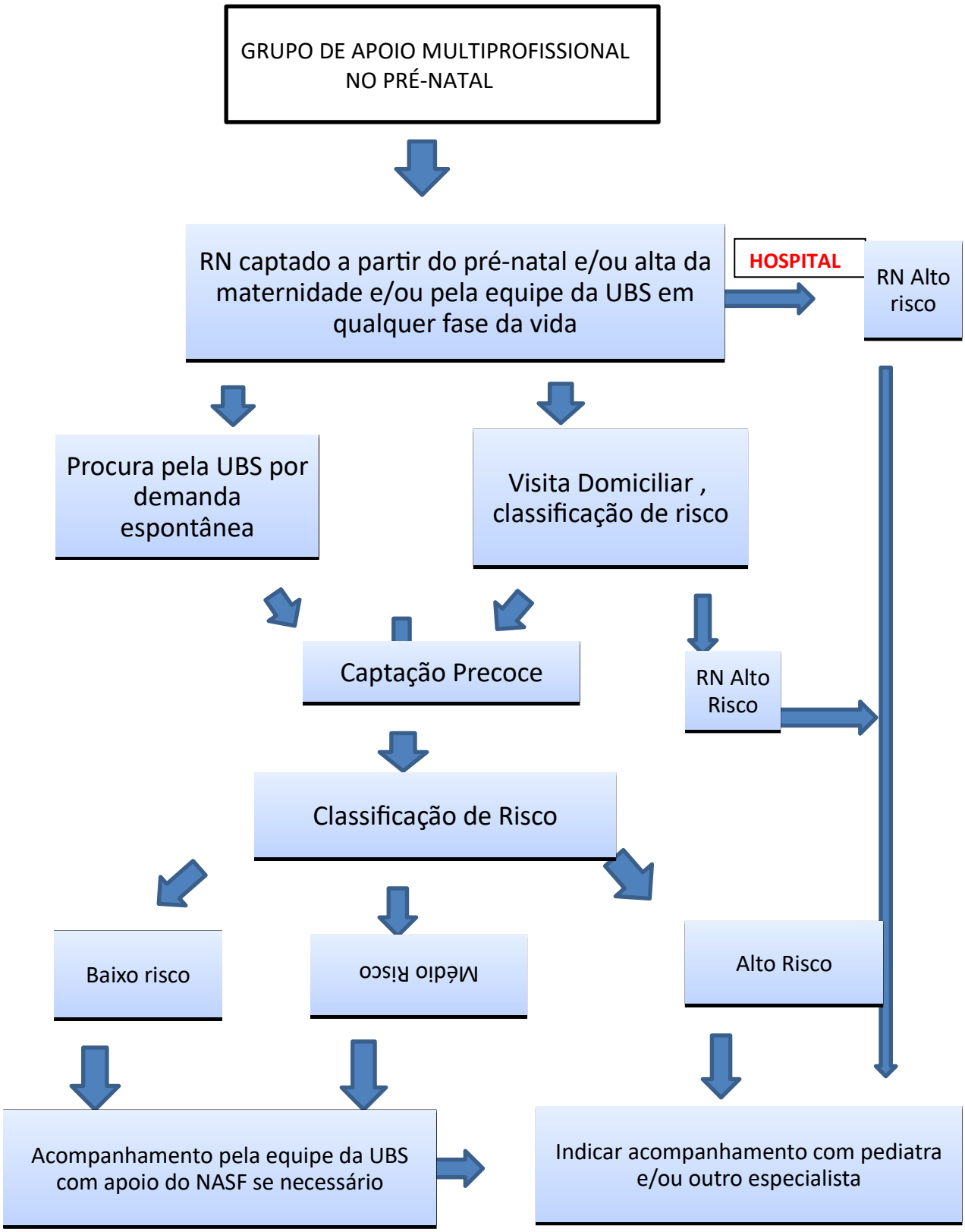
Para inserir a criança na classificação de risco, ela deverá apresentar pelo menos um dos itens descritos abaixo:

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA A CRIANÇA MENOR DE 3 ANOS

BAIXO RISCO	-criança sem intercorrência clínica e com desenvolvimento pondero estatural e neurológico adequados
MÉDIO RISCO	**A)** Fatores da criança - Baixo peso ao nascimento entre 2.000G a 2.500G - Prematuridade tardia: 35-36 semanas - Criança sem realização de triagem neonatal - Desnutrição ou curva pondero-estatural estacionária ou em declínio e/ou carências nutricionais -Sobrepeso (vide critério no tópico Monitorização do Crescimento) - Criança não vacinada ou com esquema vacinal atrasado - Cárie precoce - Internação prévia **B**) Fatores familiares - Mãe soropositiva para HIV, toxoplasmose ou sífilis, com criança negativa para estas doenças; - Mãe adolescente (menor que 18a) - Mãe com antecedente de um filho nascido morto - Óbito de irmão menor que 5 anos por causas evitáveis - Gravidez e ou Criança manifestada indesejada - Depressão pós-parto - Um dos pais com transtorno mental, deficiência, doença neurológica - Pais ou responsáveis dependentes de drogas lícitas e ilícitas.

	- Mãe ausente por doença, abandono ou óbito - Indícios de violência doméstica
ALTO RISCO	- Baixo peso ao nascimento < 2.000g - Prematuridade ≤34 semanas - Asfixia perinatal e/ou apgar ≤ 6 no 5º minuto - Infecções crônicas do grupo STORCHS + HIV + Zika confirmadas ou em investigação -Triagem neonatal positiva para hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme ou fibrose cística; - Doença genética, malformações congênitas, cromossomopatias e doenças metabólicas com repercussão clínica -Internação ou intercorrência na maternidade ou em unidade neonatal notificadas na alta hospitalar -Desenvolvimento psicomotor insatisfatório para a faixa etária - Desnutrição grave - Obesidade (Vide critério no tópico Monitorização do Crescimento) - Evolução desfavorável de qualquer doença - Sinais de violência

4.2. FLUXOGRAMA DE ACOLHIMENTO DO RN



4.3. CALENDÁRIO DE CONSULTAS

BAIXO E MÉDIO RISCO

IDADE	PROFISSIONAL
15 DIAS	CLINICO
1 MÊS	PEDIATRA
2 MESES	CLINICO
3 MESES	ENFERMEIRO
4 MESES	CLINICO
5 MESES	PEDIATRA
6 MESES	CLINICO
7 MESES	ENFERMEIRO
9 MESES	CLINICO
12 MESES	PEDIATRA
15 MESES	ENFEREMIRO
18 MESES	CLINICO
24 MESES	PEDIATRA
36 MESES	CLIN. OU ENF.
48 MESES	CLIN. OU ENF.
60 MESES	CLIN. OU ENF.
ALTO RISCO	

IDADE *	
15 DIAS	PEDIATRA
1 MÊS	CLINICO/PEDIATRA
2 MESES	CLINICO/PEDIATRA
3 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
4 MESES	CLINICO/PEDIATRA
5 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
6 MESES	CLINICO/PEDIATRA
8 MESES	CLINICO/PEDIATRA
10 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
12 MESES	CLINICO/PEDIATRA
15 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
18 MESES	CLINICO/PEDIATRA
21 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
24 MESES	CLINICO/PEDIATRA
28 MESES	ENFERMEIRO
30 MESES	PEDIATRA
32 MESES	CLINICO
36 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
42 MESES	CLINICO/PEDIATRA
48 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA
54 MESES	CLINICO/PEDIATRA

60 MESES	ENFERMEIRO/PEDIATRA

►O RN de Alto Risco será acompanhado paralelamente pelo Pediatra, assim terá uma maior frequência de avaliações.
►O RN de Médio e Alto Risco terá acompanhamento pela UBS com apoio do NASF conforme definições feitas através de discussão e/ou Projeto Terapêutico Singular.

4.4. VISITA DOMICILIAR

A visita domiciliar é uma das principais atividades preconizadas para o Agente Comunitário de Saúde (ACS) pelo Ministério da Saúde. Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto e, posteriormente a esse período.

A primeira visita domiciliar feita ao Recém Nascido deverá ter a presença de um técnico de enfermagem ou enfermeiro para a coleta do Teste do Pezinho.

Apesar de a visita domiciliar ser uma das principais atividades da ACS, ela poderá ser realizada por qualquer membro da equipe de saúde, sendo que no RN de Alto Risco, esta visita deverá ser preferencialmente realizada por um enfermeiro ou médico. Estas visitas poderão ter o apoio compartilhado da Equipe do NASF, conforme definições feitas através de discussão e/ou no Projeto Terapêutico Singular.

Cuidados com o RN - Ações da Equipe de Saúde durante visita domiciliar
- Orientar leite materno exclusivo até 6 meses de idade
- Orientar banho diário e a limpeza do RN.
- Orientar a lavagem das mãos antes de manipular o RN.
- Orientar que não se deve usar perfume ou talco no RN.
- Orientar a limpeza da região anal e perineal a cada troca de fraldas para evitar lesões na pele.
- Explicar que, nas meninas, a higiene da região anal e perineal deve ser feita no sentido da vulva para o ânus.
- Explicar a importância de cuidar adequadamente do coto umbilical para evitar infecções.
- Manter o coto umbilical sempre limpo e seco.
- Não cobrir o umbigo com faixas ou esparadrapo.
- Desaconselhar o uso de moedas, fumo ou qualquer outra substância para “curar” o umbigo.
- Manter limpo o lugar em que o RN dorme.
- Checar a Caderneta de vacinas, Caderneta de pré-natal da mãe, Sumário de alta (sinais de risco), testes de triagem neonatal(olhinho, coraçãozinho, orelhinha, pezinho e linguinha)
- Orientar o acesso à Unidade Básica de Saúde (UBS) e programar a primeira consulta até 15º dia de vida
- Solicitar que a família leve o Resumo de Alta e a Caderneta de Vacinação na primeira

consulta do RN
- Orientar dormir de "barriga para cima", colchão firme, sem lençóis frouxos ou objetos macios (risco de morte súbita)
- Aconselhar: prevenção do fumo passivo.
- Atentar para os efeitos nocivos do uso do bico ou da chupeta que podem atrapalhar a amamentação, causar doenças, problemas na dentição e na fala
- Orientar a colocar o lactente para eructar devido ao risco de aspiração do leite materno por vômito ou regurgitação.
- Inserir o RN na classificação de Risco
- Investigar sinais de alerta e orientá-los aos pais

Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança e inseri-la na Classificação de Risco.

Os menores de 2 meses são mais suscetíveis à infecções bacterianas graves e podem evoluir para óbito em curto espaço, assim é importante a identificação precoce de sinais de alerta para o encaminhamento rápido ao serviço de referência.

SINAIS DE ALERTA EM MENORES DE 2MESES:
• Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar);
• Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere);
• Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar);
• Frequência cardíaca abaixo de 100bpm;
• Letargia ou inconsciência;
• Respiração rápida (acima de 60mrm);
• Atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual);
• Febre (37,8 °C ou mais)
• Hipotermia (menos do que 35,5 °C);
• Tiragem subcostal;
• Batimentos de asas do nariz;
• Cianose generalizada ou palidez importante;
• Icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida;
• Gemidos;
• Fontanela (moleira) abaulada;
• Secreção purulenta do ouvido;
• Umbigo hiperemiado (hiperemia estendida à pele da parede abdominal) e/ou com secreção purulenta (indicando onfalite);
• Pústulas na pele (muitas e extensas);
• Irritabilidade ou dor à manipulação.
• Diurese ausente ou ausência de evacuações

Os principais objetivos da *primeira visita domiciliar* ao recém-nascido e a sua família são os seguintes:
- Observar as relações familiares;
- Facilitar o acesso ao serviço de saúde;
- Possibilitar ou fortalecer o vínculo das famílias com as equipes de saúde;
- Escutar e oferecer suporte emocional nessa etapa de crise vital da família (nascimento de um filho);

- Estimular o desenvolvimento da parentalidade;
- Orientar a família sobre os cuidados com o bebê;
- Identificar sinais de depressão puerperal;
- Promover o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida;
- Prevenir lesões não intencionais;
- Identificar sinais de perigo à saúde da criança.

4.5. PRIMEIRA CONSULTA DO RN

A primeira consulta do RN é um momento importante para o fortalecimento do vínculo da família com a Unidade Básica de Saúde. Nela o médico/enfermeiro acolherá o binômio mãe-filho de forma individualizada oferecendo orientações e apoio. No entanto, alguns procedimentos devem ser padronizados e aplicados em todas as crianças atendidas na rede pública de Nova Mutum.

►ANAMNESE

A história da criança deverá ser detalhada. Nela alguns tópicos serão pesquisados e registrados em prontuário:

- Intercorrências durante o Pré-natal
- Idade gestacional
- Tipo de parto e local onde ocorreu
- Peso, comprimento, perímetro cefálico, Apgar ao nascimento
- Intercorrências durante permanência na maternidade e após alta hospitalar
- Resultados dos testes de triagem neonatal: teste do coração, teste do ouvido, teste do pezinho, teste do olhinho
-Antecedentes familiares: idade dos pais, número de gestações anteriores, número de irmãos, idade dos irmãos, situação do vínculo mãe-pai

►EXAME FÍSICO

O primeiro exame físico do Recém – Nascido (RN) deverá ser completo, pois a detecção precoce de anormalidades resultará em intervenções que poderão evitar um posterior prejuízo à saúde da criança, assim os seguintes tópicos deverão ser abordados nesta avaliação:

1) Dados antropométricos	- Peso, Comprimento e Perímetro Cefálico OBS: Considera-se normal uma perda de peso de até 10% em relação ao peso de nascimento até o décimo dia de vida com recuperação por volta de 15 dias de vida.
2) Estado Geral	- Postura do RN, hidratação, padrão respiratório, estado de vigília
3) Cabeça	a-) Face/Orelhas: pesquisar assimetria, malformação, deformidade ou aparência sindrômica. Observar a implantação, o tamanho e a simetria das orelhas. b-) Fontanelas, bossas serossanguinolentas e cefalohematomas (mais delimitados que a bossa e com regressão mais lenta)

	c-) Olhos: reflexo fotomotor, conjuntivite OBS: *Estrabismo* (ou esotropia) e *nistagmo lateral* são comuns nesta fase, devendo ser reavaliados posteriormente. Os recém-nascidos podem apresentar eventualmente algum tipo de desvio ocular, pois a visão binocular só estará bem desenvolvida entre 3 e 7 meses. Raramente o estrabismo congênito tem seu diagnóstico feito antes dos 6 meses de vida. A idade ideal para o encaminhamento é a partir dos 4 meses. d-) Boca: observar úvula, se há fenda palatina, tamanho da língua, freio lingual, placas brancas em mucosa (Monilíase oral), coloração dos lábios
4)Pele	Observar a presença de: -edema: se generalizado pensar em iatrogenia, insuficiência cardíaca, sepse; se for localizado pensar em trauma de parto -palidez: anemia, sangramento -cianose: se for generalizada pode representar problema cardiorrespiratório grave -icterícia: principalmente se surgir nas primeiras 24h ou após o sétimo dia de vida -assaduras -pústulas (Impetigo) e bolhas palmo-plantares (Sífilis)
5) Pescoço	-Avaliar posição viciosa da cabeça. O Torcicolo Congênito tem resolução espontânea em 90 % dos casos. Nos quadros mais persistentes pode ocorrer a necessidade de correção cirúrgica, esta protelada até 3 anos de idade -Pesquisar tumorações
6)Tórax	-Avaliar assimetria, pois ela sugere malformações cardíacas, pulmonares, de coluna ou do arcabouço costal -Palpar clavículas para investigar presença de fraturas que tem evolução benigna com formação de calo ósseo em 2 a 3 semanas -Avaliar as mamas que podem estar ingurgitadas e com secreção leitosa(passagem de hormônio materno). Explicar à família que este quadro evolui com regressão espontânea com o passar dos meses. -Realizar ausculta cardíaca e observar a presença de sopros -Realizar ausculta pulmonar e observar a presença de ruídos adventícios
7) Abdômen	-A respiração é basicamente abdominal e sua frequência deve oscilar entre 40mrp a 60 mrp -Avaliar a forma: plano, abaulado, escovado (pode ser sinal de Hérnia Diafragmática).

	-Observar se há visualização de circulação colateral -Pesquisar a presença de visceromegalias ou tumorações -Pesquisar a presença de hérnia inguinal (indicação cirúrgica imediata pelo risco de encarceramento ou estrangulamento) ou hérnia umbilical (a maioria tem regressão espontânea até 24 meses) -verificar a presença de granuloma umbilical após queda do coto que pode ser tratado com nitrato de prata 1% -observar sinais de onfalite: região umbilical avermelhada, edemaciada e com secreção fétida. Neste caso a criança deve ser encaminhada ao serviço de emergência.
8) Genitália	A) Menino: -orientar a mãe sobre a fimose fisiológica e sua chance de melhora espontânea com o decorrer do tempo -palpar a bolsa escrotal para localizar os testículos. Os testículos não palpáveis nem sempre indicam anormalidade, principalmente em prematuros. Eles podem "descer" até o terceiro mês de vida quando o caso deverá ser reavaliado. Se aos 6 meses os testículos não forem palpados na bolsa escrotal, a criança deve ser encaminhada para melhor avaliação e tratamento -avaliar presença de hidrocele (foco luminoso em bolsa escrotal com resultado translúcido) que regride lenta e espontaneamente até 2 anos de idade -se possível observar localização do meato urinário e a presença de hipospadia ou epispádia B) Menina -observar se há sinéquia de pequenos lábios -a presença de secreção esbranquiçada e às vezes hemorrágica ocorre pela passagem de hormônios maternos e tem regressão espontânea. Tranquilizar a mãe sobre este quadro
9) Ânus	Observar fissuras, fístulas, prolapso e outras anormalidades
10)Sistema articular	-Avaliar a presença de Pé Torto Congênito que poderá ser resolvido espontaneamente ou com mobilização e nos casos mais graves com correção cirúrgica -Avaliar displasia de quadril através da manobra de Ortolani
11)Coluna vertebral	Palpar toda a coluna, principalmente região lombo-sacra

12) Avaliação neurológica	-Observar a presença de reflexos arcaicos (Moro, preensão palmo-plantar e sucção) presentes em RN a termo e sadio -Observar presença de hipotonia e paralisias. Observar a presença de movimentos normais e espontâneos de flexão/extensão dos membros. O *tônus* normal é de semiflexão generalizada

OBS: Saber como é a variação das frequências respiratória e cardíaca conforme a faixa etária, poderá ser útil ao profissional de saúde durante a avaliação do RN.

Frequência Cardíaca Normal

IDADE	VARIAÇÃO	MÉDIA
Recém-nascido	De 70 a 170	120
11 Meses	De 80 a 160	120
2 Anos	De 80 a 130	110
4 Anos	De 80 a 120	100
6 Anos	De 75 a 115	100
8 Anos	De 70 a 110	90
10 anos	De 70 a 110	90

Fonte: Caderno de Atenção Básica Núm.33,Ministério da Saúde,2012

Frequência respiratória normal

De 0 a 2 meses	Até 60 mrm*
De 2 a 11 meses	Até 50 mrm
De 12 meses a 5 anos	Até 40 mrm
De 6 anos a 8 anos	Até 30 mrm
Acima de 8 anos	Até 20 mrm

Fonte: Caderno de Atenção Básica Núm.33,Ministério da Saúde,2012
* mrm = movimentos respiratórios por minuto.

►Para iniciar um adequado seguimento de puericultura, o profissional responsável pela primeira consulta do lactente deverá seguir os seguintes passos:
-Realizar uma anamnese detalhada com seu registro em prontuário
-Realizar um exame físico detalhado com seu registro em prontuário
-Iniciar a suplementação conforme descrito no item de Suplementação de Vitaminas e Ferro
-Estimular o Aleitamento Materno exclusivo até o sexto mês de vida e sua manutenção nos próximos meses
-Orientar a lavagem de mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê, com o objetivo de evitar a propagação de patógenos causadores de doenças respiratórias
-Orientar a família de modo a não permitir que pessoas fumem dentro de casa ou que aqueles que acabaram de fumar peguem o bebê no colo.
-Orientar a respeito do banho e sobre os cuidados com o coto umbilical
-Orientar sobre a troca de fraldas, a prevenção de assaduras
-Orientar que o uso de talcos e perfumes deve ser evitado

-Orientar que o bebe deve dormir na posição supina (de "barriga para cima") e em uma superfície firme, medidas de proteção contra a morte súbita do lactente.
-Em relação ao uso de chupetas ("bicos"), atualmente, a introdução desse hábito tem sido desaconselhada pela possibilidade de interferir negativamente na duração do aleitamento materno.
-Orientar os pais sobre os sinais de alerta em menores de 2 meses
-Orientar sobre o calendário de vacinação. É importante verificar se o recém-nascido recebeu a primeira dose da vacina contra hepatite B e a BCG na maternidade. Orientar que a aplicação de novas vacinas se iniciará com 2 meses de vida.
-Orientar a família sobre o retorno e programar novas consultas conforme os critérios de risco

OBS: COMO SE PODE OBSERVAR, A PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO RECÉM – NASCIDO É RICA EM AÇÕES (ANAMNESE E EXAME FÍSICO DETALHADOS) E ORIENTAÇÕES E NECESSITA DE UM TEMPO MAIS LONGO DE DURAÇÃO QUE UMA CONSULTA HABITUAL. DESTA FORMA, A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEVERÁ ORGANIZAR A AGENDA DESTINANDO DOIS HORÁRIOS QUANDO SE TRATAR DA PRIMEIRA CONSULTA DO RN.

5 – CONSULTAS SUBSEQUENTES

Na primeira consulta da criança, independente da idade, deve ser realizada uma boa anamnese e feito um exame físico completo (como descrito para o Recém-Nascido). A repetição deste exame detalhado em todas as consultas não está justificada, mas ausculta cardíaca, ausculta pulmonar e exame abdominal devem estar presentes nas consultas posteriores. Em menores de 3 anos deve-se associar otoscopia, exame de orofaringe e genitália.

No seguimento longitudinal da criança, o profissional deve realizar algumas ações importantes:

5.1 – MONITORIZAÇÃO DO CRESCIMENTO

O crescimento é um processo complexo que integra desde a vida intrauterina fatores hormonais, genéticos e nutricionais, influenciados pelos ambientes socioeconômico e emocional. O acompanhamento do processo de crescimento, com a realização de medidas de peso, comprimento/estatura e perímetro cefálico, de maneira regular e sistemática, permite a detecção precoce, prevenção e definição de situação de risco.

Os registros do peso, do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis em todas as consultas, para crianças de risco ou não, até os 2 anos de idade. Entre os 2 e os 10 anos de idade, deve-se aferir o peso e a altura e registrá-los no gráfico nas consultas realizadas.

GANHO DE PESO, COMPRIMENTO(C)/ESTATURA(E) E PERÍMETRO CEFÁLICO(PC) SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA				
Idade	Ganho de peso diário(g)	Ganho de Peso Mensal(g)	Aumento de C/ E(cm/mês)	Aumento de PC (cm/mês)

0-3 meses	30	880	3,5	2,00
3-6 meses	20	550	2,0	1,00
6-9 meses	15	440	1,5	0,50
9-12 meses	12	390	1,2	0,50
1-3 anos	8	240	1,0	0,25
4-9 anos	6	180	4-6 cm/ano	1 cm/ano

Fonte: Pediatria Ambulatorial: da Teoria à Prática, Sociedade de Pediatria de São Paulo, 2016

Velocidade de crescimento anual na infância	
Idade	Crescimento (cm/ano)
Até 1 ano Primeiro semestre Segundo Semestre	25 15 10
1-2 anos	12-13
2-3 anos	8
3-4 anos	7
4-9 anos	4-6

Fonte: Pediatria Ambulatorial: da Teoria à Prática , Sociedade de Pediatria de São Paulo, 2016

O cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) permite uma melhor análise da relação entre peso/comprimento(em menores de 2 anos) ou peso/estatura(para maiores de 2 anos). O IMC é um bom marcador de adiposidade e sobrepeso, além do fato de que seu valor na infância pode ser preditivo do IMC da vida adulta. Já existem evidências da associação dos valores do IMC em crianças menores de 2 anos com obesidade na adolescência e na vida adulta.

O padrão mais utilizado para avaliar o crescimento infantil são as curvas de crescimento da OMS, possibilitando que todo mundo possa verificar se as crianças apresentam um crescimento saudável através de um método único e padronizado.

PONTOS DE CORTE DE PESO PARA IDADE EM CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS

VALORES CRÍTICOS	**DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL**
Escore z > +2	Peso elevado para a idade
Escore z > -2 e +2	Peso adequado para a idade
Escore z > -3 e < -2	Peso baixo para a idade.
Escore z < -3	Peso muito baixo para a idade.

Fonte: Adaptado do Caderno de atenção Básica Núm.33, Ministério da Saúde, 2012

PONTOS DE CORTE DE COMPRIMENTO/ALTURA EM CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS

VALORES CRÍTICOS	**DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL**
Escore z > +2 Escore z > -2 e +2	Comprimento/altura adequado para a idade
Escore z > -3 e < -2	Comprimento/altura baixo para a idade
Escore z < -3	Comprimento/altura Muito baixo para a idade

Fonte: Adaptado do Caderno de atenção Básica Núm.33, Ministério da Saúde, 2012

PONTOS DE CORTE DE IMC /IDADE EM CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS

VALORES CRÍTICOS	DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
Escore z > +3	Acima de 5 anos: Obesidade grave De 0 a 5 Anos : Obesidade
Escore z +2 e +3	Acima de 5 anos : Obesidade De 0 a 5 anos : Sobrepeso
Escore z > +1 e < +2	Acima de 5 anos : Sobrepeso De 0 a 5 anos : Risco de Sobrepeso
Escore z > -2 e +1	IMC adequado
Escore z > -3 e < -2	Magreza
Escore z < -3	Magreza acentuada

Fonte: Adaptado do Caderno de atenção Básica Núm.33, Ministério da Saúde , 2012

IMPORTANTE:

►No prematuro deve-se monitorar o peso, comprimento e perímetro cefálico utilizando uma curva de crescimento intrauterino até 40 semanas de Idade Gestacional Corrigida(IGc). A partir de 40 semanas de IGc, deve-se utilizar a curva padrão de crescimento pós-natal(curvas da OMS), considerando-a como o ponto zero na nova curva, e continuar utilizando a idade corrigida para a prematuridade (ICP), ou seja, descontando da idade cronológica as semanas que faltaram para a idade gestacional atingir 40 semanas (termo).

É recomendada a utilização da idade corrigida até 2 anos para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.

Idade corrigida = idade cronológica – (40 semanas – idade gestacional)

EXEMPLO: recém-nascido com 30 semanas de idade gestacional, aos 3 meses de idade cronológica terá idade corrigida = 40-30 = 10 semanas (2 meses e 15 dias de diferença), 3m - 2m15dv = 15 dias de idade corrigida para a prematuridade

1000 dias = 280 dias de gravidez 40 sem) + 720 dias de vida (2

► U e a
corr ame
neurológico e do desenvolvimento.

5.2 – MONITORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção básica objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre principalmente por meio de ações educativas e de acompanhamento integral da saúde da criança

A criança deve atravessar cada estádio de desenvolvimento segundo uma sequência regular, ou seja, os estádios de desenvolvimento cognitivo são sequenciais. A identificação de problemas neste processo (atraso no desenvolvimento da fala,

tendência ao isolamento social, dificuldade no aprendizado, agressividade, entre outros) é fundamental para a intervenção precoce levando a melhora do prognóstico desse paciente.

O enfoque especial dado à criança até seis anos de idade decorre das características do desenvolvimento cerebral que, nessa época, encontra-se em franco processo de maturação, o que lhe confere grande vulnerabilidade, mas também de intensa plasticidade, o que favorece sua recuperação e reorganização estrutural e funcional, fatores que decrescem nos anos posteriores. A plasticidade cerebral pode ser definida como a propriedade do Sistema Nervoso Central de modificar seu funcionamento e reorganizar-se de acordo com modificações ambientais ou lesões.

A evolução da criança com alterações do desenvolvimento depende em grande parte, do momento da detecção e do início da intervenção. Se ela não for estimulada ou motivada no devido momento, não conseguirá superar o atraso do seu desenvolvimento. Portanto, são de relevância o diagnóstico e o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, com a avaliação de habilidades motoras, de comunicação, de interação social e cognitivas nas consultas de puericultura realizadas na UBS, com apoio, se necessário, do NASF.

O quadro, a seguir, descreve aspectos do desenvolvimento das crianças menores de 10 anos.

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE O A 10 ANOS

Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexa. Reflexos: • Apoio plantar, sucção e preensão palmar: desaparecem até o 6º mês. • Preensão dos artelhos: desaparece até o 11º mês. • Reflexo cutâneo plantar: obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. No RN, desencadeia extensão do hálux. A partir do 13º mês, ocorre flexão do hálux. A partir desta idade, a extensão é patológica. • Reflexo de Moro: medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do 3º mês e não deve existir a partir do 6º mês. • Reflexo tônico-cervical: rotação da cabeça para um lado, com consequente extensão do membro superior e inferior do lado facial e flexão dos membros contralaterais. A atividade é realizada bilateralmente e deve ser simétrica. Desaparece até o 3º mês. -Entre 1 e 2 meses: melhor percepção de um rosto
Entre 2 e 3 meses: sorriso social. Entre 2 e 4 meses: bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros. Em torno de 2 meses: inicia-se a ampliação do seu campo de visão (o bebê visualiza e segue objetos com o olhar).
Aos 4 meses: preensão voluntária das mãos. Entre 4 a 6 meses: o bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro.
Em torno dos 6 meses: inicia-se a noção de “permanência do objeto”.* A partir do 7º mês: o bebê senta-se sem apoio. Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha. Entre 6 e 8 meses: o bebê apresenta reações a pessoas estranhas.
Entre 9 meses e 1 ano: o bebê engatinha ou anda com apoio.

Em torno do 10º mês: o bebê fica em pé sem apoio.
Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses: o bebê anda sozinho.
Entre 1 ano e 6 meses a 2 anos: o bebê corre ou sobe degraus baixos.
Entre 2 e 3 anos: o bebê diz seu próprio nome e nomeia objetos como seus. Em torno dos 2 anos: o bebê reconhece-se no espelho e começa a brincar de faz de conta (atividade que deve ser estimulada, pois auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional, ajudando a criança a lidar com ansiedades e conflitos e a elaborar regras sociais). Entre 2 e 3 anos: os pais devem começar aos poucos a retirar as fraldas do bebê e a ensiná-lo a usar o penico
Entre 3 e 4 anos: a criança veste-se com auxílio. Entre 4 e 5 anos: a criança conta ou inventa pequenas histórias .O comportamento da criança é predominantemente egocêntrico ; porém, com o passar do tempo, outras crianças começam a se tornar importantes. A partir dos 6 anos: a criança passa a pensar com lógica, embora esta seja predominantemente concreta. Sua memória e a sua habilidade com a linguagem aumentam. Seus ganhos cognitivos melhoram sua capacidade de tirar proveito da educação formal. A autoimagem se desenvolve, afetando sua autoestima. Os amigos assumem importância fundamental. A criança começa a compreender a constância de gênero. A segregação entre os gêneros é muito frequente nesta idade (meninos “não se misturam” com meninas e vice-versa).
A partir dos 7 anos: a criança começa a desenvolver o julgamento global de autovalor, integrando sua autopercepção, “fechando” algumas ideias sobre quem ela é e como deve ser etc. A influência dos pares (amigos, colegas da mesma idade) adquire grande importância nesta etapa da vida, enquanto a influência dos pais diminui
A partir dos 10 anos: ocorrem mudanças relacionadas à puberdade e há um estirão de crescimento (primeiro nas meninas, em torno dos 11 anos, depois nos meninos, em torno dos 13 anos).

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica Núm.33, 2012
* *Noção de permanência do objeto*: capacidade de perceber que os objetos que estão fora do seu campo visual seguem existindo. Em torno de um ano de idade, esta habilidade está desenvolvida na maioria dos bebês.

5.3 – MONITORIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

No país estamos constatando uma falha na cobertura vacinal de nossas crianças. O profissional de saúde deve manter o hábito de checar a Caderneta de Vacinação e orientar sobre os benefícios que a vacina oferece em todas as consultas de rotina. Essas atitudes simples são úteis para tentar reverter o aumento de crianças não vacinadas.

5.4 – DESENVOLVIMENTO DA AUDIÇÃO

Atentar-se ao desenvolvimento auditivo da criança também é muito importante, pois a audição é um sentido fundamental para o aprendizado da fala.

No quadro abaixo é possível observar o que se espera em termos de desenvolvimento auditivo em cada idade, desde o nascimento até os 16 meses de idade.

DESENVOLVIMENTO AUDITIVO INFANTIL	
0 aos 4 meses	Comunica-se com o meio por variações na entonação do choro e dos sonzinhos que emite. Chora, emite alguns sons e dá gargalhadas. Sorri quando alguém fala de frente para ela. Quando exposta a sons muito fortes, a criança deve apresentar algumas reações, como: se assustar, acordar, acelerar ou interromper a mamada, piscar os olhos. Reage inconsistentemente aos sons familiares (voz dos pais, sons do cotidiano).
4 aos 7 meses	Reconhece a voz da mãe e localiza os sons lateralmente
7 aos 9 meses	Consegue demonstrar reações de agrado ou desagrado ao som que ouve. Localiza a fonte sonora para os lados diretamente e para baixo indiretamente.
9 aos 13 meses	Localiza os sons para os lados e para baixo rapidamente. Compreende comandos verbais mais simples, como: “dá tchau”, “manda beijo”.
13 aos 16 meses	Localiza os sons para os lados, para baixo e para cima. Começa a compreender e responder a comandos verbais mais complexos, como: “Cadê a mamãe?”, “Cadê o papai?”
Acima de16 meses	Localiza diretamente os sons em todas as direções. Compreende ordens ou perguntas relacionadas às partes do corpo, como: “Cadê o pé?”, “Cadê a mão?”

Moura.P, *et al* Northern, JL e Downs – Hearing in children, 2002.

Os indicadores de risco para perdas auditivas congênitas no período neonatal ou progressivas na infância são os seguintes:

-História familiar de perda auditiva congênita;

-Permanência na UTI por mais de cinco dias em situação que envolva: circulação extracorpórea, ventilação assistida, exposição a medicamentos ototóxicos e diuréticos de alça, hiperbilirrubinemia com níveis de exsanguineotransfusão e infecções intrauterinas(tais como: citomegalovirose, herpes, rubéola, sífilis e toxoplasmose);

-Anomalias craniofaciais;

-Infecções pós-natais associadas à perda auditiva sensorioneural, incluindo meningites bacterianas e virais confirmadas (especialmente herpesvírus e varicela);

-Traumatismos cranioencefálicos (TCE), especialmente fraturas do osso temporal;

-Quimioterapia.

5.5 – DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

O desenvolvimento da LINGUAGEM INFANTIL é muito mais do que apenas aprender a falar. Junto com a fala a criança precisa desenvolver alguns aspectos como a compreensão e o raciocínio, por exemplo.

No quadro abaixo é possível observar, de uma maneira geral, o que se pode esperar em termos de desenvolvimento de linguagem infantil em cada faixa etária, desde os primeiros meses de vida até os 5 anos de idade.

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM INFANTIL	
1 a 3 meses	Comunica-se com o meio por variações na entonação do choro e dos sonzinhos que emite. Chora, emite alguns sons e dá gargalhadas. Sorri quando alguém fala de frente para ela.
4 a 6 meses	Grita, emite alguns sons num ritmo como se conversasse. Presta atenção enquanto alguém está falando e vocaliza.
7 a 11 meses	Emite alguns sons, repete palavras simples, bate palmas, aponta o que quer e dá tchau.
12 meses	Fala as primeiras palavras e imita a ação de outras pessoas. Aumenta a interação verbal por meio de balbucio e palavras simples. Identifica o próprio nome quando é chamada. Entende ordens simples como “dá tchau”, “bata palmas”.
18 meses	Forma frases curtas com 2 ou 3 palavras.
2 anos	Seu vocabulário tem cerca da 300 palavras. Compreende e emite frases simples. Pergunta nome e funções.
3 anos	É possível entender tudo que a criança fala, apesar de ainda apresentar alguns erros, especialmente gramaticais.
4 anos	Inventa histórias, entende regras e jogos simples.
5 anos	Fala corretamente frases completas e todos os sons da língua.

Moura, P. *et a*l Boone, D. e Plante, E. (1994)-Comunicação humana e seus hábitos.

As primeiras palavras começam a aparecer no primeiro ano de vida e até os 5 anos de idade é esperado que a criança não apresente mais trocas ou omissões de sons na fala.

Alguns sons da fala são mais fáceis e outros mais difíceis de pronunciar. Por isso, existe uma ordem de aquisição desses sons, de forma que é esperado que a criança bem novinha já consiga falar os sons mais fáceis e, com o passar do tempo e aumento da idade, vá aprendendo também os mais difíceis.

No quadro abaixo é possível observar em que idade a criança já deve conseguir pronunciar cada som da fala

IDADE MÉDIA DE AQUISIÇÃO DOS SONS DA FALA	
IDADE	**LETRAS**
1 ano e 6 meses	B, M
2 anos	P, T, D, N
2 anos e 6 meses	K, G, NH
3 anos	F, V, S, Z

3 anos e 6 meses	CH, J
4 anos	L, LH, RR (R do rato) Arquifonema /S/ (as, es, is, os, us) Arquifonema /R/ (ar, er, ir, or, ur)
5 anos	R (R da arara) Grupos com L (pl, bl, cl, gl, fl) Grupos com R (pr, br, cr, gr, fr...)

Moura. P, Honora *et al* - Esclarecendo as deficiências. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.

OBSERVAÇÃO: Se a criança já tem 18 meses ou mais e não fala nada, se parece não compreender comandos simples que a maioria das crianças da mesma idade já compreende ou se apresenta qualquer comportamento ATÍPICO que leve o profissional da Saúde a suspeitar que há algo de errado em seu desenvolvimento, solicite avaliação do especialista.

5.6 – AVALIAÇÃO DA VISÃO

As causas mais comuns de diminuição da acuidade visual em crianças são a ambliopia (redução da visão sem uma lesão orgânica detectável no olho), seus fatores de risco (estrabismo, anisometropia, catarata e ptose) e os erros de refração (miopia e hipermetropia).

Durante a consulta o profissional deve estar atento a presença de estrabismo e não esquecer que a ocorrência deste desvio ocular antes de 4 meses de vida poderá ser um achado normal, mas a partir de 6m estas alterações não devem existir.

É importante observar que a criança pequena não se queixa de dificuldades visuais. Por isso, a partir dos 3 anos, está indicada a triagem da acuidade visual, usando-se tabelas de letras ou figuras quando a criança vier para consultas de revisão.

5.7 – RASTREAMENTO DA DISPLASIA DO QUADRIL

Para se realizar o rastreamento deve-se executar às manobras de Barlow (provocativa do deslocamento) ou Ortolani (sua redução) nas primeiras consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses).

A observação da limitação da abdução dos quadris e o encurtamento de um dos membros inferiores devem ser os exames de rastreamento nas consultas após os 3 meses de idade, ou seja, nas consultas dos 4, 6, 9 e 12 meses. Quando a criança começa a deambular, a partir da consulta dos 12 ou dos 18 meses, a observação da marcha da criança é o exame de escolha.

5.8 – AVALIAÇÃO GENITAL

5.8.1 - FIMOSE

A fimose é diagnosticada quando o orifício prepucial estreito impede a exposição da glande. Quase todos os neonatos apresentam esta característica, que é assim considerada fisiológica. Ao longo dos três primeiros anos de vida as adesões entre o prepúcio e a glande vão sendo lisadas e o anel fimótico distal vai desaparecendo, de modo que em 70 e 90 % dos meninos não circuncidados o prepúcio se torna retrátil após três anos. Este percentual vai aumentando até a puberdade.

Nos meninos mais velhos a fimose pode ser fisiológica, patológica(decorrente de inflamação e cicatrização) ou pode ocorrer após circuncisão.

As pequenas coleções de smegma acumuladas entre o prepúcio não descolado e a glande, visíveis através da pele, são normais.

A dilatação manual do prepúcio estreitado por descolamento abrupto sem anestesia é desaconselhável; por ser extremamente dolorosa, causar traumatismo local e provocar trauma emocional à criança. O prepúcio retraído à força pode resultar em fissuras e formação de cicatriz levando à fimose patológica

O anel prepucial deve ser avaliado. Se for de calibre adequado, tentativas de deslocamentos suaves durante o banho devem ser realizadas. A partir de 1 ano de idade, pode-se aplicar no prepúcio cremes de corticoide de baixa potência (betametasona + hialuronidase) uma vez à noite por no máximo 4 meses, o que promove a redução do anel fimótico em 2/3 dos casos. Quando o descolamento não é obtido na infância, deve-se aguardar até a puberdade, quando as ereções promoverão o descolamento gradual.

Indicações de postectomia: prepúcio de calibre estreito que impede a exposição da glande, balanopostite recorrente, abaulamento do prepúcio à micção e parafimose.

5.8.2 - DISTOPIA TESTICULAR

A “descida” espontânea dos testículos ocorre geralmente nos primeiros 3 meses de vida (em 70% a 77% dos casos) e raramente após os 6 a 9 meses. Assim, se os testículos não forem palpáveis na primeira consulta ou forem retráteis, o rastreamento deve ser realizado nas visitas rotineiras de puericultura.

Se aos 6 meses não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, será necessário encaminhar a criança ao cirurgião infantil. Se forem retráteis, o caso deve ser monitorado a cada 6 a 12 meses. Entre os 4 e 10 anos de idade do menino pode ocorrer de a criança crescer mais rápido do que o cordão espermático e os testículos saírem da bolsa escrotal, por isso um exame deste local seria prudente de ser realizado nesta faixa etária.

5.8.3 - SINEQUIA DE PEQUENOS LÁBIOS

Trata-se da união dos pequenos lábios, resultante da inflamação do epitélio vulvar que ocorre nas meninas entre três meses e seis anos. Pode ser total ou parcial e predispõe à vulvovaginite e infecção urinária, embora isto não seja frequente.

Nas sinéquias pequenas (parciais) e assintomáticas a conduta é expectante, pois a união pode se desfazer apenas com a melhoria da higiene local e o término do período de fraldas.

Nos casos extensos ou sintomáticos, pode ser utilizado creme à base de estrogênio de baixa absorção sobre a linha de fusão, uma vez ao dia, após o banho, exercendo-se após a aplicação uma leve pressão local com auxílio de cotonete. O tratamento é feito por 10 dias podendo ser estendido por no máximo 30 dias. Não deve ser prorrogado por mais tempo pelo risco de desencadear puberdade periférica. Também pode ser orientado o uso de lubrificante local (vaselina ou óleo infantil) seguido de massagem suave com cotonete sobre a união vulvar.

Após a separação da sinequia, deve se manter boa higiene e constante observação local, pois a recorrência pode acontecer.

5.9 – AÇÕES PREVENTIVAS

A orientação preventiva é considerada uma ação importante para a promoção da saúde sendo valorizada pelos pais, mas os profissionais da área destinam um tempo reduzido a ela.

Em consultas de atenção básica, não se pode deixar de abordar quatro itens fundamentais: dar atenção à queixa principal, revisar os problemas já apresentados, enfatizar a prevenção e estimular a mudança de hábito na busca de uma rotina saudável.

Alguns tópicos merecem ser lembrados nestes aconselhamentos:

5.9.1 - Orientação para Atividade Física

Para crianças a partir dos 2 anos, deve-se aconselhar a realização de 30 a 60 minutos por dia de atividade física moderada, apropriada para a idade, entre 3 e 5 vezes por semana. A atividade pode ser cumulativa durante o decorrer do dia, somando-se as horas de atividade física na escola com as realizadas de forma extraclasse.

As crianças aparentemente saudáveis podem participar de atividades de baixa e moderada intensidade, lúdicas e de lazer, sem a obrigatoriedade de uma avaliação prévia. É importante que algumas condições básicas de saúde, como uma nutrição adequada, tenham sido atendidas para que a atividade física seja implementada. O risco de complicações cardiovasculares na criança é extremamente baixo, exceto quando existem cardiopatias congênitas ou doenças agudas. A presença de algumas condições clínicas (tais como asma, obesidade e diabetes mellitus) exige a adoção de recomendações especiais.

5.9.2 - Orientação sobre ingestão de álcool

Para crianças acima de 7 anos, é de fundamental importância reforçar a prevenção e a educação para se evitar o uso de bebidas alcoólicas tanto por meio de abordagem no núcleo familiar quanto na escola .

5.9.3 - Orientação Alimentar

Vide tópico sobre Alimentação Infantil

5.9.4 – Prevenção de acidentes

Vide tópico sobre Prevenção de Acidentes

6 - SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINAS E FERRO

6.1 – VITAMINA D

Em relação à vitamina D, o leite materno contém cerca de 25 UI por litro, dependendo do status materno desta vitamina. A necessidade diária da criança no primeiro ano de vida é de 400 UI de vitamina D. O Departamento de Nutrologia da SBP preconiza suplementação de vitamina D para recém-nascido a termo, desde a primeira semana de vida, mesmo que em aleitamento materno exclusivo ou fórmula infantil.

Necessidades recomendadas de ingestão de vitamina D (UI)

Idade	RDA	UL*
0 – 12 meses	400	1000
1 a 3 anos	600	1500
Prematuros quando peso for superior a 1500 g e houver tolerância de ingestão	400	

Fonte: Documento científico - DC Nutrologia SBP 2014; Guia prático – Hipovitaminose D. DC Endocrinologia, 2017
*UL limite superior tolerável de ingestão

Para a suplementação somente de vitamina D, os compostos mais adequados são aqueles cuja concentração segue os seguintes parâmetros: 1 gota = 200 UI. Desta forma, a seguinte regra poderá ser seguida:
-até 01 ano: 2 gotas/dia
-de 1ano até 3 anos: 3g/dia

6.2 – VITAMINA A

A concentração de vitamina A no leite materno varia de acordo com a dieta da mãe. Em regiões com alta prevalência de deficiência de vitamina A, a OMS, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) preconizam a suplementação desta vitamina, na forma de megadoses por via oral, que devem ser administradas a cada 6 meses.

ESQUEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

IDADE	DOSE	FREQUÊNCIA
Criança: 6-11 meses	100.000 UI	Uma vez
Criança: 12-59 meses	200.000 UI	A cada seis meses

Fonte: Manual de condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, Ministério da Saúde, 2013

OBS: É importante saber se a criança está recebendo polivitamínico que contenha vitamina A, para não receber a megadose.

Recomendação de ingestão diária de vitamina A

Estágio de vida	RDA	AI (µg/dia – UI/dia)	UL (µg/dia – UI/dia)
– 6 meses		400 - 1333	600 – 2000
7 – 12 meses		500 - 1667	600 – 2000
1 - 3 anos	300 – 1000		600 – 2000

Fonte: Institute of Medicine. Dietary reference intakes, 2006. OMS/MS, 2012
RDA ingestão dietética recomendada ; AI ingestão adequada; UL limite superior tolerável de ingestão
Equivalentes da atividade do retinol: RAE = 1 µg de retinol = 3,33 UI.

OBS: O composto vitamínico que associa vitamina A e vitamina D mais antigo e conhecido pelos profissionais da Saúde contém as seguintes concentrações: 1gota corresponde à 250 UI de colecalciferol(D3) e 1250 UI de acetato de retinol (Vit. A). Apesar de conter alta concentração de vitamina A, ainda recomenda-se seu uso da seguinte forma: 2 gotas diárias até 1 ano de idade e 3 gotas diárias até 2 anos de idade. Se a criança recebeu dose de Vitamina A no Posto de Saúde, seu uso está contra –indicado, sendo necessário apenas a suplementação de vitamina D.

6.3 - FERRO

A partir dos 4 meses de idade ocorre a depleção do estoque de ferro e a alimentação passa a ter papel fundamental na prevenção da anemia. Aos 6 meses de idade, as reservas de ferro endógeno da criança estão esgotadas e a necessidade de ferro exógeno aumenta rapidamente. Um estudo (Betsy Losof, 2006), que acompanhou crianças do nascimento aos 19 anos de idade, observou o quanto a deficiência de ferro interfere no quociente de inteligência.

A Academia Americana de Pediatria recomenda a suplementação de ferro aos 4 meses de vida, mesmo em aleitamento materno exclusivo, desde 2011. Para prevenir a deficiência de ferro os Departamentos Científicos de Nutrologia e de Hematologia da Sociedade Brasileira de Pediatria passaram a recomendar o início da suplementação de ferro aos 3 meses de idade, como mostra a tabela abaixo:

Recomendação quanto à suplementação de ferro

Situação	**Recomendação**
Recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional em aleitamento materno exclusivo ou não	**1 mg de ferro elementar/kg peso/dia** a partir do **3º mês** at
Recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional em uso de menos de 500mL de fórmula infantil por dia	**1 mg de ferro elementar/kg peso/dia** a partir do **3º mês** at

Recém-nascidos a termo com peso inferior a 2500g	**2 mg/kg de peso/dia**, a partir de 30 dias durante um ano ano
Recém-nascidos pré-termo com peso entre 2500 e 1500g	**2 mg/kg de peso/dia**, a partir de 30 dias durante um ano. A
Recém-nascidos pré-termo com peso entre 1500 e 1000g	**3 mg/kg de peso/dia**, a partir de 30 dias durante um ano ano
Recém-nascidos pré-termo com peso inferior a 1000g	**4 mg/kg de peso/dia**, a partir de 30 dias durante um ano ano
Fonte: Consenso sobre Anemia Ferropriva. Departamentos de Nutrologia e Hematologia – SBP/2018	

7 - ALIMENTAÇÃO INFANTIL

Estudos experimentais e ensaios clínicos demonstram que fatores nutricionais e metabólicos, em fases iniciais do desenvolvimento humano, têm efeito em longo prazo, na programação *(programming)* da saúde na vida adulta. Um exemplo importante de *programming* em humanos é a relação entre práticas alimentares inadequadas no primeiro ano de vida e o desenvolvimento futuro de obesidade. O *aleitamento* materno tem efeito protetor e dose-dependente na redução do risco de obesidade na vida adulta. Durante o crescimento somático e de compartimentos corporais (massa magra, óssea e gorda), os componentes da dieta e dos alimentos são os principais fatores ambientais a influenciar o genoma humano. Esta interação ao longo da vida, em grande parte, define o estado de saúde ou de doenças de um indivíduo.

A epigenética ou nutrigenética, refere-se às respostas que o genoma humano demonstra em relação a alguns nutrientes. Assim fatores nutricionais agindo em janelas de oportunidades nos períodos pré-natal (obesidade ,diabete , desnutrição maternas) e pós-natal (oferta alimentar inadequada e baixa taxa de aleitamento materno)podem determinar uma programação metabólica com maiores riscos à saúde da criança em fases posteriores de sua vida.

Os primeiros 1000 dias de vida de uma criança , desde a concepção (vida intra-uterina) até o final do segundo ano de vida , compreendem uma primeira e imensa janela de oportunidades que podem determinar a chance de uma vida saudável ou riscos de aumento de prevalência de doenças crônicas não transmissíveis.

1000 dias = 280 dias de gravidez 40 sem) + 720 dias de vida (2 anos)

Esse período não concentra apenas o maior estirão de crescimento do ser humano, são anos fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas nervoso e imunológico .Essa é uma grande janela de oportunidade para intervenções nutricionais.

Assim , sabendo-se que a nutrição da mãe e do lactante até dois anos de idade pode afetar a manifestação genética e a saúde do indivíduo adulto, torna-se

fundamental o controle adequado do pré-natal e das consultas de puericultura durante este período.

O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (MS/OPAS, 2002) estabeleceram, para crianças menores de dois anos, dez passos para a alimentação saudável, com base no Guia Alimentar para crianças menores de dois anos. Esta publicação vem sendo reproduzida e atualizada no decorrer destes anos, sendo a última atualização realizada em 2015. A Sociedade Brasileira de Pediatria, adota e recomenda estas orientações.

.

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Passo 1: "Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento".

Passo 2: "A partir dos seis meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais".

Passo 3: "Após seis meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legumes) três vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada".

Passo 4: "A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança".

Passo 5: "A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher; começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família".

Passo 6: "Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida".

Passo 7: "Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições".

Passo 8: "Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação".

Passo 9: "Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos: garantir o seu armazenamento e conservação adequados".

Passo 10: "Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação".

7.1 - ALIMENTAÇÃO DO LACTENTE

A alimentação saudável da criança deve começar com a dieta materna antes e durante a gestação como também durante a fase de lactação , a fim de possibilitar crescimento e desenvolvimento adequados, otimizar o funcionamento de órgãos, sistemas e aparelhos e atuar na prevenção de doenças em curto e longo prazo (p. ex., anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis).

O leite humano atende perfeitamente às necessidades nutricionais dos lactentes , além de proporcionar proteção contra infecções e alergias, estimular o desenvolvimento do sistema imunológico, a maturação dos sistemas digestório e neurológico; como também desenvolve o vínculo mãe-filho, que fará desta união um processo de nutrir também o psiquismo de ambos.

Os Departamentos de Nutrologia e de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria adotam a recomendação da Organização Mundial da Saúde

(OMS) e do Ministério da Saúde (MS) para que se recomende o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. A partir desse período, está indicada a introdução da alimentação complementar, e deve-se estimular a manutenção do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, de acordo com a vontade da criança e da mãe, desde que esta continuidade seja nutritiva.

►Benefícios do leite materno para o bebê:
• Diminuição de morbidade, especificamente relacionada a infecções como : meningite bacteriana, bacteremia, diarreia, infecção no trato respiratório, enterocolite necrosante, otite média, infecção do trato urinário e sepse de início tardio em recém-nascidos pré-termo.
• Alguns estudos sugerem diminuição das taxas de morte súbita do lactente
• Redução de hospitalizações: o aleitamento materno reduz o risco de hospitalização por vírus sincicial respiratório (VSR). O estudo realizado em Pelotas (RS) mostrou risco sete vezes maior de hospitalização por bronquiolite em crianças amamentadas por menos de um mês.
• Redução de alergias :
- O aleitamento materno exclusivo reduz o risco de asma e de sibilos recorrentes
- O aleitamento materno protege contra o desenvolvimento de dermatite atópica
- A exposição a pequenas doses de leite de vaca durante os primeiros dias de vida parece aumentar o risco de alergia ao leite de vaca, mas não afeta a incidência de doenças atópicas no futuro
- Os efeitos benéficos do aleitamento materno observados em todas as crianças são particularmente evidentes em crianças com história familiar de doenças atópicas
• Redução da obesidade
• Diminuição do risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes
• Melhor nutrição
• Efeito positivo no desenvolvimento intelectual
• Melhor desenvolvimento da cavidade bucal
• O início precoce do aleitamento materno sem restrições diminui a perda de peso inicial do recém-nascido, favorece a recuperação mais rápida do peso de nascimento, promove uma “descida do leite” mais rápida, aumenta a duração do aleitamento materno, estabiliza os níveis de glicose do recém-nascido , diminui a incidência de hiperbilirrubinemia e previne ingurgitamento mamário.

►Benefícios da Amamentação para a mãe:
• Involução uterina mais rápida e redução na hemorragia uterina pós-parto, devido à liberação de ocitocina .
• Perda mais rápida do peso acumulado na gestação.
• Auxílio no aumento do intervalo entre as gestações.
• Maior interação mãe-bebê .
• Benefício relativo aos aspectos econômicos, uma vez que o leite materno não tem custo.
• Praticidade, pois o leite materno está sempre pronto para ser consumido.
• Diminuição do risco de câncer de mama e ovário

►Nas seguintes situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado:

• Mães infectadas pelo HIV.
• Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).
• Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos são citados como contraindicações absolutas ou relativas ao aleitamento, como, por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos.
• Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.

►Já nas seguintes situações maternas, recomenda-se a interrupção temporária da amamentação:
• Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve ser mantida na mama sadia.
• Varicela: se a mãe apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta. A criança deve receber imunoglobulina humana antivaricela zoster (Ighavz),que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, devendo ser aplicada o mais precocemente possível.
• Doença de Chagas na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente.
• Abscesso mamário, até que ele tenha sido drenado e a antibioticoterapia iniciada. A amamentação deve ser mantida na mama sadia.
• Consumo de drogas de abuso: recomenda-se a interrupção temporária do aleitamento materno, com ordenha do leite, que deve ser desprezado. O tempo recomendado de interrupção da amamentação varia dependendo da droga

Diante da impossibilidade do aleitamento materno, deve-se utilizar uma fórmula infantil que satisfaça as necessidades do lactente, conforme recomendado por sociedades científicas nacionais e internacionais (ESPGHAN, AAP e SBP). Todas as fórmulas infantis disponíveis no Brasil são consideradas seguras, pois seguem as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que segue as quantidades de nutrientes do leite materno .Antes do sexto mês, deverá ser utilizada uma fórmula infantil para lactentes (primeiro semestre); a partir do sexto mês, recomenda-se uma fórmula infantil de seguimento para lactentes (segundo semestre). É importante destacar a necessidade do consumo de água(tratada, fervida e filtrada) nos intervalos das refeições para criança menores de seis meses, não amamentadas.

Para as crianças que utilizam fórmulas infantis, a introdução de alimentos não-lácteos deverá seguir o mesmo preconizado para aquelas em aleitamento materno exclusivo (a partir dos 6 meses).

Recomenda-se evitar o leite de vaca integral para crianças abaixo de 1 ano. A utilização de proteínas do leite de vaca ,nas proporções existentes no produto in natura , pode acarretar aumento de anemia , pelas micro-hemorrágias intestinais , e de alergia alimentar.

A partir dos 6 meses de vida, deve-se introduzir a alimentação complementar, mantendo-se o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais. Retardar a introdução de alimentos complementares não protege a criança do desenvolvimento de doenças alérgicas, podendo mesmo, aumentar este risco. Entretanto, antecipar a introdução de grande variedade de alimentos sólidos para crianças de 3 a 4 meses de vida parece elevar o risco de eczema atópico e de alergia alimentar.

Esquema para introdução dos alimentos complementares

Faixa etária	Tipo de alimento
Até 6º mês	Leite materno exclusivo
6º a 24º mês	Leite materno complementado
6º mês	Frutas (amassadas ou raspadas)
6º mês	Primeira papa principal de misturas múltiplas
7º a 8º mês	Segunda papa principal de misturas múltiplas
9º a 11º mês	Gradativamente, passar para a refeição da família com ajuste da consistência
12º mês	Comida da família – observando a adequação dos alimentos

Nesta idade as frutas *in natura*, raspadas, amassadas ou picadas devem ser oferecidas em colher. O tipo de fruta a ser oferecido deverá respeitar as características regionais, custo, estação do ano e a presença de fibras, lembrando que nenhuma fruta é contraindicada, a não ser a carambola nos casos de insuficiência renal. A ingestão de suco natural deve se iniciar apenas após 1 ano de idade.

A primeira papa principal de misturas múltiplas, deve ser oferecida a partir dos 6 meses de vida, no horário de almoço ou jantar (iniciada no horário em que a família também estiver alimentando-se). Nas primeiras semanas pode ser completada com o leite materno, até que a criança se mostre saciada apenas com a papa.

Com a introdução dos alimentos complementares é importante que a criança receba água nos intervalos. A água oferecida deve ser a mais limpa possível (tratada, filtrada e fervida).

A refeição deve conter pelo menos um alimento de cada um dos grupos descritos no Quadro a seguir:

Componentes da papa principal

Cereal ou tubérculo	Leguminosa	Proteína animal	Hortaliças
Arroz Milho Macarrão Batatas Mandioca Inhame Cará Farinha de trigo Aveia	Feijões Soja Ervilha Lentilhas Grão-de-bico	Carne bovina Vísceras Carne de frango Carne suína Carne de peixe Ovos	Verduras alface couve repolho Legumes tomate abóbora cenoura pepino

A segunda papa de misturas múltiplas será oferecida a partir do sétimo mês de vida. Papa deve ser amassada, sem peneirar ou liquidificar. A consistência dos alimentos deve ser progressivamente aumentada; respeitando-se o desenvolvimento da criança, evitando-se, dessa forma, a administração de alimentos muito diluídos

(com baixa densidade energética) e propiciando oferta calórica adequada. Além disso, crianças que não recebem alimentos em pedaços até os 10 meses apresentam, posteriormente, maior dificuldade de aceitação de alimentos sólidos.

A introdução de certos alimentos, potencialmente alergênicos, como ovo e peixe, pode ser realizada a partir do sexto mês de vida, mesmo em crianças com história familiar de atopia. Os estudos que avaliaram os benefícios da introdução de alimentos alergênicos a partir dos 6 meses e não tardiamente, observaram menor risco para o desenvolvimento futuro de desfechos alérgicos. A introdução após um ano de idade parece aumentar os riscos de alergia.

No primeiro ano de vida não se recomenda o consumo de mel. Nessa faixa etária, os esporos do *Clostridium botulinum*, capazes de produzir toxinas na luz intestinal, podem causar botulismo.

7.2 - ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

O período pré-escolar engloba o período entre 2 e 6 anos de idade, sendo esse um período crítico na vida da criança, onde se torna necessária e importante a sedimentação de hábitos. Nesta fase a criança apresenta ritmo de crescimento regular e inferior ao do lactente. A velocidade de crescimento estatural e o ganho de peso são menores do que nos dois primeiros anos de vida, portanto com decréscimo das necessidades nutricionais e do apetite. Por desconhecimento, os familiares atribuem este fato a uma doença e não a um fator fisiológico, chegando à consulta pediátrica com a queixa de inapetência, que é uma das mais comuns nesta faixa etária. Além disto, o comportamento alimentar da criança pré-escolar caracteriza-se por ser imprevisível e variável: a quantidade ingerida de alimentos pode oscilar, sendo grande em alguns períodos e nula em outros; caprichos podem fazer com que o alimento favorito de hoje seja inaceitável amanhã; ou que um único alimento seja aceito por muitos dias seguidos. Se os pais não aceitarem este comportamento como transitório e reagirem com medidas coercitivas, este poderá se transformar em distúrbio alimentar real e perdurar em fases posteriores.

São necessárias orientações gerais para que a conduta alimentar da criança seja saudável e a formação do hábito adequada:

→Os pais determinam o que, onde e como a criança deve se alimentar. A criança determina a quantidade a ser consumida.

→ As refeições e lanches devem ser servidos em horários fixos diariamente, com intervalos suficientes para que a criança sinta fome na próxima refeição. O intervalo entre uma refeição e outra deve ser de 2 a 3 horas.

→ Na fase pré-escolar, o esquema alimentar deve ser composto por cinco ou seis refeições diárias, com horários regulares: café da manhã – 8h; lanche matinal – 10h; almoço – 12h; lanche vespertino – 15h; jantar – 19h e algumas vezes lanche ou ceia antes de dormir.

→ É necessário que se estabeleça um tempo definido e suficiente para cada refeição. Se nesse período a criança não aceitar os alimentos, a refeição deverá ser encerrada e apenas na próxima será oferecido algum alimento.

→O tamanho das porções dos alimentos nos pratos deve estar de acordo com o grau de aceitação da criança. O ideal é oferecer uma pequena quantidade de alimento e perguntar se a criança deseja mais.

→ A oferta de líquidos deve ser realizada após a refeição, de preferência água.
→ Os sucos devem limitar a quantidade máxima de 120 mL/dia, para crianças de 1 a 3 anos e de 175mL/dia, para crianças de 4 a 6 anos.
OBS: O consumo de suco (naturais e artificiais) deve ser criterioso pelo risco de predispor à obesidade devido ao maior consumo de calorias e não ingestão das fibras das frutas que contribuem para diminuir a absorção do açúcar.
Em qualquer faixa etária, deve-se controlar o consumo de suco, mesmo os naturais. A ingesta de frutose acima da quantidade que o organismo consegue metabolizar, leva ao aumento de triglicérides e à resistência insulínica, um dos componentes da síndrome metabólica.
→ Quanto às mamadeiras de preferência nem utilizá-las, mas se estiverem em uso, eliminá-las até os 3 anos de idade.
→ O ambiente na hora da refeição deve ser calmo e tranquilo, sem a televisão ligada ou quaisquer outras distrações como brincadeiras e jogos. A criança deve ser encorajada a comer sozinha, mas sempre com supervisão, para evitar engasgos. É importante deixá-la comer com as mãos e não cobrar limpeza no momento da refeição. Quando souber manipular adequadamente a colher, pode-se substituí-la pelo garfo.
→ Recomenda-se limitar a ingestão de alimentos com excesso de gordura, sal e açúcar, pois são comprovadamente fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis no adulto. Dietas ricas em gorduras, sal e açúcares levam a distúrbios nutricionais a curto, médio e longo prazo (da infância a idade adulta) como anemia, desnutrição, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2, osteoporose entre outras
→Oferecer alimentos ricos em ferro, cálcio, vitamina A e D, zinco e fibras; pois são essenciais nesta fase da vida

7.3 - ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

A idade escolar é uma fase de transição entre infância e adolescência e compreende crianças na faixa etária de 7 a 10 anos. Esse é um período de intensa atividade física, ritmo de crescimento constante, com ganho mais acentuado de peso próximo ao estirão da adolescência. Durante a fase escolar, o ganho de peso é proporcionalmente maior ao crescimento estatural. As crianças se tornam mais fortes, mais rápidas e bem mais coordenadas. É importante, portanto, o incentivo à prática de atividades físicas lúdicas, como as brincadeiras.

À deficiência da ingestão de cálcio, soma-se o consumo de alimentos ricos em gordura, sal e açúcares, tais como “salgadinhos”, bolachas, lanches, produtos panificados que contêm gorduras *trans* e saturada, que aumentam o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Além da deficiência sérica de cálcio, há também a deficiência de vitamina D, ocasionada pela falta de exposição solar, suplementação medicamentosa e erro alimentar. São poucos alimentos fontes de vitamina D, e as quantidades são pequenas. As deficiências de vitamina D e cálcio estão relacionadas a retardo no crescimento, doenças autoimunes, cânceres, fraturas e desenvolvimento de osteoporose na vida adulta.

A adequação no consumo de sal, por meio da redução do sal de adição (< 5 g/dia), dos enlatados, embutidos, salgadinhos e de condimentos industrializados, deve

ser preconizada para que se diminua o risco de doenças futuras extremamente prevalentes em nosso meio, como a hipertensão arterial sistêmica.

O consumo de refrigerantes, sucos artificiais e bebidas à base de soja nos horários das refeições e dos lanches pode comprometer a ingestão de cálcio.

Escolares e adolescentes estão mais expostos a transtornos alimentares de distintas formas. Se por um lado há a preocupação da comunidade científica e dos próprios pais com o desenvolvimento da obesidade nos indivíduos de tenra idade, por outro deve-se atentar para o fato de que a preocupação excessiva ou malconduzida com o ganho de peso pode causar transtornos alimentares como a bulimia e a anorexia. A diminuição do tempo e regularidade da atividade física e o uso de computadores em âmbito doméstico são dois outros fatores importantes para o sedentarismo e o aumento dos distúrbios nutricionais, entre eles a obesidade, na faixa etária estudada.

Recomendações Nutricionais

→O cardápio deve respeitar os hábitos da família e as características regionais. O esquema alimentar deve ser composto por 5 refeições diárias, incluindo: café da manhã, almoço, lanche vespertino, jantar e lanche da noite.

→Alimentação variada, que inclua todos os grupos alimentares, evitando-se o consumo de refrigerantes, balas e outras guloseimas.

→Consumo diário e variado de frutas, verduras e legumes (> 5 porções/dia). A fruta deve ser priorizada. Se for oferecer suco, a ingestão deve ser limitada, no máximo, a 120 mL diários para crianças de 1 a 3 anos de idade, a 175 mL para crianças de 4 a 6 anos de idade e a 250 mL dos 7 aos 18 anos, dentro da ingestão diária recomendada de 2 a 2 1/2 porções de frutas por dia. A fruta também contém açúcar (frutose) e o consumo, na forma de suco, se dá em maior quantidade do que se consumisse a fruta, aumentando o índice glicêmico. Diante disto é mais importante consumir a fruta, que contem vitaminas e fibras, pois previne a obesidade.

→Estimular o consumo de peixes marinhos duas vezes por semana.

→ Controle da ingestão de sal (< 5 g/dia) para prevenção de hipertensão arterial.

→ Consumo apropriado de cálcio (cerca de 600 ml de leite/dia e/ou derivados) para formação adequada da massa óssea e prevenção da osteoporose na vida adulta.

→Controlar o ganho excessivo de peso pela adequação da ingestão de alimentos ao gasto energético e pelo desenvolvimento de atividade física regular.

→ Evitar a substituição de refeições por lanches.

→ Estimular a prática de atividade física

→ Reduzir o tempo gasto com atividades sedentárias (TV, videogame e computador). Limitar o tempo de assistir TV em 2 horas/dia ou menos.

→Estimular a “autonomia orientada”: que a própria criança sirva seu prato com orientações adequadas das porções.

8 – SAÚDE BUCAL

A primeira infância é o período ideal para introduzir bons hábitos e iniciar um programa educativo/preventivo de saúde bucal, porém é necessário a colaboração e motivação de todo o núcleo familiar.

A inclusão de hábitos de higiene bucal, o consumo consciente de açúcares e a alimentação saudável realizada pela família resulta em melhor qualidade de vida para todos. O papel da equipe de saúde consiste em acompanhar os hábitos familiares, orientar e estimular a prevenção.

A introdução da criança no ambiente odontológico começa na primeira semana de vida, com o teste da linguinha e a puericultura odontológica, que consistem em:

Teste da Linguinha

- Avaliação do frênulo lingual até o sétimo dia de vida, para o diagnóstico rápido da presença de língua presa, evitando dificuldades na amamentação, possível perda de peso e, principalmente, o desmame precoce com introdução desnecessária da mamadeira;
- Avaliar mobilidade da língua;
- Sugere-se que seja feito o teste da linguinha junto a o teste do pezinho;
- Deve-se realizar o “pique” do freio lingual na própria unidade de saúde, no momento seguinte ao diagnóstico da língua presa;
- Sabemos também que a língua presa, se não resolvida quando bebê, acarreta problemas na fala, causa atraso no desenvolvimento intelectual da criança, pois não sabendo falar, ela também não aprende a ler e escrever da forma correta, além de ser passível de sofrer bulling na escola e nos ambientes que frequentar.

Puericultura odontológica

- Orientar os pais sobre a higiene oral do bebê;
- Avaliar presença ou não de elementos dentários;
- Estimular o aleitamento materno pela importância no desenvolvimento facial com interferência positiva nas funções de mastigação, deglutição, fonação, respiração nasal e prevenção de problemas no desenvolvimento das arcadas e posicionamento dentário;
- Orientar em relação a produtos que não devem ser usados durante a higienização (como o mel/mel rosado);
- Orientar a higiene de objetos utilizados pelo bebê, como mamadeira, chupeta e panos de higiene oral, lembrando da necessidade de ferver tudo que entrar em contato com a boca do bebê.

Prematuridade e a Odontologia

A evolução de crianças nascidas prematuramente diferencia-se da população geral em dois aspectos fundamentais: o padrão de crescimento e o desenvolvimento pré-natal. Isso inclui também a dentição decídua, que tende a ter atraso na erupção dentária. A idade de todo bebê prematuro deve ser corrigida, porque o desenvolvimento pode ser diferente do padrão típico de crianças nascidas com idade gestacional superior a 37 semanas. A Idade Corrigida é usada para avaliar de forma mais adequada o desenvolvimento físico, intelectual e comportamental do prematuro.

Higiene bucal

Para bebês sem dentes ou em fase de erupção dos incisivos: com uma gaze, ou fralda separada somente para este fim, umedecer em água potável e passar em toda a

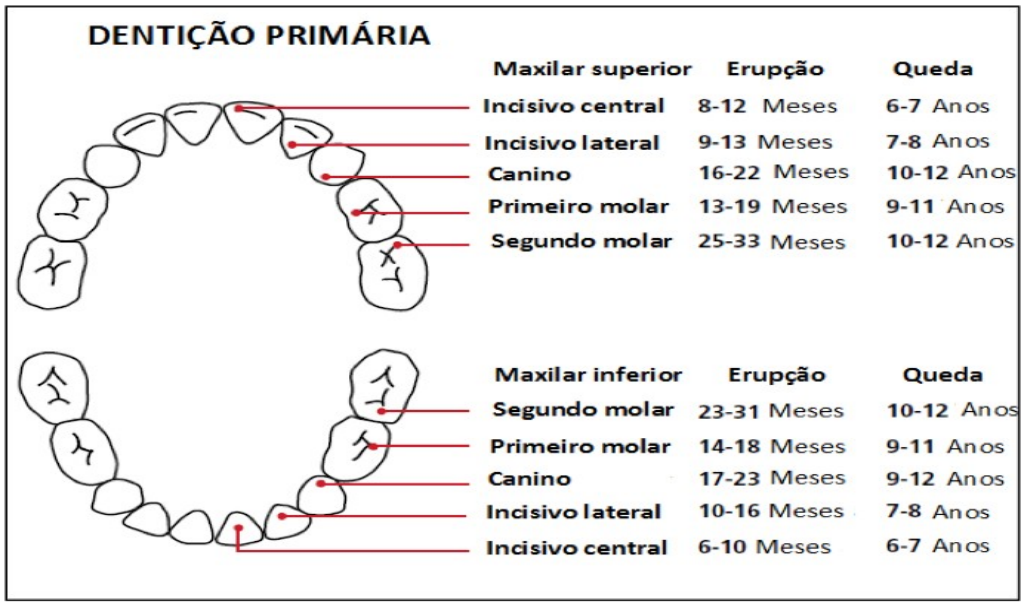
cavidade oral, com o objetivo de remover restos de leite, massagear a gengiva, estimular a mobilidade da língua e acostumar o bebê com a higienização diária. Realizar essa higiene duas vez ao dia.

Para bebês em fase de erupção dos molares: iniciar o uso da escova de dente macia, duas vezes ao dia. O uso do fio dental é indicado quando os dentes estão juntos, sem diastemas, uma vez ao dia.

Até o sexto ano de vida, a higienização bucal deve ser realizada pelos pais, e cuidadores. A partir do sexto ano, pode ser realizada pela criança, após cada refeição, porém monitorada e repetida pelos pais, pelo menos uma vez ao dia, até os 12 anos de idade.

Erupção dentária

-



Lembrando que na dentição decídua não há pré-molares, esses elementos permanentes ocupam o espaço que na dentição decídua pertence aos molares de leite.

Os primeiros molares permanentes, erupcionam sem que a criança perca nenhum dente. Erupcionam por volta dos 6 anos de idade, algumas vezes antes mesmo que troquem os incisivos centrais inferiores, e o posicionamento deles é atrás dos molares de leite, que caem entre 10 e 12 anos, o que faz com que os pais achem que é mais um dente de leite vindo, ou seja, se tiver cárie o dente troca futuramente, o que é um grande engano.

Um dos motivos de trabalharmos com prevenção precocemente, se deve ao fato dos primeiros molares permanentes erupcionarem cedo, quando a criança ainda tem pouca destreza manual para realizar sua higiene oral sozinha, por isso a importância extrema do monitoramento dos pais sobre a higiene do filho, e a frequência nas consultas odontológicas.

Frequência de visitas ao dentista

Lembrando que sempre que surgirem dúvidas os pais devem procurar o cirurgião-dentista de sua unidade para maiores esclarecimentos, bem como se houver aparecimento de lesões bucais.

Após os 12 meses sugere-se levar a criança ao dentista a cada 6 meses para avaliação, acompanhamento, interação com o profissional e sua equipe, e também para prevenção de problemas bucais.

Fluoretos

A fluoretação das águas de abastecimento público tem sido uma importante medida de promoção de saúde, sendo responsável pela queda nos índices de cárie.

Não se recomenda o uso de suplementação de flúor no pré-natal, nem em puericultura, em locais onde exista água de abastecimento fluoretada.

Em relação ao flúor tópico, o mesmo não deve ser ingerido, devido ao aparecimento de fluorose na dentição permanente.

A recomendação atual da Sociedade Brasileira de Odontopediatria é de que mesmo as crianças pequenas devem utilizar pasta de dente com flúor.

O creme dental fluoretado deve ser usado somente com supervisão, na última escovação do dia, em quantidades mínimas, após a erupção dos primeiros molares decíduos, com o incentivo para a criança cuspir a pasta após a escovação.

A quantidade ideal de creme dental para as crianças que já possuem os dentes do fundo, mas ainda não sabem cuspir (até 7 anos) é a quantidade equivalente a 1 grão de arroz cru ou com concentração de flúor entre 1.000 e 1.500 partes por milhão (pp). Para aquelas que já sabem cuspir e podem escovar os dentes sozinhas (a partir dos 8 anos de idade), a quantidade ideal é a equivalente a 1 grão de ervilha.

Relação antibiótico x cárie, uso de mamadeira noturna e cárie precoce

É comum o relato das mães associando o enfraquecimento dos dentes e a elevada incidência de cárie em seus filhos ao uso de antibióticos na infância. Entretanto, eles não estão entre os fatores determinantes da doença, pois esta é multifatorial, crônica e resulta da dissolução do esmalte dental devido ao meio ácido promovido por bactérias específicas, como Streptococcus mutans e Lactobacillus no biofilme dental.

Estes microorganismos são adquiridos pelas crianças logo após o nascimento. Esta produção local de ácidos pode superar a capacidade de tamponamento da saliva e biofilme dental, propiciando a desmineralização do esmalte dental pelos ácidos resultantes do metabolismo bacteriano da sacarose, sendo o dissacarídeo o mais cariogênico, este presente em antibióticos em solução.

Além do uso da sacarose sem a higienização correta, também encontramos o hábito da amamentação noturna em crianças com cárie precoce. Nesse caso, o leite (servido na mamadeira, e com açúcar ou achocolatado) permanece estagnado no dente quando a criança cai no sono. Nesse período ocorre a diminuição do reflexo da deglutição, e consequentemente diminuição da salivação, o que intensifica a formação

de placa e acarreta uma grande redução de seu 'ph', o que se torna mais um fator causal à evolução da doença cárie.

Sabendo-se que os hábitos presentes na dieta infantil constituem um fator significativo na etiologia e progressão da doença cárie e considerando que as lesões cariosas ocorrem precocemente na infância, estratégias objetivando prevenir esta doença neste segmento da população devem ser dirigidas aos cuidadores, tanto em consultas de puericultura, consultas de rotina no consultório, ou em palestras para grupos já existentes nas unidades de saúde, já que o aparecimento da cárie em crianças de baixa idade está, em geral, diretamente relacionado a falta de informação dos pais e cuidadores.

Uso de chupetas e mamadeiras

O ideal é não estimular este hábito, pois a sucção da chupeta e mamadeiras em bebês recém-nascidos pode ser mais fácil que a sucção do leite materno, portanto o bebê acaba por abandonar a amamentação materna. Além do fato de chupeta e mamadeira causarem alterações bucais bem evidentes, como más oclusões e alterações no padrão de deglutição da criança.

Traumatismos

O traumatismo dentário é uma situação de urgência frequente nos serviços odontológicos. Um traumatismo bucal pode, frequentemente, levar a lesões dentárias que afetam tanto os tecidos de suporte do dente, quanto os tecidos duros, acometem mais frequentemente os dentes anteriores e podem causar problemas funcionais, estéticos, psicológicos e sociais.

Traumatismos na dentição decídua são comuns e a maioria das lesões são verificada em crianças entre 2 e 3 anos de idade. Os traumatismos iniciam-se nos primeiros anos de vida e tendem a aumentar à medida que as crianças começam a dar os primeiros passos. Na criança, o número de avulsões que ocorrem devido a traumatismos são mais frequente que nos adultos devido a fragilidade do tecido ósseo que envolve principalmente os dentes decíduos. As causas de traumatismos na primeira infância podem estar relacionadas ao desenvolvimento físico da criança (andar, correr e brincar) ou ainda por violência doméstica ou de rua, como maus tratos, agressões e abusos físicos.

Independente da causa do trauma, o traumatismo é uma situação de urgência, porém, em muitos casos, o atendimento que deveria ser imediato, não é efetivamente realizado devido a falta de conhecimento de pais e responsáveis ou pelo fato de o primeiro atendimento ser realizado em pronto socorros, clínicas médicas ou unidades de saúde sem serviço odontológico. Dessa maneira, o tema traumatismo dentário deve integrar todas as atividades educativas, sejam individuais ou coletivas, direcionadas a este grupo.

O ideal é sempre explicar aos pais/cuidadores, professores e crianças que quando ocorrer traumatismos dentários, deve-se procurar o pedaço do dente fraturado, ou em caso de avulsão (saída do dente inteiro do alvéolo) procurar o dente, colocá-lo imediatamento em um copo com leite, para melhor conservação dos ligamentos e ir rapidamente ao dentista, tendo dessa forma um prognóstico muito mais favorável.

9 – VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Todo profissional de saúde tem momentos especiais de contato com as crianças, os adolescentes e suas famílias – recepção, vacina, curativos, farmácia, grupos de educação em saúde, consulta médica, odontológica, de enfermagem e psicológica, visita domiciliar, dentre outros. Esses momentos são oportunos e criam condições favoráveis para que se observe a existência de sinais e sintomas que possam ser resultantes de uma situação de violência.

A seguir, são apresentadas as violências segundo sua natureza:

a) **Violência física:** caracterizada como todo ato violento com uso da força física de forma intencional, não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou adolescente, que pode ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no corpo, e podendo provocar inclusive a morte.
b) **Violência psicológica:** é toda ação que coloca em risco ou causa dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. Inclui: rejeitar, isolar, aterrorizar, depreciar, discriminar, desrespeitar, ignorar, corromper, humilhar, criticar, desvalorizar, cobrar excessivamente, manipular, ameaçar, insultar, explorar, negligenciar, praticar *bullying,* utilizar a criança para satisfazer as necessidades psíquicas de outrem.
c) **Violência sexual:** é todo ato ou jogo sexual com intenção de estimular sexualmente a criança ou o adolescente, visando utilizá-lo para obter satisfação sexual, em que os autores da violência estão em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente
d) **Negligência:** caracteriza-se pelas omissões dos adultos (pais ou outros responsáveis pela criança ou adolescente, inclusive institucionais), ao deixarem de prover as necessidades básicas para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes.

Alterações comportamentais da criança e do adolescente em situações de violência*

SINAIS DA VIOLÊNCIA	ATÉ 11 MESES	1 A 4 ANOS	5 A 9 ANOS
Choros sem motivo aparente			
Irritabilidade frequente, sem causa aparente			
Olhar indiferente e apatia			
Tristeza constante			
Demonstrações de desconforto no colo			

Reações negativas exageradas a estímulos comuns ou imposição de limites			
Atraso no desenvolvimento; perdas ou regressão de etapas atingidas			
Dificuldades na amamentação, podendo chegar a recusa alimentar; vômitos persistentes			
Distúrbios de alimentação			
Enurese e encoprese			
Atraso e dificuldades no desenvolvimento da fala			
Distúrbios do sono			
Dificuldades de socialização e tendência ao isolamento			
Aumento da incidência de doenças, injustificável por causas orgânicas, especialmente as de fundo alérgico			
Afecções de pele frequentes, sem causa aparente			
Distúrbios de aprendizagem até o fracasso na escola			
Comportamentos extremos de agressividade ou destrutividade			
Ansiedade ou medo ligado a determinadas pessoas, sexo, objetos ou situações			
Pesadelos frequentes, terror noturno			
Tiques ou manias			
Comportamentos obsessivos ou atitudes compulsivas			
Baixa autoestima e autoconfiança			
Automutilação, escarificações, desejo de morte e tentativa de suicídio			
Problemas ou *déficit* de atenção			
Sintomas de hiperatividade			
Comportamento de risco, levando a traumas frequentes ou acidentes			
Uso abusivo de droga			

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências 2010
OBS: Os espaços coloridos indicam a presença do sinal da violência na respectiva faixa etária.

9.1 - SINAIS DE VIOLÊNCIA FÍSICA

Além dos sinais gerais de danos emocionais citados anteriormente, há que se suspeitar de violência física quando a criança ou adolescente apresentar os seguintes sinais gerais físicos:

- Lesões não compatíveis com a idade ou o desenvolvimento psicomotor da criança:

- Fraturas em crianças menores de 18 meses

- Lesões não justificáveis pelo acidente relatado:

- Fraturas de fêmur em crianças menores de dezoito meses

- Fraturas de crânio em relato de quedas de berço

- Fraturas de perna em quedas de bicicleta em crianças com menos de 4 anos quando ela não teria capacidade de andar em bicicleta tão alta da qual a queda poderia provocar um trauma

- Lesões bilaterais:

- Hemorragia bilateral de retina

- Lesões em várias partes do corpo:

- Lacerações, equimoses, hematomas, cortes, perfurações ou queimaduras que lembrem objetos (como fios, cintos, fivelas, solado de sapato etc.) ou partes do corpo do(a) agressor(a) (mãos, dedos etc.);

- Lesões circulares no pescoço, nos punhos ou nos tornozelos são indícios de tentativa de enforcamento ou de que a criança estivesse sendo mantida amarrada
- Ausência de cabelo e presença hemorrágica no couro cabeludo indicam puxões vigorosos dos cabelos e encobrem lesões internas mais comprometedoras, como fraturas
- Edema subdural
- Lesões em áreas habitualmente cobertas ou protegidas do corpo: regiões laterais de tronco, interna de braços ou coxas, região perineal ou genital, pescoço, axilas, dentes amolecidos ou fraturados
- Lesões em estágios diferentes de cicatrização ou cura são características de maus-tratos, o que indica injúrias repetidas, que podem culminar com a morte da criança
- Queimaduras por imersão ou escaldadura em luva, em meia, com limites bem definidos ,envolvendo todo o membro ou parte dele, em região genital e na área das nádegas, ou ainda com forma do objeto, como ponta de cigarro
- Lesões abdominais em crianças maiores e adolescentes, decorrentes de espancamentos, socos ou pontapés; podem acarretar a ruptura ou o sangramento de vísceras ou síndromes obstrutivas de intestino delgado, por formação de hematomas de parede

OBS:Especialmente na criança abaixo de 2 anos é possível encontrar a **Síndrome do Bebê Sacudido**, causada por violenta movimentação da criança, segurada pelos braços ou tronco. Esta ação, em face à fragilidade da musculatura do pescoço e ao grande volume cerebral, provoca o choque entre a calota craniana e o tecido encefálico deslocado, ocorrendo desde micro-hemorragias por rupturas de artérias e veias até hemorragias maciças e rompimento de fibras do tecido nervoso.Há comprometimento grave do sistema nervoso central, com convulsões ou paralisias, sem sinais infecciosos ou inflamatórios que os justifiquem, acompanhado de hemorragia de retina.

9.2 - INDICATIVOS DE NEGLIGÊNCIA - OMISSÃO DE CUIDADOS

a) Comportamentos dos pais/responsáveis

• Descaso com a higiene e o aspecto pessoal da criança.
• Descuido na guarda, no preparo ou na oferta dos alimentos à criança.
• Ausência de acompanhamento ou preocupação dos responsáveis com o rendimento escolar.
• Culpabilização da criança e do adolescente ou ainda da unidade educacional quanto às dificuldades apresentadas por ela.
• Descuido com a segurança da criança e ocasionalmente do adolescente e ausência de medidas na prevenção de acidentes.
• Descaso no acompanhamento e seguimento do calendário vacinal, de higiene e nutrição.
• Demora inexplicável na procura de recursos médicos diante de sinais de doença, não seguimento de recomendações ou escolha por tratamentos inadequados para a criança e o adolescente.
• Falta de proteção ou defesa contra acidentes e/ou violência praticada por outros.
• Ausência de preocupação na escolha ou com a segurança dos locais onde a criança e/ou o adolescente é deixado ou com os escolhidos como seus cuidadores – terceirização do cuidado.

b) Sinais de ausência de cuidados que podem ser identificados na criança e, ocasionalmente, em adolescentes

• Doenças parasitárias ou infecciosas frequentes.
• Lesões de pele frequentes ou dermatite de fraldas de repetição (sem tentativas eficientes de tratamento).
• Cáries dentárias (sem procura ou persistência no tratamento).
• Déficits de crescimento e desenvolvimento sem problema de saúde que os justifiquem.
• Desnutrição sem doença de base aparente.
• Obesidade por descuido ou imposição nutricional.
• Uso de roupas inadequadas à idade, ao sexo, ao clima ou à condição social.
• Atraso no desenvolvimento psicomotor ou relacional.
• Faltas frequentes à unidade de educação infantil, ensino fundamental e médio.
• Dificuldade de aprendizagem, sem demonstração de apreensão dos responsáveis em encontrar causa e/ou soluções.
• Atraso na escolaridade, por não procura ou por fracasso.
• Problemas de adaptação social.

9.3 - SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

O uso da violência física associada à violência sexual está presente apenas em uma pequena parte dos casos identificados. A maioria das situações de violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, é praticada por pessoas

próximas, que contam com a confiança da criança, e ocorrem de maneira progressiva por longos períodos de tempo.

O contato genital não é condição obrigatória para que uma situação seja considerada abusiva. Carícias não genitais, beijos, exibicionismo, voyeurismo e exposição à pornografia podem ser tão danosos quanto as situações que envolvam o contato genital.

Sinais indiretos de erotização precoce

• A falta de preocupação dos pais com a exposição da criança às intimidades do casal. • A exposição a atitudes de exibicionismo, como falas inadequadas à idade sobre atitudes sexuais pessoais e de outros. • Imagens ou outros materiais eróticos ou pornográficos. • Incentivo ao desenvolvimento precoce sexual, através de vestimentas que expõem o corpo, brinquedos ou jogos que objetivam aguçar a curiosidade sexual, dentre outros.

Sinais indiretos mais frequentes de violência sexual em crianças e Adolescentes

• Atitudes sexuais impróprias para a idade. • Demonstração de conhecimento sobre atividades sexuais superiores a sua fase de desenvolvimento, através de falas, gestos ou atitudes. • Masturbação frequente e compulsiva, independente do ambiente em que se encontre. • Tentativas frequentes de desvio para brincadeiras que possibilitem intimidades, a manipulação genital, ou ainda que reproduzem as atitudes do abusador com ela. • Mudanças de comportamento. • Infecções urinárias de repetição.

O quadro a seguir apresenta os sinais físicos e comportamentais e os sentimentos frequentes das crianças e dos adolescentes que são vítimas de violência sexual.

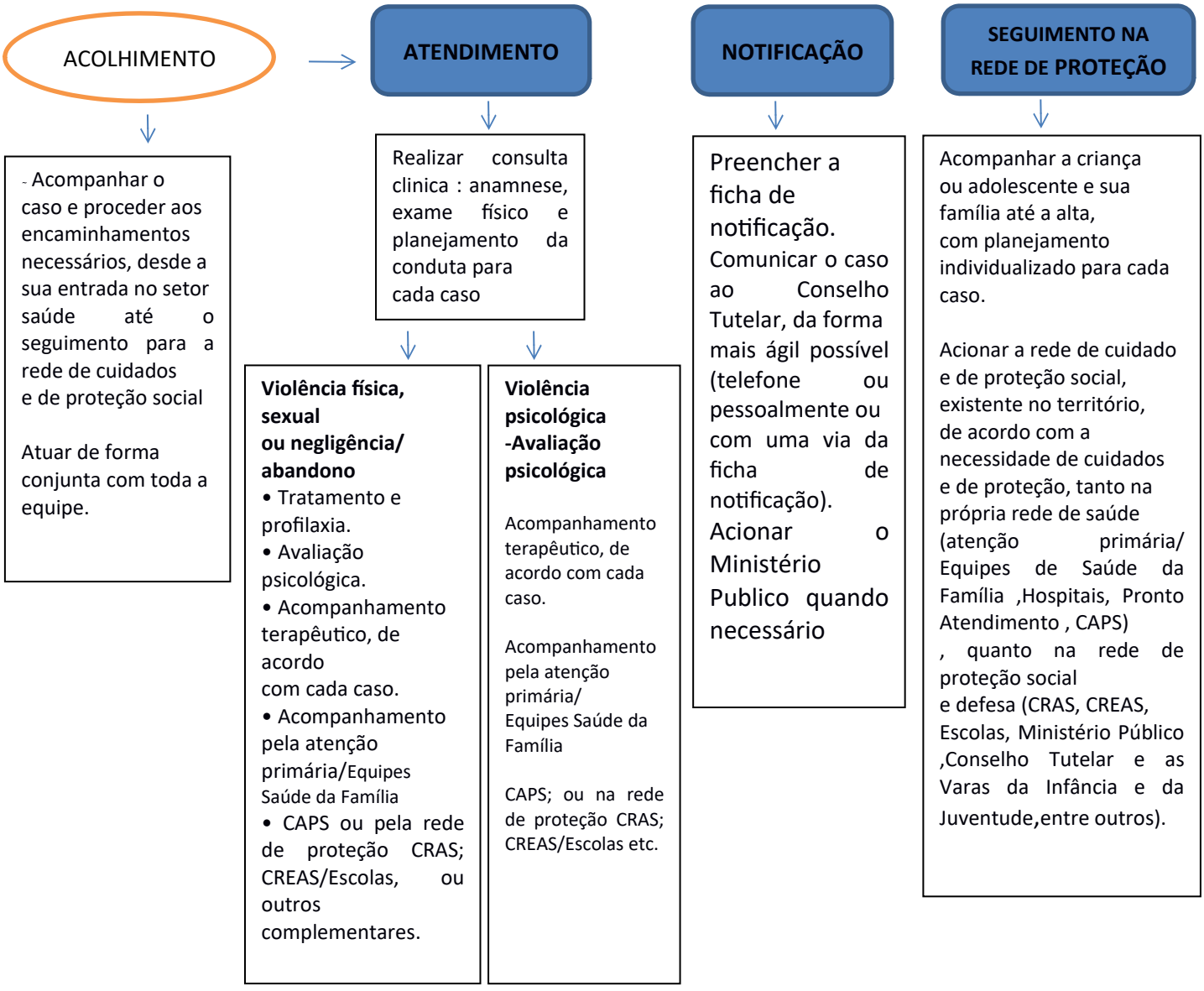
Sinais físicos e comportamentais e os sentimentos decorrentes da violência sexual*

Sinais físicos	**Sinais comportamentais ****	**Sentimentos frequentes**
Traumatismos e lesões diversas na genitália e/ou no ânus (vermelhidão, inchaço, mordida) • Dilatação himenal • Sangramentos (na vagina, no ânus etc.) • Secreções vaginais (“corrimentos”) • Infecções urinárias • Doenças sexualmente transmissíveis (DST) • Gravidez • Infecções crônicas de garganta. Nestes casos, deve-se fazer o diagnóstico diferencial. O agravo pode ter se dado pela prática do sexo oral. Deve-se pensar em gonorreia • Doenças psicossomáticas (dor de barriga, dor de cabeça, dor nas pernas, nos braços, na vagina, no ânus) • Dores abdominais • Enurese • Encoprese • Distúrbios na alimentação (perda ou ganho excessivo de peso)	• Distúrbios do sono (sonolência, pesadelos, cansaço, recusa em ir para a cama, insônia) ou do apetite(bulimia, anorexia) • Sintomas obsessivos compulsivos, como preocupação exagerada com limpeza • Ansiedade extrema • Comportamento muito agressivo ou apático • Imagem corporal distorcida • Baixa autoestima, insegurança • Dificuldade de concentração e aprendizagem • Relutância em voltar para casa • Faltas frequentes à escola • Dificuldades para participar de atividades físicas • Afastamento, isolamento social, existência de poucos amigos da mesma faixa etária • Choro sem motivo aparente • Medos constantes (medo de adultos, medo de ser atraente, repulsa ao contato físico) • Comportamento tenso, hipervigilância (“estado de alerta”) • Desconfiança • Tristeza, abatimento profundo, depressão (em razão de sentimento de culpa, de sentir-se “mau”) • Conduta regressiva com comportamento muito infantilizado • Comportamento sexualmente explícito (quando a criança brinca, demonstra conhecimento detalhado sobre sexo, inapropriado para a idade) • Masturbação excessiva, brincadeiras sexuais agressivas • Comportamento sedutor • Fugas • Automutilação • Comportamentos antissociais • Uso de álcool e drogas • Agressões sexuais • Promiscuidade, “prostituição” • Tentativas ou fantasias suicidas, suicídio	• Culpa • Vergonha • Impotência • Confusão • Ambivalência • Tristeza • Medo • Insegurança • Desamparo

Fonte: Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica Núm.33,2010
* Estes indicadores podem estar presentes em outras formas de violência.

** Não se deve considerar nenhum indicador isoladamente, pois cada um deles pode caracterizar diferentes etapas do desenvolvimento normal ou outros fatores desencadeantes de problemas físicos e/ou psicológicos. Deve-se observar a ocorrência concomitante de vários sintomas e sinais ou seu surgimento inapropriado para a idade da criança.

9.4 – FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA



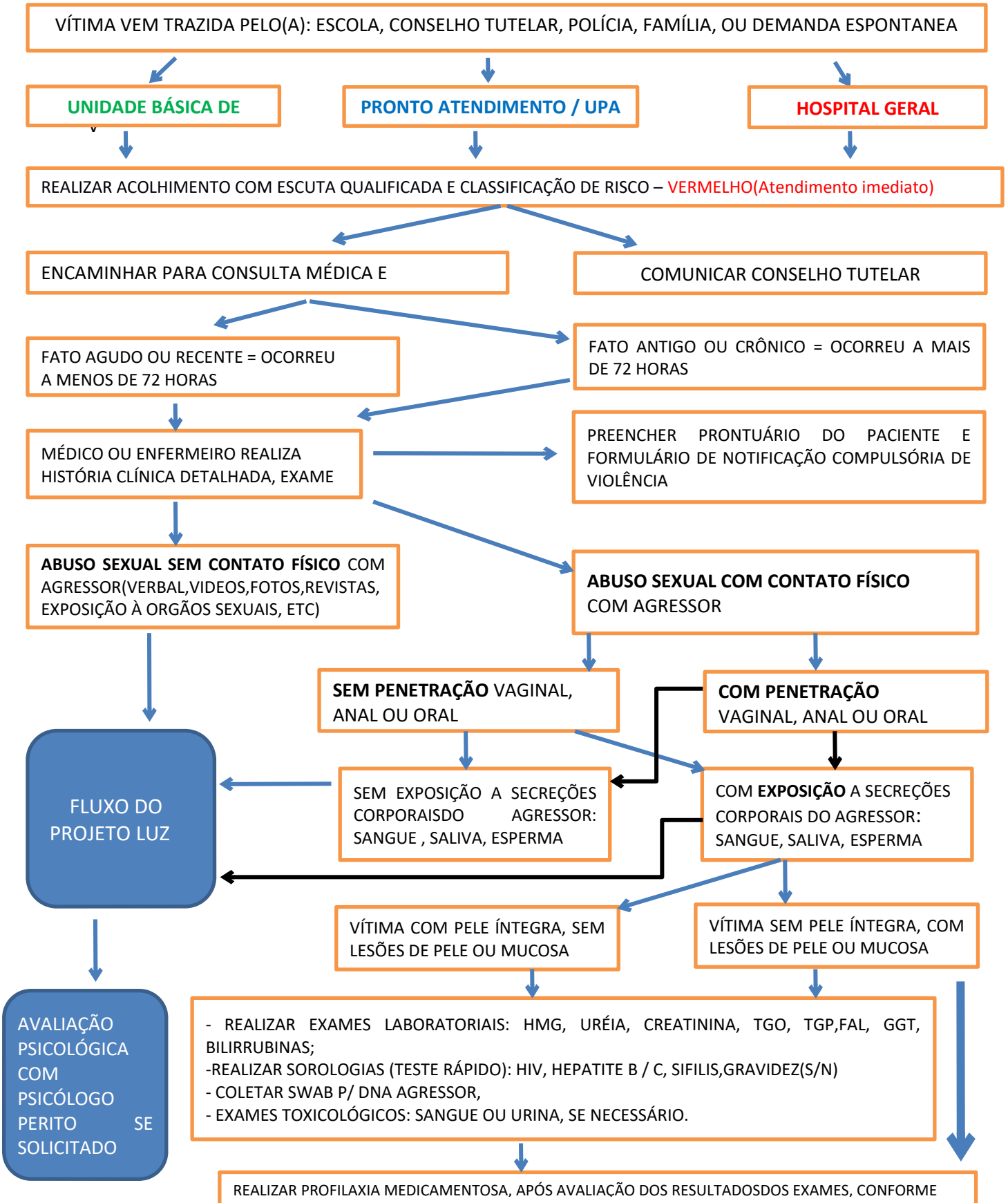
*CAPS: Centros de Atenção Psicossocial; CRAS: Centro de Referência de Assistência Social; CREA: Centro de Referência Especializado de Assistencia Social.
**Fonte : Adaptado de Ministério da Saúde , Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência , 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM –MT
ESTADO DE MATO GROSSO – CNPJ: 24.772.162/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço Eletrônico: admsaude@novamutum.mt.gov.br

O município de Nova Mutum desenvolveu o Projeto Luz que visa atender,acolher e proteger crianças e adolescentes vítimas de violência sexual .Os passos a serem seguidos pelos profissionais de saúde diante destes casos serão demonstrados a seguir:

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL

DEMANDA NA UNIDADE DE SAÚDE



10 – PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Um dos fatores preponderantes de mortalidade e morbidade de crianças e jovens, em qualquer lugar do mundo, são os traumas pelas chamadas causas externas ("acidentes" e violências): trânsito, afogamentos, agressões, queimaduras, quedas, asfixias, intoxicações.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 4 mil menores de 14 anos morrem por ano vítimas de traumas e, em média, 117 mil são hospitalizadas só na rede pública de saúde por esse motivo.

Principais acidentes fatais em menores de 14 anos - Brasil; 2015

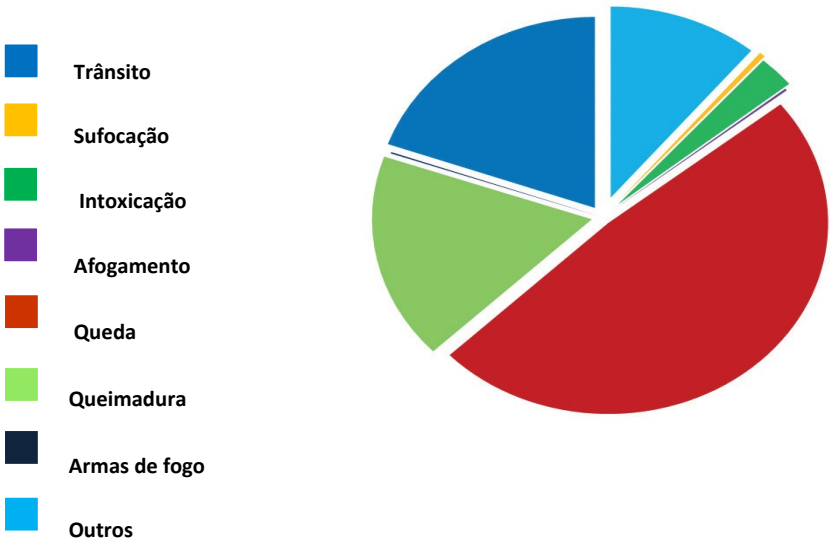
	< 1 ano		1 a 4 anos		5 a 9 anos		10 a 14 anos		0 a 14 anos	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Injúrias não intencionais	830	100	1062	100	785	100	1204	100	3881	100
Transporte	112	13	332	31	390	50	606	50	1440	37
Quedas	35	4	54	5	38	5	55	5	182	5
Afogamento	26	3	354	33	201	26	362	30	943	24
Asfixia	611	74	116	11	55	4	48	4	810	21
Queimadura	20	2	84	8	58	7	51	4	213	6
Envenenamento	2	0	11	1	2	0	14	1	29	1

Fonte: Datasus, 2015 - http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/cbt10uf.def.

1ª causa de morte 2ª causa de morte 3ª causa de morte

Por outro lado, mais marcantes que os dados de mortalidade são os dados de morbidade: estima-se que, anualmente, uma em cada dez crianças brasileiras saudáveis necessite de atendimento no sistema de saúde em virtude de traumas físicos, que levam à ocupação de 10 a 30% dos leitos hospitalares e geram cerca de três casos de deficiência permanente para cada mil habitantes.

Morbidade por acidentes 0-14 anos/2015



Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS, 2017

Com relação às internações, segundo a principal fonte de dados que é o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), ocorre, também, predomínio de acidentes em todas as faixas de idade.

Conhecer as particularidades e diferentes características do desenvolvimento de uma criança também é um bom caminho para compreender a incidência de determinados acidentes nesse processo. Com o passar do tempo, os pequenos passam a desenvolver suas habilidades motoras, cognitivas e sensoriais. Entretanto, enquanto esse processo não está completo, a criança fica vulnerável a uma série de perigos exigindo, portanto, cuidados especiais e atenção total.

É importante que todos tenham em mente que as crianças não são miniaturas dos adultos, seus corpos são mais frágeis e ainda estão em desenvolvimento, têm menor tolerância a lesões, pois a gravidade de uma lesão depende da capacidade de absorção de energia que o corpo tem (quanto menor o corpo, menor essa capacidade), além da pequena habilidade em reconhecer perigos.

0 a 1 ano
Principal característica: fragilidade.
Eventos mais comuns: sufocação (letal) e quedas (lesões).
Dicas:

• Transportar no assento tipo bebê conforto, na posição de costas para o painel, quando dentro de veículos;
• Não dormir em leito compartilhado;
• Não deixar o bebê sobre um apoio que seja alto e sem proteção como cama, poltrona, trocador e colo de criança;

• Não deixar o bebê mamar sozinho a mamadeira, pois há risco de engasgo e/ou aspiração do leite;
• Não utilizar andadores, seu uso deve ser banido;
• Nunca oferecer objetos de risco como potes de talco, embalagens de remédio, tubos de pomada ou objetos pontiagudos;
• Nunca segurar o bebê no colo se estiver próximo a substâncias quentes, como café, cigarro, chá e sopa;
• Não incentivar brincadeiras com animais desconhecidos;
• Jamais deixar objetos pesados, quebráveis ou medicamentos sobre móveis baixos e acessíveis.

2 a 4 anos
Principais características: curiosidade e inconsequência.
Eventos mais comuns: trânsito e afogamentos (letais), quedas e queimaduras (lesões).
Dicas:
• Proteger varandas, janelas e escadas com grades e redes;
• Utilizar antiderrapantes em tapetes;
• Restringir o acesso à cozinha durante o preparo das refeições;
• Usar as “bocas” de trás do fogão, com os cabos das panelas voltados para dentro;
• Colocar protetores nas tomadas;
• Limitar o acesso aos banheiros, à lavanderia e à piscina;
• Não deixar baldes ou bacias com água em locais de fácil acesso às crianças;
• Ao transportar criança em automóvel, usar cadeira apropriada;
• Manter medicamentos em recipientes com tampas de segurança e produtos de limpeza em embalagens originais, em armários trancados. O mesmo vale para bebidas alcoólicas;
• Guardar em lugar seguro objetos pontiagudos e cortantes;
• Manter a supervisão constante;
• Sempre ter em mente que a criança não reconhece os perigos e não sabe se proteger deles;
• Transmitir medidas educativas de proteção como subir escadas degrau por degrau, usar capacete ou descer do sofá sentado;

Não deixar a criança andar sozinha na calçada, ela sempre deve estar de mãos dadas com um adulto e do lado interno da calçada.

5 a 9 anos
Principais características: influenciáveis e com habilidades motoras abaixo do julgamento crítico.

Eventos mais comuns: trânsito e afogamentos (letais), quedas e queimaduras (lesões).

Dicas:

• Manter os cuidados das fases anteriores, mas reforçando a capacidade da criança reconhecer as próprias competências, limites e dificuldades;

• Procurar deixar a criança em ambientes seguros (casa, escola, clube e casa de familiares);

• Não deixar a criança andar sozinha na rua;

• Transportar a criança adequadamente no veículo, utilizando assento de elevação infantil;

• Utilizar colete salva-vidas na criança quando estiver em piscinas, mar, lagos ou rios;

• Manter supervisão constante.

10 a 14 anos

Principais características: vulnerável a pressões sociais, ganho de liberdade e sensação de ser inatingível.

Eventos mais comuns: trânsito e afogamentos (letais), quedas e queimaduras (lesões).

Dicas:

• Servir de modelo em atitudes preventivas concretas e abstratas;

• Estimular a responsabilidade no adolescente pela consequência das ações e escolhas dele;

• Ensinar que ande sozinho na rua respeitando os sinais de trânsito;

• Não facilitar o acesso às armas de fogo, bebidas alcoólicas, tabaco ou qualquer outra droga.

11 - GRUPOS DE APOIO

Os grupos de apoio (GA) serão responsáveis em realizar atividades de educação para saúde com a participação dos pais ou responsáveis pela criança , dando ênfase à prevenção de doenças e acidentes, higiene, aspectos da educação infantil ou outros temas de interesse da comunidade.

O objetivo destes grupos é a promoção, prevenção e educação em saúde , levando à mudanças positivas de hábitos na população tendo como consequência a melhora no desenvolvimento das crianças da cidade.

Estes grupos de apoio terão numa formação multiprofissional, podendo aproveitar os grupos bem estruturados já existentes nas Unidades Básicas de Saúde.

O grupo de apoio poderá agir em diversos momentos do crescimento infantil, mas inicialmente daremos prioridade aos seguintes períodos:

- Pré-natal: abrangendo a gestação e o período pós-natal até os primeiros 3 meses de vida da criança. Serão abordados assuntos referentes à gestante (dieta materna, tipos de parto, cuidados com as mamas, saúde emocional, necessidade de exercícios, posturas adequadas, uso de álcool/drogas/fumo, sexualidade, cuidado dentário, planejamento familiar) e cuidados com o RN

(aleitamento materno, higiene do RN, importância da vacinação, prevenção de acidentes)

- 3m/6m amamentação, dieta complementar, noções de Desenvolvimento Neuropsicomotor(DNPM),prevenção de acidentes
- 1 a 2 a: noções do desenvolvimento da fala, cuidados dentários, prevenção de obesidade, orientação alimentar, prevenção de acidentes
- 3 a 4 a: prevenção de obesidade, prevenção de acidentes, ênfase ao aprendizado e à fala
- 7 a 9 a: dificuldades no aprendizado, prevenção de fumo/álcool/drogas, sexualidade, prevenção de acidentes, cuidados com a higiene

A formação e o modo operante destes GA serão descritos posteriormente em um Manual a ser criado com este objetivo.

12 - GRUPO INTERSETORIAL E MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA CRIANÇA

12.1 – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE DO MARTON LUCCA (ANTIGO CAICA)

Este programa municipal tem como objetivo prestar um serviço de atendimento em Saúde especializada nas áreas de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Pediatria aos alunos inseridos ao Centro Social Marton Lucca, visando facilitar o acesso aos serviços de saúde citados.

As atividades desenvolvidas neste Centro Social são representadas pelo atendimento especializado multi ou uni profissional, através de atividades individuais ou coletivas envolvendo os alunos; assim como a realização de palestras, oficinas e capacitações aos instrutores, monitores e coordenadores, como também palestras aos pais ou responsáveis.

Alguns requisitos são necessários para a participação dos alunos nestas atividades: estar devidamente matriculado no Centro Social Marton Lucca, entregar o termo de acompanhamento terapêutico assinado pelos responsáveis para os serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia e estar acompanhado pelos pais ou responsáveis e apresentação do cartão de vacina para as consultas de Pediatria.

A meta deste programa é conscientizar a família sobre a importância da adesão e participação no acompanhamento terapêutico do aluno, a atualização e qualificação de equipe Saúde/Centro Social e o aumento do número de Oficinas realizadas mensalmente.

12.2 – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

O PSE foi instituído em 2007 pelo Ministério da Saúde e visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde.

A Escola é a área institucional privilegiada deste encontro da educação e da saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma Educação Integral. Para o alcance dos objetivos e sucesso do PSE é de fundamental importância compreender a Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos. Para alcançar estes propósitos o PSE foi constituído por cinco componentes:
a) Avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens que estão na escola pública;
b) Promoção da Saúde e de atividades de Prevenção;
c) Educação Permanente e Capacitação dos Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens;
d) Monitoramento e Avaliação da Saúde dos Estudantes;
e) Monitoramento e Avaliação do Programa.

12.3 – NAIFE (Núcleo de Acompanhamento Integrado à Família na Escola)

O NAIFE tem como objetivo desenvolver ações que efetivamente tenham cunho preventivo e de acompanhamento da comunidade escolar, no que tange ao desenvolvimento integral de toda a criança. O NAIFE se caracteriza como um projeto do governo municipal iniciado em 2016 que, a partir da integração da rede de proteção com a representatividade das esferas da saúde, educação e assistência social, assegure, de fato, que as crianças do município de Nova Mutum, se desenvolvam integralmente.

A equipe do NAIFE, formada por psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga e fisioterapeuta, desenvolve suas atividades nos Centros Municipais de Educação Infantil Integral (CMEIIs) e Centros Municipais de Educação Básica Integral (CMEBIs) de Nova Mutum contemplando os alunos matriculados na Educação Infantil, bem como os professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais do município.

12.4 - NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)

O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em janeiro de 2008. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são equipes compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de Atenção Básica(AB) compartilhando práticas e saberes em saúde com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que ampliem o seu escopo de ofertas.

O NASF constitui-se em retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no lócus da própria AB. O NASF desenvolve trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: clínico-assistencial e

técnico-pedagógica. A primeira produz ou incide sobre a ação clínica direta com os usuários; e a segunda produz ação de apoio educativo com e para as equipes.

O NASF faz parte da Atenção Básica ,mas não se constitui como um serviço com espaço físico independente. Isso quer dizer que os profissionais do Núcleo utilizam-se do próprio espaço das Unidades Básicas de Saúde e do território adstrito para o desenvolvimento do seu trabalho. Eles atuam a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes vinculadas, de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde .

Pode-se afirmar, então, que o NASF:

• É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades.

• Constitui-se como apoio especializado na própria Atenção Básica, mas não é ambulatório de especialidades ou serviço hospitalar.

•Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e não por meio de encaminhamentos impessoais.

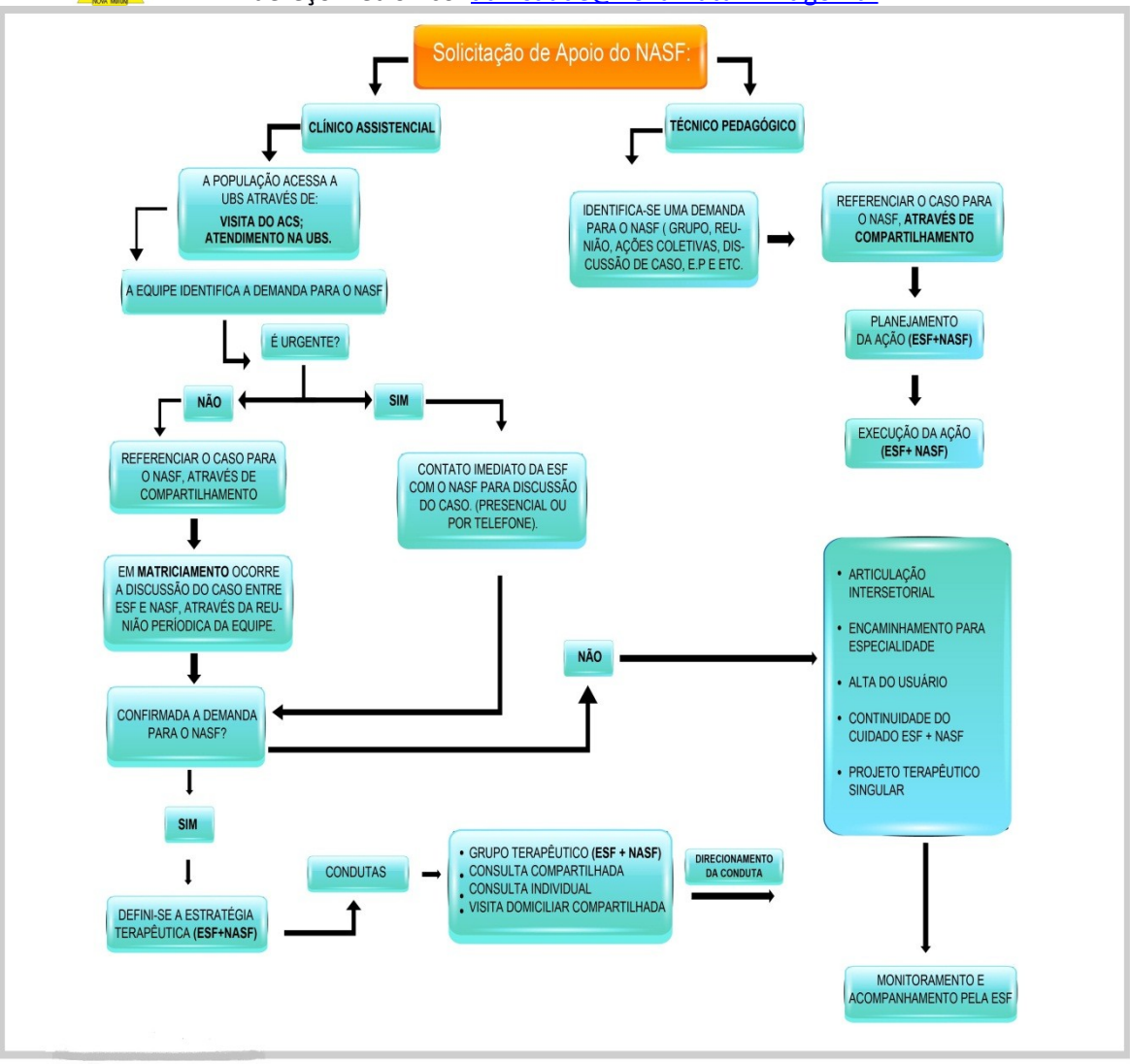
• Deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e também imprevistas.

• Possui disponibilidade, no conjunto de atividades que desenvolve, para realização de atividades com as equipes, bem como para atividades assistenciais diretas aos usuários (com indicações, critérios e fluxos pactuados com as equipes e com a gestão).

• Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família (eSF), o que não significa, necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações.

• Ajuda as equipes a evitar ou qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de atenção.

• Ajuda a aumentar a capacidade de cuidado das equipes de Atenção Básica, agrega novas ofertas de cuidado nas UBS e auxilia a articulação com outros pontos de atenção da rede.



13 - BIBLIOGRAFIA

PEDIATRIA

1 - Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33)

2 – Secretária de Estado da Saúde de Espírito Santo, Atenção à Saúde da Criança, Vitória, 2017.

3 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

4 – Sociedade Brasileira de Pediatria, Manual Prático de Atendimento em Consultório e Ambulatório de Pediatria, Problemas Comuns em Consultório Pediátrico, 2006.

5 - Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Nutrologia. Manual de Alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar / Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Nutrologia. – 4ª. ed. - São Paulo: SBP, 2018.
6 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual de condutas gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
7 - Secretária de Estado da Saúde de São Paulo, Manual de Acompanhamento da Criança, 2015.
8 – Sociedade de Pediatria de São Paulo, Pediatra Atualize-se, Panorama da Mortalidade por Acidentes em Crianças e Adolescentes no Brasil, ANO 2, Núm. 6, Nov/ 17.
9 - Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da atenção básica: saúde da criança / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
10 - Minas Gerais. Secretaria de Estado da Saúde. Atenção à Saúde da Criança. Maria Regina Viana *et al.* Belo Horizonte: SAS/DNAS, 2008, 3 Edição.
11 – Sociedade de Pediatria de São Paulo, Pediatria Ambulatorial da Teoria à Prática, 2016.
12 – Sociedade Brasileira de Pediatria, Seguimento Ambulatorial do Prematuro de Risco, 2012.

ODONTOLOGIA:

13.BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e de denvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, n. 33)
14. Protocolo integrado de atenção à saúde bucal.-Curitiba: Secretaria da Saúde de Curitiba. Centro de Informações em Saúde, 2004.100 p. : il.

FONOAUDIOLOGIA:

15. Moura .P,Honora *et al* - Esclarecendo as deficiências. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.
16. Moura. P, *et al* Northern, JL e Downs – Hearing in children, 2002.
17. Moura .P, *et al* Boone, D e Plante, E. (1994) - Comunicação humana e seus hábitos.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Novo Mutum
Secretaria Municipal de Saúde

PLANEJAMENTO FAMILIAR
PROJETO DE MÉTODOS CIRÚRGICOS DEFINITIVOS LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA

Nova Mutum-MT/2022

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....3
2. IDENTIFICAÇÃO.....4
2.1 Identificação do órgão federado: Prefeitura Municipal de Nova Mutum 4
2.2 Identificação do Representante Legal:.....4
3.DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO MUNICÍPIO.....5
3.1 Rede Instalada para Saúde.....5
Os serviços estão distribuídos em níveis de referência:.....6
4.OBJETIVOS.....7
5. OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.....7
5.1 Unidades integrantes e coparticipantes do serviço.....7
5.2 População alvo.....8
5.3 População priorizada.....8
5.4 Abordagem educativa nos grupos de Planejamento Familiar.....9
5.5 Aconselhamento.....9
5.6 Atividades clínicas.....10
6. Critérios de adesão: laqueadura e vasectomia – equipe Multiprofissional de Planejamento Familiar 10
6.1 Critérios para inclusão no programa:.....10
6.2 Documentação necessária – métodos de esterilização definitivos.....11
6.3 Serviço de referência credenciado/equipe cirúrgica.....11
Fluxograma para realização de laqueadura.....13
Fluxograma para Ralização de Vasectomia.....14
7. Cronograma.....15
ANEXOS.....16
ANEXO I.....16
ANEXO II.....17
ANEXO III.....18
ANEXO IV.....19
ANEXO V.....20
ANEXO VI.....21
ANEXO VII.....22
ANEXO VIII.....23
ANEXO IX.....24
ANEXO X.....25

1.INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei nº. 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do Planejamento Familiar, estabelece em seu artigo:

> *Art. 1º "O planejamento familiar é direito de todo cidadão" [...]*
> *Art. 2º: "[...] entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.".*

A assistência em planejamento familiar deve incluir acesso à informação e todos os métodos e técnicas para concepção e anticoncepção, e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum, em relação ao Planejamento Familiar, implementa ações como educação continuada, assim como avaliação e o monitoramento das variáveis que possam interferir na saúde reprodutiva dos casais/mulheres residentes no município.

Tendo por objetivo garantir na rede de serviços, o programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades básicas, sendo, a assistência à concepção e contracepção, a infertilidade, o atendimento ao pré-natal, a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis e o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis, mantendo assim uma avaliação priorizada ao risco reprodutivo, visando assim à redução da morbimortalidade materno-neonatal.

Como resultados dessas ações serão evidenciados na redução das complicações evitáveis durante o pré-natal, parto e o puerpério, em decorrência da assistência qualificada e priorizada a todas as etapas, que englobam desde a pré-concepção, o puerpério e atenção à criança.

Os casais bem orientados e assistidos conseguem manter suas famílias dentro dos limites por eles planejados, assim como dar uma melhor qualidade de vida para a sua família.

Os padrões de uso dos métodos contraceptivos no Brasil e com o aumento de aumento de numero de casos gravidez na adolescência estão entre os indicadores desta precariedade, conforme a lei 92/ diz:

> *Art. 4º "O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade".*

Pode-se citar a lei em questão, pois a mesma contém mecanismos de controle sobre as práticas da laqueadura de trompas e da vasectomia.

Os serviços de saúde do município devem, através de instruções a respeito da fertilidade, da anticoncepção e dos métodos anticoncepcionais, subsidiar a escolha consciente e o uso adequado do método que mais se adapta à realidade do casal, homem ou mulher, bem como fornecer o método anticonceptivo escolhido.

2. IDENTIFICAÇÃO

2.1 Identificação do órgão federado: Prefeitura Municipal de Nova Mutum

Município de Nova Mutum - CNPJ: 24.772.162/0001-06

Endereço: Avenida Mutum, 1.250 N

Bairro: Centro

Cidade: Nova Mutum – MT

CEP: 78.450-000

Número do telefone: (65) 3308-5400 Ramal: 5467

Endereço eletrônico: admsaude@novamutum.mt.gov.br

2.2 Identificação do Representante Legal:

Nome: Sônia Maria de Ávila, CPF: 535.265.701-91

3.DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO MUNICÍPIO

O município de Nova Mutum está situado no médio norte Mato-grossense Mesorregião 127 – Norte Mato-Grossense e Microrregião 523 – Alto Teles Pires, a uma latitude 13º49'44" longitude oeste 56º05'16", estando a uma altitude de 450 metros, sede do município e 480 a 550 metros área de produção. Possui uma área de 9.544,574 km² oque equivale a 1,12% da area total do estado de Mato Grosso.

O município antes de ser colonizada a região era conhecida como "Irmandade" e pertencia a Jorge Rachid Jaudy. Em 1966 um grupo de empresários paulistanos capitaneados por José Aparecido Ribeiro, adquiriu uma extensa área de terras, de aproximadamente 169 mil hectares no município de Diamantino, constituindo a Mutum Agropecuária S/A. Conseguiram a aprovação junto a SUDAM do projeto de pecuária em área de 120 mil hectares, sendo 54 mil hectares de pastagens e 60 mil hectares para reservas florestais, restando 56 mil hectares para futuras ampliações.

O projeto de pecuária consistia em cria, recria e engorda de bovinos, divididos em dois grandes núcleos: Arinos e Mutum. O projeto foi implantado definitivamente em 1981. Como a área era muito grande houve a ideia de gerar oportunidades para novos pioneiros, sendo desenvolvidos experimentos com arroz, milho e soja em 1974. A população de Nova Mutum aumentou 152,36%, em um período de 21 anos. A informação tem por base o resultado do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

Foram confirmados 31.649 habitantes. Em 2021, o município estava com população estimada de 48.222 habitantes os limites geográfico Norte: Nova Maringá, Tapurah e Lucas do Rio Verde, Leste: Sorriso e Santa Rida do Trivelato, Sul: Nobres e Diamantino, Oeste: São José do Rio Claro e Diamantino.

3.1 Rede Instalada para Saúde

O Sistema Municipal de Saúde é descentralizado, na condição de Gestão Plena, de acordo com as normas do SUS.

O município de Nova Mutum está progredindo nas ações de atenção básica a saúde média e alta complexidade. Disponibilizando aos munícipes, atendimento em várias especialidades médicas e exames de média complexidade.

O sistema municipal de saúde está organizado, conforme os princípios e diretrizes do SUS: Universalidade, Descentralização, Equidade, Integralidade, Regionalização e

Hierarquização e Participação Social.

Os serviços estão distribuídos em níveis de referência:

- Atenção Primária à Saúde: o muncipio possui 11 Estratégias de Saúde da Família, conta com Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Equipe de Saúde Bucal, Posto de Saúde nas comunidades Rurais em Processo de Credenciamento para eAP, possui equipe NASF para subsídios as ações APS.
- O Pronto Atendimento Municipal é porta de entrada para as urgências e emergências de saúde, e suporte para as unidades de saúde do município. É equipado por estabilizar os pacientes em estado grave, e referenciado para Hospital Hilda Strenger Ribeiro (Instituto São Lucas) que é o hospital pactuado para realizar serviços médicos hospitalares do município.
- Nos Centro de Especialidades à oferta de consultas com especialistas conforme as demandas de saúde, o município compra os serviços de Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia, Ortopedista, Psiquiatra, Neurologista, Cardiologista, Neuropediatra, Nefrologista, Urologista, Reumatologista, Otorrinolaringologista e Oftalmologista as demais consultas e procedimentos são inseridos no SISREG estadual.
- O Centro de reabilitação é descentralizado para as ESF com todas unidades possuindo Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Psicólogo para atendimento das demandas locais e há também atendimento de dois Nutricionistas referenciados conforme localidade geográfica do paciente.
- O município conta com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) que é referência e subsidia as ESF no tratamento e acompanhamento de pessoas que apresentam sofrimento psiquico decorrenta de transtorno mental .
- O Laboratório Municipal realiza os exames demandados pelas unidades de saúde do município, sendo reconhecido pela qualidade dos exames e celeridade na entrega dos resultados.
- A Assistência Farmacêutica é centralizada com duas Farmácias em duas regiões sendo a Farmácia Básica Municipal atendendo a região Sul e a Farmácia Municipal a região Norte da cidade, a dispensação de medicamentos dada conforme a prescição médica tendo a REMUME ferramenta de norteadora. Possui Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) que realiza as compras, armazena e distribui para as unidades conforme solicitações e as necessidades unidades.
- O município conta com Conselho Municipal de Saúde que garante a participação

da população nos processos de decisão, acompanhamento e avaliação das ações de saúde.

- A Vigilância em Saúde desenvolve ações de promoção, monitoramento contínuo no município. É por meio de estudos e análises que revelem os comportamentos indicadores de saúde, favorecendo as questões relevantes que contribui para planejamento das açoes em saúde mais abrangente no municipio. A vigilância atua com a perspectiva de prevenir e controlar doenças e agravos para o alcance dos resultados.

Conforme o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (MS 2005).

Todas as mulheres e homens têm o direito livre e conscientemente, de decidir se desejam ter filhos, o seu número de prole, o espaçamento entre eles, devendo-lhes ser asseguradas às informações e os meios necessários para concretizar esta decisão".

No município Nova Mutum há um grande número de mulheres em idade fértil e que necessitam de uma assistência de qualidade e humanizada. Atualmente, há dificuldade de acesso para homens e mulheres que desejam realizar a esterilização cirúrgica, devido não existir hospital credenciado para a realização dos procedimentos de Laqueadura e Vasectomia.

4.OBJETIVOS

Implementar serviço público para realização de laqueadura e vasectomia no Hospital Instituto São Lucas/ Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro de referência municipal Nova Mutum e instruir uma equipe multiprofissional do Programa de Planejamento Familiar, para garantir uma assistência à anticoncepção ampla, segura, humanizada e resolutiva para a escolha consciente e o uso adequado do método que mais se adapta à realidade do casal/paciente.

5. OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

À Anticoncepção e da Esterilização Cirúrgica

5.1 Unidades integrantes e coparticipantes do serviço

- 11 Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF);
- 02 Postos de Saúde;

As ESFs e Postos de Saúde oferecem os serviços de assistência à concepção, atendimento ao pré- natal, assistência ao puerpério e ao neonato, controle das doenças sexualmente transmissíveis, controle e prevenção do câncer cérvico uterino e do câncer de mama e realizam atividades preventivas como orientações o uso de métodos anticoncepcionais (reversíveis e irreversíveis), medicina preventiva e IST/AIDS.

A mulher/homem/casal que quiserem esclarecer dúvidas ou tiver o interesse em realizar a esterilização cirúrgica, pode contar a as equipes das unidades de saúde que encaminharão para a Equipe Multiprofissional de Aconselhamento. Os profissionais das equipes de saúde incluindo os Agentes Comunitários de Saúde encaminham todas mulheres, homens ou casal com vida sexual ativa, no sentido de obter intervenções oportunas, tanto preventivas como educativas e terapêuticas.

A Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento será composta com os seguintes profissionais enfermeiro, psicóloga, assistente social e médica devidamente capacitados, o usuário participará das reuniões, na qual terá acesso à informação e discussão que possibilite uma escolha mais acertada e consciente acerca do método contraceptivo. Serão realizados encontros com os casais ou indivíduo e se for decidido por método definitivo será encaminhado para a realização do procedimento.

5.2 População alvo

Mulheres/homens/casal em idade fértil, conforme legislação.

5.3 População priorizada

Serão priorizadas mulheres que apresentem um ou mais fatores de risco reprodutivo relacionados a seguir:

- Antecedentes obstétricos desfavoráveis, tais como: abortos, óbitos fetais e neonatais, infertilidade, cerclagem, amniorrexe prematura, trabalho de parto prematuro, DHEG, DMG.
- Doenças crônicas (Risco reprodutivo severo): Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, doença renal, cardiopatia, doenças autoimunes, pneumopatias, hepatopatias, infecção HIV/AIDS e outras doenças sistêmicas graves;
- Uso/abuso de drogas: benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, tabagismo, alcoolismo e outras drogas lícitas e/ou ilícitas.

5.4 Abordagem educativa nos grupos de Planejamento Familiar

A atuação dos profissionais de saúde atuando na Equipe de Multidisciplinar de Aconselhamento deve ser pautada no artigo 226, parágrafo 7° da Constituição da República Federativa do Brasil.

> *Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.*
>
> *§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.*

As atividades educativas individuais e em grupos serão desenvolvidas com o objetivo de disponibilizar ao usuário conhecimento sobre os tipos de métodos de anticoncepção para melhor escolha e posterior utilização do método mais adequado. Assim, propiciar o questionamento e reflexão sobre os temas relacionados com a prática da anticoncepção, inclusive a sexualidade.

Priorizar práticas educativas participativas que permita a troca de informações e experiências baseadas nas vivências das próprias mulheres. A linguagem do profissional deve ser acessível, simples e precisa.

Serão ser abordados os seguintes temas como, importância do planejamento familiar; noções sobre fisiologia e anatomia dos órgãos sexuais e sexualidade; tipos de métodos; características, vantagens, desvantagens, efetividade, contra-indicações e complicações relativas aos métodos e prevenção das ISTs/AIDS.

5.5 Aconselhamento

O aconselhamento multidisciplinar é entendido como um processo de escuta ativa individualizada e centrada no indivíduo. Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre o profissional visando o resgate dos recursos internos do indivíduo para que ele tenha possibilidade de se reconhecer como sujeito de sua própria saúde e transformação. O aconselhamento será realizado da seguinte forma:

- Identificação e acolhimento ao indivíduo ou casal entendido como suas necessidades, dúvidas, preocupações, medos e angústias entre outras, relacionadas às questões de planejamento familiar e prevenção das IST/AIDS;
- Avaliação de risco individual ou do casal, para a infecção pelo HIV e outras ISTs;
- Reconhecimento pelo profissional de que o sucesso a ser alcançado depende da ação conjunta: profissional e indivíduo ou casal.

A ideia demarcada no aconselhamento é a troca, para haver uma relação de confiança

5.6 Atividades clínicas

A primeira consulta será feita pelo médico e pela enfermeira e incluirá: a anamnese, exame físico geral e ginecológico, com especial atenção para a orientação do auto-exame de mamas e levantamento de data do último exame citopatológico do colo do útero, para avaliar a necessidade de realização da coleta ou encaminhamento para tal; análise da escolha e prescrição do método anticoncepcional.

5.7 Escolha do Método Anticoncepcional

A Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento orientará sobre todas os métodos anticoncepcionais aprovados pelo Ministério da Saúde informando sobre as indicações, contraindicações e implicações no uso garantindo a mulher, homem ou casal na escolha do método que melhor se adapte a sua realidade.

Na decisão do método anticoncepcional devem ser levados em consideração a escolha do paciente, características dos métodos, fatores individuais e situacionais relacionados a eficácia, efeitos secundários, aceitabilidade, disponibilidade, facilidade de uso, reversibilidade e proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis.

6. Critérios de adesão: laqueadura e vasectomia – Equipe Multiprofissional de Aconselhamento

Após receber as devidas orientações pelos profissionais da APS da SMS de Nova Mutum mulher/homem/casal, que escolham realizar o método definitivo, serão encaminhados a Equipe Multiprofissional do Programa de Planejamento Familiar, com a Ficha de encaminhamento para Aconselhamento em Laqueadura Tubária/ Vasectomia devidamente preenchido (anexo IV).

Serão realizadas entrevistas de acolhimento para a adesão por profissionais que compõem a Equipe Multiprofissional (enfermeiro, psicóloga, assistente social e médico); e roda de conversa por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce e o risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto.

Os encontros da EMA com a mulher/homem/casal que manifestou interesse em realizar um dos procedimentos cirúrgicos de esterilização serão realizados na ESF Araras às quintas feiras a partir das 18:00 horas sendo dois encontros quinzenais. E o paciente estando apto a realização do procedimento de acordo com parecer de todos os profissionais, terá sua documentação enviada para o setor regulação da Secretária Municipal de Saúde para ser

agendada a consulta com o especialista que emitirá o laudo de AIH. Posterior a emissão do laudo de AIH o setor de regulação realizará o agendamento do procedimento cirúrgico no hospital credenciado e habilitado de referência.

A equipe de regulação entrará em contato com o paciente para informar sobre os tramites, dia, hora que ser

6.1 Critérios para inclusão no programa:

- Cumprir as exigências da Lei Federal nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996; da, Resolução CIB/MT nº 007de 10 de fevereiro de 2011 e **Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.**
- Ter recebido a orientação e oferta de todos os métodos anticoncepcionais, registrado no prontuário individual;
- Estar participando das reuniões dos grupos educativos;
- Expressar o desejo de esterilização por escrito;
- Nos casos de pós-parto/cesárea, o procedimento de esterilização cirúrgica será realizado 60 dias após os usuários que expressarem o desejo da esterilização;
- Avaliação Psicológica/Laudo Psicológico e Conclusão
- Avaliação do Assistente Social
- Consulta médica
- Consulta Enfermagem

Após realizar discussão dos casos a Equipe Multiprofissional de Aconselhamento encaminha os aptos para consulta com o especialista para indicação do procedimento cirúrgico com toda a documentação necessária.

6.2 Documentação necessária – métodos de esterilização definitivos

Documento do usuário que expressa o desejo da esterilização;

- RG do casal (cópia)
- CPF (cópia)
- Certidão de Casamento (cópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos (cópia)
- Cartão SUS (cópia)
- Carteira de vacina em dia (cópia)

- Comprovante de endereço
- Ficha de encaminhamento para realização de laqueadura tubária/vasectomia (anexo V)
- Termo de responsabilidade (anexo VI)
- Ficha individual de notificação de laqueadura tubárea e vasectomia (anexo VII)

6.3 Exames necessários para serviço de referência credenciado/equipe cirúrgica

- Hemograma
- Coagulograma;
- Glicemia de jejum
- Parcial de urina
- Papanicolau;
- VDRL;
- HIV;
- Creatinina
- Solicitar teste imunológico de gravidez se for necessário;
- Outros, se necessário;

6.4 Fluxo de relatório para acompanhamento e supervisão dos procedimentos relativos a realização dos procedimentos de Laqueadura Tubária e Vasectomia.

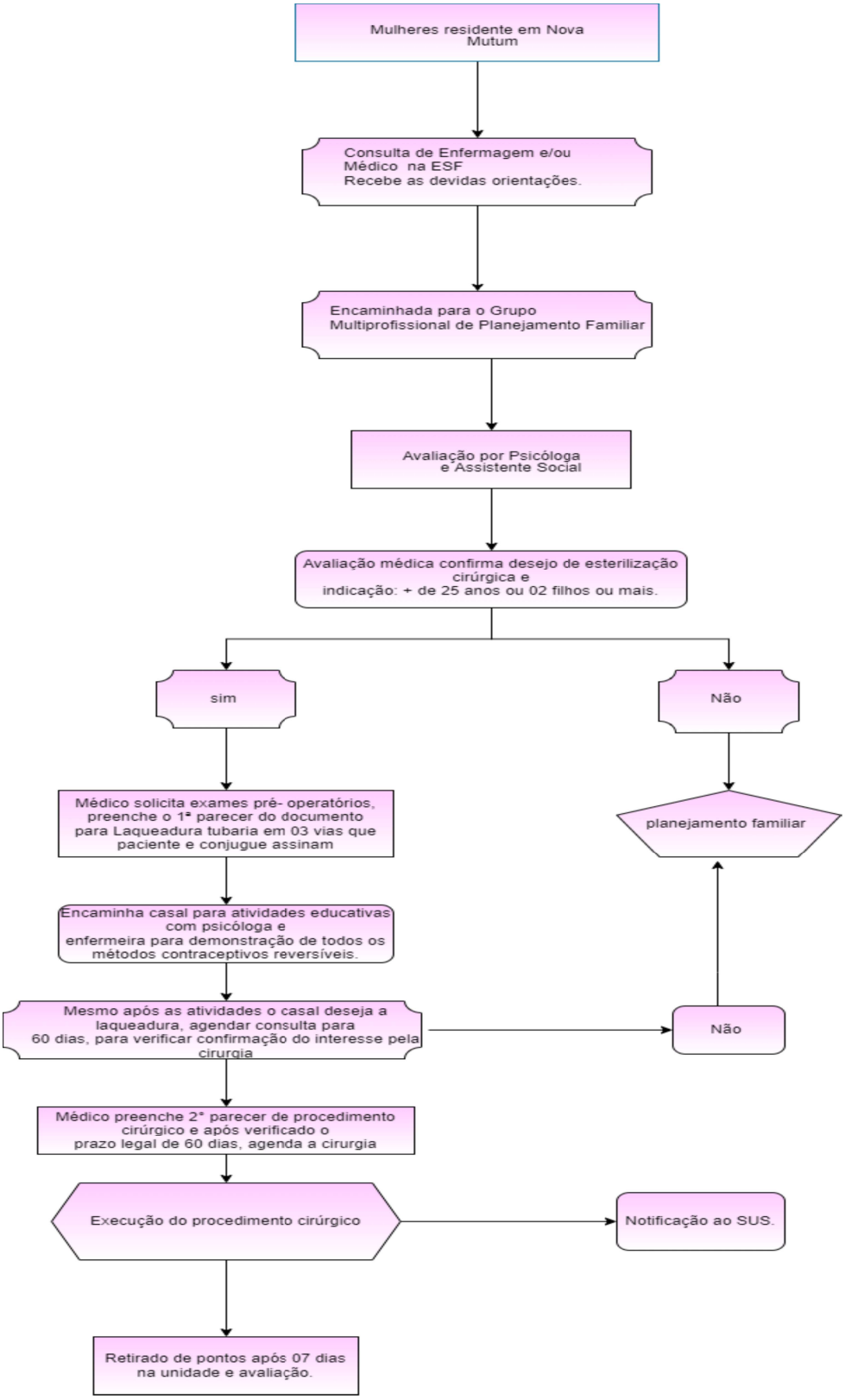
Mensalmente no último dia útil a Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento encaminhará a Secretaria de Saúde o "Relatório de Atendimento da Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento" (Anexo VIII). A Secretaria Municipal de Saúde recebe o relatório de atendimento da equipe muldisciplinar de aconselhamento (anexo IX) preenche o "Consolidado de Atendimento e (Anexo X) e mensalmente, encaminha ao Escritório Regional de Saúde, caso não haja realização de procedimentos, a Unidade Hospitalar deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Saúde.

O Hospital de Referência, após a realização do procedimento deverá preencher a "Ficha de Notificação Compulsória" conforme anexo VII, em duas vias, sendo que:

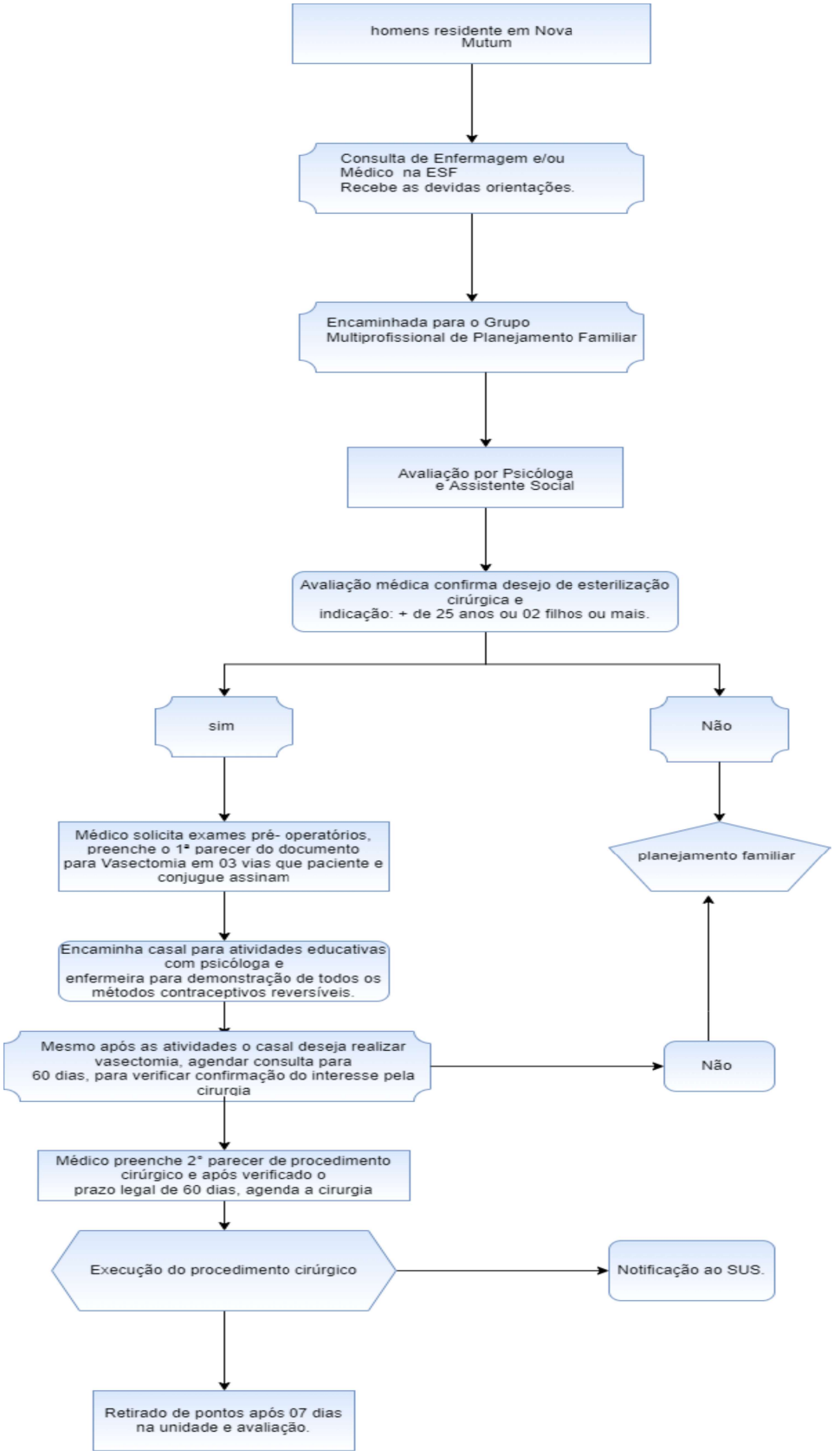
I – As primeiras vias da "Ficha de Notificação Compulsória", do "termo de Responsabilidade" e da "Ficha de Encaminhamento para a Realização de Laqueadura Tubária e Vasectomia" deverão ser anexadas ao prontuário do (a) usuário (a) na Unidade Hospitalar credenciada, para fins de supervisão.

II – Na segunda via da Ficha de Notificação Compulsória deverá ser encaminhada a Secretaria de Saúde Municipal mensalmente.

Fluxograma para realização de laqueadura



Fluxograma para Ralização de Vasectomia



7. Cronograma

Seguir o cronograma da implantação do Programa de Planejamento Familiar:

Atividades	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
Encaminhamento do projeto para o Conselho Municipal de Saúde	Março					
Encaminhamento do projeto para aprovação na Comissão Intergestores Bipartite – Estadual		Julho				
Planejamento do cronograma de implantação			Julho			
Remanejamento e ajuste de Recursos Humanos.				Julho		
Capacitação dos profissionaisdas equipesde PlanejamentoFamiliaredeMétodos Definitivos					Outubro	
Início do serviço cadastrado com profissionais capacitados e com medicamentos e procedimentos.						Novembro

7 Equipe Multiprofissional de Planejamento Familiar e MétodosDefinitivos

Médico ESF	Dr.Andressa Fabrizio CRM 7944
Enfermeira	Daniele Merisio Raimundi Santos Coren: 442.455
Psicóloga	Liz Maria Almeida de Andrade CRP:18/02386
Assistente Social	Sylvia Graham de Araujo Novaes CRESS 4160

ANEXOS

ANEXO I

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
FICHA DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA

Inclusão	01	Alteração	00	Exclusão	00
CNPJ do Hospital:	40.182.607/0001-54				

Razão Social/Nome: INSTITUTO SAO LUCAS/ HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO			
Logradouro: RUA JATOBAS		Número: S/N	Complemento: SALA 02
Bairro: JARDIM ORQUIDEAS	CEP: 78.450-0000	Município: Nova Mutum	UF: MT
Nome do Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil	Agencia: 3325	Conta Corrente: 130319-8	
UF: MT	Código do Município: 510622		

ESPECIALIDADE		**LEITOS**		**Números de Profissionais**
Nome Código	Código	Contratados	Total	
Obstetrícia	2	8	8	4
Cirurgia Geral	1	9	9	6
Clinica Geral	3	21	21	29
TOTAL		38	38	35

Orienta:
Métodos Naturais: Sim
Outros: _____
Oferece:
Métodos de Barreira
(x) Preservativo Masculino
(x) Preservativo Feminino
( ) Diafragma

Métodos Hormonais
(x) Hormonal Oral Combinado
(x) Minipílula
(x) Hormonal Injetável Mensal
(x) Hormonal Injetável Trimestral
(x) Anticoncepção de Emergência
(x) DIU Tipo: Cobre

OUTROS:_____

Hallan Alencar Ribeiro
Diretor Administrativo

Dr. Mauricio Eidiro Nishiyama
Diretor de Serviços de Saúde

ANEXO II

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
FICHA DE CADASTRO DE UNIDADES COM EQUIPE MULDISCIPLINAR DE ACONSELHAMENTO

Nome da Unidade: ESF Araras CNES: 3017524
Razão Social: Prefeitura Municipal de Nova Mutum CNPJ:24.772.162/0001-06
Logradouro: Avenida dos Beija Flores - 173 N
Bairro: Centro
CEP: 78.450-000 Município: Nova Mutum – MT Regional/Consórcio: Teles Pires

Equipe Responsável Pelo Planejamento Familiar	NOME
Médico	Andressa Fabrizio
Enfermeiro	Daniele Merisio Raimundi Santos
Psicológo	Liz Maria Almeida de Andrade
Assistente Social	Sylvia Graham de Araújo Novaes
Outros Específicos	

Orienta:
Métodos Naturais: Sim
Outros: _____

Oferece:
Métodos de Barreira
(x) Preservativo Masculino
(x) Preservativo Feminino
( ) Diafragma

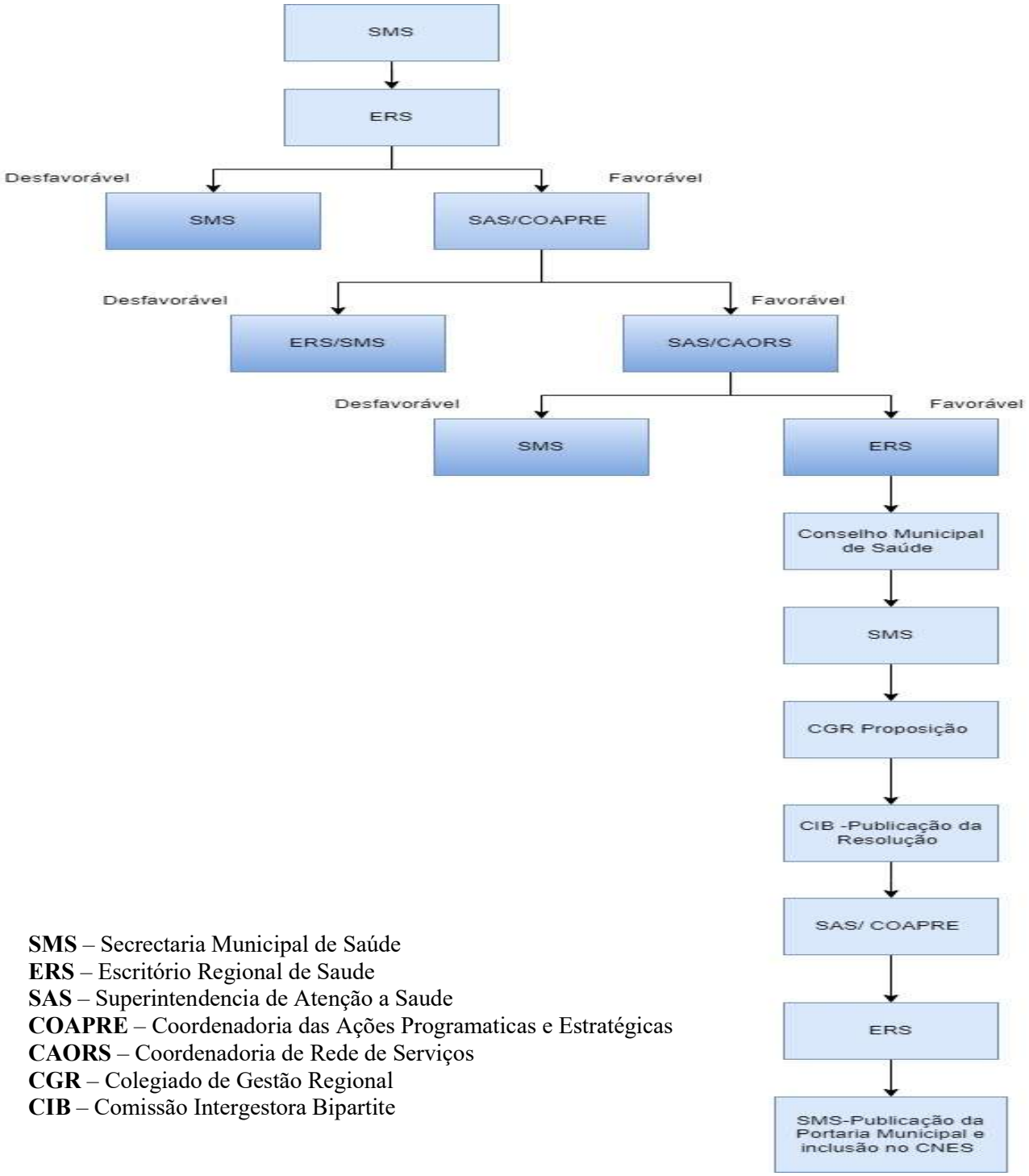
Métodos Hormonais
(x) Hormonal Oral Combinado
(x) Minipílula
(x) Hormonal Injetável Mensal
(x) Hormonal Injetável Trimestral
(x) Anticoncepção de Emergência
(x) DIU Tipo: Cobre

OUTROS:_____

_____ _____
Andressa Fabrizio **Sônia Maria de Ávila**
CRM/MT : 7944 **Secretária Municipal de Saúde**

ANEXO III

FLUXOGRAMA PARA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO
HABILITAÇÃO DE HOSPITAIS PARA LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA



SMS – Secrectaria Municipal de Saúde
ERS – Escritório Regional de Saude
SAS – Superintendencia de Atenção a Saude
COAPRE – Coordenadoria das Ações Programaticas e Estratégicas
CAORS – Coordenadoria de Rede de Serviços
CGR – Colegiado de Gestão Regional
CIB – Comissão Intergestora Bipartite

ANEXO IV

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA ACONSELHAMENTO EM LAQUEADURA TUBÁRIA / VASECTOMIA

Nome da Unidade de Origem:_____CNES:_____
Endereço:_____N.º:_____Bairro:_____CEP: 78.450-000
Município:_____UF:_____Escritório Regional de Sinop
Consórcio:_____ Outros/Especificar:_____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome do paciente:

Data de Nascimento: ___/___/___ Idade:_____ Sexo: □Feminino □Masculino
Estado Civil: _____Casado □ Viúvo □

Divorciado □ Amasiado □
CPF:_____RG:_____
Grau de Instrução: □Analfabeto □Ensino Fundamental □Ensino Médio □Ensino Superior
Ocupação:_____Renda Familiar: _____

Nome do Cônjuge:_____
Data de Nascimento:_____/_____/_____ Idade: _____
Endereço:_____ Residencial:_____N.º:_____
Bairro:_____CEP:_____ Cidade: _____UF: _____
Procedimento Solicitado: ( ) Laqueadura Tubária ( ) Vasectomia

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

N.º de partos normais:_____N.º de partos cesariana:_____ N.º de abortos:____N.º de nati-mortos:_____ N.º de filhos vivos:____Data do último parto:_____

Condições clínicas que contra indicam uma Gravidez: _____
_____

Observações:_____
_____
_____
_____

Médico:_____CRM:_____

Assinatura:_____Data:____/_____/_____

ANEXO V

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA / VASECTOMIA

Nome: _____

Data de Nascimento:_____/___/____Idade:_____Sexo: □Masculino □Feminino
Estado Civil: □Solteiro □Casado □Viúvo □Divorciado CPF:____/____/____-___
RG:_____
Grau de Instrução: □Analfabeto □Ensino Fundamental □ Ensino Médio □Ensino Superior
Ocupação:_____Renda Familiar: _____

Orientou:
Métodos Naturais.

Quais?

_____
_____

Se outros, quais?

_____
_____

Ofereceu:
Métodos de Barreira
□ Preservativo Masculino □ Preservativo Feminino □ Diafragma

Métodos Hormonais

□ Hormonal Oral Combinado □ Minipílula □ Hormonal Injetável Mensal □ Hormonal Injetável Trimestral □ Anticoncepção de Emergência.

( )DIU: Tipo:_____

OUTROS:
Motivo da opção pela Laqueadura Tubária ou Vasectomia

Parecer da Equipe Multiprofissional - Assinatura e Carimbo

Assistente Social: _____( ) Favorável ( ) Desfavorável Data: / /
Enfermeiro: _____ ( ) Favorável ( ) Desfavorável Data: / /
Médico: _____( ) Favorável ( ) Desfavorável Data: / /
Psicólogo: _____( ) Favorável ( ) Desfavorável Data: / /

ANEXO VI

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____, voluntariamente desejo submeter-me à contracepção cirúrgica e esclareço que:

1. Tenho conhecimento sobre outros métodos contraceptivos, os quais me foram oferecidos.

2. Estou consciente que a contracepção cirúrgica ( ) Laqueadura Tubária, ( ) Vasectomia é um método definitivo e que as tentativas de reversão não têm sucesso garantido e nem são oferecidas de modo rotineiro.

3. Estou consciente que toda e qualquer cirurgia tem os seus riscos operatórios.

4. Estou consciente que ocasionalmente este método pode falhar;

5. Estou consciente que com a cirurgia estarei interrompendo minha fertilidade, que caso contrário poderia se prolongar por vários anos.

Idade do casal:	
Homem:	Número de filhos vivos:
Mulher:	Número de filhos vivos:
Número de gestações:	Partos vaginais:
Cesáreas:	Abortos:

Métodos utilizados e seus efeitos:
Patologias associadas:_____

Observações:_____
_____

Declaramos que as informações são verdadeiras:

_____ Assinatura doª cliente

_____ Assinatura doª companheiro(a)

Documento:_____ Data:__/__/__

Documento:_____ Data:__/__/__

A equipe multiprofissional de aconselhamento de planejamento familiar é favorável a realização desta cirurgia de contracepção.

_____ Assinatura e carimbo do Assistente Social

_____ Assinatura e carimbo do Enfermeiro

_____ Assinatura e carimbo do Médico

_____ Assinatura e carimbo do Psicólogo

ANEXO VII

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁREA E VASECTOMIA
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Nome / Razão Social:	
CGC / CNPJ:	**Data:**

DADOS DO PACIENTE

Nome do(a) paciente:			
Logradouro:			
Número:		Complemento:	Bairro:
CEP:		Município (**código IBGE**):	Nome do Município:
SEXO	M□ F□	Data de nascimento: / /	Nº de filhos:

GRAU DE INSTRUÇÃO
Analfabeto □ □ Ensino Fundamental □ Ensino Médio □ Ensino Superior

Documentação completa presente no prontuário:
Sim □ Não □
INDICAÇÃO

INDICAÇÃO
(Cid 10 – Em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou futuro concepto)

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS UTILIZADOS ANTERIORMENTE
Métodos Naturais: _____
Outros**:** _____
Oferece:
Métodos de Barreira
□ Preservativo Masculino □ Preservativo Feminino □ Diafragma
Métodos Hormonais
□ Hormonal Oral Combinado □ Minipílula □Hormonal Injetável Mensal
□ Hormonal Injetável Trimestral □ Anticoncepção de Emergência
DIU: Tipo:_____
OUTROS:_____

DADOS DA INTERNAÇÃO

Data da Internação:	Data da Alta:	Médico Responsável

_____
Responsável pelo preenchimento/Carimbo

ANEXO VIII

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
CONSOLIDADO DE ATENDIMENTO

Secretaria Municipal de Saúde: _____
Escritório Regional de Saúde: _____
Mês/Ano: _____

1. Atendimento da Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento no Mês, conforme relatório de atendimento da Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento*:*

1.1 Número de mulheres atendidas:_____

2. Realização de Laqueadura Tubária/Vasectomia, conforme recebimento de Ficha de Notificação Compulsória Hospitalar:

2.1 Número de Laqueaduras Realizadas: _____
2.2 Número de Vasectomias Realizadas: _____
***2.3 Total de Procedimentos Realizados:* _____**

Faixa Etária:
< 20 = ____ 20 a 24 = ____ 25 a 30 = ____ 30 a 35 = ____ + 35 = ____ **Total:_____**

Quantidade de mulheres atendidas com:
Nenhum filho:____ 1 filho:_____ 2 filhos:_____ 3 filhos:_____ 4 filhos:_____ 5+ filhos:_____ **Total:_____**

1.2 Número de Homens atendidos*:*_____ Faixa Etária:< 20 = ____ 20 a 24 = ____ 25 a 30 = ____ 30 a 35 = ____ + 35 = ____ **Total:_____**

Quantidade de homens atendidos com:
Nenhum filho:____ 1 filho:_____ 2 filhos:_____ 3 filhos:_____ 4 filhos: _____ 5+ filhos:_____ Total:_____

1.3 Número de mulheres encaminhadas para a realização de laqueadura tubária: ___
1.3.1 – Número de mulheres < 25 anos encaminhadas para realização de laqueadura tubária:____

1.4 Número de homens encaminhados para a realização de vasectomia: ____

_____
Nome e função do responsável pelo preenchimento

Data:___/____/_____

ANEXO IX

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULDISCIPLINAR DE ACONSELHAMENTO

Secretaria Municipal de Saúde: _____

Nome do Cliente	**Idade**	**Estado Civil**	**N.ºFilhos**	**Procedimento Realizado**			
				Aconselhamento		Encaminhamento para realização de esterilização	
				Sim □ Não□		Sim □ Não □	

Unidade com Equipe Multidisciplinar de Aconselhamento:

Mês/Ano:

Data___/____/_____ **Responsável pelo preenchimento**

ANEXO X

RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 007 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
PLANILHA PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS REGIONAL

Escritório Regional de Saúde:_____

Mês/Ano: _____

Município	Mulheres Atendidas (Número) *	Faixa etária						Mulheres encaminhadas p/ esterilização definitiva.	Número de Laqueaduras Tubárias realizadas
		<20	20 - 24	25 - 30	30 - 35	+35	TOTAL		

Município	Homens Atendidos (Número)	Faixa etária						Homens encaminhadas p/ esterilização definitiva.	Número de Vasectomias realizadas
		<20	20 - 24	25 - 30	30 - 35	+35	Total		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM –MT
ESTADO DE MATO GROSSO – CNPJ: 24.772.162/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereco Eletrônico: admsaude@novamutum.mt.gov.br

PROTOCOLO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL

NOVA MUTUM - MT
2024

PROTOCOLO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL

Elaboração:

Aline Faccio Ramos - Enfermeira Obstetra
Andressa Fabrizio - Médica de Família e Comunidade
Camila Mello Fantin - Psicóloga
Daniele Merísio Raimundi Santos - Enfermeira Obstetra
Edison Leonardo Balz Carvalho - Educador Físico
Everson Flavio de Oliveira - Odontolólogo
Juliana Eisele - Nutricionista
Juliana Manfroi - Enfermeira
Mara Domingos - Médica Pediatra
Sylvia Graham de Araújo Novaes - Assistênte Social

Colaboradores:

Aldo Luis Hota - Médico Obstetra
Alini da Fonseca Rodrigues - Farmacêutica
Anderson Lins Ferreira Formighieri - Coordenador de Departamento de Atenção Básica
Elisane Maria Della Mea - Coord. de departamento do MAC
Juliana Schirmer - Coord. do Pronto Atendimento Municipal
Leila Simoni Raimundi - Enfermeira
Luciane Mayer - Diretora da Secretaria de Saúde
Luíz Vianney Saldanha Cidrão Nunes - Médico
Malu Suzane de Almeida - Enfermeira
Sonia Maria de Ávila - Secretária de Saúde
Victor Hugo Dantas de Almeida - Médico Obstetra

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 6
CAPÍTULO 1 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO CUIDADO EM SAÚDE NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL 7
RECURSOS HUMANOS 9
CAPÍTULO 2 - A GESTAÇÃO NO ÂMBITO DOS DIREITOS DO TRABALHO, SOCIAIS E DEMAIS ESPECIFICIDADES 15
VIOLÊNCIAS NA GRAVIDEZ 15
DIREITO RELACIONADO AO PARTO 16
DIREITOS SOCIAIS 16
ENTREGA EM ADOÇÃO 16
A ESTUDANTE GRÁVIDA 17
DIREITOS TRABALHISTAS 17
AMAMENTAÇÃO 17
AFASTAMENTOS 17
CAPÍTULO 3 - ABORDAGEM DA AMENORREIA 19
ATIVIDADE SEXUAL 19
USO DE MÉTODO ANTICONCEPCIONAL 19
TEMPO DE AMENORREIA 19
SINAIS E SINTOMAS DE PRESUNÇÃO 20
SINAIS DE CERTEZA 21
CAPÍTULO 4 - CONSULTA DE PRÉ-NATAL 22
CALENDÁRIO DE CONSULTAS 22
A PRIMEIRA CONSULTA DE PRÉ-NATAL 22
ANAMNESE 23
CÁLCULO DA IDADE GESTACIONAL (IG) E DA DATA PROVÁVEL DE PARTO (DPP) 24
EXAME FÍSICO 25
EXAME FÍSICO GERAL 25
EXAME FÍSICO ESPECIAL 26
EXAME FÍSICO GINECO-OBSTÉTRICO 27
EXAME FÍSICO OBSTÉTRICO 27
TESTES RÁPIDOS 28
EXAMES LABORATORIAIS 28
ULTRASSONOGRAFIAS (USG) 28
SUPLEMENTAÇÃO 30
SINTOMÁTICOS NA GESTAÇÃO 31

VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO VACINAL 31
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL 35
ENCAMINHAMENTOS 35
TEMPO ESTIMADO DA CONSULTA 36
SEGUIMENTO DAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 37
EXAME FÍSICO 37
EXAMES DE SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE 37
CAPÍTULO 5 - MUDANÇAS FISIOLÓGICAS NA GRAVIDEZ 39
CAPÍTULO 6 - ENCAMINHAMENTO AO OBSTETRA 43
CAPÍTULO 7 - PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO 45
ANAMNESE E EXAME CLÍNICO 45
PROCEDIMENTOS 45
ORIENTAÇÕES 46
CAPÍTULO 8 - PRÉ-NATAL PEDIÁTRICO 47
ROTINA DE ENCAMINHAMENTO 48
CAPÍTULO 09 - PRÉ-NATAL NUTRICIONAL 49
GESTANTE BAIXO RISCO - ROTINA: 49
GESTANTE MÉDIO/ALTO RISCO: 49
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ANTROPOMÉTRICA 50
CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL POR SEMANA GESTACIONAL 50
CONSULTAS NUTRICIONAIS SUBSEQUENTE 51
CAPÍTULO 10 - QUESTÕES NUTRICIONAIS NO PRÉ-NATAL 52
ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL REALIZADA NA UBS PELA EQUIPE TÉCNICA EM ENFERMAGEM: 52
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NA CONSULTA PRÉ-NATAL 52
CAPÍTULO 11 - QUESTÕES EMOCIONAIS NO PRÉ-NATAL 56
CAPÍTULO 12 - ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO 58
TEMPO DE ATIVIDADE FÍSICA 58
EXERCÍCIOS PARA GESTANTES NO 1° TRIMESTRE 58
EXERCÍCIOS PARA GESTANTE NO 2° TRIMESTRE 59
EXERCÍCIOS PARA GESTANTES NO 3º TRIMESTRE 59
ATIVIDADES FÍSICAS RECOMENDADAS: 59
CAPÍTULO 13 - SINAIS DE ALERTA NA GESTAÇÃO 61
SANGRAMENTO VAGINAL 61
CEFALEIA, ESCOTOMAS VISUAIS, EPIGASTRALGIA E EDEMA EXCESSIVO 67
CONTRAÇÕES REGULARES, PERDA DE LÍQUIDO 68
CAPÍTULO 14 - CONDIÇÕES CLÍNICAS OBSTÉTRICAS ADVERSAS 70
ANEMIA 70

DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL 71
DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS DA GESTAÇÃO 72
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 74
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 76
CAPÍTULO 15 - ROTINA DE ENCAMINHAMENTO AO PARTO 93
CAPÍTULO 16 - CONSULTA PUERPERAL 94
ABORDAGEM MEDICAMENTOSA E REAVALIAÇÃO DE PUÉRPERA COM COMORBIDADES 97
CAPÍTULO 17 - PRÉ-NATAL DO PARCEIRO 98
REFERÊNCIAS 100
ANEXOS 105
ANEXO I - ORIENTAÇÕES DO PRÉ NATAL 105
ANEXO II - ORIENTAÇÕES DO 2º TRIMESTRE 106
ANEXO III - ORIENTAÇÕES DO 3º TRIMESTRE 107
ANEXO IV - INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL 108
ANEXO V - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GLÍCOSÍMETRO E INSUMOS 109
ANEXO VI - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 110
ANEXO VII - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE GLICOSÍMETRO 111

INTRODUÇÃO

Este protocolo destina-se às equipes de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum e tem por objetivo padronizar os procedimentos necessários e orientar os profissionais no seu dia a dia na assistência qualificada e humanizada ao planejamento familiar, à gestação e ao puerpério.

O pré-natal tem por objetivo assegurar um desenvolvimento adequado da gestação, favorecendo o parto de um recém-nascido saudável, minimizando impactos negativos para a saúde materna e familiar e sendo o principal fator de prevenção para evitar que uma gestação de risco habitual evolua para alto risco.

Em suma, este instrumento estabelece intervenções técnicas, uniformizando e atualizando conceitos e condutas referentes ao processo assistencial na rede de serviços.

CAPÍTULO 1 - ATIVIDADES RELACIONADAS AO CUIDADO EM SAÚDE NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL

As rotinas estabelecidas nas unidades de saúde devem respeitar as características locais, com máximo aproveitamento do tempo e das instalações. Isso inclui normatizações sobre procedimento de busca ativa; visitas domiciliares; educação em saúde; recepção e registro; convocação de pacientes; dispensação de medicamentos; fornecimento de laudos e atestados médicos; verificação de dados físicos; rotina das consultas e solicitação de exames. Também estão incluídos aspectos sobre a atuação em casos de urgência, considerando a assistência preliminar para esses casos e como deverá ser feito o acionamento do serviço de remoção.

A implantação de um roteiro de atividades deve ser flexível e aprimorada continuamente a partir de realidades locais, de indicadores que demonstrem o rendimento do serviço, idealmente aliada a sugestões de todos os envolvidos no processo: trabalhadores, usuários e gestores. É importante investir na valorização e na educação permanente dos envolvidos.

O registro das atividades desenvolvidas permite análise linear e dinâmica dos cuidados ofertados e seus resultados. É imprescindível a informação documentada de dados da gestante e do cuidado ofertado na unidade, no domicílio e nos setores referenciados, buscando diminuir a multiplicidade de intervenções desnecessárias por diferentes profissionais.

O encaminhamento da gestante deve ser realizado quando há vantagens claras da transferência de unidade para a mulher. A avaliação especializada pode ser na forma de uma interconsulta, com retorno da gestante à unidade de origem, ou pode ser aceita como transferência, se os cuidados assim exigirem. Em ambas as situações, a responsabilidade de acompanhamento do caso permanece com a unidade de saúde de origem, que deve manter vínculo com a usuária e sua família.

Algumas estratégias podem ajudar a prevenir dificuldades potenciais entre profissionais da atenção primária e especializada: o uso de um protocolo unificado a participação ativa da mulher e seus familiares, a utilização de documentos da evolução clínica através do cartão da gestante, relatório de encaminhamento e comunicação verbal entre os profissionais envolvidos. É imprescindível que as

unidades estabeleçam um plano para encaminhamento/transferência, tendo uma rotina por escrito para facilitar a homogeneidade dos procedimentos.

A gestante e os familiares devem conhecer os motivos da remoção, e os profissionais de saúde devem atentar para as informações prioritárias a serem fornecidas. É importante também que se definam os papéis, estabelecendo quem fará o contato com a referência e com o setor de transporte, o local onde a mulher deverá esperar e onde ocorrerá o estacionamento de viaturas, criando-se um fluxo nas situações eletivas e de emergência. As iniciativas de transferência contam com o apoio da central reguladora. As condutas devem ser registradas e a unidade deve acompanhar o desfecho do caso, estabelecendo uma estrutura para o fluxo de informações.

Quando ocorrer consulta especializada na referência, o retorno à unidade de origem deve ser agendado e garantido. Deve-se levar em consideração que os desafios sociais afetam diretamente o sucesso da atenção pré-natal, seja pela adesão ao programa, ou ao tratamento e a resolução dessa situação envolve uma ação complexa, exigindo esforços multiprofissionais e governamentais.

Outra atividade relacionada ao cuidado em saúde a ser enfatizada diz respeito ao monitoramento do absenteísmo das gestantes no pré-natal. É importante que a equipe multiprofissional esteja atenta para monitorar as faltas, empenhar-se em caracterizar o problema e apoiar a superação das dificuldades percebidas, segundo a rotina da unidade, podendo utilizar, por exemplo, a busca ativa pela equipe de saúde.

No processo de gestão do cuidado em saúde, recomenda-se a utilização dos seguintes instrumentos:

- Método de acompanhamento pré-natal (uso interno): possibilita o registro dos dados relevantes da gestação com uma visão ampliada do curso da gravidez, do parto e do puerpério.

Ex: planilhas, drive, caderno de controle, ficha de acompanhamento (folha espelho).

- Cartão da gestante: deve ser completamente preenchido, com as informações principais sobre o curso da gravidez, anotando-se os riscos, quando estes existirem. Seu preenchimento é realizado em toda a consulta e pelo profissional que a avaliou naquela data.

- Relatório de encaminhamento: quando necessário, deve conter todos os dados relevantes, como motivo do encaminhamento, um resumo da história clínica, evolução e tratamentos, especificando os medicamentos prescritos e outras orientações específicas.

RECURSOS HUMANOS

É imprescindível que a unidade de saúde conte com a quantidade adequada de recursos humanos, que sejam atuantes e capazes de cuidar da mulher e de seu filho integralmente, valorizando as situações especiais, inclusive a dinâmica social dessa família. O perfil desses profissionais deve agregar competência, dedicação e sensibilidade ao momento peculiar da gestação na vida da mulher, com disposição para fornecer apoio. Os profissionais envolvidos no atendimento devem estar atentos a grupos suscetíveis de agravos à saúde, particularizando, quando necessário, cuidados assistenciais específicos, como por exemplo a adolescentes, portadores de dificuldade de comunicação, portadores de necessidades especiais, imigrantes, usuários com dificuldade socioeconômica e/ou da estrutura familiar, entre outros. O acompanhamento da gestante e da puérpera na atenção primária deve ser multiprofissional.

A seguir são apresentadas as principais atribuições de cada profissional no processo de atenção à gestante e à puérpera na atenção primária.

- **Agente Administrativo:**
  - Orientar a mulher e sua família sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
  - Monitorar as consultas pré-natais e a consulta odontológica;
  - Orientar a gestante sobre a data das consultas e realizar a busca ativa da gestante faltosa;
  - Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário;
  - Participar ativamente das atividades educativas da unidade, aproveitando também o contato com a mulher e seus familiares para informar sobre os cuidados de saúde.

- **Agente Comunitário de Saúde:**
  - Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
  - Realizar visitas domiciliares para a identificação das gestantes e para desenvolver atividades de educação em saúde tanto para as gestantes como para seus familiares, orientando-os sobre os cuidados básicos de saúde e nutrição, cuidados de higiene e sanitários;
  - Encaminhar toda gestante ao serviço de saúde, buscando promover sua captação precoce para a primeira consulta, e monitorar as consultas subsequentes;
  - Conferir as informações preenchidas no Cartão da Gestante;
  - Acompanhar as gestantes que não estão realizando o pré-natal na unidade primária de saúde local, mantendo a equipe informada sobre o andamento do pré-natal realizado em outro serviço;
  - Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar a busca ativa das gestantes faltosas;
  - Informar o(a) enfermeiro(a) ou o(a) médico(a) de sua equipe, caso a gestante apresente algum dos sinais de alarme: febre, calafrios, corrimento com mau cheiro, perda de sangue, palidez, contrações uterinas frequentes, ausência de movimentos fetais, mamas endurecidas, vermelhas e quentes e dor ao urinar, dispneia.
  - Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário;
  - Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar.
  - Participar ativamente das atividades educativas da unidade, aproveitando também o contato com a mulher e seus familiares para informar sobre os cuidados de saúde.
- **Técnico(a) em Enfermagem:**
  - Orientar a mulher e sua família sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
  - Conferir as informações preenchidas no Cartão da Gestante;

- Aferir a pressão arterial, o peso e a altura e, se necessário, outros dados vitais, como temperatura e pulso da gestante, registrando essas informações no cartão da gestante e no prontuário.
- Administrar vacinas ou outros medicamentos injetáveis com receita médica.
- Participar ativamente das atividades educativas da unidade, aproveitando também o contato com a mulher e seus familiares para informar sobre os cuidados de saúde.
- Pode acompanhar a consulta de pré-natal e puerpério, auxiliando segundo a rotina da unidade.
- Informar o(a) enfermeiro(a) ou o(a) médico(a) de sua equipe, caso a gestante apresente algum sinal de alarme;
- Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário;
- Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas;
- Realizar visitas domiciliares quando necessário durante o período gestacional e puerperal.
- Avaliar a evolução da incisão cirúrgica, acompanhar o processo de aleitamento materno, orientar a mulher e seu parceiro (a) sobre o planejamento familiar.
- Realizar curativos, retirada de pontos de incisão cirúrgica e outros pequenos procedimentos segundo a rotina da unidade.

- **Enfermeiro(a):**
  - Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
  - Fornecer o Cartão da Gestante devidamente preenchido na abertura do pré- natal. O cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta;
  - Realizar as consultas de pré-natal conforme orientação do Ministério da Saúde (MS): intercalada Enfermeiro e Médico;
  - Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré- natal e ultrassonografias de acordo com a idade gestacional;

- Realizar testes rápidos;
- Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico, sintomáticos padronizados para cólica, dor e náusea);
- Orientar a vacinação das gestantes;
- Registrar seu atendimento no prontuário e no cartão da gestante a cada consulta.
- Identificar as gestantes com algum sinal de alarme e/ou identificadas como de alto risco e encaminhá-las para consulta médica;
- Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame cito patológico do colo do útero quando necessário;
- Desenvolver atividades educativas (com gestantes e/ou equipe de saúde);
- Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade;
- Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas;
- Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal quando houver necessidade.
- Acompanhar o processo de aleitamento materno e orientar a mulher e seu parceiro (a) sobre o planejamento familiar.
- Realizar visita domiciliar de acordo com a rotina da unidade.

- **Médico(a):**
  - Orientar a mulher e sua família sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
  - Na ausência do Enfermeiro, realizar abertura de pré-natal com o fornecimento do Cartão da Gestante devidamente preenchido e a abertura do controle gestacional no GMUS. O cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta;
  - Realizar a consulta de pré-natal conforme orientação do MS: intercalada Enfermeiro e Médico;

- Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré- natal;
- Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal;
- Orientar a vacinação das gestantes;
- Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais de alarme;
- Atender as intercorrências e encaminhar as gestantes para os serviços de urgência/emergência obstétrica, quando necessário;
- Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade;
- Identificar as gestantes de alto risco e encaminhá-las ao serviço de referência;
- Realizar exame clínico das mamas quando necessário;
- Desenvolver atividades educativas (com gestantes e/ou equipe de saúde);
- Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas;
- Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal quando necessário;
- Acompanhar o processo de aleitamento materno e orientar a mulher e seu parceiro (a) sobre o planejamento familiar.
- Registrar seu atendimento no prontuário e no cartão da gestante a cada consulta.
- Realizar visita domiciliar, de acordo com a rotina da unidade.

- **Cirurgião-dentista**
  - Orientar a mulher e sua família sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
  - Realizar a consulta odontológica de pré-natal. Preencher corretamente seu atendimento no cartão da gestante, que deve ser verificado e atualizado a cada consulta;
  - Avaliar a saúde bucal da gestante e a possibilidade de tratamento, observando os cuidados indicados em cada período da gravidez;
  - Solicitar exames complementares quando necessário;

- Adequar o meio bucal garantindo conforto à gestante e a continuidade do tratamento após a gravidez quando necessário;
- Atender as intercorrências/urgências odontológicas observando os cuidados indicados em cada período da gravidez e encaminhar a gestante para níveis de referência de maior complexidade, caso necessário;
- Orientar a gestante e a equipe de saúde quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade em relação à saúde bucal;
- Identificar as gestantes de alto risco e encaminhá-las para avaliação médica;
- Desenvolver atividades educativas e de apoio à gestante e aos seus familiares;
- Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas odontológicas;
- Realizar busca ativa das gestantes faltosas de sua área de abrangência;
- Acompanhar o processo de aleitamento materno e os cuidados com o bebê, enfatizando a importância do papel da amamentação na dentição e no desenvolvimento do aparelho fonador, respiratório e digestivo da criança;
- Orientar a mulher e seu parceiro (a) sobre hábitos alimentares saudáveis e de higiene bucal.

CAPÍTULO 2 - A GESTAÇÃO NO ÂMBITO DOS DIREITOS DO TRABALHO, SOCIAIS E DEMAIS ESPECIFICIDADES

Direito à saúde

TODA GESTANTE TEM DIREITO A ATENDIMENTO GRATUITO E DE QUALIDADE NOS HOSPITAIS PÚBLICOS E CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

A gestante tem o direito de ser atendida com respeito e dignidade pela equipe, sem discriminação de cor, raça, orientação sexual, religião, idade ou condição social. Ser chamada pelo nome que preferir e saber o nome do profissional que a atende. Aguardar o atendimento sentada, em lugar arejado, tendo à sua disposição água para beber e banheiros limpos.

Ela deve receber a Caderneta da Gestante na primeira consulta de pré-natal e esta deve conter todas as informações sobre o seu estado de saúde, desenvolvimento do bebê e resultados de exames realizados.

A gestante sempre tem o direito à vaga. Para o parto, ela deve ser atendida no primeiro serviço de saúde que procurar. Em caso de necessidade de transferência para outro serviço de saúde, o transporte deverá ser garantido de maneira segura.

A gestante tem direito à dispensa do horário de trabalho para realização de no mínimo seis consultas pré-natais e demais exames complementares, é direito a realização dos testes rápidos disponíveis no SUS e a consulta odontológica.

Para o parceiro (a), ele tem o direito a participar das consultas pré-natal realizar exames de rotina, testes rápidos e passar por consulta de pré-natal do parceiro (a).

VIOLÊNCIAS NA GRAVIDEZ

A gestante que sofrer qualquer tipo de violência, seja física, sexual, moral ou psicológica por parte de pessoas próximas ou desconhecidas e desejar ajuda do serviço de saúde, tem direito de ser acolhida e ouvida pelo profissional que a está atendendo e ser encaminhada aos serviços competentes, de acordo com a necessidade.

DIREITO RELACIONADO AO PARTO

De acordo com a Lei Federal nº 11.340/2007, é garantido o direito de que a gestante seja informada anteriormente, pela equipe do pré-natal, sobre qual a maternidade de referência para seu parto e de visitar o serviço antes do parto.

A Lei Federal nº 11.108/2005, garante às parturientes o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Este acompanhante é escolhido por ela, podendo ser homem ou mulher.

Se o bebê chegar antes da hora e precisar de cuidados especiais, a parturiente tem o direito a ficar perto dele no hospital, como acompanhante, durante todo o tempo necessário.

Tem o direito de ter a criança ao seu lado em alojamento conjunto, amamentar e receber orientações sobre amamentação, assim como a presença de um acompanhante de livre escolha.

A mulher tem o direito a receber as vacinas necessárias durante o pré-natal e no pós-parto pelo SUS. Outro direito garantido é a realização gratuita de testes de triagem neonatais (pezinho, coraçãozinho, orelhinha, olhinho, linguinha).

DIREITOS SOCIAIS

Os pais têm direito e o dever de registrar seu bebê e obter a Certidão de Nascimento, gratuitamente, em qualquer cartório (1ª via).

A família beneficiária do Programa Auxílio Brasil tem direito ao benefício variável extra na gravidez e durante a amamentação.

A gestante tem direito ao atendimento preferencial nos guichês e caixas especiais ou prioridade nas filas para atendimento em instituições públicas e privadas além de assento prioritário.

ENTREGA EM ADOÇÃO

A Lei nº 12.010/2009 garante à gestante o direito de receber atendimento psicossocial gratuito se desejar, precisar ou decidir entregar a criança em adoção devendo procurar a Vara da Infância e Juventude da cidade.

A ESTUDANTE GRÁVIDA

De acordo com a Lei nº 6.202/1975, a estudante grávida tem o direito à licença-maternidade sem prejuízo do período escolar. A partir do oitavo mês de gestação a gestante estudante poderá cumprir os compromissos escolares em casa, segundo o Decreto-Lei nº 1.044/1969.

O início e o fim do período de afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola.

DIREITOS TRABALHISTAS

A gestante não poderá ser demitida enquanto estiver grávida e até cinco meses após o parto, a não ser por “justa causa”.

Durante a gravidez, a gestante poderá se adequar a outras funções no trabalho, sem prejuízo dos salários e demais benefícios, quando as condições de saúde da mãe e do bebê o exigir, além de ser assegurada a volta à função anteriormente exercida logo após o retorno da licença-maternidade.

AMAMENTAÇÃO

Até o bebê completar seis meses de vida a mãe tem o direito de ser dispensada do trabalho todos os dias, por dois períodos de meia hora ou um período de uma hora para amamentar.

AFASTAMENTOS

O pai logo após o nascimento do bebê tem direito a licença de cinco dias.

A mãe tem direito à licença-maternidade de 120 dias (art. 392) segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do emprego e do salário, devendo a gestante notificar o seu empregador da data do início do afastamento, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste.

O salário-maternidade é garantido às seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, empregadas domésticas, contribuintes individuais, facultativas e seguradas especiais, por ocasião do parto, inclusive o natimorto, aborto, adoção ou guarda

judicial. Nos casos em que a criança venha a falecer durante a licença maternidade, o salário-maternidade não será interrompido.

Em casos de aborto, será pago o benefício por duas semanas, a licença varia entre 14 a 30 dias de acordo com a prescrição médica.

CAPÍTULO 3 - ABORDAGEM DA AMENORREIA

Paciente do sexo feminino que consulta por qualquer motivo, apresentando amenorreia deve ser investigada sobre:

- Atividade Sexual
- Uso de método anticoncepcional
- Tempo de amenorreia
- Sinais e sintomas de presunção
- Sinais de certeza

ATIVIDADE SEXUAL

Na mulher, a presença de atividade sexual com parceiro do sexo masculino é condição para uma gestação. Gravidez é a principal causa de amenorreia em mulheres na menacme com vida sexual ativa, e em mulheres sem vida sexual, a amenorreia será de causa não gestacional, devendo-se investigar causas endócrinas, ginecológicas, nutricionais, etc.

USO DE MÉTODO ANTICONCEPCIONAL

Estar fazendo uso de contraceptivo não isenta o casal da possibilidade de uma gestação. Todos os anticoncepcionais têm um percentual de falha, inclusive os métodos definitivos como laqueadura tubária e vasectomia. Na paciente com amenorréia que estava em uso de algum método anticoncepcional, será maior a chance de gestação quanto mais falho for o método, principalmente se este não estava sendo usado corretamente.

TEMPO DE AMENORREIA

O atraso menstrual frequentemente é o primeiro sinal de uma gestação em curso, sendo a data da última menstruação dado imprescindível para o seguimento pré-natal. O tempo de amenorreia determina qual estratégia será usada para o diagnóstico da gestação.

Diagnóstico laboratorial: é realizado pela identificação do hormônio coriogonadotrófico (hCG), um indicativo de gravidez. Usualmente, a detecção do hCG

no sangue é anterior à da urina. O tipo de exame a ser solicitado poderá ser realizado na urina ou no sangue, conforme descrito no quadro abaixo.

Quadro 2. Condutas Diante da Amenorreia entre 5 e 12 Semanas, 2023.

Amenorreia entre 5 e 12 semanas:
Se positivo na urina → gravidez
Se negativo na urina → solicita no sangue
Se positivo no sangue → gravidez
Se negativo no sangue → repetir em 15 dias (se persistir suspeita)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Orientar a paciente a sempre retornar para verificação do resultado, mesmo se o resultado for não reagente. E, caso a paciente não retorne deve ser realizado busca ativa.

Em casos de atraso menstrual superior a 12 semanas, a avaliação passa a ser clínica.

Quadro 3. Condutas Diante da Amenorréia Superior a 12 Semanas, 2023.

Amenorreia superior a 12 semanas
Se BCF + → gravidez → procede com seguimento pré-natal
Se BCF - → mantendo suspeita de gestação, realizar teste rápido de gravidez.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

SINAIS E SINTOMAS DE PRESUNÇÃO

A gestação pode apresentar alguns sinais e sintomas que não necessariamente significam entidades clínicas (doenças) em curso. A depender do estágio da gestação, esses sintomas mudam, e quase sempre eles refletem as alterações fisiológicas da gravidez no corpo da gestante.

Tais sintomas podem ajudar a abrir uma suspeita, mas não são específicos de gravidez, pois numerosas outras condições clínicas também podem se apresentar por meio deles em mulheres não gestantes. Sintomas esses sendo náuseas, vômitos, dor

em andar inferior do abdome, cólicas, epigastralgia, pirose, lombalgia, cefaleia, polaciúria, hiperfagia, fraqueza.

SINAIS DE CERTEZA

Estes são relacionados a presença de sinais que confirmam a gestação em curso:

Detecção dos batimentos cardíacos fetais (BCF) - são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo Pinard a partir de 20 semanas;

Percepção dos movimentos fetais (de 16 a 20 semanas);

BHCG detectável em exame (sangue ou urina);

Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser observado por via transvaginal com apenas 4 a 5 semanas gestacionais e a atividade cardíaca é a primeira manifestação do embrião com 6 semanas gestacionais.

Uma vez diagnosticada a gestação, deve-se proceder para a abertura do pré-natal o mais precoce possível.

CAPÍTULO 4 - CONSULTA DE PRÉ-NATAL

O pré-natal é um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de assegurar o desenvolvimento pleno da gestação e culminando com o parto de um recém nascido saudável, minimizando impactos na saúde materna e abordando diferentes aspectos do período gravídico, desde os psico socioemocionais até atividades de educação em saúde (BRASIL, 2012). Além do diagnóstico precoce e abordagem oportuna de intercorrências que possam vir a acontecer nesse período.

CALENDÁRIO DE CONSULTAS

Segundo o MS, as gestantes devem fazer no mínimo seis consultas pré-natal, sendo a primeira antes das 12 semanas de gestação, intercaladas entre o Médico e o Enfermeiro da unidade.

Todas as consultas devem ser registradas corretamente no cartão da gestante e no prontuário eletrônico. Segue o cronograma das consultas de acordo com a idade gestacional:

- Até 28ª semana – mensalmente;
- Da 28ª até a 36ª semana – quinzenalmente;
- Da 36ª até a 41ª semana – semanalmente.

Não existe “alta” do pré-natal antes do parto. O seguimento do acompanhamento a essa mulher se dá após o parto nas consultas e avaliações puerperais.

ATENÇÃO: QUANDO O PARTO NÃO OCORRER ATÉ A 41ª SEMANA DE GESTAÇÃO, É NECESSÁRIO ENCAMINHAR A GESTANTE PARA AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA HOSPITALAR.

A PRIMEIRA CONSULTA DE PRÉ-NATAL

A primeira consulta de pré-natal deve ser o mais precoce possível, idealmente antes da 12ª semana, podendo ser realizada tanto pelo Médico quanto pelo Enfermeiro da unidade, com devido e correto seguimento de abertura do pré-natal.

Melhor ainda seria se as consultas iniciais se dessem antes da gestação com o aconselhamento pré-concepcional (ver capítulo 03).

A primeira consulta é fundamental para um pleno desenvolvimento do acompanhamento pré-natal. O acolhimento, anamnese e exame físico da primeira consulta devem ser detalhados e com especificidade dirigida para gestantes no intuito de identificar o maior número possível de alterações que possam afetar o prognóstico gestacional.

Quanto mais cedo for calculado o risco gestacional, mais rapidamente se poderá efetuar eventuais correções. Pequenas inadequações nesse período podem se relacionar a desfechos desfavoráveis.

A primeira consulta é essencial para o reforço do vínculo entre a unidade de saúde e a gestante no sentido de permitir que a adesão e a continuidade da assistência sejam asseguradas.

Para o seguimento adequado das consultas de pré-natal deve ser preenchido corretamente a caderneta de pré-natal e fornecida para a gestante na primeira consulta, bem como a descrição de toda a avaliação realizada em prontuário.

ANAMNESE

Deve-se levantar dados sobre planejamento e aceitação da gestação, aspectos socioepidemiológicos, antecedentes pessoais, ginecológicos, obstétricos, familiares e sinais e sintomas da gravidez atual.

Os principais componentes podem ser assim listados:

1. Planejamento e aceitação da gestação;
2. Data da Última Menstruação (para assim determinar Idade Gestacional e Data Provável do Parto);
3. Regularidade dos ciclos/histórico ginecológico;
4. Uso de anticoncepcionais;
5. Paridade;
6. Intercorrências clínicas, obstétricas e cirúrgicas;
7. Detalhes de gestações prévias;
8. Hospitalizações anteriores;
9. Uso de medicações;

10. História prévia de doença sexualmente transmissível;
11. Exposição ambiental ou ocupacional de risco;
12. Reações alérgicas;
13. História pessoal ou familiar de doenças hereditárias/malformações;
14. Gemelaridade;
15. Fatores socioeconômicos;
16. Estado civil;
17. Atividade sexual;
18. Nível de escolaridade;
19. Uso de tabaco, álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas;
20. História infecciosa prévia;
21. Vacinações prévias;
22. História de violências;
23. Histórico psicossocial.

CÁLCULO DA IDADE GESTACIONAL (IG) E DA DATA PROVÁVEL DE PARTO (DPP)

Cálculo realizado a partir da Data da Última Mensatuação (DUM):

Frequentemente utiliza-se a regra de Naegele, que considera que a gravidez tenha duração média de 280 dias e, através da DUM estima-se a IG. A idade gestacional é calculada da seguinte forma:

DUM conhecida: número de dias a partir do primeiro dia da última menstruação até o dia da consulta, dividindo o total por 7, obtém-se a IG em semanas.

DUM desconhecida, mas se conhece o período da última menstruação: início do mês considerar dia 05, meio do mês considerar dia 15 e final do mês considerar dia 25.

Para o cálculo da data provável do parto, soma-se 7 ao dia da DUM e 9 ao número referente ao mês em que ela ocorreu. Quando a DUM ocorre entre abril e dezembro, para o cálculo do mês da data provável do parto, é preciso lembrar que o parto ocorrerá no ano seguinte.

Quando não se sabe a DUM e o período do mês, pode ser usada a medição da altura uterina para determinação da idade gestacional e data do início das movimentações fetais, que frequentemente ocorrem entre 18 e 20 semanas.

Pode-se utilizar a altura uterina de acordo com a descrição a seguir:

- Até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho uterino;
- Na 8ª semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho normal;
- Na 10ª semana, o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual;
- Na 12ª semana, o útero enche a pelve, de modo que é palpável na sínfise púbica;
- Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical;
- Na 20ªa semana, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical;
- A partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. Porém, este parâmetro torna-se menos fiel a partir da 30ª semana de idade gestacional.

QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DETERMINAR A IDADE GESTACIONAL, SOLICITAR O MAIS PRECOCEMENTE POSSÍVEL A ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA

EXAME FÍSICO

Fundamental para avaliação holística e determinar condutas.

EXAME FÍSICO GERAL

Sempre avaliar o estado nutricional, peso e Índice de Massa Corporal (IMC), além de preencher no gráfico correto na caderneta da gestante, pois serve de dado orientativo para melhor avaliação e conduta pertinente ao ganho de peso gestacional.

Além de avaliar a pressão arterial (PA) e a presença de edema, também são fundamentais nas consultas a fim de acompanhar, diagnosticar e intervir precocemente na iminência de Hipertensão Gestacional, Pré-eclâmpsia e Eclâmpsia etc.

Avaliação nutricional (peso e cálculo do IMC);

Medida da PA;

Palpação abdominal e percepção dinâmica, medida da altura uterina;

Ausculta dos batimentos cardiofetais (BCF);

Registro dos movimentos fetais (MF);

Verificação da presença de edema;

Exame ginecológico e coleta de material para colpocitologia oncótica (CCO) - se necessário;

Exame clínico das mamas - se necessário;

Toque vaginal de acordo com as necessidades de cada mulher e com a idade gestacional - se necessário;

Quadro 4. Verificação da Presença de Edema:

Achado	Anote
Edema ausente	-
Apenas edema de tornozelo sem hipertensão ou aumento súbito de peso	+
Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou ganho de peso	++
Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso	+++
Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos	++++

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2023.

EXAME FÍSICO ESPECIAL

Voltado para a avaliação de alterações relacionadas às modificações gravídicas como, por exemplo, alterações de pele (cloasma gravídico, estrias), mucosas, varizes, ausculta cardíaca e pulmonar, avaliação de sistema gastrintestinal.

EXAME FÍSICO GINECO-OBSTÉTRICO

Avaliação das mamas na gravidez, volume das mamas, tipo de mamilo, proliferação de tecido glandular, presença de rede de Haller, sinal de Hunter, tubérculos de Montgomery, presença de próteses mamárias e cirurgias mamárias. Realiza-se a inspeção estática e a dinâmica, além da palpação das mamas e do segmento axilar.

Já o exame pélvico engloba a inspeção da anatomia genital, perineal e anal, presença de alterações da coloração, lesões vegetantes e ulcerações. Na realidade, essa inspeção deve ser ampliada, avaliando-se também o períneo e a região anal. Pode ser realizado o exame especular.

EXAME FÍSICO OBSTÉTRICO

Inspeção e palpação do abdome, onde se realiza a mensuração da altura uterina e ausculta dos BCF.

Normalmente na primeira consulta (se adesão precoce ao pré-natal, < 12 semanas), o útero encontra-se ainda na pelve, dificultando sua palpação, sendo possível mensuração da altura uterina a partir da 16/18 semana de gestação.

Palpação do conteúdo uterino:

Reconhecer pelo toque a apresentação, situação e posição do feto;

Paciente em decúbito dorsal, com músculos relaxados e membros em extensão, o ventre descoberto e a bexiga vazia;

Ter o cuidado de examinar a paciente com mão leve, sem movimentos bruscos, a fim de não causar dor à paciente.

Figura 1. Manobras de Leopold-Zweifel (4 tempos)



TESTES RÁPIDOS

Toda gestante que inicia pré-natal deve realizar testes rápidos já na primeira consulta, sendo eles: HIV, HCV, HbsAg e sífilis, disponíveis pelo SUS para atendimento nas UBS. Devem ser repetidos no segundo e no terceiro trimestre.

EXAMES LABORATORIAIS

Na sequência são solicitados os exames laboratoriais, a fim de melhor avaliação da condição clínica da gestante e acompanhamento da saúde da mãe e feto.

Sendo eles:

1. Tipagem sanguínea e fator RH;
2. Teste de Coombs indireto nas pacientes Rh negativo;
3. Hemograma;
4. Urina tipo I;
5. Glicemia de jejum;
6. VDRL;
7. Urocultura;
8. Sorologia para Toxoplasmose (IgG e IgM);
9. Sorologia para Citomegalovirus (IgG e IgM);
10. Anti-Hbs

Se necessário e em casos específicos:

- Exame Parasitológico de Fezes (EPF);
- Coleta de CCO.

ULTRASSONOGRAFIAS (USG)

Podem ser solicitadas via SUS 02 USG, sendo 01 no primeiro trimestre de gestação e a outra no terceiro trimestre.

- USG obstétrico 1° trimestre: USG de primeiro trimestre é voltada para a confirmação da viabilidade da gestação, o estabelecimento com precisão da idade gestacional, determinação do número de fetos e, na presença de

gravidez múltipla, avaliação da corionicidade e amnionicidade. Solicitado pelo médico ou enfermeiro via APAC.

- Translucência nucal: realizada entre 11 a 14 semanas de gestação. É uma medida realizada na região da nuca do feto no ultrassom. Seu objetivo é estimar o risco do feto de ter Síndrome de Down e cardiopatias congênitas. Uma medida aumentada significa um aumento de risco. Sensibilidade de cerca de 80 a 90%. Não realizado pelo SUS, devendo ser orientado a paciente sobre sua importância.
- Morfológico de primeiro trimestre: considera a idade materna, histórico de filhos anteriores com Síndrome de Down, translucência nucal, avaliação do ducto venoso, osso nasal e regurgitação tricúspide. Solicitado entre 11 a 14 semanas de gestação. Não realizado pelo SUS.
- Morfológico do segundo trimestre: diagnosticar malformações fetais isoladas ou ligadas a síndromes malformativas, buscando, sempre que possível, um diagnóstico sindrômico e etiológico. Deve ser realizado prioritariamente entre 20 e 24 semanas de idade gestacional. Realizado pelo SUS quando solicitação do obstetra por PNAR, devendo ser orientado a paciente sobre sua importância.
- Dopplervelocimétrica das artérias uterinas: a restrição da vascularização no leito placentário tem sido considerada entre os fatores críticos relacionados à instalação precoce da pré eclâmpsia e os achados anormais na artéria uterina refletem o grau de severidade da doença. O rastreamento realizado entre 11 e 14 semanas de gestação se constitui na época ideal para se configurar as mulheres de risco para insuficiência útero-placentário. Pode também ser realizada entre 21 e 24 semanas. Não realizado pelo SUS.
- Dopplerfluxometria obstétrica: mensuração dos fluxos das artérias umbilicais (compartimento placentário), artéria cerebral média e fluxo do Ducto venoso (compartimento fetal). No primeiro e segundo trimestres possibilita o rastreamento de risco para a gestante desenvolver Pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal. É indicado nas gestantes com doença hipertensiva, trombofilias, insuficiência placentária. No terceiro trimestre é indicado para avaliação do bem-estar fetal nas restrições de crescimento, oligodrâmnio e

avaliação da vitalidade fetal, sinais de sofrimento fetal por hipóxia. Realizada pelo SUS por solicitação do obstetra, no pré-natal de baixo risco deve ser orientado a paciente sobre esta usg.

SUPLEMENTAÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam a suplementação de sulfato ferroso (OMS recomenda de 30-60 mg de ferro elementar/dia, e MS 40 mg de ferro elementar/dia) durante toda gestação, mantendo-se o sulfato ferroso por até três meses depois do parto ou aborto. E ácido fólico (recomendação de 0,4 mg/dia por ambas as instituições) até 14 semanas de gestação.

Ressalta-se que na rede de saúde pública o ácido fólico está disponível na dose de 5 mg ou solução oral de 0,2 mg/ml (40 gotas). Essa suplementação deve ser prescrita já na primeira consulta. A prescrição da suplementação pode ser realizada pelo médico e/ou pelo enfermeiro.

Quadro 5. Suplementação da Gestação

Suplemento	Quando Iniciar	Dosagem	Quando Interromper
Sulfato Ferroso	O mais precoce possível - abertura do pré-natal	40 mg/dia 1 comprimido ao dia	Indicado até 03 meses após o parto
Ácido Fólico	O mais precoce possível - abertura do pré-natal (o ideal seria que já tivesse sido utilizada a dosagem de ácido fólico antes da gestação)	0,4 mg/dia (solução oral)	Indicado seu uso até 14 semanas de gestação
	Em casos específicos como: história prévia de gestação acometida por defeitos no tubo neural, diabetes prévio à gestação, uso de anticonvulsivantes, obesidade com IMC> 35kg/m², polimorfismos genéticos, síndromes de má absorção	4 mg (comprimido de 5mg)	Indicado seu uso até 14 semanas de gestação

	(doença celíaca, doença de Crohn, cirurgias bariátricas, retocolites ulcerativas, entre outras), a dosagem de ácido fólico recomendada é de 4mg.		

Fonte: elaborado pelos autores, 2023.

SINTOMÁTICOS NA GESTAÇÃO

Prescritos ainda na primeira consulta, tanto pelo Médico como pelo Enfermeiro.

- Paracetamol 500 mg – comprimido

Tomar 01 comprimido de 6/6 horas se dor e febre – 10 comprimidos

- Metoclopramida, cloridrato 4 mg/ml – solução oral, frasco 10 ml

Tomar 50 gotas de 6/6 horas se náuseas – 03 frascos

- Escopolamina butilbrometo, associado com paracetamol, 10 mg + 500 mg – comprimido

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas se dor abdominal em cólica – 10 comprimidos

- Hidroxido de alumínio 60 mg/ml - suspensão oral, frasco 100 ml

Tomar 10 ml de 08/08 horas se dor em queimação/ azia no estômago – 1 frasco

VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO VACINAL

Condição importante para o seguimento do pré-natal e deve ser verificada em todas as consultas. As vacinas no pré-natal tem o duplo objetivo de imunizar gestante e feto. A transferência placentária dos anticorpos maternos IgG garante que em suas primeiras semanas de vida o recém-nascido esteja protegido para algumas doenças sem ter sido vacinado e nem ter entrado em contato com o patógeno diretamente.
Estão disponíveis no SUS para as gestantes, vacinação contra:

- Tétano
- Hepatite B
- Influenza
- COVID-19

ESTAS VACINAS NÃO TRAZEM RISCO ADICIONAIS PARA AS GESTANTES

E/OU PARA O FETO!

Quadro 6. Vacinas do Pré-Natal, 2022.

Vacina dupla do tipo adulto - dT (difteria e tétano) Indicação: proteção contra tétano acidental (na gestante e na puérpera) e tétano neonatal (no RN). Recomendação: Todas as gestantes. Vacina dupla bacteriana do tipo adulto (dT) para prevenção de tétano acidental (materno), e tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) para prevenção de tétano neonatal, difteria e coqueluche. A gestante deverá receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação e demais doses de acordo com a situação vacinal. Aplicação: 1ª dose: dT o mais precoce possível 2ª dose: dT 30 dias após a primeira dose 3ª dose: dTpa 30 dias após a segunda dose e somente após 20ª semana de gestação Gestante NÃO vacinada previamente: administrar 3 (três) doses de vacina contendo toxóide tetânico e diftérico (dT) com intervalo de 60 dias entre as doses. Sendo 2 (duas) doses de dT em qualquer momento da gestação e 1 (uma) dose de dTpa, a partir da vigésima semana de gestação; Esquema vacinal para tétano previamente completo (três doses): aplicar somente dTpa após a 20ª semana; Puérperas não vacinadas na gestação: completar esquema o mais rápido possível.
Vacina contra hepatite B (recombinante) Indicação: Proteção contra a Hepatite B na gestante e consequente prevenção da transmissão vertical (para o feto). A susceptibilidade à hepatite B pode ser verificada pela dosagem do anticorpo anti-Hbs, o qual é marcador de imunidade à doença. Recomendação: Todas as gestantes que não possuírem esquema tríplice registrado em caderneta ou com anti-HBs não reagente. Aplicação:

Mulheres com anti-HBs não reagente, tendo ou não se vacinado anteriormente, fazer três doses (nos meses 0, 1 e 6).

Para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional: administrar 3 (três) doses da vacina hepatite B (0, 1 e 6 meses), considerando o histórico de vacinação anterior e os intervalos preconizados entre as doses ou ainda o anti-HBs não reagente. Caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir após o parto.

Caso tenha ocorrido interrupção no esquema: a dose deverá ser administrada assim que for possível, mantendo corretamente os intervalos (a segunda dose deve ser 30 dias após a primeira dose e a terceira dose deve ser 6 meses após a primeira dose, mantendo o intervalo de pelo menos 8 semanas entre a segunda e a terceira dose).

Mulheres com esquema completo e anti-HBs reagente: não necessitam se vacinar novamente.

Particularidades: Gestantes com hepatite B reagente (HBsAg reagente), no primeiro trimestre preferencialmente, solicitar imunoglobulina humana anti-hepatite B para o recém-nascido via formulário de solicitação de Imunobiológicos Especiais para o CRIE - Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais.

Aplicação:

Logo após o nascimento, os recém-nascidos de mulheres com HBV (HBsAg reagente) devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB), e a primeira dose do esquema vacinal para vírus da hepatite B (HBV). A dose da vacina ao nascimento deve ser dada preferencialmente na sala de parto ou nas primeiras 12 horas e, se não for possível, em até 24 horas após o parto, podendo a imunoglobulina ser administrada no máximo até 7 (sete) dias de vida.

Vacina contra Influenza

Indicação: proteção contra quadros graves de influenza na gestante e na lactante.

Recomendação: Todas as gestantes e puérperas. Dar preferência à vacina 4V pela maior cobertura às cepas circulantes, mas na ausência desta aplicar a 3V.

Aplicação: dose única, a qualquer momento da gravidez e puerpério, nos períodos

de campanha. OBS.: contraindicada a pacientes com alergia prévia a ovo ou alergia prévia a componentes da vacina.
Vacina contra Covid-19 Indicação: proteção contra quadros graves de COVID-19 na gestante e puerpério. Recomendação: todas as gestantes em qualquer idade gestacional e puérpera. Laboratórios que produzam vacinas que não contenham vetor viral (Sinovac/Butantan e Pfizer/Wyeth). Aplicação: esquema e período conforme indicação do Programa Nacional de Imunização.
Situações Especiais Vacina antirrábica Em casos de possível exposição ao vírus da raiva humana, a vacina pode ser utilizada em gestantes. Não fazer esquema pré-exposição. Vacina contra febre amarela (atenuada) Deve ser evitada. Aplicar em gestantes e lactantes somente se forem residentes (ou estiverem transitando) em áreas em surto da doença com recomendação de vacinação. Lactantes que amamentem crianças menores de 6 meses que precisarem se vacinar devem suspender a amamentação por 28 dias após a vacinação (com um mínimo de 10 dias).
São contraindicadas na gestação as vacinas contra: Dengue HPV Sarampo, Caxumba e Rubéola (Tríplice Viral) Varicela

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL

Deve ser realizada na abertura e reavaliada em todas as outras consultas de pré-natal.

No decorrer da gestação podem acontecer eventos e/ou condições que façam com que a classificação de risco gestacional seja alterada, sendo necessário essa vigilância e monitoramento em todas as consultas a fim de prevenir complicações e agravos. Documento consta nos anexos.

ENCAMINHAMENTOS

1. **Pré-natal odontológico**

Encaminhar para consulta odontológica e registrar esta conduta na caderneta, ainda na primeira consulta de pré-natal.

Agendamento da consulta: preferencialmente com a próxima consulta de pré-natal (médico/enfermeiro).

Serão realizadas no mínimo duas consultas no período gestacional:

- Logo após a abertura do pré-natal
- Após a 25a semana.
- Para a segunda consulta (25s): realizar novo encaminhamento pelo profissional que acompanha as consultas de rotina do pré-natal.

É IMPORTANTE A CO-RESPONSABILIZAÇÃO DA EQUIPE NA VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

2. **Pré-natal pediátrico**

As gestantes devem ser encaminhadas no 3° trimestre de gestação, realizado ou pelo enfermeiro ou pelo médico, via APAC. A mesma será direcionada a Central de Regulação.

3. **Obstetra**

Todas as gestantes devem ser encaminhadas ao obstetra para acompanhamento. Verificar fluxo de encaminhamento ao obstetra em capítulo 06.

4. Nutricionista

A gestante deve ser encaminhada para nutricionista na primeira consulta de pré-natal.

TEMPO ESTIMADO DA CONSULTA

A consulta de pré-natal tem duração de cerca de **30 minutos** para que possa ser realizado anamnese, exame físico, preenchimento adequado da caderneta de gestante, condutas e repasse de informações importantes a gestante.

AO FINAL DE TODA CONSULTA DE PRÉ-NATAL, A GESTANTE DEVE PASSAR NA RECEPÇÃO, RECEBER ORIENTAÇÕES PERTINENTES E AGENDAR O RETORNO DE ACORDO COM A IDADE GESTACIONAL QUE SE ENCONTRA.

Portanto, na primeira consulta é realizado:

- Preenchimento correto e completo da caderneta de gestante;
- Anamnese;
- Exame físico;
- Solicitação de exames laboratoriais de rotina do pré-natal;
- Solicitado USG obstétrica de acordo com idade gestacional (pelo Enfermeiro ou Médico);
- Testes rápidos (HIV, HCV, HBSAG e SÍFILIS);
- Verificação da situação vacinal;
- Avaliação e fornecimento de suplementação (sulfato ferroso e ácido fólico);
- Encaminhamento ao pré-natal odontológico;
- Classificação de risco gestacional;
- Orientações de forma geral conforme descritos no capítulo;
- Agendado retorno de acordo com idade gestacional e calendário de consultas do MS;

SEGUIMENTO DAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL

Nas consultas subsequentes deve-se identificar a idade gestacional, realizar anamnese sucinta, identificar queixas, sanar dúvidas, medos, anseios, investigar mudanças de hábitos, questionar sobre sintomas urinários, leucorreia, perdas vaginais, movimentação fetal, contrações/cólicas, edemas, uso de suplementação, verificação da situação vacinal, estratificação de risco gestacional.

EXAME FÍSICO

Fundamental para avaliação holística e determinar condutas.

Exame físico geral:

Mucosa, hidratação;

Avaliar o estado nutricional, peso e IMC, além de preencher no gráfico correto na caderneta da gestante;

Avaliar a pressão arterial (PA) e a presença de edema;

Avaliação de alterações relacionadas às modificações gravídicas como alterações de pele (cloasma gravídico, estrias), mucosas, varizes;

Ausculta cardíaca e pulmonar, avaliação de sistema gastrintestinal;

Inspeção e palpação do abdome, onde se realiza a mensuração da altura uterina e ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF), além da percepção da movimentação fetal;

Edema;

Exame físico especial: em casos específicos (se queixas);

EXAMES DE SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE

- Coombs indireto nas pacientes Rh negativo;
- Hemograma;
- Urina tipo I;
- Urocultura;
- Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG): realizado entre as 24 e 28 semanas de gestação;

Observação: Em caso de impossibilidade de realização do TOTG na idade gestacional correta, solicitar glicemia de jejum e pós-prandial;

- VDRL;
- Testes rápidos: HIV, HCV, HbsAg e Sífilis;
- Sorologia para Toxoplasmose (IgG e IgM) - se susceptível. Solicitar IgM em caso de IgG reagente no 1° exame (possibilidade de reativação);
- Sorologia para Citomegalovírus (IgG e IgM) - se susceptível;
- USG Obstétrica: a depender da IG.

Se necessário e em casos específicos:

- EPF
- Coleta de CCO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

As gestantes classificadas como de risco habitual devem ser ecaminhadas ao obstetra no terceiro trimestre conforme Capítulo 06 que trata da ROTINA DE ENCAMINHAMENTO AO OBSTETRA. Encaminhar pré-natal risco habitual com 33 semanas, pelo médico ou enfermeiro.

Todas as gestantes devem ser encaminhadas ao Pediatra no terceiro trimestre de gestação para realização de consulta pediátrica no pré-natal, conforme capítulo 08 que dispõe sobre CONSULTA PEDIÁTRICA NO PRÉ-NATAL.

CAPÍTULO 5 - MUDANÇAS FISIOLÓGICAS NA GRAVIDEZ

As alterações fisiológicas observadas na gestação são decorrentes, principalmente, de fatores hormonais e mecânicos, e os ajustes verificados no organismo da mulher devem ser considerados normais durante o estado gravídico, embora determinem, por vezes, pequenos sintomas que afetam a saúde da paciente.

Quadro 7. Principais Modificações Fisiológicas na Gestação, 2023.

Útero
Estiramento e acentuada hipertrofia das células musculares existentes;
Aumento no tecido fibroso, no tecido elástico, nos vasos sanguíneos e nos vasos linfáticos;
O colo uterino apresenta amolecimento e cianose pronunciados devido ao aumento da vascularização, edema, hipertrofia e hiperplasia das glândulas cervicais.
Ovários
Cessa a ovulação e a maturação dos folículos;
Um corpo lúteo funciona produzindo progesterona.
Vagina
A vascularização aumenta;
Hiperemia e amolecimento do tecido conjuntivo na pele e músculos do períneo e da vulva;
As secreções vaginais aumentam em quantidade.
Parede abdominal
Pode se formar uma linha de pigmentação escura e se estender da cicatriz umbilical até a sínfise púbica;
Estiramento dos músculos abdominais.
Mamas
Podem ocorrer sensação dolorosa e formigamento nas primeiras semanas de gestação;
Há um aumento das glândulas mamárias;
O colostro pode ser extraído a partir do segundo trimestre.
Sinal de Hunter: Escurecimento da aréola primitiva e aparecimento da aréola

secundária, menos pigmentada, de limites imprecisos (aréola gravídica).

Tubérculos de Montgomery: Surgem na aréola primitiva. São glândulas mamárias acessórias ou sebáceas, hipertrofiadas. Surgem cerca de 12 a 15 tubérculos. Desaparecem no puerpério.

Coração/Circulação

O coração é deslocado para esquerda e para cima;

Sopros cardíacos são comuns, e geralmente, desaparecem após o parto;

O volume cardíaco aumenta de 40% a 50% do início da gravidez até seu término.

Sistema Respiratório

Ocorre um aumento da frequência respiratória;

Diafragma é elevado devido ao aumento uterino;

Pode ocorrer dificuldade respiratória e cansaço aos esforços.

Sistema Urinário

No início da gestação pode ocorrer micções frequentes;

Ao final da gestação, a drenagem sanguínea na base da bexiga fica comprometida, provocando edema;

A gestante fica mais suscetível a traumas e infecções.

Sistema Gastrointestinal

As gengivas podem se tornar hiperemiadas e amolecidas, podendo sangrar com facilidade;

O estômago e o intestino são deslocados para cima e para o lado do útero;

A pirose é comum, provocada pelo refluxo das secreções ácidas na parte inferior do esôfago.

Sistema Tegumentar

A gestante tem a tendência de aumento da pigmentação cutânea devido aumento de melanina, mais evidente em algumas regiões corporais:

Face e pescoço (manchas escuras conhecidas como cloasma e melasma gravídico);

Auréolas mamárias;

Linha alba no abdome (formando a linea nigra);

Vulva;

Com a ação do estrogênio há: Dilatação dos vasos periféricos, fazendo com que fique aparente na face, pescoço, porção superior do tórax e membros superiores; Pode aparecer eritema palmar (palmas das mãos avermelhadas); Estrias gravídicas se apresentam geralmente no final da gravidez: ocorre por alterações do tecido conjuntivo e maior retenção hídrica, (abdômen e mamas, coxas e nádegas). Alterações capilares; Ocorre perda de cabelos nos meses que seguem o parto, devido processo de repouso dos folículos capilares (fase telógena).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Devido às alterações fisiológicas durante a gestação, a pessoa gestante pode apresentar como principais queixas:

- Náuseas e êmeses;
- Pirose;
- Dificuldade para respirar/ sensação de falta de ar;
- Estrias;
- Câimbras;
- Cloasma gravídico;
- Sangramento gengival;
- Mastalgia;
- Lombalgia;
- Sialorréia;
- Constipação;
- Dor abdominal;
- Cólicas;
- Flatulência ;
- Edema;
- Fraqueza e desmaios;
- Varicosidades; hemorroidas;

- Vertigens;
- Polaciúria;
- Aumento da secreção vaginal.

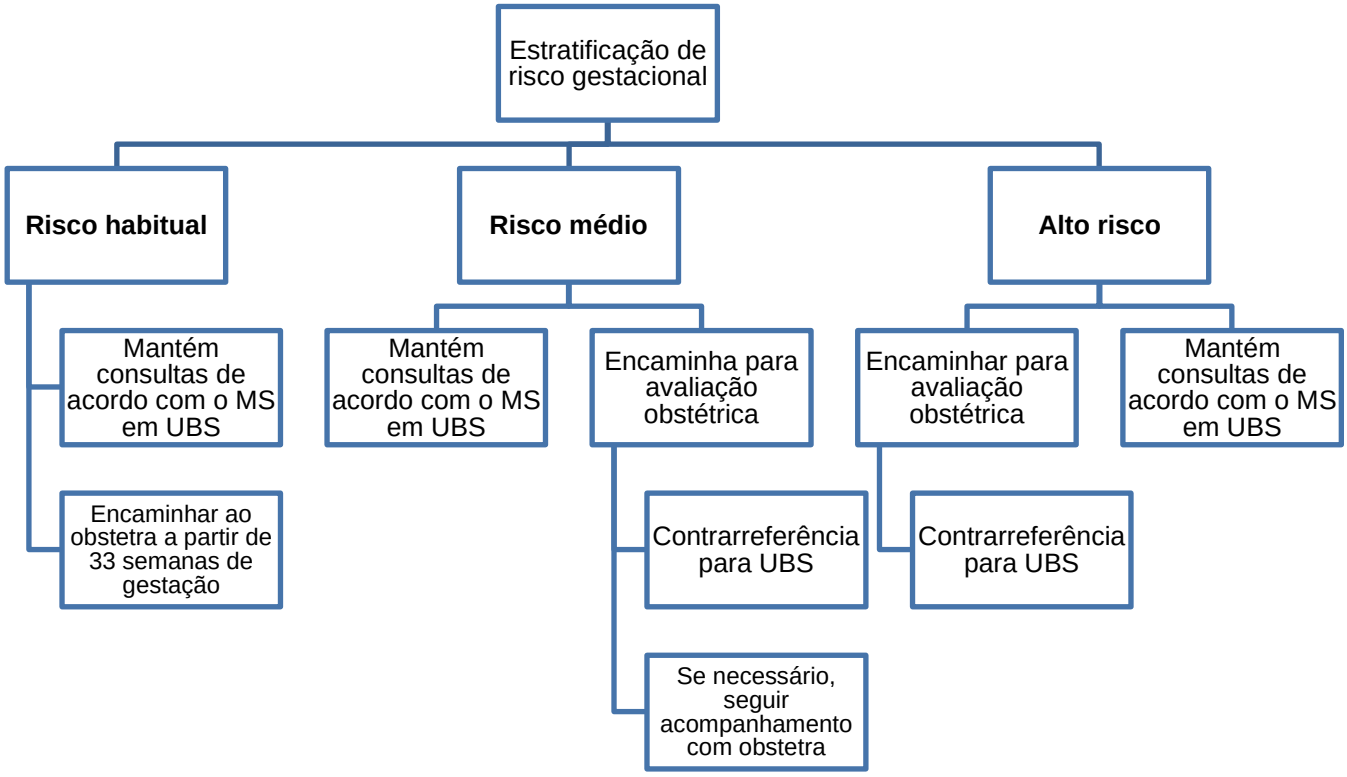
CAPÍTULO 6 - ENCAMINHAMENTO AO OBSTETRA

Todas as gestantes residentes no município de Nova Mutum devem ser encaminhadas ao obstetra para acompanhamento na reta final da gestação, independente da classificação de risco gestacional.

Aquelas de médio e alto risco já são encaminhadas assim que identificada essa condição na estratificação de risco gestacional, realizada em todas as consultas.

As de risco habitual são encaminhadas para acompanhamento conjunto a partir das 33 semanas de gestação, podendo este ser realizado pelo médico ou enfermeiro via APAC.

Fluxograma 1. Encaminhamento ao Obstetra



- Em casos de urgência-emergência obstétrica:
- Entrar em contato com o médico regulador para direcionar o caso ao PAM ou Hospital.
- Receber a contrarreferência da instituição, assim que resolutividade da

condição de urgência/emergência, retornar tão logo a UBS para encaminhamento ao obstetra com brevidade e, se necessário, realizar busca ativa da gestante pela equipe multiprofissional, incluindo ACS, com consulta agendada.

CAPÍTULO 7 - PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO

O pré-natal odontológico é fator importante para evitar complicações na gestação, na saúde bucal da mãe e do bebê. Devido às alterações hormonais que ocorrem durante a gestação, aumentam o surgimento de inflamações na gengiva (gengivite), sensibilidades e até mesmo hiperplasias gengivais (crescimento excessivo da gengiva).

ANAMNESE E EXAME CLÍNICO

- Inspeção, exploração - Avaliação visual sistemática do paciente.
- Diascopia (vitropressão) - É a pressão de uma lâmina de vidro contra alguma lesão para verificar se ela é vascular ou não. Se a lesão desaparecer com a pressão, ela é vascular; caso contrário, é pigmentar;
- Palpação - É o exame físico, com toque na cabeça e no pescoço. Essa manobra permite que o profissional observe o amolecimento ou endurecimento das estruturas e, com isso, descubra se alguma delas sofre de inflamações e tumores. Então, ao realizar a palpação, o dentista toca com as pontas dos dedos e avalia diversos aspectos, como textura, espessura, consistência, sensibilidade, volume e temperatura; já as estruturas moles são examinadas por meio de palpação bidigital, digital e dígito-palmar;
- Percussão - É o ato de tocar ou bater em um objeto dentário. Da mesma forma que a inspeção, pode ser feita de maneira direta ou indiretamente. Normalmente, é feito com o cabo de um espelho dental;

PROCEDIMENTOS

- Adequação do meio bucal (profilaxia, raspagens periodontais, restaurações, acesso a polpa dentária e medicação, gengivectomias, exodontias, drenagens de abscessos);
- Procedimento diagnóstico (punção, biópsia);
- Procedimentos mais invasivos com uso de anestésico, preferencialmente realizados no segundo trimestre de gestação.

O PROFISSIONAL DENTISTA TEM TOTAL AUTONOMIA PARA INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM QUALQUER PACIENTE, INCLUSIVE EM PERÍODO GESTACIONAL, DESDE QUE NÃO INTERFIRA EM TRATAMENTO MÉDICO JÁ EM ANDAMENTO.

ORIENTAÇÕES

- Prevenção da cárie e doenças periodontais;
    - Início da calcificação dos dentes decíduos por volta do quarto mês de vida intrauterina e da dentição permanente a partir do primeiro mês de vida do bebê, desta forma condições desfavoráveis durante a gestação, tais como: uso de medicamentos, carências nutricionais, infecções entre outros, podem trazer problemas na formação e mineralização dos dentes;
    - Desenvolvimento do paladar do bebê na vida intrauterina (dieta rica em açúcares a partir do 4o mês de gestação pode desenvolver avidez pelo açúcar no bebê);
    - Importância do aleitamento materno;
    - Discussão do uso de chupeta, mamadeira;
    - Prevenção de bactérias causadoras de doenças bucais.

CAPÍTULO 8 - PRÉ-NATAL PEDIÁTRICO

A consulta pediátrica no terceiro trimestre do pré-natal representa uma oportunidade para antecipar riscos e um dos três pilares para redução da morbimortalidade neonatal, juntamente com a assistência ao recém-nascido em sala de parto e a consulta pós-natal dentro da primeira semana de vida. A consulta pré-natal reduz os medos, as apreensões e a ansiedade da família em relação à chegada do filho, por antecipar informações e estratégias para enfrentar e resolver situações do cotidiano dos bebês.

Esta consulta estabelece um canal de comunicação entre o obstetra, a ESF, a família e o pediatra, visando:

- A redução do número de cesarianas, pela explicação sobre as vias de parto e seu impacto sobre o RN;estímulo à amamentação, explicando os benefícios para a mãe e o feto;
- Orientar a importância da alimentação da gestante pela influência no desenvolvimento do feto;
- Explicar sobre os primeiros 1000 dias e sua importância, inclusive na programação metabólica do futuro RN até os 2 anos de idade;
- Os cuidados com o RN no primeiro mês de vida (coto, cólicas, hábitos intestinais, suplementações, golfos, entre outros);
- Orientar a família sobre os cuidados e necessidades especiais nos casos em que o futuro RN possua alguma síndrome ou má formação;

A avaliação pediátrica deve ser realizada rotineiramente para todas as gestantes, não se restringindo à classificação de gestação de alto risco. Algumas situações podem aumentar o risco de complicações fetais e neonatais aumentando a importância da indicação desta consulta:

- Gestação em idade precoce (menor que 16 anos) ou tardia (maior que 35 anos);
- Gemelaridade;
- Risco para prematuridade;
- História de aborto espontâneo anterior, óbito fetal ou neonatal;
- Diagnóstico pré-natal de malformações fetais e/ou de síndromes genéticas;

- Condições maternas de risco para restrição de crescimento intrauterino e para aumento de morbimortalidade do feto e/ou o RN (alcoolismo, tabagismo, uso de drogas injetáveis, uso crônico de medicamentos, acidentes e traumas, exposição a radiação, sorologias maternas positivas para patógenos de possível transmissão vertical);
- Doenças maternas prévias ou intercorrentes (cardiopatias, hipertensão arterial sistêmica (HAS), nefropatias, alterações neurológicas, hematológicas, nutricionais ou metabólicas, infecções sintomáticas ou assintomáticas com soro conversão na gestação);

As orientações fornecidas na consulta pediátrica pré-natal deverão ser impressas e entregues à família para consultar em casa sempre que necessário.

EM CASO DE DÚVIDAS OU MELHORES ESCLARECIMENTOS SOBRE O TEMA, CONSULTAR O PROTOCOLO MUNICIPAL DE PUERICULTURA

ROTINA DE ENCAMINHAMENTO

As gestantes devem ser encaminhadas no 3° trimestre de gestação, realizado ou pelo enfermeiro ou pelo médico, via APAC. A mesma será direcionada a Central de Regulação.

As gestantes serão atendidas em grupo, podendo ser realizado consultas individuais e seguimento em casos especiais:

- Má formação fetal e/ou síndromes genéticas;
- HIV;
- Gestantes de alto risco gestacional;
- Gestante com vulnerabilidade social (alcoolismo, tabagismo, uso de drogas injetáveis, uso crônico de medicamentos, acidentes e traumas, exposição a radiação).

CAPÍTULO 09 - PRÉ-NATAL NUTRICIONAL

As gestantes devem ser encaminhadas ainda na primeira consulta de pré-natal para avaliação com nutricionista. O encaminhamento pode ser realizado tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro.

A consulta com nutricionista, pode ser individual ou em grupo, com a primeira consulta preferencialmente até a 16ª semana gestacional.

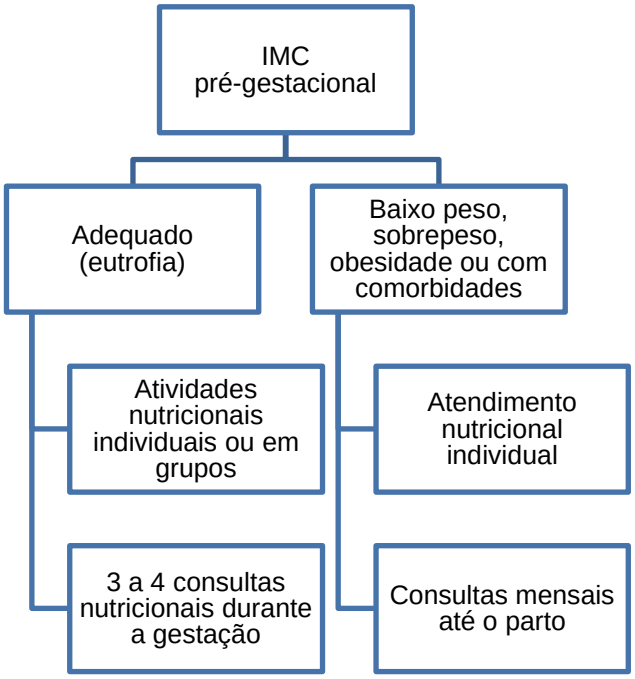
GESTANTE BAIXO RISCO - ROTINA:

- Equipe E-Multi em atendimentos em cada unidade de referência, 1x/trimestre. Devendo receber encaminhamento e administrativo marcar na agenda unificada.

GESTANTE MÉDIO/ALTO RISCO:

- Diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade, baixo peso pré-gestacional, pós cirurgia bariátrica, gestação múltipla, adolescentes - idade <18 anos, transtorno alimentar.
- Nutricionista do CEM recebe encaminhamento das UBS via APAC de gestantes de alto risco e realiza agendamentos.
- Consulta mensalmente, sendo dividida em 2 consultas com intervalo de 15 dias ainda no 1° trimestre e as demais mensalmente.

Fluxograma 2. IMC



AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ANTROPOMÉTRICA

Avaliação antropométrica:

IMC pré-gestacional e classificação do estado nutricional;

Estimativa de peso recomendada para categoria de IMC pré-gestacional;

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL POR SEMANA GESTACIONAL

- História clínica e Avaliação Dietética: (anamnese alimentar detalhada)
- Investigar a composição das refeições, local e horários adotados;
- Verificar a frequência de consumo dos alimentos e quantificar, pelo menos, o alimento de consumo mais frequente de cada grupo;
- Investigar o uso de adoçante (tipo/quantidade) produtos dietéticos, refrigerantes, doces, frituras e outros erros alimentares;
- Quantidade e qualidade dentro da condição socioeconômica da gestante;
- Investigação de sinais e sintomas digestivos e da função intestinal.

Acompanhamento dos exames laboratoriais e complementares e a tomada de conduta nutricional

Orientação nutricional de acordo com o estado nutricional, adequando as condições socioeconômicas, observando o ganho de peso recomendado e a prevenção e tratamento das carências nutricionais específicas;

Esclarecer as dúvidas;

CONSULTAS NUTRICIONAIS SUBSEQUENTE

- Observar a adesão às orientações nutricionais:
- Quantidade e qualidade;
- Ganho de peso semanal.

CAPÍTULO 10 - QUESTÕES NUTRICIONAIS NO PRÉ-NATAL

A avaliação do estado nutricional da gestante deverá refletir as condições nutricionais da mulher e indiretamente, do feto (BRASIL, 2011).

O diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional do binômio mãe-filho são importantes para a prevenção da morbimortalidade perinatal, prognóstico do crescimento e desenvolvimento fetal e também na promoção da saúde materno-infantil (DEMARCHI; FREITAS; BARATTO, 2018).

ANTROPOMETRIA NUTRICIONAL REALIZADA NA UBS PELA EQUIPE TÉCNICA EM ENFERMAGEM:

- Gestante adulta (≥ 18 anos a <59 anos)
- Peso
- Altura
- Avaliação do consumo alimentar.

O Peso deve ser realizado todo atendimento independente de quantas vezes por mês a gestante passe pelo ESF. E a altura apenas uma vez durante o pré-natal.

- Gestante <18 anos
- Peso
- Altura
- Avaliação do consumo alimentar.

O Peso deve ser realizado todo atendimento independente de quantas vezes por mês a gestante passe pelo ESF. E a avaliação da altura deve ser realizada no mínimo a cada trimestre.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NA CONSULTA PRÉ-NATAL

Primeiramente deve-se calcular o IMC pré-gestacional, pois assim estima-se o ganho de peso total recomendado até o final da gestação. Cada gestante deverá ter ganho de peso de acordo com seu IMC pré-gestacional (baixo peso, adequado, sobrepeso ou obesidade).

Calcular com o peso pré-gestacional informado pela paciente com até no máximo 2 meses antes da concepção ou no caso de não saber, medir com o peso até a 13ª semana gestacional.

Peso Pré Gestacional

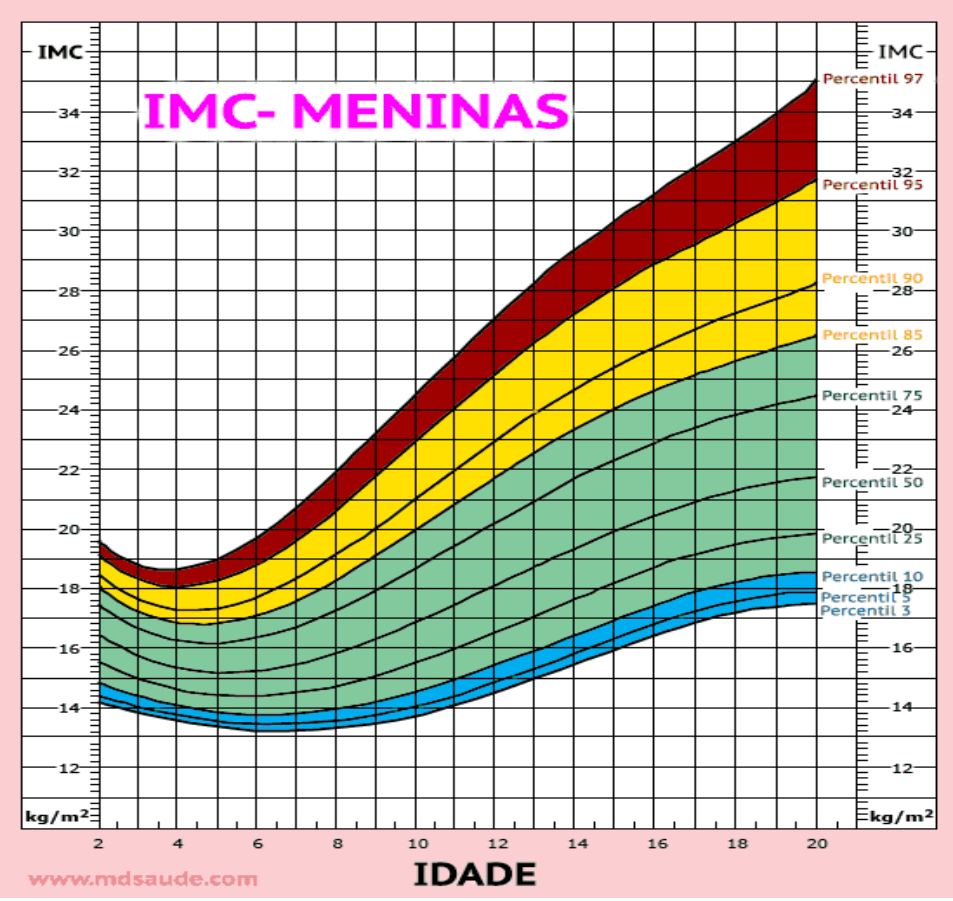
- Realizar e classificar.

Classificação da gestante adulta a partir do IMC segundo a OMS

IMC	Classificações
< 18,5	Abaixo do peso normal
18,5 a 24,9	Peso normal
25,0 a 29,9	Excesso de peso
30,0 a 34,9	Obesidade grau I
35,0 a 39,9	Obesidade grau II
>/igual a 40,0	Obesidade grau III

Gestante Adolescente

Figura 2. Gráfico de classificação de gestante adolescente de acordo com IMC



Percentil	Escore-z	Classificação
<3	< -2	Baixo peso
>/igual 3 e < 85	>/igual -2 e < +1	Adequado
>/igual 85 e <97	>/igual +1 e < +2	Sobrepeso
>/igual 97	>/igual +2	Obesidade

Ganho de peso recomendado por trimestre gestacional para adultos e adolescentes

Tabela 3. IMC - Gestação Única

IMC pré-gestacional	Ganho de peso (kg) até a 13º semana de gestação	Ganho de peso (kg) semanal no 2º e 3º trimestre (a partir da 14ª semana de gestação)	Ganho de peso total (kg)
Baixo peso (<18,5)	2,0	0,51 (0,44 – 0,58)	12,5–18,0
Eutrófico (18,5 – 24,9)	1,5	0,42 (0,35 – 0,50)	11,5 – 16,0
Sobrepeso (25 – 29,9)	1,0	0,28 (0,23 – 0,33)	7,0 – 11,5
Obesidade (>/igual 30)	0,5	0,22 (0,17 – 0,27)	5,0 – 9,0

Tabela 4. IMC - Gestação Gemelar

IMC pré-gestacional	Ganho de peso (kg) semanal			Ganho de peso total (kg)
	0 – 20 Semanas	20 – 28 semanas	28 semanas ao parto	
Baixo peso (<18,5)	0,560 – 790	0,680 – 0,790	0,560	22,5 – 27,9
Eutrófico (18,5 – 24,9)	0,450 – 0,680	0,560 – 0,790	0,450	18 – 24,3
Sobrepeso	0,450 –	0,450 –	0,450	17,1 – 21,2

(25 – 29,9)	0,560	0,680		
Obesidade (>/igual 30)	0,340 – 0,450	0,340 – 0,560	0,340	13 – 17,1

CAPÍTULO 11 - QUESTÕES EMOCIONAIS NO PRÉ-NATAL

A experiência de gerar um filho é um momento de destaque no ciclo vital da mulher e do homem com repercussões importantes para seus meios familiares. Assim, a gestação, invariavelmente, é um período de intensas mudanças no corpo e na psique da mulher, além das expectativas, planos e projetos desenvolvidos pela família. Tal processo de significação está intrinsecamente ligado ao envolvimento psicoafetivo da unidade familiar.

As experiências mais profundas da vida dos seres humanos são sempre marcadas por fortes emoções. É imprescindível que os profissionais os quais realizam o pré natal compreendam que essa pode ser uma fase crítica para algumas pessoas, um período no qual a mulher e a família necessitarão realizar arranjos de ordem afetiva, familiar, econômica e social. Essas mudanças necessárias na vida presente e futura podem gerar, por algum tempo, insegurança, medo ou mesmo conflitos internos e também nas relações interpessoais.

Características emocionais presentes na gestação e pós-parto:

1º trimestre:

Ao tomar conhecimento sobre a novidade de estar grávida, a mulher passa por alterações em seu psiquismo que colaboram no processo de maternalidade. Seus sentimentos internos e suas primeiras vivências podem parecer inicialmente contraditórios. Assim, a ambivalência afetiva é comum no perfil psicodinâmico da grávida, especialmente no 1º trimestre gestacional, oscilando entre sentimentos de satisfação, euforia e desânimo e insegurança.

2º trimestre:

O 2º trimestre pode ser considerado uma fase mais prazerosa, em que devido a redução dos desconfortos físicos, ocorre uma maior motivação, muitas vezes devido ao início da personificação do bebê e do reconhecimento público da gestação.

3º trimestre:

No 3º trimestre é comum ocorrer o aumento do estresse e da ansiedade.

Pós parto:

O bebê possui necessidades fisiológicas e psíquicas importantes após a vida extra uterina, e a puérpera vivencia experiências intensas principalmente neste período, sendo elas: a transição existencial, o luto perinatal, o “baby blues ou tristeza materna”, que atinge cerca de 35 a 50% das mães e é resultante da alteração vivencial e hormonal brusca que acontece no pós-parto, com duração até algumas semanas.

Diante dos fatores apresentados é necessário que as equipes de saúde desenvolvam estratégias de acompanhamento e orientação as gestantes e familiares, a fim de acompanhar, promover a saúde mental materna e familiar, prevenindo o desenvolvimento de transtornos emocionais, podendo ser estas estratégias individuais ou coletivas, conforme a necessidade.

Quando necessário, encaminhar as gestantes e/ou puérperas para acolhimento e avaliação psicológica.

CAPÍTULO 12 - ATIVIDADE FÍSICA NA GESTAÇÃO

A atividade física durante a gestação controla o ganho de peso, reduz as dores lombares, previne contra algumas doenças, como diabetes gestacional, facilita o trabalho de parto e melhora o sistema cardiovascular, beneficiando mãe e bebê. Porém, é fundamental conversar com o Médico ou Enfermeiro antes de iniciar qualquer exercício.

Os principais benefícios incluem: diminuição das câimbras; melhora na circulação sanguínea; redução do inchaço; fortalecimento da musculatura abdominal; redução do desconforto intestinal; melhora da postura corporal; mais rápida recuperação no pós-parto; diminuição das dores lombares; maior controle respiratório. Ainda podemos acrescentar melhoras nos níveis hormonais, níveis de tensão e ansiedade, bem como sensação de bem estar e relaxamento muscular.

TEMPO DE ATIVIDADE FÍSICA

Toda mulher sem contra indicação médica pode e deve ser fisicamente ativa durante a gravidez. As gestantes precisam fazer 2 horas e 30 minutos por semana de exercícios físicos em intensidade moderada para obter benefícios. Esse tempo deve ser dividido em pelo menos três dias da semana.

EXERCÍCIOS PARA GESTANTES NO 1° TRIMESTRE

No primeiro trimestre de gestação, é comum haver mais cansaço, sonolência, enjoos e hipotensão. Assim, é normal que as mulheres que já praticavam exercícios físicos antes de engravidar diminuam a intensidade dos mesmos. Entre as que eram sedentárias antes da gravidez, o começo deve ser gradual.

Cuidados: a partir da 10ª semana de gestação há um aumento significativo nos níveis de hormônio que deixa articulações e ligamentos da gestante mais flexíveis para o parto. Por conta disso, devem-se evitar alongamentos extremos para prevenir lesões.

EXERCÍCIOS PARA GESTANTE NO 2° TRIMESTRE

O segundo trimestre da gravidez costuma ser o de maior disposição das gestantes. Os enjoos e náuseas são menos frequentes e a pressão arterial tende a se estabilizar. Quem estava praticando atividades em intensidade leve normalmente consegue evoluir para atividades moderadas.

Cuidados: exercícios na posição supina (de barriga para cima) podem ficar menos confortáveis e seguros. Orientar exercícios na posição deitada de lado ou em pé e evitar os abdominais.

EXERCÍCIOS PARA GESTANTES NO 3º TRIMESTRE

No terceiro trimestre (entre as semanas 27 e 40) aumenta a pressão do útero sobre a aorta e a veia cava superior, podendo aumentar também a pressão arterial. É hora de reduzir a intensidade das atividades físicas, mas não precisa parar.

Cuidados: Para essa reta final da gestação, é recomendado fazer exercícios preparatórios para o parto, como mobilidade de quadril, alongamentos e agachamentos.

Em todos os casos, a recomendação máxima é sempre ter orientação médica, atentar aos sinais do corpo e não sobrecarregá-lo com os treinos.

ATIVIDADES FÍSICAS RECOMENDADAS:

- Caminhada: pode ser praticada até mesmo por quem não costumava se exercitar antes da gravidez. A recomendação para gestantes é que ela tenha duração aproximada de 30 minutos e que seja realizada de três a cinco vezes durante a semana. Orientar a utilização de roupas leves e confortáveis, calçados adequados e água para hidratação.
- Natação: esta modalidade é mais indicada para quem já a praticava antes da gestação. Porém, quem estiver começando também pode se beneficiar. A recomendação é nadar em intensidade leve a moderada e controlar a frequência cardíaca.
- Hidroginástica: além de ter a possibilidade de combinar exercícios aeróbicos com os de resistência, a hidroginástica ainda apresenta a vantagem de reduzir

o impacto sobre as articulações e de aliviar o peso do abdome gravídico. A hidroginástica auxilia no desenvolvimento da capacidade cardiovascular, no fortalecimento dos músculos e proporciona sensação de relaxamento. Pode ser realizada no terceiro trimestre de gestação.

- Musculação: fortalecer a musculatura é importante para reduzir dores nas costas e nas articulações. Porém, até mesmo as mulheres que já praticavam antes da gestação precisam diminuir a carga dos treinos e respeitar os limites do corpo conforme a gestação evolui.
- Yoga/alongamento: além de promover mais flexibilidade, atividades que envolvam alongamento, como é o caso da yoga, podem auxiliar no controle de ansiedade. Trata-se de uma modalidade indicada tanto para gestantes que já tenham o hábito de exercitar como para aquelas que estão iniciando. Há modalidades de yoga destinadas especialmente a gestantes, já levando em consideração este momento da vida da mulher.
- Pilates: esta modalidade de atividade física apresenta a vantagem de fortalecer os músculos do assoalho pélvico, que auxiliam na sustentação do peso da barriga, nos casos de incontinência urinária e, por fim, no parto normal. Realizado com assistência profissional, o Pilates também contribui com a melhora da frequência cardíaca, da respiração e da postura.

CAPÍTULO 13 - SINAIS DE ALERTA NA GESTAÇÃO

SANGRAMENTO VAGINAL

Anormal em qualquer época da gravidez. Requer avaliação médica imediata!

INTERCORRÊNCIA	COMO IDENTIFICAR/AVALIAR	O QUE FAZER	QUEM FAZ
Abortamento	Sangramento vaginal Presença de cólicas em abdome inferior Exame especular: visualização do colo uterino, para a constatação da origem intrauterina do sangramento e detecção de fragmentos placentários no canal cervical e na vagina; Toque vaginal: avaliar permeabilidade do colo uterino e presença de dor. Ameaça de aborto X abortamento em curso: a diferenciação é pelo colo do útero (se está pérvio ou não). Idade gestacional acima de 12 semanas: risco de perfuração uterina por partes ósseas fetais,	Na ameaça de aborto Administrar, por tempo limitado, antiespasmódicos (hioscina, 10 mg, um comprimido, via oral, de 8/8 horas); Recomendar abstinência sexual e repouso; Uma ameaça de abortamento pode evoluir para gestação normal ou para abortamento inevitável; Solicitar USG para determinação de conduta médica; Após Caso não seja possível realizar USG, entrar em contato com médico regulador para possível avaliação	Médico(a)

	necessita de exame ultrassonográfico. Para o diagnóstico de certeza entre uma ameaça de aborto e abortamento inevitável: presença de saco embrionário íntegro e/ou concepto vivo. Para o diagnóstico de aborto incompleto: presença de restos ovulares. Para o diagnóstico de aborto retido: presença de concepto morto ou ausência de embrião, colo uterino impérvio. No aborto infectado: secreção fétida endovaginal, dor pélvica intensa à palpação, calor local e febre, além de comprometimento variável do estado geral.	obstétrica No abortamento inevitável e aborto retido Avaliar necessidade de encaminhamento ao hospital de referência obstétrica ou então conduta expectante. No abortamento infectado Iniciar fluidoterapia, para a estabilização hemodinâmica; Encaminhar para o hospital de referência obstétrica, após contato prévio com médico regulador.	
Gravidez Ectópica	Perda sanguínea uterina e dor pélvica intermitente, na fase inicial, evoluindo para dor contínua e intensa. Sinais de irritação	Solicitar USG Obstétrica para avaliação do local de implantação da gestação. Encaminhar a	Médico(a)

	peritoneal e repercussões hemodinâmicas, lipotímia, quadros graves com choque hipovolêmico.	gestante para um hospital de referência obstétrica.	
Descolamento Corioamniótico	Sangramento de pequena intensidade no primeiro trimestre; Evolução em geral é boa e não representa quadro de risco materno e/ou ovular. Realização de exame ultrassonográfico: Visualização do descolamento corioamniótico.	Recomendações: Abstinência sexual; Solicitar USG Obstétrica, a condução pode ser realizada na UBS. Caso não seja possível realizar USG, encaminhar ao hospital de referência obstétrica.	Médico (a)
Doença Trofoblástica Gestacional	Presença de sangramento vaginal intermitente, de intensidade variável, indolor e, por vezes, acompanhado da eliminação de vesículas (sinal patognomônico); A altura uterina ou o volume uterino, em geral, é incompatível com o esperado para a idade gestacional,	Encaminhar a gestante ao hospital de referência obstétrica.	Médico(a)

	sendo maior previamente a um episódio de sangramento e menor após (útero em sanfona); Não há presença de batimentos cardíacos ou outras evidências de embrião (nas formas completas); A presença de hiperêmese é mais frequente, podendo levar a mulher a estados de desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos; A doença trofoblástica pode vir com sangramento volumoso e até choque; A doença trofoblástica pode vir com DHEG precoce.		
Descolamento Prematuro Da Placenta (DPP)	Aparecimento de dor abdominal súbita, com intensidade variável; Sangramento vaginal que pode variar de sangramento discreto a	Na suspeita diagnóstica, encaminhar a gestante, como emergência, ao hospital de referência	Médico(a)

	volumoso, muitas vezes incompatível com o quadro de hipotensão (ou choque) materno; pode ocorrer "sangramento oculto" quando não há exteriorização do sangramento; pode evoluir para quadro grave caracterizado por atonia uterina (útero de Couvelaire); Causa importante de sangramento no 3º trimestre. Realização do exame obstétrico: Na fase inicial, ocorre taqui-hipersistolia (contrações muito frequentes [> cinco em dez minutos] e intensas), seguida de hipertonia uterina e alteração dos batimentos cardíacos fetais; Útero, em geral, encontra-se hipertônico, doloroso, sensível às manobras palpatórias;	obstétrica, após contato prévio com médico regulador.	

	Os batimentos cardíacos fetais podem estar alterados ou ausentes; Comprometimento variável das condições gerais maternas, desde palidez de pele e mucosas até choque e distúrbios da coagulação sanguínea.		
Placenta Prévia	Sangramento vaginal, súbito, de cor vermelho-vivo, de quantidade variável, indolor. É episódica, recorrente e progressiva. Realização do exame obstétrico: Revela volume e tono uterinos normais e frequentemente apresentação fetal anômala; Habitualmente, os batimentos cardíacos fetais estão mantidos; exame especular revela presença de sangramento proveniente da cavidade	Referenciar a gestante para o alto risco. Se gestante com sangramento ativo: passar por consulta médica e entrar em contato com médico regulador para avaliação obstétrica.	Médico(a)

	uterina e, na suspeita clínica, deve-se evitar a realização de toque vaginal. Realização de exame ultrassonográfico, se possível: Visualização de placenta em localização baixa, confirmando o diagnóstico; Frequentemente, as placentas no início da gestação encontram-se localizadas na porção inferior do útero. Entretanto, somente 10% das placentas baixas no segundo trimestre permanecem prévias no termo.		

CEFALEIA, ESCOTOMAS VISUAIS, EPIGASTRALGIA E EDEMA EXCESSIVO

Podem sugerir pré-eclâmpsia.

INTERCORRÊNCIA	COMO IDENTIFICAR E AVALIAR	O QUE FAZER	QUEM FAZ
Hipertensão Arterial, Pré-Eclâmpsia, Eclâmpsia	Hipertensão arterial: pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou a pressão arterial	Na hipertensão arterial Metildopa 750-2.000 mg/dia; Alternativas	Médico(a)

	diastólica ≥ 90 mmHg, em duas medidas com intervalo de pelo menos quatro horas; Pré-eclâmpsia: HAS e proteinúria após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas. Eclâmpsia: Corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.	Antagonistas de canais de cálcio (ACC): Nifedipino (10-80 mg/dia); Os betabloqueadores são considerados seguros na gravidez, embora se atribua a eles redução no crescimento fetal. Pré-eclâmpsia Referenciar à urgência obstétrica e, caso a gestante não fique internada, encaminhar ao pré-natal de alto risco. Na eclâmpsia Referenciar à urgência obstétrica.	

CONTRAÇÕES REGULARES, PERDA DE LÍQUIDO

Sintomas indicativos de início de trabalho de parto.

INTERCORRÊNCIA	COMO IDENTIFICAR/AVALIAR	O QUE FAZER	QUEM FAZ
Trabalho De Parto Prematuro (TPP)	Frequentemente relacionado a infecções urinárias e vaginais. Contrações uterinas rítmicas e regulares, sem modificação cervical, caracteriza-se como falso trabalho de parto prematuro.	olicitar avaliação especializada.	Médico(a)

	Tais casos costumam evoluir bem apenas com o repouso, principalmente se identificada e tratada a causa de base.		
Alterações Do Líquido Amniótico	Polidrâmnio A altura uterina é superior àquela esperada para a idade gestacional estimada, associada à diminuição da movimentação fetal e dificuldade de palpar partes fetais e na ausculta. Oligoidrâmnio A altura uterina é inferior àquela esperada para a idade gestacional estimada, associada à diminuição da movimentação fetal e fácil percepção das pequenas partes fetais à palpação obstétrica. Amniorrexe prematura.	Encaminhar ao pré-natal de alto risco. Se gestante com perda de líquidos ativo: passar por consulta médica e entrar em contato com médico regulador para avaliação obstétrica.	Médico(a)

CAPÍTULO 14 - CONDIÇÕES CLÍNICAS OBSTÉTRICAS ADVERSAS

UMA VEZ IDENTIFICADA QUAISQUER CONDIÇÕES DE RISCO, CONDUTAS DEVEM SER TOMADAS!

ANEMIA

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde, criado por meio da Portaria MS nº 730, de 13 de maio de 2005, recomenda a suplementação de 40mg/dia de ferro elementar (200mg de sulfato ferroso). Orienta-se que a ingestão seja realizada uma hora antes das refeições. A suplementação de ferro deve ser mantida no pós-parto e no pós-aborto por 3 meses.

A anemia é definida durante a gestação com os valores de hemoglobina abaixo de 11g/ dl. A anemia durante a gestação pode estar associada a um risco aumentado de baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal e trabalho de parto prematuro.

Os fatores de risco para anemia na gestação são:

Dieta com pouco ferro, vitaminas ou minerais;

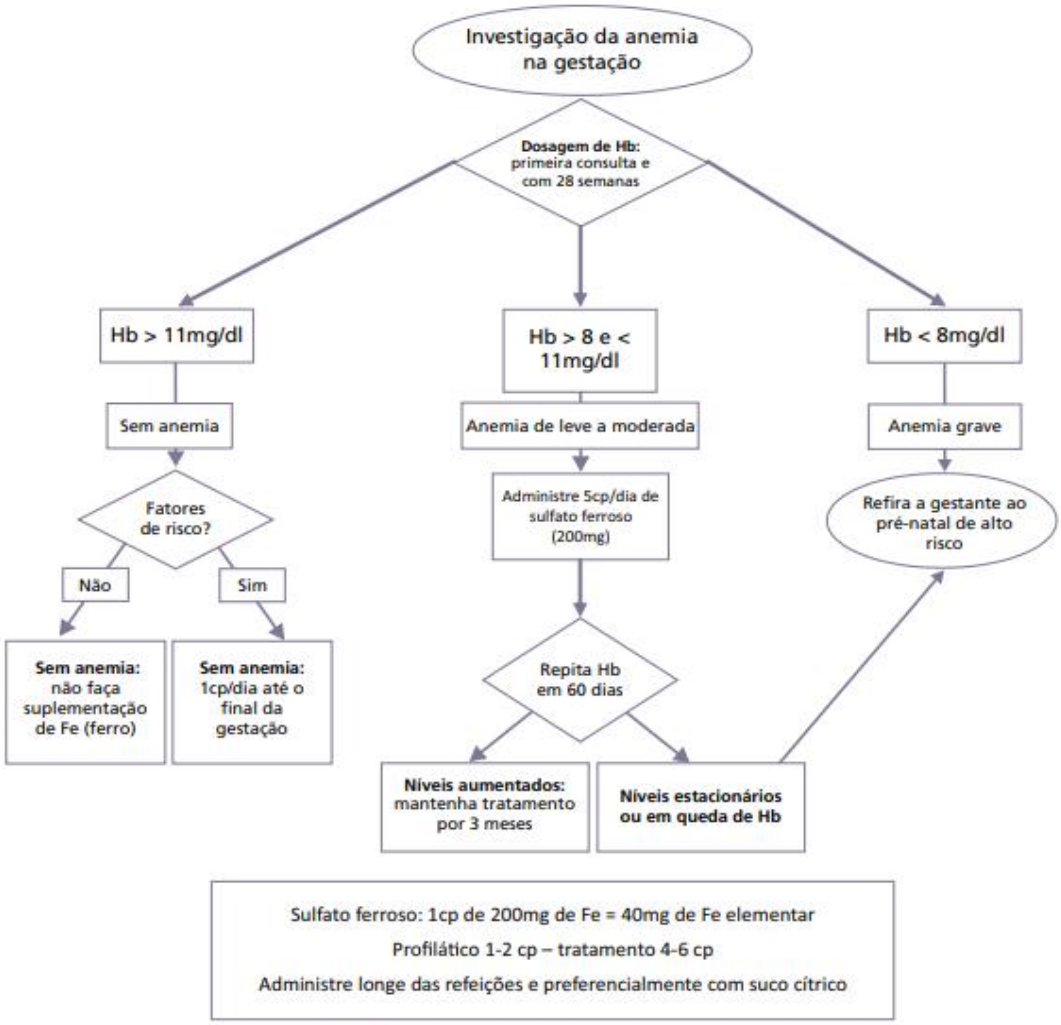
Perda de sangue decorrente de cirurgia ou lesão;

Doença grave ou de longo prazo (como câncer, diabetes, doença nos rins, artrite reumatoide,

Aids, doença inflamatória do intestino, doença no fígado, insuficiência cardíaca e doença na tireoide);

Infecções de longo prazo;

Histórico familiar de anemia herdada, como talassemia e anemia falciforme.



Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Atenção Básica, 2012.

DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL

Decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. O processo de aloimunização se inicia a partir do contato da mulher Rh negativo com o sangue incompatível Rh positivo: por transfusão equivocada, ou por passagem transplacentária do sangue de feto Rh positivo.

Investigar, durante a anamnese, transfusões sanguíneas prévias, uso de drogas ilícitas injetáveis, história obstétrica DHP (icterícia neonatal, exsanguinotransfusão neonatal, transfusões intra uterinas ou hidropisia fetal), histórico de profilaxia anti-Rh.

Na abertura do pré-natal solicita-se a tipagem sanguínea com fator Rh. Uma vez identificado Rh negativo, solicitar então o Coombs Indireto, o qual deve ser repetido mensalmente após a 24° semana de gestação.

Se identificados anticorpos anti-D (Coombs indireto positivo), as gestantes devem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco.

Nas mulheres Rh negativo deve ser realizado imunoglobulina nas primeiras 72h pós parto se houver incompatibilidade Rh entre mãe e bebê, após abortamento, gestação ectópica, gestação molar, sangramento vaginal ou após procedimentos invasivos (amniocentese, biópsia de vilo corial, cordocentese) quando o pai é Rh positivo e a mãe é Rh negativo.

DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS DA GESTAÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os distúrbios hipertensivos da gestação constituem importante causa de morbidade grave, incapacidade de longo prazo e mortalidade tanto materna quanto perinatal (PERAÇOLI, et al., 2023).

Abaixo serão descritas as principais alterações da pressão arterial na gravidez, de acordo com o Protocolo de Pré-Eclâmpsia da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez.

1. Hipertensão Arterial na Primeira Metade da Gestação:

- Hipertensão Arterial Crônica:

Presença de hipertensão reportada pela gestante como manifestação prévia à gravidez ou identificada antes de 20 semanas de gestação;

- Síndrome do Avental Branco:

Presença de hipertensão arterial durante as consultas pré-natais em consultório, que não se mantém em avaliações domiciliares

2. Hipertensão Arterial na Segunda Metade da Gestação:

- Pré-eclâmpsia/Eclâmpsia:

Manifestação de hipertensão arterial identificada após a 20ª semana de gestação, associada ou não à proteinúria significativa e/ou disfunção de órgãos-alvo como

contagem de plaquetas < 150.000/mm3 , disfunção hepática com transaminases oxalacética (TGO) ou pirúvica (TGP) > 40 UI/L, insuficiência renal (creatinina > 1 mg/dL), edema pulmonar, iminência de eclampsia ou eclampsia. Além disso, a associação de hipertensão arterial com sinais de disfunção placentária, como restrição de crescimento fetal e/ou alterações Dopplervelocimétricas fetais, também devem chamar atenção para o diagnóstico de pré-eclampsia, mesmo na ausência de proteinúria;

- Pré-eclâmpsia Sobreposta à Hipertensão Arterial Crônica:

Esse diagnóstico deve ser estabelecido em algumas situações específicas:

1) quando, após 20 semanas de gestação, ocorre o aparecimento ou piora da proteinúria já detectada na primeira metade da gravidez (aumento de pelo menos três vezes o valor inicial);

2) quando gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica necessitam de incremento das doses terapêuticas iniciais ou associação de antihipertensivos;

3) na ocorrência de disfunção de órgãos-alvo;

4) presença de sinais de disfunção placentária progressiva, como restrição de crescimento fetal e/ou alterações Dopplervelocimétricas fetais.

- Hipertensão Gestacional:

Manifestação de hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação, em gestante previamente normotensa, porém sem proteinúria ou disfunção de órgãos-alvo. Essa forma de hipertensão deve desaparecer até 12 semanas após o parto.

- Síndrome HELLP: intensa hemólise (Hemolysis), comprometimento hepático (Elevated Liver enzymes) e consumo de plaquetas (Low Platelets), em paciente com PE.

Tratamento:

- Acompanhamento pré-natal periódico conforme cronograma MS;
- Encaminhamento para pré-natal de alto risco: obstetra e nutricionista;
- Controle pressórico com fármacos;
- Tratamento das complicações;
- Orientação alimentar com ganho de peso adequado e controle metabólico;

- Exercícios físicos devem ser estimulados, porém, devem-se seguir as orientações obstétricas respeitando contraindicações individuais.
- Atuar na urgência e emergência imediatamente.

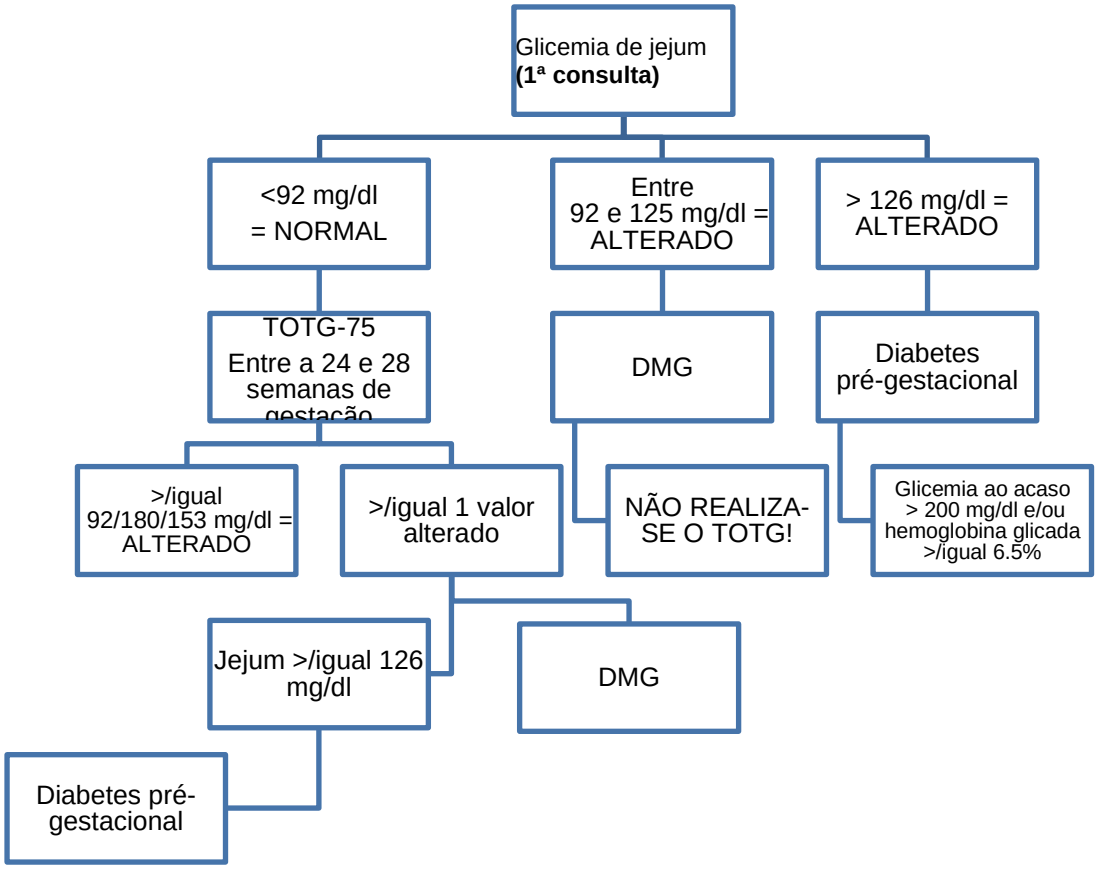
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

Diabetes Mellitus representa um conjunto de distúrbios endócrinos caracterizados por hiperglicemia consequente à deficiência insulínica. Sabemos que este é o problema metabólico mais frequente na gestação.

Diabetes mellitus gestacional: mulher com hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez, com níveis glicêmicos sanguíneos que não atingem os critérios diagnósticos para DM;

- Diabetes Mellitus Diagnosticado na Gestação (Overt Diabetes):
  - Mulher sem diagnóstico prévio de DM, com hiperglicemia detectada na gravidez e com níveis glicêmicos sanguíneos que atingem os critérios da OMS para o DM em não gestantes;
  - Riscos neonatais:
  - Desconforto respiratório;
  - Hipoglicemia;
  - Hipocalcemia;
  - Icterícia neonatal;
  - Alterações hematológicas.
  - Controle deficiente do diabetes mais tarde na gestação aumenta o risco de:
  - Malformações congênitas importantes;
  - Aborto espontâneo;
  - Macrossomia fetal (peso fetal > 4.500g);
  - Pré-eclâmpsia;
  - Distocia do ombro;
  - Cesariana;
  - Natimorto.

Fluxograma 3. Diagnóstico da DMG



Tratamento:

- Acompanhamento pré-natal periódico conforme cronograma MS;
- Encaminhamento para pré-natal de alto risco: obstetra e nutricionista;
- Controle rigoroso do nível de glicose - realizar controle glicêmico em jejum e pós-prandial em pelo menos dois dias alternados durante a semana;
- Tratamento das complicações;
- Orientação alimentar com ganho de peso adequado e controle metabólico;
- Exercícios físicos devem ser estimulados, porém, devem-se seguir as orientações obstétricas respeitando contraindicações individuais.

Glicosímetro, tiras e lancetas

As gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional receberão um aparelho glicosímetro com tiras reagentes e lancetas para acompanhamento dessa condição a gestação.
Esses insumos poderão ser retirados na Farmácia Municipal de Nova Mutum, desde que preenchidos e apresentados os seguintes documentos:
1. Prescrição médica em duas vias, válida por 120 dias.
2. Formulário de solicitação de glícosímetro e insumos conforme ANEXO V
3. Termo de Consentimento Informado, ANEXO VI
Obs.: No ato da retirada dos materiais, a paciente ou responsável deverá apresentar também: documento com foto da paciente, caderneta de gestante e assinar o comprovante de recebimento dos insumos.
Devolução de glicosímetro:
O aparelho, que será utilizado durante toda a gestação, deverá ser devolvido à mesma farmácia que realizou a retirada, ainda no período puerperal (em até 42 dias após o parto).
No momento da devolução, será assinado o Termo de Devolução de Glicosímetro (ANEXO VII**)**
Obs.: Outros motivos de devolução do aparelho:
Desuso, uso indevido ou ausência de acompanhamento por 06 meses consecutivos;
Óbito ou mudança de Município (informação prestada pelo portador ou familiar);
Fim do ciclo gravídico-puerperal;
Interrupção do auto-monitoramento glicêmio
Defeitos do aparelho
Solicitação pela SMS

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Este protocolo abordará de modo sucinto os temas abaixo. Para maiores informações acessar os protocolos os quais são frequentemente atualizados pelo Ministério da Saúde.

1. Hepatite B

A hepatite B crônica tem pouca influência no curso da gestação, assim como a gestação em geral não altera a história natural da doença; porém, após o parto, poderá ocorrer reativação viral com exacerbação da doença hepática na parturiente (BRASIL, 2022).

A maioria das mulheres jovens com infecção crônica pelo HBV apresenta-se na fase de imunotolerância da infecção (HBsAg positivo, HBeAg positivo), que se

caracteriza pela intensa replicação viral, porém, sem doença hepática ativa (ALT/AST em níveis dentro da normalidade e histologia hepática com mínimas alterações).

O risco de transmissão vertical pelo HBV aumenta conforme a idade gestacional, podendo levar a maior incidência de prematuridade, baixo peso ao nascer e morte fetal ou perinatal, possivelmente devidos a fatores associados à infecção.

O rastreio da hepatite B na gestante deve ser realizado pelo teste rápido de hepatite B em todos os trimestres.

Gestantes expostas ao HBV em qualquer trimestre, por relação sexual ou acidente com material biológico, deverão receber associação de vacina e Imunoglobulina humana contra a hepatite B (IGHAHB).

Gestantes portadoras de exame HBsAg reagente deverão ser encaminhadas ao obstetra e ao infectologista, bem como, deve ser solicitado ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE em formulário específico para a vacina hepatite B e da imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) ao RN. A referência e contrarreferência devem ser documentadas no cartão da gestante.

Documentos necessários para anexar junto ao formulário CRIE com CID e Data Provável do Parto: RG, CPF, cartão SUS, cartão de vacina da gestante, notificação, exame HbsAg reagente, comprovante de endereço, cópia de cartão pré-natal e a prescrição da IGHHB e a vacina HB para o RN.

Das opções terapêuticas disponíveis para HBV, o tenofovir (TDF) é o único antiviral que tem seu uso recomendado na gestação.

Quanto à segurança da medicação para a gestante, há relatos de acidose láctica e esteatose hepática em pacientes que utilizam antivirais, sendo fundamental monitorar as enzimas hepáticas durante o tratamento.

A decisão quanto a suspensão da profilaxia medicamentosa será definida por especialista da rede de referência, preferencialmente entre um e três meses após o término da gestação. Pode ser considerada a manutenção da quimioprofilaxia com TDF se houver planejamento de gestações futuras.

Transmissão vertical do HBV

A principal forma de TV da infecção pelo HBV é a perinatal, sendo a transmissão intrauterina mais rara. A imunoprofilaxia combinada de IGHAHB e vacina no recém-nascido exposto previne a transmissão perinatal da hepatite B em mais de 90% dos RN.

Logo após o nascimento, os RN de mulheres com HBV (HBsAg reagente) devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) e a primeira dose do esquema vacinal para HBV. As demais doses serão aplicadas aos 2, 4 e 6 meses.

- Parto

Não há evidências concretas dos benefícios da realização de cesariana como medida preventiva da transmissão vertical de hepatite B.

- Amamentação

A amamentação não está contraindicada, ainda que não tenham sido realizadas ações para prevenção de TV-HBV.

2. Hepatite C

A infecção pelo HCV ocorre pela via parenteral, por meio da exposição ao sangue contaminado, por via sexual e por transmissão vertical. A infecção pelo HCV não é, por si só, impeditiva para o planejamento da gravidez.

Gestantes portadoras de exame HCV reagente deverão ser encaminhadas ao obstetra e ao infectologista.

Os medicamentos utilizados para o tratamento da hepatite C aguda e crônica são contraindicados durante a gestação. Caso a mulher em idade fértil ou sua parceria tiverem feito uso de ribavirina, recomenda-se aguardar seis meses para iniciar o processo de concepção.

- Parto

Não há evidências científicas que recomendem uma via de parto preferencial, orienta-se evitar procedimentos invasivos, parto laborioso e tempo de rotura de membranas maior que seis horas para minimizar a possibilidade de transmissão vertical.

- Amamentação

O aleitamento materno não é contraindicado em mulheres portadoras do HCV; contudo, a presença de fissuras ou feridas sangrantes na mama constitui-se em um

meio de exposição ao lactente, sendo recomendada a interrupção temporária de amamentação na mama lesionada até a cicatrização completa, com manutenção da ordenha e descarte do leite.

3. HIV

Há evidências de que a maioria dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre tardiamente na gestação e, principalmente, durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, sendo estes momentos importantes para a profilaxia da transmissão vertical do HIV. O aleitamento materno é contraindicado.

- Diagnóstico

Deve ser realizado através dos testes rápidos preferencialmente no planejamento familiar. O teste de HIV deve ser feito na abertura do pré-natal e em todos os trimestres da gestação. O diagnóstico da infecção pelo HIV é realizado mediante a dois diferentes testes rápidos positivos.

A amostra com resultado não reagente no teste rápido 1 (TR1) será definida como: “Amostra Não Reagente para HIV”. Se existir a suspeita de infecção pelo HIV, nova testagem deve ser realizada após 30 dias.

Amostras com resultado reagente no TR1 deverão ser submetidas ao teste rápido 2 (TR2) de outro laboratório. Amostras com resultados reagentes no TR1 e no TR2 terão seu resultado definido como: “Amostra Reagente para HIV”, sem a necessidade de nenhum teste adicional.

As amostras com resultados discordantes entre TR1 e TR2 não terão seu resultado definido. Caso o diagnóstico definitivo não seja estabelecido, a gestante deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco/Serviço de Atenção Especializada em DST/Aids.

A gestante HIV positiva deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco e ao infectologista.

- Parto:

A cesárea não é indicada de forma eletiva em gestantes com HIV, desde que estejam com CV-HIV abaixo de 1.000 cópias/mL para prevenir TV-HIV.

O AZT injetável é indicado para a prevenção da transmissão vertical e deve ser administrado durante o início do trabalho de parto, ou até 3 (três) horas antes da cesariana eletiva, até o clampeamento do cordão umbilical.

Para as mulheres já em TARV, os ARV devem ser mantidos nos horários habituais, VO, com um pouco de água, mesmo durante o trabalho de parto ou no dia da cesárea programada.

Não é necessário uso de AZT profilático EV nas gestantes que apresentem CV-HIV indetectável após 34 semanas de gestação, e que estejam em TARV com boa adesão (106, 107). Entretanto, independentemente da CV-HIV, o médico pode eleger ou não o uso do AZT intraparto EV, a depender do seu julgamento clínico se houver risco de má adesão.

- Investigação de tuberculose em gestantes vivendo com HIV

A tuberculose (TB) é a principal causa de óbito por doença infecciosa definida em pessoas vivendo com HIV; portanto, recomenda-se que seja investigada em todas as consultas, inclusive durante o pré-natal. São sinais e sintomas de tuberculose a presença de tosse, febre, emagrecimento e/ou sudorese noturna. A existência de qualquer um desses sintomas pode indicar TB ativa e deve ser investigada.

Recomenda-se rastreio de infecção latente pelo M. tuberculosis mediante prova tuberculínica (PT).

Nas gestantes vivendo com HIV, o tratamento da infecção latente da Tuberculose deve ser iniciado após o primeiro trimestre da gestação.

O esquema preferencial de tratamento para ILTB na GVHIV é a isoniazida na dose de 300mg, uma vez ao dia, durante seis a nove meses, suplementada por piridoxina (vitamina B6) na dose de 50mg/dia durante a gestação, pelo potencial toxicidade neurológica da isoniazida na mulher e no RN.

4. Sífilis

Causada pelo Treponema pallidum. É uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável, cujas vias de transmissão são: sexual, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o bebê durante a gestação e parto.

A taxa de transmissão vertical de sífilis para o feto é de até 80% intraútero.
Até 50% das gestações em mulheres com sífilis não tratada terão desfechos gestacionais adversos, entre eles morte intra-útero, parto pré-termo, baixo peso ao nascer ou morte neonatal.

Diagnóstico: Testes Rápidos no 1°, 2° e 3° trimestre e solicitação do VDRL.

Quadro 8.Tratamento:

Estadiamento	Esquema terapêutico	Seguimento (teste não treponêmico)
Sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente recente (com até um ano de evolução)	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo)	Teste não treponêmico mensal
Sífilis tardia: sífilis latente tardia (com mais de um ano de evolução) ou latente com duração ignorada e sífilis teriária	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI IM, 1x/semana (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 3 semanas. Dose total: 7,2 milhões UI IM	Teste não treponêmico mensal

ATENÇÃO: Recomenda-se tratamento imediato após apenas um teste reagente para sífilis (teste treponêmico ou não treponêmico), sem a necessidade de aguardar o resultado do teste complementar, desde que a gestante não tenha sido tratada anteriormente de forma adequada ou não tenha o registro do tratamento disponível.

Gestantes com história comprovada de alergia grave à penicilina devem ser dessensibilizadas. Os tratamentos alternativos devem ser considerados apenas quando a penicilina não puder ser obtida ou quando a dessensibilização não for possível para pacientes com alergia grave à penicilina, sendo ele: Ceftriaxona 1g, via intramuscular, 1 vez ao dia, por 10 a 14 dias.

O intervalo entre doses não deve ultrapassar 7 dias. Caso isso ocorra, o esquema deve ser reiniciado.

Fatores relacionados à falha terapêutica da sífilis materna:

- Coinfecção HIV-sífilis;
- Altos títulos de VDRL no momento do tratamento e parto;
- Severidade da doença fetal: hidropsia, hepatomegalia, espessamento placentário, ascite e anemia fetal;
- Tratamento após 24 semanas;
- Esquema terapêutico reduzido para a fase clínica

Seguimento:

VDRL deve ser realizado mensalmente nas gestantes.

Títulos baixos (até 1:4) podem permanecer como cicatriz sorológica após o tratamento.

Após o parto, o seguimento é trimestral até o 12º mês de acompanhamento (3, 6, 9 e 12 meses).

Considera-se sucesso de tratamento:

- A diminuição da titulação do teste não treponêmico em duas diluições em até três meses e quatro diluições (ex.: 1:64 para 1:4) em até seis meses, com evolução até a soro reversão (teste não treponêmico não reagente).
- A diminuição na titulação em duas diluições em até seis meses para sífilis recente ou em até 12 meses para sífilis tardia.

Retratamento

Ausência de redução da titulação em 2 diluições no intervalo de 6 meses (sífilis recente, primária e secundária) ou 12 meses (sífilis tardia). Aumento da titulação em duas diluições ou mais. Persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos.

Parceiro

Avaliação clínica e laboratorial. Se houve exposição a pessoa com sífilis (até 90 dias), recomenda-se tratamento presuntivo a esses parceiros sexuais, com dose única de benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões, UI, IM (1,2 milhão de UI em cada glúteo). Todas as parcerias devem ser testadas.

5. Citomegalovírus

Ocasionado pelo Herpes vírus tipo 5, possui período de incubação que varia entre 28 a 60 dias. A transmissibilidade permanece possível por 2 anos após a primo-infecção.

O vírus permanece latente em células mononucleares e pode ser reativado em situações de imunodepressão. O ser humano é o único reservatório do citomegalovírus.

A transmissão vertical pode ocorrer por via transplacentária, por secreções durante o parto e na amamentação. Pode gerar abortamento e malformações, sequelas neurológicas.

A soroconversão no 1° trimestre pode gerar sequelas neurológicas em 8% a 13% dos neonatos. Infecções no 2° e 3° trimestre não estão associadas a sequelas neurológicas graves.

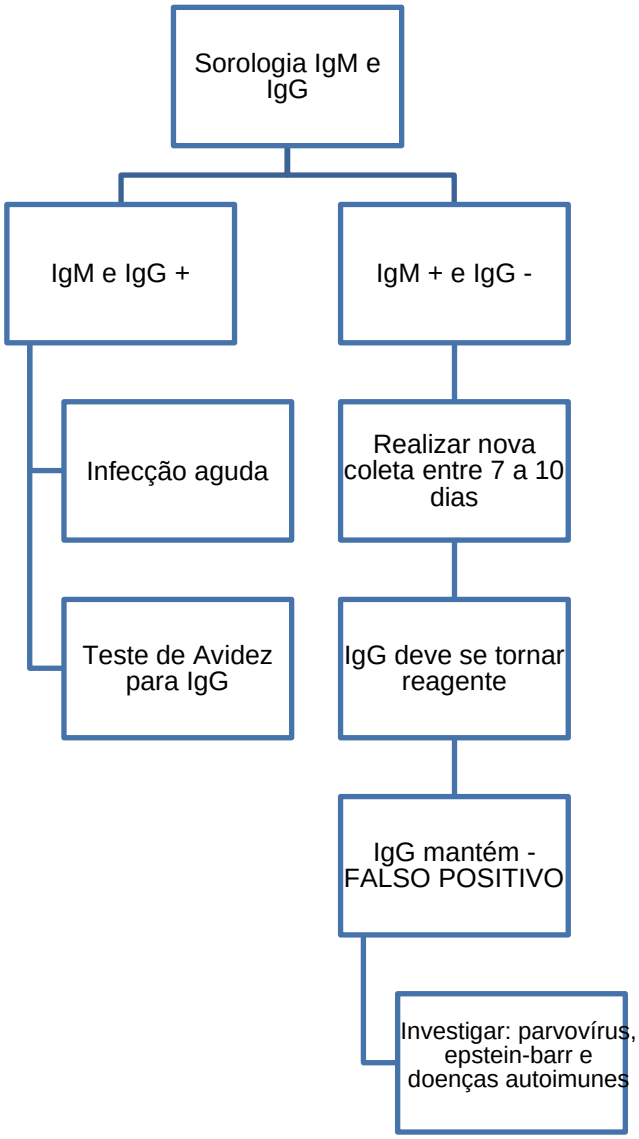
Quadro Clínico

É assintomático na maioria das vezes. Sintomas inespecíficos: febre, calafrios, sudorese exantema, dor articular, linfoadenopatia, anorexia, cansaço, mal-estar, leucocitose e presença de linfócitos atípicos no hemograma.

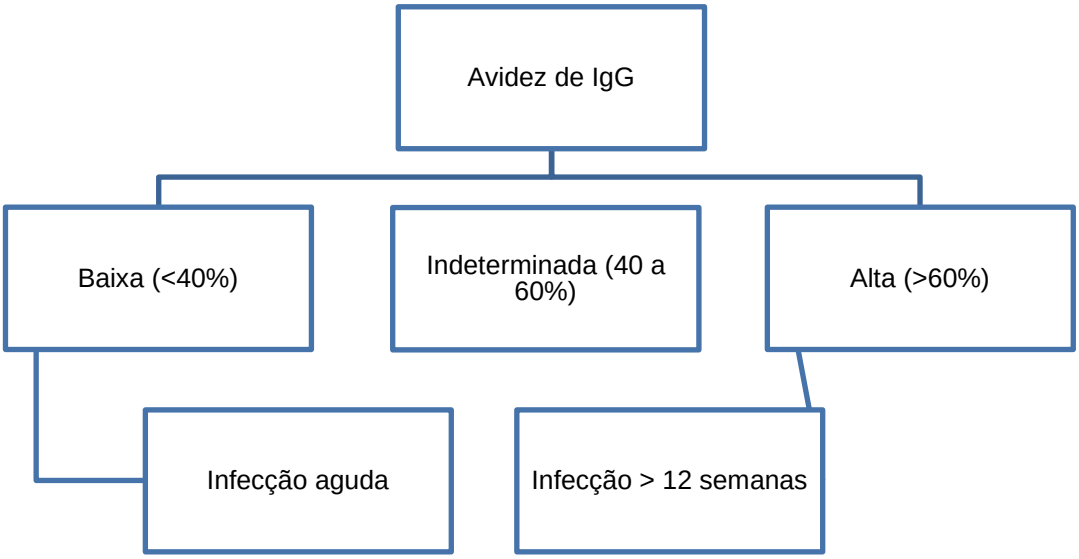
A sorologia para citomegalovírus deve ser solicitada antes de 14 semanas.

IgM torna-se reagente 1 a 3 semanas após a infecção e permanece reagente por 9 a 12 meses. IgG torna-se reagente 3 a 5 semanas após a infecção e permanece reagente por tempo indeterminado.

Fluxograma 4. Sorologias CMV



Fluxograma 5. Teste de Avidez



Profilaxia

Assumir que crianças menor de 3 anos tenham citomegalovírus na urina e na saliva. Lavar as mãos com sabão e água quente após qualquer cuidado com a criança. Não compartilhar talheres, copos, toalhas, lençóis e travesseiros. Evitar dormir na mesma cama. Lavar as roupas separadamente.

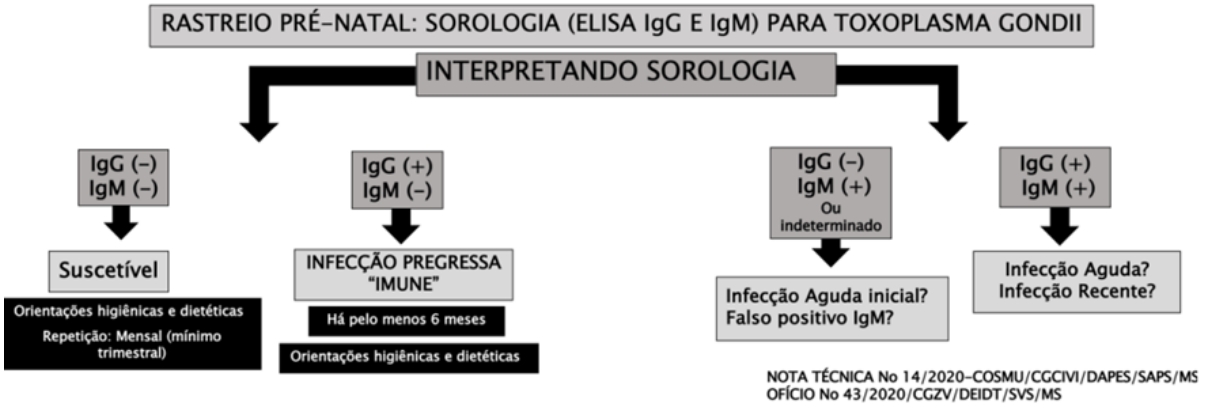
Conduta

Em caso de Gestante com Citomegalovírus encaminhar para Pré-Natal de Alto Risco.

6. Toxoplasmose

Seu agente causador é o Toxoplasma gondii, a taxa de transmissão vertical é diretamente proporcional à idade gestacional e a morbimortalidade fetal é inversamente proporcional ao tempo de gestação no momento da infecção aguda.
Diagnóstico: Solicitar sorologia, IgG e IgM, para Toxoplasmose.

Figura 3. Rastreio Toxoplasmose



IgM e IgG não reagentes: Orientar quanto ao risco de adquirir infecção aguda na gestação e às medidas higieno dietéticas. Repetir a sorologia a cada 3 meses e no parto.

Figura 4. Prevenção



- **IgG reagente e IgM não reagente:**

Compatível com infecção pregressa. Repetir a sorologia IgM em cada trimestre por possibilidade de reativação. Se 1ª sorologia for com ≥16 semanas deve-se verificar se há sorologia prévia a gestação atual.

- **IgM reagente e IgG não reagente:**

Iniciar imediatamente Espiramicina 500mg, 2 comprimidos de 8/8 horas.

Encaminhar ao Obstetra.

Repetir a sorologia em 2-3 semanas.

>Se IgG – e IgM +: suspender Espiramicina pois é um falso positivo de IgM, gestante susceptível a Toxoplasmose.

>Se IgG+ IgM +: Infecção Aguda.

Até 16 semanas deve manter a Espiramicina, ≥16 semanas deve-se iniciar Esquema Tríplice.

- **IgM e IgG reagentes:**

Interpretar como infecção aguda;

Iniciar a Espiramicina;

Solicitar teste de avidez.

Figura 5. Fluxograma Teste de Avidez ≤ 16 semanas

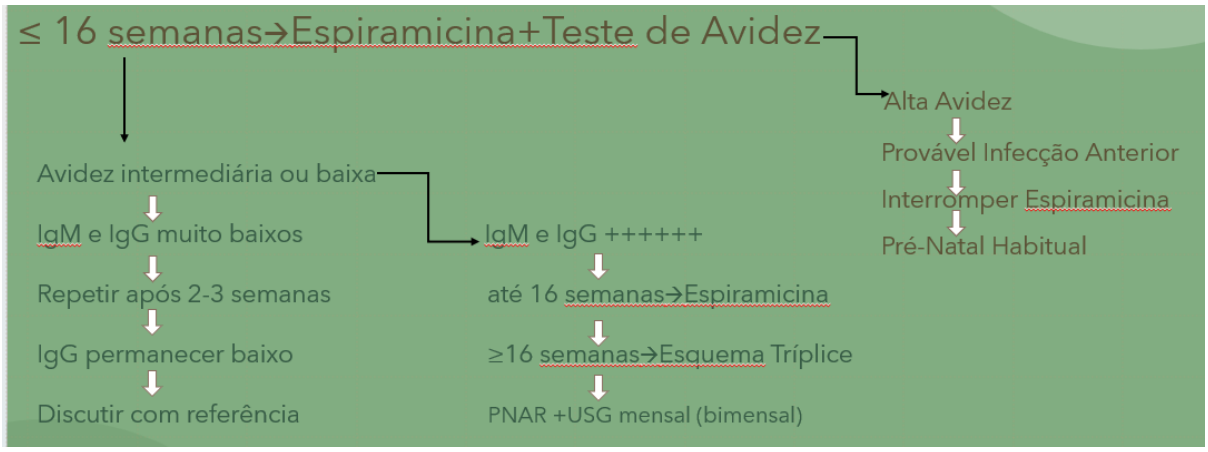
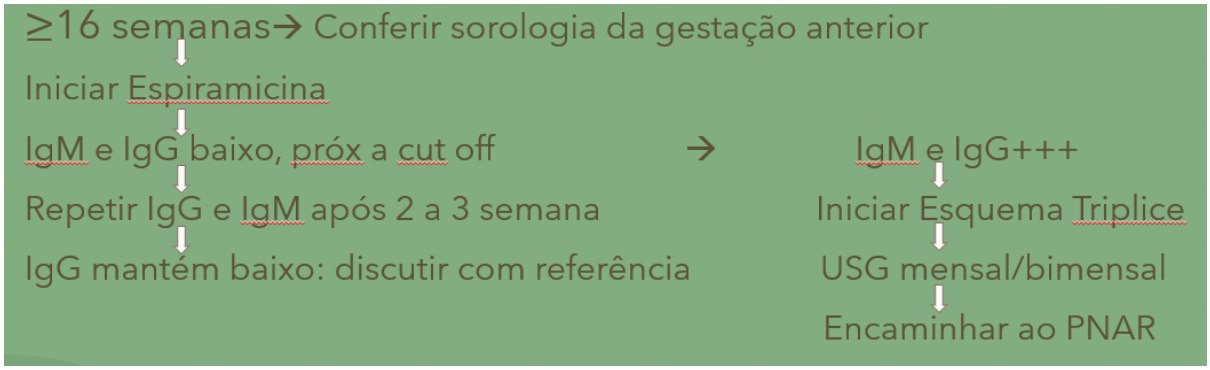


Figura 6. Fluxograma Teste de Avidez ≥16 semanas



Esquema Tríplice

- Sulfadiazina 500mg: 3 comprimidos de 12/12 horas até o final da gestação;
- Pirimetamina 25 mg:
  - Dose de ataque: 2 comprimidos, de 12/12 horas, por dois dias (via oral) (8 cp).
  - Manutenção: 2 comprimidos/dia a partir do 3º dia até o final da gestação.
- Ácido Folínico 15 mg/dia Dose: 1 cp ao dia - via oral até o final da gestação.

Efeitos Adversos

Náuseas, vômitos, dor abdominal, anorexia, sensação de boca amarga que podem acometer 1 a 2% das gestantes. Exantemas papulares, vesiculares e bolhosos podem ocorrer em 2 a 3% dos casos. É muito raro o desenvolvimento da síndrome de Stevens Johnson. Neutropenia, anemia e trombocitopenia podem ocorrer em 0,1% dos casos. Solicitar hemograma completo a cada 15 dias para monitoramento. Cristalúria: orientar a adequada ingestão de líquidos.

7. Epilepsia

É a doença neurológica grave mais comum na gestação, com incidência relatada de 0,3% a 0,5%. A etiologia é idiopática em 40% dos casos e em 60% pode ser devido a infecções, tumores, traumas, medicações e alterações metabólicas ou vasculares do sistema nervoso central.

Mulheres com epilepsia devem realizar planejamento pré concepcional uma vez que as medicações são de risco C ou D, podendo causar má formações congênitas principalmente no primeiro trimestre. As crises epilépticas pelo risco ao feto e a gestante como parto prematuro, sangramentos, hiperemese, hipóxia fetal e morte súbita materna. O planejamento da gestação deve ser realizado em conjunto com um neurologista.

O tratamento da epilepsia na gestação é preferencialmente em monoterapia. Havendo falha do primeiro fármaco, realiza-se a substituição gradual por outro medicamento de primeira escolha: lamotrigina, gabapentina, levetiracetam e primidona. As medicações citadas são categoria de risco C. O valproato de sódio possui risco elevado de malformações, fenobarbital e topiramato são de risco intermediário. Lamotrigina ou levetiracetam possuem menor risco de malformações. Em via de regra não se deve suspender ou substituir o esquema terapêutico no diagnóstico da gestação em mulheres com bom controle da epilepsia devido aos riscos maternos e fetais na ocorrência das crises.

Recomendações:

- Suplementação com ácido fólico 4 a 5 mg/dia, pelo menos três meses antes da concepção, e mantido durante toda a gravidez.
- Seguimento conjunto com neurologista.
- Minimizar fatores desencadeantes: sono de má qualidade, uso de drogas ou álcool, situações estressantes, esforço físico extenuante, febre, alterações metabólicas e má aderência ao tratamento.
- Ultrassonografia morfológica fetal de primeiro e segundo trimestres

Na crise convulsiva, manter a gestante em segurança, proteção física, manutenção de vias aéreas e oxigenação, monitorar a mãe e o feto, identificar fatores desencadeantes. A crise, geralmente, é autolimitada, em casos de crises prolongadas ou recorrentes:

Fenitoína:

A dose de ataque: 10 mg/kg (dose máxima de 1.000 mg), em velocidade de infusão de 50 mg/min, com rigorosa monitorização materna e fetal.
a dose de manutenção de 100 mg, VO, 8/8 horas.

8. Depressão/Ansiedade

A depressão deve ser investigada de forma ativa, questionando a gestante se a mesma se sente triste, desanimada, sem vontade de realizar suas atividades diárias. As crises de pânico costumam diminuir no início da gravidez e aumentar no terceiro trimestre.

Fatores de risco: gravidez não desejada, antecedente pessoal de depressão, fatores socioeconômicos, antecedente familiar de doença psiquiátrica, complicação na gravidez, mau passado obstétrico, multiparidade, uso de álcool e de drogas ilícitas, violência doméstica.

O diagnóstico de depressão é dado quando a gestante apresenta 5 critérios, dos citados abaixo, por 2 semanas, sendo que os dois primeiros devem estar presentes.

Quadro 9. Critérios Diagnósticos Depressão

Critérios diagnósticos de depressão maior segundo o DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 4º edição:
1 Humor deprimido a maior parte do dia, quase todos os dias, indicado pelo relato subjetivo (por ex.: diz sentir-se triste, vazio) ou observações feitas por terceiros (por ex.: chora muito). Obs.: pode ser humor irritável.
2 Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades diárias, na maior parte do dia, quase todos os dias (indicado pelo relato subjetivo ou observação de terceiros).
3 Perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta (por ex.: mais de 5% do peso corporal em um mês), ou aumento ou diminuição do apetite, quase todos os

dias.
4 Insônia ou hipersonia, quase todos os dias.
5 Agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias (observáveis pelos outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento).
6 Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias.
7 Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser delirante), quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente).
8 Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação de outros).
9 Pensamentos de morte (não apenas medo de morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico de cometer suicídio.

Fonte: American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington, DC; 2000.

Tratamento:

- Psicoterapia em todos os casos.
- Casos moderados a graves: adicionar tratamento farmacológico.

Se ideação suicida: encaminhar para atendimento emergencial, fazendo contato com médico regulador para internação hospitalar.

No tratamento medicamentoso é utilizado preferencialmente os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS):

1: Sertralina: 50-200mg/dia, primeira escolha, categoria de risco B.

2: Citalopram 20-40mg/dia, categoria B.

3: Escitalopram 10-20mg, categoria C, indicam risco fetal no terceiro trimestre.

4: Fluoxetina 20-80mg/dia, categoria de risco C.

Efeitos colaterais: Cefaleia, irritabilidade, ansiedade, impaciência, agitação, tremores, diarreia, náuseas, insônia.

Uma possível complicação é a Síndrome da Má Adaptação Neonatal, quadro autolimitado, pouco frequente, dura alguns dias, os sintomas são letargia, hipotonia, irritabilidade, tremores e convulsões no RN.

O uso de benzodiazepínicos como ansiolítico é contraindicado na gravidez, exceto para situações agudas. Caso necessário deve-se preferir os de meia vida curta: lorazepam (9-16 horas) ou o alprazolam (10-14 horas), em vez do clonazepam (18-50 horas). Melhores opções sedativas e ansiolíticas seriam a clomipramina (categoria C) e a levomepromazina (categoria C).

CAPÍTULO 15 - ROTINA DE ENCAMINHAMENTO AO PARTO

Gestantes de baixo/médio risco que chegarem às 41s 0d de gestação deverão ser encaminhadas ao hospital para avaliação obstétrica, podendo ser encaminhada diretamente da UBS via encaminhamento médico autorizado pela Regulação.

Em gestantes com DMG a conduta deve ser individualizada, se estiver em uso de insulina ou metformina deve se avaliar a possibilidade do parto com 39 semanas, caso a paciente diabética tenha bom controle glicêmico e com crescimento fetal dentro do percentil adequado pode ser avaliado parto com 40 semanas. Gestantes com outras condições de risco devem ser encaminhadas ao hospital para avaliação obstétrica com IG igual a 40s 0d. Todo encaminhamento e avaliação especializada deve-se antes entrar em contato com o médico regulador.

Gestantes com quaisquer intercorrências clínicas durante a gestação deverão também ser encaminhadas ao seguimento de alto risco e ao hospital para avaliação obstétrica imediata se necessário, com autorização da regulação.

Gestantes em trabalho de parto ativo devem ser encaminhadas ao hospital via encaminhamento autorizado pela regulação.

CAPÍTULO 16 - CONSULTA PUERPERAL

O pós-parto é um momento muito delicado para a mulher, pois envolve o cuidado do bebê e as mudanças físicas e emocionais no cotidiano e nas relações sociais. Deve-se dar especial atenção às condições psíquicas e sociais da mulher neste momento, pois uma das características marcantes desse período é a ansiedade despertada com a chegada do bebê, o que pode ocasionar sintomas depressivos.

Segundo o Ministério da Saúde deve-se realizar a consulta puerperal e do recém-nascido na primeira semana de vida (onde o RN deve ser encaminhado para consulta com a Pediatra) mantendo o acompanhamento da puérpera até o 42º dia pós-parto.

As variações desse período estão relacionadas às mudanças anatomofisiológicas no organismo feminino e questões psicossociais como: maternidade, sexualidade, autoestima, privação do sono, reorganização da vida pessoal e familiar.

Assistência ao puerpério

Tem como finalidade prevenir complicações no binômio mãe-bebê e assegurar a lactação normal.

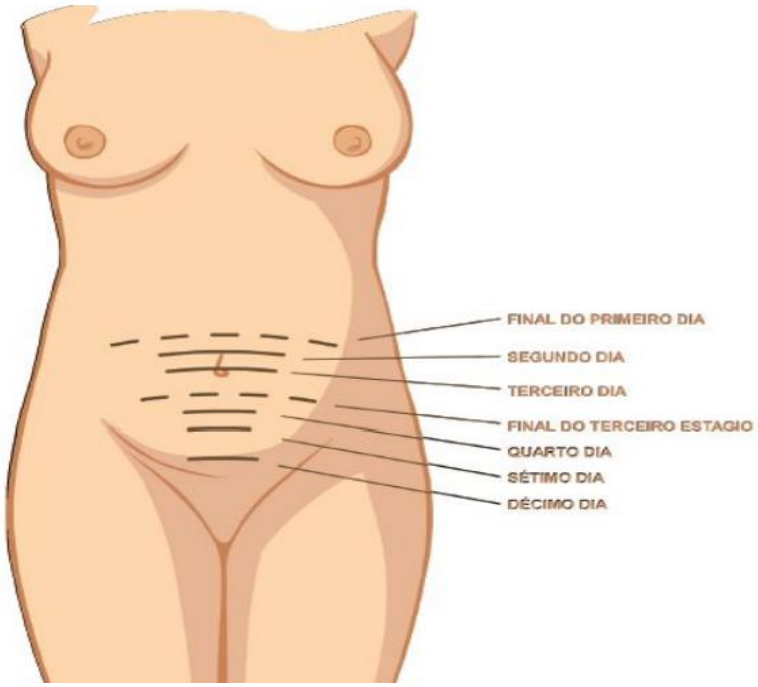
A mulher precisa ser cuidada, evitando assim, agravos à saúde materna e neonatal e deve incluir o parceiro, quando presente, e a família em seus diversos arranjos.

Modificações anatomofisiológicas no puerpério

A puérpera perde cerca de 5 a 6kg após o parto, e pode perder cerca de 2 a 3kg nos próximos 10 dias. Há diminuição da hiperpigmentação da pele e do cloasma gravídico. O útero regride rapidamente e, após o parto, contrai-se formando uma massa dura que pode ser palpada abaixo da cicatriz umbilical, diminuindo 1cm a cada dia.

A puérpera sente dores semelhantes a cólicas nos primeiros dias de involução uterina, principalmente com a amamentação, devido a ação da ocitocina.

Figura 5. Involução da Altura Uterina



O volume da loquiação vai diminuindo com a involução uterina. Quaisquer alterações de odor devem ser consideradas. Lóquios podem ser:

Lóquio rubro: até o 3º dia, vermelho vivo.

Lóquio fúcsia: do 3º ao 5º dia, vermelho escuro.

Lóquio flava: do 5º ao 10º dia, sero sanguinolento.

Lóquio alba: do 10º dia em diante, esbranquiçado (seroso).

Modificações psicoemocionais do puerpério

São frequentes os episódios de tristeza ocasionados pela mudança hormonal brusca logo após o parto. Esse estado depressivo transitório ocorre em 70% a 90% das puérperas, o qual chamamos de Blues Puerperal, ou melancolia Puerperal.

Deve-se suspeitar de depressão pós-parto (ou outros transtornos mentais sérios) se a mulher possuir as seguinte características: sintomas da depressão por mais de 2 semanas (ocorre em média de 10 a 15% das mulheres), sintomas que interferem nas atividades diárias, pensamentos homicidas ou suicidas (as mulheres devem ser questionadas especificamente sobre esses pensamentos), alucinações ou comportamento psicótico. E na existência destas manifestações devem ser acompanhadas por profissionais especializados.

Seguimento pós-parto

Após o parto, o hospital deve comunicar a alta hospitalar às equipes de saúde para que possam dar seguimento ao acompanhamento puerperal. Essa comunicação deve ser realizada por e-mail ou contra-referência, especificando condições de agravamento e risco.

O hospital ainda deve antes da alta realizar as devidas orientações no puerpério imediato sobre amamentação, sinais e sintomas de alarme e sobre os cuidados com recém-nascido.

Ainda no hospital, os recém-nascidos devem realizar as vacinas da BCG e Hepatite B, realizar as triagens neonatais (teste do coraçãozinho, teste da linguinha, teste do olhinho e teste de triagem auditiva), bem como serem orientados a procurar suas UBS de referência para realização do teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida. É de responsabilidade do hospital o fornecimento do cartão de saúde da criança.

O ACS é responsável pelo cadastramento e vinculação do recém-nascido à unidade.

É responsabilidade de toda equipe da APS o cuidado e acompanhamento dessa criança e dessa mãe, devendo estar atenta as condições de risco e vulnerabilidades, acolher os medos e anseios da mãe/família, mudanças fisiológicas e emocionais do puerpério, vacinas, alimentação e hidratação, eliminações, ferida operatória (se for o caso), planejamento familiar, sinais vitais, avaliação da amamentação, sucção do recém-nascido, freio lingual, realizar rotina de acompanhamento e atender as demandas emergentes.

No puerpério deve ser prescrito o sulfato ferroso 40 mg de ferro elementar, 30 minutos antes do almoço, de preferência com suco de frutas cítricas, até três meses após o parto.

Atentar aos Sinais de ALERTA

As principais complicações, potencialmente fatais, no ciclo gravídico-puerperal são:

- Hemorragia pós-parto: avaliar e investigar perdas de sangue súbita e abundante ou aumento persistente dessa perda, desmaios, tonturas, palpitações, hipotensão.

- Infecção puerperal: avaliar e investigar febres, calafrios, dor abdominal, ferida cirúrgica (em caso de cesariana ou episiotomia), cor e odor de leucorreia presente.
- Pré-eclâmpsia/Eclâmpsia: avaliar e investigar cefaléia acompanhada por um ou mais dos seguintes sintomas: distúrbios visuais, náusea, vômito.
- Tromboembolismo: avaliar e investigar: dor, vermelhidão ou inchaço na panturrilha unilateral, além de falta de ar ou dor no peito.
- Transtornos emocionais

Outros sinais e sintomas de alerta importantes: mamas “empedradas” e doloridas.

ABORDAGEM MEDICAMENTOSA E REAVALIAÇÃO DE PUÉRPERA COM COMORBIDADES

Em caso de comorbidades revisar prescrição medicamentosa e demais condutas, com atenção às contraindicações devido ao aleitamento materno e encaminhar, caso necessário, ao serviço especializado para avaliação após parto mediante pré-natal de alto risco.

CAPÍTULO 17 - PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

A gestação provoca mudanças e adaptações na rotina. A participação do parceiro(a) neste processo pode ser fundamental para o bem-estar dele, da gestante e da família.

A realização do pré-natal do parceiro rompe com a ideia de que as responsabilidades e os cuidados com a criança são de exclusividade da parceira. Fortalece os direitos da gestante e bebê no parto e nascimento. Diminui índices de violência obstétrica. Diminui o medo e a tensão durante o parto e favorece o aleitamento materno e vínculo entre bebê e família.

Objetivos do pré-natal do parceiro:

>Preparar para um cuidado ativo e consciente;

>Fortalecimento de vínculos com a parceira e filho(s);

>Detectar precocemente doenças;

>Atualizar a caderneta vacinal;

>Incentivar a participação em atividades educativas nos serviços de saúde e hábitos saudáveis de vida.

Para assistência pré-natal do parceiro completa são necessárias mínimo de uma consulta, sendo aproveitado a vinda do parceiro na consulta pré natal da gestante e/ou agendando consulta pré natal do parceiro conforme disponibilidade do mesmo.

1ª consulta:

Solicitação de exames e realização dos testes rápidos:

- ABO-RH; Glicemia; Sífilis; VDRL; HIV/Anti-HIV; Hepatite C; Hepatite B- HBsAg; Hemograma; Lipidograma
- Orientações sobre pré-natal;
- Verificação da situação vacinal;
- Identificar doenças pregressas, antecedentes familiares e fatores de risco;
- Avaliar pressão arterial e IMC.

2ª consulta:

- Checar exames;
- Orientar consulta odontológica do parceiro (avaliação odontológica inicial)
- Avaliar pressão arterial e IMC.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Federal nº 11.340/2007. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília, DF. 2007.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, DF. 2005.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009.Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. Brasília, DF. 2009.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975. Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. Brasília, DF. 1975.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei Nº 1.044, de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica. Brasília, DF. 1969.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF. 1943.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília, DF. 1996.

FINOTTI, M. Manual de anticoncepção. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2015.

PEIXOTO, S. Manual de assistência pré-natal. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2a. ed., 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, DF. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

DEMARCHI, A. P.; FREITAS, E.; BARATTO, I. Avaliação nutricional e laboratorial em um grupo de gestantes no município de Pato Branco-PR. RBONE - Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento, v. 12, n. 72, p. 466-478,, 2018.

PERAÇOLI, J. C., COSTA, M. L., CAVALLI, R. C., OLIVEIRA, L. G. KORKES, H. A.; RAMOS, J. G. L., et al. Pré-eclampsia – Protocolo 2023. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST. Brasília, DF. 2022.

American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington, DC; 2000.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da

Criança e do Adolescente. Postagens: A Consulta Puerperal na Atenção Primária à Saúde. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/a-consulta-puerperal-na-atencao-primaria-a-saude/>.

Manual de assistência pré-natal / Sérgio Peixoto. -- 2a. ed. -- São Paulo : Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2014.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012.318 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n° 32)

Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico N° 20. Volume 51. Maio/2020. • RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Estado da Saúde. Departamento de Ações em Saúde.

Rio Grande do Sul. Secretaria de Estado da Saúde. Departamento de Ações em Saúde. Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Assessoria Técnica e Planejamento. Guia do pré-natal na Atenção Básica/Porto Alegre: Secretaria de Estado da Saúde/RS, 2018. 40p. Il.

Rio Grande do Sul. Secretaria de Estado da Saúde. Departamento de Ações em Saúde. Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Assessoria Técnica e Planejamento. Nota Técnica 01/2019 Assistência à Saúde da Criança de 0 A 2 ANOS na Atenção Básica.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS. Curso EaD sobre o sistema e-SUS: profissionais da saúde. Porto Alegre: Telessaúde-UFRGS, 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 2.068, de 21 de outubro de 2016. Institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.Saúde da criança : crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Postagens: A Consulta Puerperal na Atenção Primária à Saúde. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/a-consulta-puerperal-na-atencao-primaria-a-saude/>.

OMS. Diretriz: suplementação diária de ferro e ácido fólico em gestantes. Genebra: Organização Mundial de Saúde, 2013.

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/FEMINAZ11ZV3.pdf

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 2. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/sifilis

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/toxoplasmose

NOTA TÉCNICA Nº 14/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS

Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012.

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

Manual de gestação de alto risco [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.

ANEXOS

ANEXO I - ORIENTAÇÕES DO PRÉ NATAL

Orientação sobre sinais de alerta: Perda líquida ou sangramento genital e redução dos movimentos fetais;
Orientação sobre modificações/adaptações do organismo à gravidez: Essas informações devem ser compartilhadas com o parceiro, pois fazem parte da estratégia de sua inclusão na assistência pré-natal.
Orientação sobre hábitos higiênicos e vestes: banho diário, higiene perineal no sentido ântero-posterior, roupa íntima de algodão, vestes largas e confortáveis, e suporte mamário que realmente dê suporte às mamas. Recomenda-se evitar duchas vaginais durante a gravidez. Não é recomendado o preparo das mamas na gestação.
Orientação sobre o trabalho de parto: Essa informação é mais dirigida para gestantes na segunda metade da gravidez, mas se houver oportunidade e tempo, pode-se aproveitar para começar essas orientações precocemente.
Orientações alimentares e sobre ganho de peso A alimentação deve ser saudável e balanceada, estimulando a ingestão de água e fibras. A gestante deve ingerir frutas, verduras e legumes, leite e derivados, o qual contêm nutrientes importantes para o crescimento fetal, da mesma forma que podem contribuir para evitar o ganho excessivo de peso. A gravidez requer aumento médio de 15% na ingestão calórica.
Demais hábitos de vida: uso de tabaco, álcool e outras drogas, exercícios físicos
Orientações sobre a atividade laboral: O ideal é que gestante mantenha sua atividade laboral, mas, quando sua atividade demanda longos períodos em posição ortostática, esforço físico intenso e exposição profissional a agentes químicos, físicos e tóxicos, deve-se recomendar que ela seja designada para outra função.
Cuidados com dentes e gengivas: manter a escovação e o uso do fio dental
Orientações sobre a atividade física e a prática de esportes: podem ser recomendados para gestantes, e a escolha da atividade deve levar em consideração suas preferências. As atividades físicas mais adequadas são as caminhadas, a natação e a hidroginástica. Os exercícios de alto impacto estão relacionados a maior risco de lesões articulares e, por isso, devem ser suspensos durante a gravidez.
Orientações sobre a atividade sexual: está liberada durante a gravidez, e sua restrição só será recomendada em caso de desconforto, sangramento gestacional ou trabalho de parto pré-termo.
Uso de medicamentos (não uso de fármacos sem orientação médica);
Uso das suplementações pré-natais;
Vacinas da gestação;
Estímulo da participação do parceiro ou dos familiares no pré-natal
Importância da continuidade do pré-natal e realização das consultas e exames em tempo adequado.
Sanar dúvidas e medos da pessoa gestante e acompanhante/ parceiro(a);

ANEXO II - ORIENTAÇÕES DO 2º TRIMESTRE

Orientação sobre sinais de alerta: Perda líquida ou sangramento genital e redução dos movimentos fetais;
Orientação sobre modificações/adaptações do organismo à gravidez
Orientação sobre hábitos higiênicos e vestes confortáveis;
Sono e repousos adequado;
Orientações alimentares e sobre ganho de peso (controle do peso);
Demais hábitos de vida: uso de tabaco, álcool e outras drogas, exercícios físicos
Orientação sobre o trabalho de parto;
Orientações sobre a atividade laboral
Cuidados com dentes e gengivas
Orientações sobre a atividade física e a prática de esportes
Orientações sobre a atividade sexual;
Uso de medicamentos (não uso de fármacos sem orientação médica);
Uso das suplementações pré-natais;
Vacinas da gestação;
Estímulo da participação do parceiro ou dos familiares no pré-natal
Importância da continuidade do pré-natal e realização das consultas e exames em tempo adequado.
Sanar dúvidas e medos da pessoa gestante e acompanhante/ parceiro(a);

ANEXO III - ORIENTAÇÕES DO 3º TRIMESTRE

Orientação sobre sinais de alerta: Perda líquida ou sangramento genital e redução dos movimentos fetais;
Orientação sobre modificações/adaptações do organismo à gravidez;
Orientação sobre hábitos higiênicos e vestes confortáveis;
Sono e repousos adequado;
Orientações alimentares e sobre ganho de peso (controle do peso);
Demais hábitos de vida: uso de tabaco, álcool e outras drogas, exercícios físicos
Orientação sobre o trabalho de parto;
Cuidados com recém-nascido e amamentação;
Como identificar trabalho de parto, sinais de alerta e exercícios que facilitam o parto;
Métodos de alívio para dor do parto/ contrações;
Fluxo para hospital/ internação para parto;
Auxiliar no plano de parto;
Orientações sobre a atividade laboral;
Cuidados com dentes e gengivas
Orientações sobre a atividade física e a prática de esportes
Orientações sobre a atividade sexual;
Uso de medicamentos (não uso de fármacos sem orientação médica);
Uso das suplementações pré-natais;
Vacinas da gestação;
Estímulo da participação do parceiro ou dos familiares no pré-natal
Importância da continuidade do pré-natal e realização das consultas e exames em tempo adequado.
Sanar dúvidas e medos da pessoa gestante e acompanhante/ parceiro(a);

ANEXO IV - INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL

INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL

RISCO .....10 ou + Pontos ALTO (Acompanhamento na APS e AAE)
RISCO .....5 a 9 Pontos MÉDIO (Acompanhamento na APS ou especialista)
RISCO .....até 4 Pontos BAIXO (Acompanhamento na APS)

Data da consulta												
Pontuação												

1.CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS, SOCIOECONÔMICAS

<15 ANOS 2
>40 ANOS.....2
Mulher de raça negra.....1
Baixa escolaridade (<5 anos de estudo).....1
Tabagista ativo.....2
Indícios de ocorrência de violência.....2
Gestante situação de rua.....2
Ganho de peso inadequado.....0
Baixo peso no início da gestação (IMC <18).....2
Sobrepeso (25-29,9 kg).....1
Obesidade (IMC > 30 – 39,9 kg).....4
Obesidade grau 3 (IMC > 40 kg).....10

OBS: A soma dessa sessão não configura encaminhamento direto ao alto risco. Exceção ao obesidade grau 3.

2. HISTÓRIA REPRODUTIVA ANTERIOR

Dois abortos consecutivos ou três não consecutivos.....2
Prematuridade na gestação anterior.....2
Mais de um parto prematuro (<36 semanas).....10
Restrição de crescimento intrauterino na gestação anterior.....2
Natimorto sem causa determinada.....10
Incompetência Istmo Cervical.....10
Isoimunização Rh.....5
Pré-eclâmpsia com resultado obstétrico ruim: eclâmpsia, síndrome HELLP, óbito fetal intrauterino, internação materna em UTI.....10
Psicose puerperal na gestação anterior.....10
Transplante.....5
Cirurgia bariátrica há menos de 6 meses.....10
Acretismo placentário.....2

3. CONDIÇÕES CLÍNICAS PRÉVIAS À GESTAÇÃO

Hipertensão Arterial Descompensada.....10
Diabetes Mellitus 1 ou 2.....10
Tireoidopatias.....10
Doença Psiquiátrica Grave.....10
Doenças hematológicas (doença falciforme, púrpura trombocitopênica autoimune (PTI) e trombótica (PTT), talassemias, coagulopatias), antecedentes de tromboembolismo.....10
Cardiopatias com repercussão hemodinâmica.....10
Pneumopatias Graves (DPOC, Asma).....10
Doenças Auto-imunes (Colagenose).....10
Uso de medicamentos teratogênicos (Anticonvulsivantes: barbitúricos, carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, primidona e fenobarbital. Estabilizadores de humor: carbonato de lítio, ácido valproico).....10
Doença Renal Grave.....10
Hemopatias e Anemia grave (hemoglobina < 8 g/dl).....10
Hepatopatias crônicas (Hepatites Virais, Cirrose).....10

4. INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS/OBSTÉTRICAS NA GESTAÇÃO ATUAL

Doença Hipertensiva da Gestação/Pré-eclâmpsia.....10
Diabetes Gestacional não compensada com dieta em 2 semanas.....10
Infecção Urinária de repetição (3 ou +) ou infecção urinária alta.....10
Cálculo renal com obstrução.....10
Restrição de crescimento intrauterino.....10
Feto acima do percentil 90% ou suspeita de macrossomia.....10
Polidrâmnio/ Oligoidrâmnio.....10
Colo curto em USG transvaginal entre 20 e 24 semanas.....10
Suspeita de acretismo placentário.....10
Placenta prévia diagnosticada após 28 semanas de gestação.....10
Hepatopatias (ex: colestase ou elevação de transaminases).....10
Anemia grave ou anemia refratária ao tratamento.....10
Isoimunização RH.....10
Câncer materno com diagnóstico ou tratamento durante a gestação.....10
Neoplasias ginecológicas na gestação atual.....10
Alta suspeita clínica de câncer de mama.....10
Lesão de alto grau em colo uterino (NIC II - III).....10
Suspeita de malformação fetal ou arritmia Fetal.....10
Gemelaridade.....10
Sífilis terciária ou com achados ecográficos sugestivos de sífilis congênita ou resistente ao tratamento com penicilina benzatina.....10
Condiloma acuminado no canal vaginal/colo ou lesões extensas localizadas em região genital/perianal.....10
Hepatites agudas com diagnóstico em gestação atual.....10
Hanseníase com diagnóstico na gestação atual.....10
AIDS/HIV com diagnóstico na gestação.....10
Tuberculose.....10
Toxoplasmose/Rubéola/Citomegalovírus.....10
Dependência e/ou uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas.....10
Endocrinopatias descompensadas.....10
Dengue, vírus Zika ou Chikungunya (quadro febril exantemático).....5
COVID-19 (acompanhar a evolução de quadro clínico. Os casos graves devem ser imediatamente encaminhados para urgência/hospitais).....5

INSTRUMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL, DELIBERAÇÃO 198/CIB/2021 RETIFICADA EM 26.05.2022, ESTADO DE SANTA CATARINA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

ANEXO V - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GLÍCOSÍMETRO E INSUMOS

Formulário de solicitação de glícosímetro e insumos Diabetes Mellitus Gestacional Protocolo Municipal de Pré Natal de Risco Habitual Comissão de Farmácia e Terapêutica

Unidade de Saúde	
Data de adesão ao pré-natal	

Identificação do usuário	
Nome	Data de nascimento
Cartão SUS	CPF
Endereço	

Identificação prescritor	
Nome	
CRM	Especialidade

Histórico clínico e obstétrico
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Data do diagnóstico:

_____
Médico prescritor, carimbo e assinatura

ANEXO VI - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum
Protocolo Municipal de Pré Natal de Risco Habitual
Comissão de Farmácia e Terapêutica

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

(Preenchimento pelo paciente, em 2 vias, sendo que 1 via ficará retida na farmácia que dispensou o insumo)

Preenchimento pela Unidade de Saúde

Eu, _____, CPF _____, concordo de espontânea vontade em submeter-se ao referido tratamento, assumindo a responsabilidade e os riscos relacionados ao uso do aparelho glicosímetro e/ou dos insumos.

Estou ciente de que o aparelho é de uso pessoal e intransferível, e que sou responsável pela manutenção da higiene do aparelho e da troca de bateria, quando necessário;

Estou ciente que devo realizar o Pré natal junto a unidade de saúde municipal;

Estou ciente que receberei os insumos somente enquanto estiver no período gravídico-puerperal (gestação e puerpério - até 42 dias pós parto);

Estou ciente de que devo apresentar na farmácia, CADERNETA DE GESTANTE (com as consultas periódicas em dia) SEMPRE que fizer a retirada dos insumos.

Estou ciente que o aparelho deve ser devolvido ainda no período puerperal, na mesma Farmácia Municipal em que o retirei;

Comprometo-me a devolver o aparelho em bom estado caso o tratamento seja interrompido ou por solicitação da SMS em caso de troca;

Em caso de perda ou roubo do glicosímetro, a troca, conserto ou aquisição de um novo aparelho somente serão feitas mediante a apresentação de Boletim de Ocorrência (B.O);

Declaro ter sido informado sobre as indicações e contraindicações para o automonitoramento, além de outras informações para o cuidado do diabetes e comprometo-me a seguir todas as orientações a mim fornecidas.

_____ _____ Data _____/_____/___

Assinatura do paciente Responsável pelas orientações

Preenchimento pela Farmácia Municipal

Recebi da Farmácia _____ , os seguintes insumos:

( ) Glicosímetro, marca: _____Nº série: _____
( ) Lancetador, marca: _____ Nº série: _____
( ) Lancetas, quantidade: _____
( ) Tiras reagentes, quantidade: _____

_____ _____

Responsável pela retirada Profissional dispensador

Data: _____/_____/_____

ANEXO VII - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE GLICOSÍMETRO

Secretaria Municipal deSaúde de Nova Mutum
Protocolo Municipal de Pré Natal de Risco Habitual
Comissão de Farmácia e Terapêutica

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE GLICOSÍMETRO

Eu, _____ estou devolvendo o glicosímetro de marca _____ e N° de série _____, que foi fornecido pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, paciente _____, CPF _____, estando ciente dos critérios de uso e manutenção, bem como sobre as condições para devolução:

( ) Desuso, uso indevido ou ausência de acompanhamento por 06 meses consecutivos;
( ) Óbito ou mudança de Município (informação prestada pelo portador ou familiar);
( ) Fim do ciclo gravídico-puerperal;
( ) Interrupção do auto-monitoramento glicêmio
( ) Defeitos do aparelho
( ) Solicitação pela SMS

Nova Mutum, _____, de _____ de _____.

_____
Responsável pela devolução

_____
Responsável pelo recebimento e conferência

PROTOCOLO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL

Anderson Lins Ferreira Formighieri
Coordenador de Departamento de Atenção Básica

Sonia Maria de Ávila
Secretária de Saúde